

中医病案分析

華北書局出版



自学中医之路丛书

中医病案分析

北京中医学院 主编

审 阅

北京中医学院分院	河北中医学院
黑龙江中医学院	长春中医学院
辽宁中医学院	内蒙古医学院中医系
天津中医学院	

天津科学技术出版社

执 笔 人

鲁兆林

高春媛

2147/2218

自学中医之路丛书

中医病案分析

北京中医学院 主编

审 阅

北京中医学院分院 河北中医学院

黑龙江中医学院 长春中医学院

辽宁中医学院 内蒙古医学院中医系

天津中医学院

责任编辑：于伯海

天津科学技术出版社出版

天津市赤峰道10号

天津新华印刷四厂印刷

新华书店天津发行所发行

开本787×1092毫米 1/32 印张6.75 字数183 000

1991年6月 第1版

1991年6月 第1次印刷

印数：1—5 130

ISBN 7-5308-0799-4/R·226 定价：3.10 元

编者的话

历史悠久的中国医药学，有着独特的理论体系和丰富的临床经验。在当今世界医学之林中愈发闪烁着夺目的光彩，国内外学者越来越看到中医学宝库的巨大蕴藏量及其对世界科学的深远影响。从而形成学习、研究中医药学的热潮，并且呈现出日益国际化的发展趋势。

然而，中医古籍汗牛充栋，浩如烟海，且文理古奥，颇难索解。初学之人，常感无从入手，叹为观止。为了适应学习中医的需要，我们编写了这套《自学中医之路》丛书，以供初学中医人员及广大中医工作者和西医学习中医等同志们在教学、医疗工作中应用与参考。

本丛书的内容包括中医基础理论和临床辨证论治两部分，共十六个分册。计有阴阳五行学说、病因病机学说、脏腑经络学说、诊法概要、八纲与八法、六经辨证、卫气营血辨证、脏腑病证常用方药、心病辨治、肝病辨治、脾病辨治、肺病辨治、肾病辨治、中医病案分析、历代临证格言选萃、针灸与按摩。

编写中，我们本着：①理论联系实际的原则。对基础理论的阐述，力求概念准确，逻辑性强，思维清晰，切合实用；五脏辨治等分册，结合内、外、妇、儿等学科常见病证，详细介绍辨证论治的规律与方法。②保持中医理论的科学性，系统性和完整性。尽管避免某些教材中存在的非必要

的重复、冗繁和脱节做到深入浅出，简明精练。各分册能够独立成章，又使全丛书统一、谐调，成为有机的整体。③本丛书内容的深度和广度，以最近卫生部组织编写并审定的全国高等中医药教材为依据，并汲取各院校教学、医疗、科研的新成果、新经验。可以说，本丛书既是自学中医的普及读物，又可作中医院校的辅导教材。

本丛书是由天津科学技术出版社组稿，由天津中医学院、北京中医学院、北京中医学院分院、黑龙江中医学院、长春中医学院、辽宁中医学院、河北中医学院、内蒙古医学院等八所院校集体编写的。在全体编写人员的努力和天津科学技术出版社编辑同志的协助下，历时二年，几经修订，才得以奉献给广大读者。书中不足之处恳请批评指正，以便使本书进一步修改、完善，更好地为中医事业的发展发挥出应有的作用。

《自学中医之路》丛书编写组

1986年6月

前 言

中医医案是祖国医学伟大宝库的重要组成部分。读好医案，能获得科研第一手资料，占有治学的真凭实据；不断深化已得的理论知识；逐步完善对疾病发展规律的认识；圆通辨证治疗的措施，因此，近贤章太炎先生曾说：“中医之成就，医案最著，欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻。循此钻研，事半功倍。”

古今许多名医寝馈岐黄，将其于医道三折肱之甘苦，记入医案之中。更有许多大临床家，毕生忙于诊务，无暇著述。他们的临床经验，多由其门人及后学搜集整理为医案书籍出版。一部《临证指南医案》曾给无数习医者指示迷津；清代名医何鸿舫的一页处方，东瀛人愿以高价收存。因而从明代江瓘伊始，医案的研究工作越来越为众多医务工作者所重视。

迄今已有的研究整理医案的著作中，《名医类案》贵在首创；《续名医类案》篇幅浩博；《清代名医医案精华》辑有清之精英；《全国名医验案类编》长于温病；《现代名中医类案》聚当代之名流；《伤寒论方医案选》集经方之验案，贵在专门；《古今救误》广辑拨乱反正案例，颇能醒聩发蒙。其余各地名医医案之多，不胜枚举，亦多为独具一格，别出匠心之作。

此书总论，阐述中医医案发展源流及学习方法。各论共

分四类，选择常见病证65种，辑案二百余例。上自北宋，以至于今。不唯古今名家之案择优录入；即或无名后学之案，但见于杂志而确有特色者，亦适当选录。编写体例，前缀“概说”，简论该证的辨证分型；后附“分析”，力求对所选病案之精华画龙点睛。方中药量，皆按公制，以“克”标明。

限于水平，难免续貂之嫌，还望读者多予赐教。

编 者

1987年5月

目 录

总论	(1)
一、中医医案发展源流.....	(1)
二、学习医案的必要性.....	(2)
三、医案的书写体例.....	(4)
四、怎样读好各家医案.....	(7)
各论	(10)
一、内科杂病医案.....	(10)
(一) 感冒.....	(10)
(二) 咳嗽.....	(14)
(三) 喘证.....	(16)
(四) 哮证.....	(21)
(五) 肺癆.....	(24)
(六) 胃脘疼.....	(29)
(七) 腹疼.....	(34)
(八) 呕吐.....	(37)
(九) 泄泻.....	(42)
(十) 便秘.....	(46)
(十一) 黄疸.....	(49)
(十二) 水肿.....	(54)

(十三)	淋证	(58)
(十四)	消渴	(63)
(十五)	惊悸怔忡	(67)
(十六)	头痛	(71)
(十七)	眩晕	(75)
(十八)	中风	(78)
(十九)	癫痫	(83)
(二十)	痹证	(87)
(二十一)	痿证	(91)
二、	妇科医案	(95)
(一)	月经不调	(95)
(二)	闭经	(104)
(三)	痛经	(109)
(四)	崩漏	(111)
(五)	倒经	(116)
(六)	月经异常诸证	(119)
(七)	带下病	(128)
(八)	妊娠恶阻	(134)
(九)	胎漏胎动滑胎	(136)
(十)	妊娠水肿	(139)
(十一)	子痫	(142)
(十二)	子淋、转胞	(146)
(十三)	产后腹痛	(148)
(十四)	产后发热	(150)
(十五)	恶露不净	(155)
(十六)	不孕证	(157)
(十七)	癰瘕	(162)
(十八)	脏躁	(168)

（十九）阴痒·····	（170）
三、儿科医案·····	（172）
（一）鹅口疮、口疮、口糜·····	（172）
（二）小儿呕吐·····	（174）
（三）小儿泄泻·····	（177）
（四）疳症·····	（180）
（五）小儿蛔虫证·····	（182）
（六）小儿紫癜·····	（186）
（七）小儿遗尿·····	（192）
（八）麻疹·····	（195）
（九）疳腮·····	（200）
（十）顿咳·····	（202）
（十一）水痘·····	（206）
（十二）小儿风水证·····	（207）
（十三）疫毒痢·····	（212）
四、皮科、外科医案·····	（215）
（一）疖、疖病·····	（215）
（二）疔疮·····	（218）
（三）痈·····	（224）
（四）有头疽·····	（230）
（五）无头疽·····	（234）
（六）缠腰火丹·····	（241）
（七）丹毒·····	（245）
（八）白疔·····	（249）
（九）瘾疹·····	（257）
（十）乳痈·····	（260）
（十一）瘰·····	（264）
（十二）瘰癧·····	（267）

总 论

一、中医医案发展源流

中医医案的起源很早，在《春秋左传》中就曾记载了当时的医家医和为晋侯治病与医缓为晋侯治病的经过。虽然是历史事实的描述，但论述过程中，不仅提出了疾病的表现，还阐发了病机，可谓是医案记录的雏型。现今所见到的较为完整的最早医案，当属《史记·扁鹊仓公列传》中的记载。尤其在太仓公列传中，记录了淳于意治疗的二十五个医案，不仅叙述了病情的经过，而且记录了病证的表现，病机的分析，治疗的方法与具体方剂、治疗结果等诸方面。记载已十分全面。虽然，这些医案没有记载具体的药物与剂量，但已经概括了医案所应记录的基本内容，是中医医案的早期代表。当时称这些医案为“诊籍”。正如文中淳于意所说：“今臣意所诊者，皆有诊籍，所以别之者，臣意所受师方始成。师死，以故表籍所诊，期决死生，观所失所得者合脉法，以故至今知之。”淳于意书写诊籍的目的很明确，是“为观其所失所得”，不断总结正反二方面的经验，以提高医疗水平。宋代以后，医案的积累与总结在医家中渐渐引起重视。钱乙著《小儿药证直诀》许叔微《普济本事方》等，均附有一定数量的医案。以印证其理论或方药的正确性，尤其许叔微《伤寒九十论》一书，分为九十证，每证一案，先记叙医

案，后加以分析评论。名为《九十论》，实为九十个医案的记叙与分析总结，是中医学中第一部记述医案的专门著作。因此，民国时期名医谢利恒氏曾称赞说：“医案之作，盖始于宋许叔微。”到了明代，医案作为中医的一个学科，渐渐形成。不仅很多医家重视个人医案的总结。而且有的医家已经专门从事医案的整理与研究。明代嘉靖年间，江瓘及其子江应元、江应宿编辑成《名医类案》一书，对明以前在书籍中的医案进行了广泛的收集、归纳。成为一部专门研究医案的专著。江氏以为这样可以起到“宣明往范昭示来学，既不诡于圣经，复易通乎平俗”的作用。也就是说，可以起到使古代医家的治疗规范得到宣扬，以启发后学之人，使古代的医学理论与现实的临床治疗紧密结合在一起。至清代，医案学的研究更加引起重视。大量的医案专著涌现出来。如喻嘉言的《寓意草》、徐大椿的《洄溪医案》、薛雪的《薛生白医案》、叶桂的《叶天士医案》等。更有魏之琇不仅对《名医类案》加以重订，同时更将其后的医案进行编辑、整理。写成《续名医类案》。成为《名医类案》的姊妹篇。这两部医案著作共收集了三百余家的八千余例医案，可见中医医案之丰富。也同时反映出中医医案在中医学中的重要地位，掌握学习分析医案的方法，在中医学的学习中，就显得十分重要了。

二、学习医案的必要性

医案为我们保存了大量的第一手实践资料。其成功的经验和失败的教训，都对临床工作水平的提高有很大帮助。我

们作为一个中医临床工作者，在看病过程中，总是以中医基础理论为指导。同时，接受前人的治疗经验以应用，来解决病人的痛苦。但是，中医治疗疾病强调辨证论治的思想。也就是说，同一病证，根据不同的人、不同的季节、不同的地区、不同的病因、不同的舌苔脉象和兼证，辨证不同，治法也不相同。如何掌握辨证的规律，并在临床上加以应用，没有大量的实践经验是不容易掌握的。仅仅根据理论上的一般性原则归纳总结，往往在临床上不易灵活加减变通，因此，一个中医工作者，大多需要多年的实践积累，才能成为一个较好的医生。即使如此，由于每一个医生的实践范围所限，不可能全面进行实践。因此，对于一些没有实践过的病证，往往治疗时仍无可奈何。缘于此，学习医案就十分必要。从中可以借鉴到前人的经验教训，以利于个人的临床。我们现在学习中医的另一个途径是向有经验的老中医学习，学习他们的丰富经验。然而，一个人的学习条件是有限的，有条件的地方，可以有幸向一位或几位老中医、老前辈学习；没有条件的地方，可能向一位老中医学习都有困难。但是，中医书籍有大量的医案保存下来。其中也有为数众多的医案专著，如果我们掌握了分析医案的方法，则可以间接的向众多的历代名医学习其实践临证经验，这无疑对提高我们的临床工作大有裨益。可见，正确地掌握医案的学习方法，是每一个中医工作者所必需具备的一个学习手段。

另外，在医案的记述中，在临床的实践中，不仅积累了丰富的经验。同时又充实了中医学的理论，甚至发展了中医学的理论。历代一些名医，一生忙于诊务，无暇著述，他们的一些中医学理论，一些临床辨证分析的基本观点，往往在

医案中散见。其中有些理论可能是其独到见解，补充了我们基本中医学理论的不足或不够细致入微之处。比如：中医理论中有“胃主燥而喜润”的观点。这在临床上有其重要的实践意义。而清代医家叶天士在其《临证指南医案》一书中，则多次提到胃阴受伤的病因病机与治疗。指出“阳土喜柔，偏恶则燥，若四君、异功等，竟是治脾之药，腑宜通即是补，甘濡润胃气下行。则有效验。”指出了养胃阴的治疗方法以及胃阴损伤的病机，对中医病机治疗学内容给以充实。此外，中医医案学又为中药方剂学的研究和发展提供了一定的实践依据。大家都知道，中药的效用是来源于临床实践的，我们通过医案中的选方选药，可以进一步掌握方药在临床上如何具体运用。药物的用量如何恰当掌握，药物的配伍如何适应临床。方剂如何临证加减变通等，这对临床工作的水平提高是很有帮助的。比如：李东垣创立的补中益气汤，被后世所推崇，并广泛地应用于临床，且大大扩充了其适用范围。东垣先生创立该方仅是为了治疗气虚发热之证的，并未言及其它。而后世在应用过程中，则不断扩大其应用范围，内、妇、儿、外诸科均有案例。而内科证中，又有数十种病证均采用该方治疗。这些医案的学习，则会加深我们对于该方的认识。掌握该方的加减变化，以提高临床治疗水平。

三、医案的书写体例

学习医案十分重要，但要想能够较为准确地分析医案，必须掌握古代医案的书写体例。因为不同的医案的书写格式，各有其特点，有的有利于病机的分析，有的便于掌握其

治法；有的可容易理解其药物的选择应用等。也有的格式会给医案分析造成一定的困难。需要我们去揣摩推断等。其书写体例，大体有以下几种：

1. 记述式：所谓记述式，就是依照诊治的过程，尽量真实地记录其全过程。有如历史记事的方法。这种医案书写形式，多见于古代医案，是医案的最初书写方法。在《史记·扁鹊仓公列传》中记载的淳于意治疗的二十五个医案，就是例证。这种采取记叙法的医案，往往使病情夹于叙述之中不得突出，诊断、预后等内容也是反映在叙述之中，在病机分析方面，疾病治疗方面的内容，由于运用叙述方法多很简略，这对医案的分析研究常造成一定困难，后世医家要想从中取得宝贵经验，多无法效仿，故尔，古人称之为“诊籍”，后世撰写医案多不采用这一方法，是有一定道理的。

2. 先案后论式：所谓先案后论的形式，是指在医案的书写时，先记录病情、诊断、治疗的内容，写成医案，然后再加以评论和分析，提出个人对这一案例的体会。或从中医理论方面阐发，或从诊治方药上阐发。由于这种书写体例，有本人的体会和认识，对我们研究分析医案很有帮助。是一种较容易学习的医案。如许树微在《伤寒九十论》记载的医案，就是采用的这种方法。

这种医案的书写体例，虽然对学习医案有很大帮助，但可惜历代医案著作，为数不多，现今有些医案，往往是后人评论前人的医案。虽然对理解医案有一定的帮助与参考价值。但毕竟不是本人的看法，不一定十分准确，不得作为主要依据，还应根据我们学习的知识，去独自进行深入的分析。

3. 方论附案：所谓方论附案，是指古人在论述某一方剂或某一理论后。为了印证方药的效验与理论的正确，往往附以医案的说明。对这类医案的研究，应与其相应的方药、医论结合起来，才能加深对医案的理解。如民国时期名医张锡纯著《医学衷中参西录》，创立新方一百七十余首。其中大部分都在方剂后附以验案以方附案的方法，只要掌握方剂的效用，则不难理解医案；而通过医案的学习，又可以加对方剂临床应用的体会。

方论附案的书写形式，不见于医案专著之中，仅仅是在诸家的其它医学著作当中挟有出现。在这些著作当中，并非专门介绍医案，但通过医案的研究，可以加深对医家著作的理解。

4. 正叙式：所谓正叙式，是指记叙医案时，根据诊治疾病的先后过程，先叙述症状的表现，舌苔脉象，然后分析病因病机，进行辨证，再提治疗方法，记录治疗方药。由于这种医案的书写形式，符合一般的诊治过程，符合临床辨证的程序，因此，为医案书写中常用的一种。这种记录形式，附合医生看病的思维过程。因此较为易读，便于分析，至今仍是一些医生记录医案的常用形式。

但这种正叙述式的医案当中，也有记述简洁或不十分完备者。或者脉证，舌象记录不全；或者病机分析简洁而不细致；或者仅有方药而无治法；或者仅有用方而无药物。各不相同，这类医案在学习时，往往会给学者带来一定困难，则需要我们在分析时，或以证测方，或以方测证，或以证测脉，或以脉测证，或以法测方，或据证分析病机，或以病机补充脉证等，根据中医的基本理论及该医生的学术思想，予

以充实，以便得到正确的理解。

5. 倒叙式：所谓倒叙式，是指医案书写时，先论病因病机，进行辨证，然后再叙述症状表现，将证候放于病因病机之后，或夹杂于病机阐发之中，其症状的描写多很简略，这是对疾病、病机有较成熟的看法，医学理论亦较娴熟的医家往往采用的方法。由于突出病因病机，对我们分析医案多有较大的帮助，是易于学习和分析的一种医案书写格式。

6. 夹述夹议式：所谓夹述夹议式，是指书写病案时，边记叙症状，边分析病机，将病证与病机结合在一起。这种书写格式，是病证与病机并重，即符合一般认识疾病的过程。分析又较细致，使临床表现与基础理论紧密结合在一起，也是一种叙述清楚的医案书写格式。

以上六种书写体例，是古代中医医案中常选用的方法，一般不超出这几个类型，每种书写体例各有特色，掌握古代医案的书写体例，对我们正确分析学习医案是有很大帮助的。

四、怎样读好各家医案

各种医案有其不同的书写形式，记述了前人治疗各种疾病的经验，如何能够正确分析研究，将其挖掘出来，需要掌握学习与分析医案的正确方法，为此，必须掌握以下几个方面：

1. 结合医家的学术思想阅读分析医案：每一位医家在学术上都有自己的见解，在选方用药上都有自己的经验，这些在中医学的研究中，占有一定的学术地位，并有很多的内

容被我们所认识。现在研究中医的各家学说，已经成为一个重要的学科内容。因此，在研究医案时，我们借助于掌握的医家学术思想，去分析其医案，就会有较深刻的理解。

2. 结合医案前后的医论分析医案：古代医案中，有相当数量的医案夹杂于医论之中，其案往往与医论、方论等有密切关系。因此，若能结合其所论研究医案，多对医案的认识有所加深。反之，若不顾及医论，仅从医案着眼，往往也会失其要领，或者不得深入。

3. 运用中医基础理论分析医案：尽管每位医家有各自的学术观点与临床经验，诊治疾病多有独到之处，但均以中医基础理论为指导。《内经》、《伤寒论》、《金匱要略》、中药学、方剂学等有关著作则是中医基础理论的主要内容，运用这些知识去研究医案，是分析医案的最主要方法，往往可以较深入地分析医案。从中受到启迪。因此，要想达到较正确、深入地分析医案的目的，必须有较为扎实的中医基础知识。当然，从医案的分析中，我们也会进一步加深对中医理论的进一步理解，甚至得到充实与提高。

4. 用归纳法、对比法分析医案：中医学强调辨证论治，强调辨病与辨证相结合，同一病，因其病因、病机、体质、四时之差异，往往有不同的治法。再看，每一位医家在治疗某些疾病时，多有自己诊治的独到体会，通过多个医案的分析对比与归纳，往往可以体会到某一医家治疗某一疾病的规律和独到心得体会，也能体会到临床辨证的规律。

5. 方证互测的研究方法：在古代医案中，由于有些医案是随诊记实，多古朴简洁，因此，脉证方药诸方面，有时会记述不全。或少脉证，或缺方药，或少治法，或无病因，

这给学习者造成一定困难。为了总结前人的经验，为今日临床服务，我们可以运用中医学知识，对医案不足之处给以补充完善，并验证于临床，从中可以汲取医案中的有益经验。

6. 从医案误治分析医案：古代一些医案的记述，先记录前人误治，然后才提出个人的诊治意见。对于这类医案，其误治的教训，也不要忽视，往往能通过误治的原因，找到疑似难辨之点，对我们的辨证水平提高大有帮助，也可以加深对医案的理解。

以上六种研究医案的方法，是研究医案所常采用的，如能很好掌握，并能够经常进行医案的学习，运用这些方法，一定能够不断提高医案的分析水平。从中学习前人的有益临床经验，以提高我们的医疗水平。

各 论

一、内科杂病医案

(一) 感 冒

【概说】

感冒一证，临床最为常见，北宋《仁斋直指方》中已有用参苏饮治疗感冒风邪的记载。明代龚廷贤的《寿世保元》中已有四时感冒的病名。但是历来对于感冒，病名仍极不统一：有中风、虚风、伤风、迴风、沓风、漏风、中寒、中热、伤寒、中暑、中湿等等。以解放以后全国统编教材开始，才比较明确的。

感冒属于外感病范畴，因四时邪气侵袭人体而致病。症状以头痛、鼻塞、流涕、喷嚏、恶风、发热为主。继则引起咽痒、咳嗽、寒热、四肢酸疼等证。病程一般3～7天。根据四时气候变化及病邪的性质不同可分为风寒、风热两大类型，以及挟暑、挟湿、兼燥等兼挟证。由于体质的差异以及素有宿疾，因而又常常出现阳虚外感、阴虚外感、血虚外感、气虚外感、痰湿外感等等的变证。根据感邪的轻重的不同，分为二型：轻型者，一般称为伤风，一周左右即可痊愈；重型者，具有较强的传染性，常常引起广泛的流行，称之为时行感冒。

感冒虽然不是严重的疾病，如果迁延不愈，常常引起人

体抵抗力的下降。从而诱发、合并、转生其它较为严重的疾病。因此，临床上要对感冒证给以足够的重视。古人云：“伤寒不醒便成痹。”就是这个道理。

本病发病机理，总由病邪从呼吸道侵入而首先犯肺，肺合皮毛，一般都有表证，因此治则总以宣肺解表为要。

【选案】

案一，宋××，男，55岁

初诊，1960年4月20日。

患者本体素弱，平时易罹感冒，此次持续月余，服药不愈，头痛畏风，自汗出，身倦乏力。关节不利，二便正常，舌淡无苔。脉沉迟无力。此属阳虚感冒，营卫不固。治宜温阳益气，宗玉屏风散加减。处方：

黄芪15克 防风9克 白术9克 川熟附子9克

先煎附子30分钟，再纳余药同煎，去滓取汁，分2次温服。

复诊，畏风消失，恶寒亦减，头痛见减，仍时有汗。脉弦缓右沉迟、左沉弱，舌苔白腻，属卫阳既虚，内湿渐露，改用温阳利湿为治。处方：

生黄芪12克 白术9克 川熟附子6克 苡仁15克 山茵陈9克 桑枝30克

再诊，诸证大减，气机舒畅，尚微感恶凉，脉缓有力。前方去桑枝加良姜6克，以温胃阳。

末诊，服药后已不畏冷。脉右沉迟，左弦缓。继宜温阳补中，改用丸剂缓调以善其后。早服附子理中丸6克，晚服补中益气丸6克。逐渐恢复而获痊愈。

《蒲辅周医案》

案二，马××，鼻气上通于脑，下通于肺，今鼻塞流涕多头痛。自有风邪内容。风为清邪，其在上，脑既不通，肺气自闭。肺主气，而与大肠相表里，此气阻便闭之所由来也。脉左关微弦，右涩滞。清上焦为主，勿急峻通大便，致伤阴为要。

处方：白杏仁 桑叶 菊花 淡芩 薄荷 薏米 郁金
川贝 橘红 萎皮 黑山栀 火麻仁 莱服子 鲜荷叶

《柳宝诒医案》

案三，徐女，三日来恶寒发热，头痛骨楚，而温温欲吐。舌苔白腻，用下方辛温解表以退热，芳香化浊以镇呕。

处方：

荆芥穗 5克 紫苏叶 5克 藁本 9克 川桂枝 5克 （后下）
香白芷 5克 川羌活 9克 姜半夏 9克 广陈皮 5克 六神曲 9克 生姜 2片

二诊，胃肠型感冒与肠伤寒，在难于肯定之剂，用发汗剂可以得其梗概。今药后热已退净，两日未再升，非肠伤寒也。胃呆，大便难，食后有泛恶现象，以下法调其肠胃。处方：

佩兰梗 5克 姜半夏 5克 薤白 9克 广陈皮 5克
生枳实 9克 云苓 9克 白豆蔻 5克 六神曲 9克 佛手 5克 谷麦芽各 9克

《章次公医案》

【分析】

案一为阳虚外感，表有外感风寒，里证是阳气不足。一般治则应该先表后里，但对于阳气虚弱的人，如果仅用辛温发汗。反会使气随汗泄，造成漏汗不止、阳气更衰。正如仲

景说：“尺中脉迟者，不可发汗。”若只用补阳药物，又不能兼有发散外感寒邪之作用。故治疗应宗温阳益气解表法。而且温阳药物的用量应大些，这就是古人一贯告诫的：“强人病表发其汗，虚人病表建其中”的治则。方中有黄芪、白术益气建中，附子温阳助汗。先煎附子去其毒性，同时缓和峻猛的药力，再加防风3克，辛温宣透，所以一诊之后，外感症状大减。仍有自汗，是阳气固表的能力较差。脉弦缓，舌苦白腻，是平素阳气不能温运，湿邪停滞不化。因此二诊又宜温阳利湿，方中的芪、术、附温阳。茵陈、薏苡仁利湿、渗湿。湿去才利于宣发阳气。桑枝30克既可舒利关节，又能宣通气机。“凡治湿不利气机，非其治也”。二诊之后，感冒基本痊愈，只有怕凉，仍为阳气不足。原方去掉桑枝通利，加高良姜温胃散寒，宣发中阳。怕凉症状也基本好转。但因其素来阳气虚弱，非是三剂、五剂可以收功，需要丸药缓服，帮助体内正气逐渐恢复。由上可见，感冒一证的诊治，兼挟证是不可忽视的，必须结合患者的素质、宿疾等诸因素全面考虑。

案二为外感风热案，外感风热一般有两种情况：一是感患外界燥热气候所致；一是外感风寒随体质而化为风热。此案就属于后一种情况。根据突然发作的鼻塞，涕多，头疼可知是患感冒。再详审舌脉及其它兼症，有大便不通，左关脉微弦，可知是原有肠胃积热。因此判定感冒必从热化。可能还有咽痛，口干等其它见证。这类病人的治则与阳虚外感患者就大不相同了，只能先辛凉解表，宣肺透热，再略加润便清热。表里同治，以治表为主。方中桑叶，菊花、薄荷、荷叶、贝母、杏仁都是为表证而设；加黄芩、山梔清里热，

麻仁、莱菔子润便通里；再加郁金疏通气机。一般通便都必须加行气降气药物，降气行气药物能够推动肠胃的运行。如张仲景的承气汤中降气药物用量大于硝黄就是这个道理，由于治则准确，用药周全，因而一诊之后问题就基本解决了。

案三是外感风寒兼内湿证，恶寒发热，头痛骨楚是外感症状，舌苔白不是风热，温温欲吐（温温读作兀兀）形容时泛恶心，但并未呕吐的症状，是原有湿浊蕴于中焦，气机升降不畅，浊气上逆而呕，治疗表里兼顾。荆芥、紫苏、桂枝、蒿本、羌活、白芷辛温解表，气味芳香，又兼醒脾宽中止呕。二诊表解胃呆，大便难皆是湿阻气机，肠道不利，加利肠胃，化湿浊，畅气机之藿佩、佛手、豆蔻等，去解表药，使湿邪从三焦而化，使一例胃肠型感冒得以根治。

（二）咳嗽

【概说】

咳是临床多发病。“咳嗽虽多，无非肺病”。肺为五脏的华盖，其理特点是“清虚之脏”，可以接受五脏的精华之气，而不能受五脏六腑之浊气；可受大自然清灵之气，而不能受任何尘污之气；可经受正常的气候变化，而过度的寒、湿、热、燥诸邪气都能影响肺的功能，因此说它是“娇脏”。不论什么原因干扰肺气正常的宣发与肃降，都能引起咳嗽一证，也可以说，咳嗽既是一个以主证命名的证候，也是多种疾病中发生的一个症状。

从明代张景岳起，已明确把咳嗽分为外感、内伤两大类型，一直延用至今。

外感咳嗽，都有感冒的病史、症状。当然，也因外感的情况不同而分为风热咳嗽，风寒咳嗽、燥热咳嗽三个基本类

型，风热咳嗽痰多呈黄稠；风寒咳嗽的痰多呈稀白痰，易于咳出；而燥热咳嗽一般咽喉发痒、干咳少痰，或量少呈白沫，或粘稠成块，难以咳出，甚者咳痰带血丝。内伤咳嗽，则是因其它疾病的干扰，使肺阴不足，肺气虚弱而发生。临床见证不一。常见的有肝火犯肺，因肝火灼伤肺脏，炼液为痰，阻遏肺气升降而咳；肺肾阴虚，因久病阴虚，而生虚热，虚火灼肺而咳；脾不建运，水积为痰，湿浊上泛，阻肺而咳；心肺气虚，气虚不足，难以宣清肃降，逆而为咳等几种。

当然，咳嗽对于肺本身来说，是一个本能的保护性反应，因为咳嗽的震动，使气道运动，排出痰浊病邪，有利于肃清肺脏，因此，咳嗽的治疗原则，不能仅仅止咳，必须针对病因，化痰、健脾、清肝、养阴、补气、温肾等皆可做为止咳的治则。《内经·咳论》说：“五脏六腑皆令人咳，非独肺也。”就是这个意思。

【选案】

案一，气阴并亏之质，肝火最易升腾，外风乘之，引动积饮，咳呛气急。曾投散风清热，气急渐平，而咳呛未已，痰多白沫，呛则气火上升，左边头痛，咽喉亦觉燥干。脉小数，左弦细，舌苔微黄，尖红而痛。火浮于上，清肃不行，急宜清肃上中，豁痰润燥。

沙参 苏子 杏仁 竹茹 蜜葵皮 川贝 白芍 白薇
橘红 紫菀 海浮石 茯苓 冬瓜子 枇杷叶

《巢崇山医案》

案二，晨起痰先浓后薄，定是脾胃湿痰。早起便常薄而溏，亦是脾胃湿热，脾不健，湿不化，上蒸于胃为痰，下注于肠为泄。脉濡细而滑，舌苔黄而腻，治法宜健脾理胃。

茯苓 生冬术 姜半夏 冬瓜子 扁豆衣 橘红 瓦楞子
杏仁 川贝 甘草 竹茹 苡仁

《金子久医案》

【分析】

案一为阴虚燥咳。阴血不足，肝失所养，最易肝火上升，多发心烦失眠多梦等。肝火消烁肺金，炼液成痰，故曰：“引动积饮。”阴虚外感，最易化热。前方只散风清热，未予滋阴，因而呛咳未止，仍吐白沫痰。肝气升于左，故头痛左边为重。外感已平，重在清肃中上，清在上之虚火，肃胸中之积热。选用润燥豁痰药从根本上治疗。方中沙参，白芍滋阴润燥；白薇滋阴清虚热；苏子、杏仁下气止咳；竹茹，蜜炙栝蒌皮、海浮石、川贝、紫菀、枇杷叶等，性味甘凉，能止咳化痰，软坚润燥；再加茯苓，冬瓜子疏通水道，帮助排除痰饮积聚。整个处方不燥不热、不滋腻。既除痰咳，又治阴虚，标本兼顾，即使久服亦无大弊。

案二为内伤咳嗽。脾虚生痰，肺受痰扰，咳嗽先有浓痰，脉见滑象，苔黄腻，又是湿痰久积化热。治宜健脾行气，止咳化痰，兼清湿热。薏苡仁、扁豆衣、生冬术、甘草皆能健脾行气，乃是一变方四君子汤。茯苓、冬瓜子又能利湿健脾，橘红、半夏、竹茹行气化痰，杏仁、川贝润肺止咳。瓦楞子一味，能软坚化结，消瘀去痰，运用尤有新意。全方是变方四君子汤为主。二陈汤为辅，易陈皮为橘红，以免过燥。再加清热化痰之竹茹，利湿清肺的冬瓜子，攻逐顽痰的瓦楞子，主次分明，加减得当。

（三）喘证

【概说】

《内经》说：“诸痿喘呕，皆属于上；诸气膹郁，皆属于肺。”膹就是喘息。喘息一证，主要为肺的病变。症状是呼吸急促，重到张口抬肩、鼻翼扇动，端坐不能平卧等等。基本上可以分为虚实两类。张景岳说：“实喘者有邪，邪气实也；虚喘者无邪，元气虚也。”实喘以呼吸气长而有余，呼出为快，气粗声高，脉数有力，发病骤急。致实之由不外四端：一，外感风寒，闭阻肺气，治宜辛温发散，如定喘汤，参苏饮之类。二，风热伤肺，热甚气壅，治宜寒凉，如泻白散、桑白皮汤、麻杏甘石汤之类。三，气逆阻肺，无痰有声，治宜降气解郁，如苏子降气汤、五磨饮之类。四，水饮痰浊，阻遏肺气，治宜祛痰利气，如二陈汤、导痰汤、小青龙汤之类。而虚喘则气短而息微，呼吸难以接续，以深吸气为快，气怯声低，脉微弱浮大中空，一般病势徐缓，时轻时重，过劳即甚。临床多见二种，一由于脾肺气虚、气促而喘，挟热象者可用生脉散加减；无热象者可用六君子汤、独参汤、补中益气汤等。一由于肝肾不足，不能摄纳，治宜摄气归元；由肾阳虚而喘者，可用真武汤、黑锡丹等。由肝肾阴虚而喘者，可用地黄丸，都气丸等治疗。

喘症虽非分虚实二类，也还必须与全身症状参合，才能准确辨证。正如《素问·经脉别论》所说：喘可以出于五脏，不独仅是肺病。治疗起来正如李中梓所说：“治实者攻之即效，无所难也。治虚者补之未必即效，须悠久成功，其间转折进退，良非易也。故辨证不可不急，而辨喘证尤为急。”所以古人说：“外不治癖，内不治喘。”此言治喘之难。

有些喘证与咳嗽证有关，有些与哮证有关必须参合两

证，方能疗效显著，近世在防治老慢支方面取得了很大进展，其间不少宝贵经验，可资临床借鉴。

【选案】

案一，七旬以来，冒寒奔驰，咳呕喘急，脉弦滑，时暖冷气。夫寒痰停院必呕，宿痰阻气必咳。老人元海根微，不任劳动。劳则咳，嗽则气升而喘，必静摄为宜。仿温肺汤，用辛温止嗽以定喘。

淡干姜 五味子 炙桑皮 茯苓 党参 甜杏仁 胡桃肉 制半夏 款冬花 橘红

林佩琴《类案治裁》

案二，张友樵治一酒客，夏日疾嗽气喘，夜不得卧，服凉药及开气药不效，有议用《金匱》麦冬汤者。张诊之，右寸数实，此肺实非肺虚也，投以人参则立死矣。遂用葶苈15克焙研，滑石15克，煎服立愈。明年复感客邪，壅塞肺气，喘咳复作，医以葶苈进不效，反烦闷汗泄。张诊其右手浮数，口渴恶热，冷汗自出，喘急烦闷。曰：“此热邪内壅，肺气郁急，是逼汗外越，非气虚自汗也。服葶苈反烦闷者，肺热极盛，与苦寒相格拒也。夫肺苦气上逆，本宜苦以泄之。而肺欲散，又当急食辛以散之。与麻杏甘石汤一剂肺气得通，喘止汗敛，诸证悉平。”

魏之琇《续名医类案》

案三，黄锦芳治祝某病喘咳，日夜不宁，寒热交作，两边头痛，二便不通，两肩频耸，上气奔迫。脉则二尺甚弱，两寸甚洪，乃气上升而不下降之候。用五味30粒，骨脂1.8克。沉香0.9克，远志肉1.5克以安右部之肾。龙骨3克、牛膝3克，车前1.2克，龟板3克，以安左部之肾，使左右二

肾之气皆归原宅而不上奔，故服一剂而喘咳除，头疼寒热俱去，又服一剂二便俱通遂愈。

《续名医类案》

【分析】

案一为内有痰饮，外感风寒喘咳案。患者年已七旬，因奔驰劳累，感冒寒气而发病。外寒引动内痰。外邪使肺气宣发不利，内痰阻肺不能肃降，内外夹攻，遂使咳嗽喘急。并且干扰胃气，又发生噎冷气，上逆做呕，如果身体较壮，可用小青龙汤一服而取效。但对于老年人，治疗不可呈一时之快。必须顾反正气，处方以党参、茯苓、胡桃肉温补脾肾，化气助阳；半夏、生姜降气止呕，温胃散寒；杏仁、五味敛肺治咳；桑皮、款冬下气止喘；橘红祛痰止呕。再加医嘱写明必以静摄为宜，心静，则阳气闲固。《内经》说：“阳气者，烦劳则张。”阳气能守驻丹田，摄纳呼吸之气，助肺止喘。

案二为热痰阻肺致喘。患者素有痰饮，遇夏月炎热，积痰化热，上阻肺气，故发气喘。因为疾病不是单纯热邪，所以只给凉药，热势可能稍缓，但痰不能消；给顺气药，能稍措其势，但亦不对证。麦门冬汤治火逆上气是指虚火上逆，麦冬，人参是补气阴之药。此案是痰热，显然也不适宜。证见右寸脉数而实，所以用葶苈子、滑石两味，取《金匱》葶苈大枣泻肺汤方义，葶苈子苦寒，可以通泄肺气，化痰止喘；滑石甘寒，清热渗湿，通利诸窍，使肺中热痰有可出之途。《本草纲目》说滑石不独利下窍，而且能利毛腠之窍，故能帮助清宣肺热。因用药准确，药量大，壅肺之热痰，一服便消。此药较峻猛，虚证显然不适宜。其后又因外感发

喘，根据症状看，右寸脉浮而数，是外感有热。口渴恶热，喘急烦闷，显然是肺热壅实，为什么服葶苈子不效呢？病案倒述了不效的原因，并非不应该用苦寒药来治疗。因为《内经》说：“微者从之，甚者逆之。”凡病来势猛烈，就不能峻补峻泻，苦寒直折。所以服葶苈之后，反而内热与苦寒格拒，邪热欲出不能，发生烦闷一证。再者肺气宜宣宜散，治疗也应照顾脏腑特点，比如泻肝热，在大队苦寒药中必定要加些柴胡、薄荷，照顾肝的疏散之性。此处苦寒泻热药中再加些辛散开宣肺气之药，当然就全面了。所以选用麻杏石甘汤，麻黄既能辛散表邪，开宣肺气，又能止咳平喘，而石膏能清肺热，此方蒲辅周老先生亦喜欢用，他认为属于风寒郁闭，热邪壅盛咳喘者用此加减化裁，屡获良效。此案辨证疑点在于“冷汗自出”。临床所见风寒外束，内热喘急的病案大多表闭无汗，或有微汗，象这样冷汗自出，就容易误为表虚自汗，实际上张仲景说：“汗出而喘，无大热者”可与此汤。无大热是指表无大热。热盛于内，不能发越，形势夺路而出，也可有微汗出，头汗出，或热极有大汗出。此证冷汗自出，发生在服葶苈之后，药物与肺热相格拒，邪热逼汗外出。虽有汗出，热亦不能解，因此，汗出是此证的辨证关键。

案三为肾虚作喘，据两尺脉甚弱，两寸脉甚洪，知为肾虚而不纳气。肺气上逆不下而喘急。逆气干犯清阳，故头痛为甚。两边头痛，因左右者，气机升降之道路。二便不通，因肾虚气化不利。寒热交作，因肾之阴阳俱虚，阴虚则热作，阳虚则寒作，故寒热交作。如此治疗不能仅补肾阳或肾阴。张景岳云：“阴阳俱不足，补阳则阴竭，补阴则阳

历代中医书籍大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

不管哪种方式，看到你的信息我会第一时间回复，尽全力帮您！

加微信可以扫描以下二维码加我！



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医

脱。”所以只能平补肝肾，协调阴阳。因为从《难经》起就有左肾右命、左阴右阳之说，故案中所说，“安右部之肾”即补肾阳，“安左部之肾”即补肾阴之意。诸药补阳而不燥热，补阴而不滋腻，正合病情。龟板咸平，滋阴潜阳；牛膝酸平，补益肝肾（此处当以怀牛膝为佳）；龙骨涩平，平肝潜阳，这几味药皆用3克，补肾阴而敛浮越之气。用车前子1.2克宣泄肾浊，开通水道，帮助气化，使补阴而不滞腻。而且据日本学者研究，车前子还可以止咳祛痰，所以上四味药组合，是安左部之肾。五味子酸温，敛肝滋肾；破故纸苦温，补肾壮阳；沉香辛温，降气暖肾，常用于喘急气逆之证。再以远志1.5克，安神益智，亦可祛痰利窍。药只八味，选用精良，分兵两路，阴阳俱补，尤其照顾咳喘上气。故一剂知，二剂诸证得平。此案的方药尤有特色，每味药都在补肾的基础上分别兼有止咳、化痰，下气、敛肺等效，特别是补肾阳用远志1.5克佐之，补肾阴用车前1.2克佐之，使整个方子灵活机巧。

（四）哮喘

【概说】

哮喘是一种发作性痰鸣气喘证。以呼唤急促，喉间有哮喘音为主证。

哮喘发作时，一般突然而起，先感鼻喉作痒，喷嚏、呼吸不利、胸闷暖气，情绪不宁。继则明显咽塞胸憋，微咳干呛，渐至呼吸困难。呼气延长，喉中痰鸣，痰粘量多，难以排出。严重者张口抬肩，目胀睛突，不能平卧，俯伏方舒，烦躁不安，面色苍白，唇甲青紫，额上冷汗。全身伴有寒热症状，若能将大量粘痰顺利咳出，则窒闷渐减，呼吸渐畅，

诸证随之缓解。

哮喘病皆有宿根，反复发作。内因是肺、脾、肾三脏功能低下，水液代谢失调，先有伏痰在内。外因是外感风、寒、雨、湿，饮食酸、咸、甘、肥、生冷海腥，鼻闻异臭，恼怒悲伤，劳累过度等引动肺中伏痰，致痰升气阻而发病，其中与气候关系最为密切。

内因又根据人体差异而分为二类，因肺肾阴虚而有内热者，常有痰热郁于体内，发作多为热哮，痰黄稠粘胶，不易咳出，口渴喜饮，舌红苔黄腻，脉滑细数等虚热之象。以越婢加半夏汤、定喘汤等治疗为好。因肺脾肾气虚，阳虚而生内寒者，常有寒痰在内，发作多为冷哮，见痰白粘稀多泡沫，口不渴，舌苔白滑，脉象浮紧等外寒内饮之象，治宜射干麻黄汤、小青龙汤等加减。

总的治疗原则应分为已发与未发之时，已发作，以邪实为主，当攻邪以治其标。当然亦要辨明冷热，顾及正气。未发以正虚为主，宜扶正固本，应分别脏腑之不同，治以补肺，健脾，益肾等法。

哮证与喘证虽时常并见，但应予区别。哮证在喘息之时，有明显的哮鸣音，且病有宿根，发作有诱因，是一种反复发作性疾病。喘以呼吸紧迫为主，常是并发于各种急慢性疾病中的一个主证。哮必兼喘，通称哮喘，喘不一定兼哮，是其鉴别点。

【选案】

案一，周珊甫君夫人，年逾五旬，素患肺病，咳嗽哮喘，痰声如拽锯，呼吸几不能通。予视其体胖神强，两手脉滑有神。盖富裕之家，奉养太过、肥甘油腻，蕴酿成痰。拟

方用杏仁泥，白前、桔梗各45克，薄荷1.5克，橘红2.4克，贝母、苡仁各8克，茯苓6克，甘草1.5克，枇杷叶1片，做煎剂。一服呼吸大畅，哮喘亦定，接服三剂痊愈。

袁桂生《丛桂草堂医案》

案二，哮喘气急，原由寒入肺俞，痰凝胃络而起。久发不已，肺虚必及于肾，胃虚必累于脾。脾为生痰之源，肺为贮痰之器。痰恋不化，气机阻滞，一触风寒，喘即举发。治之之法，在上治肺胃，在下治脾肾；发时治上，平时治下，此一定章程。若欲除根，必须频年累月，服药不断，倘一曝十寒，终无济于事也。

发时服方：款冬花 桑白皮 紫菀 苏子 沉香 茯苓 杏仁 橘红 制半夏 黄芩

平时服方：五味子 紫石英 陈皮 半夏 茯苓 薏仁 蛤壳 杜仲 胡桃肉 熟地

《柳选四家医案·王旭高医案》

【分析】

第一为热哮。患者虽已五十开外，但两手脉滑有神，体脉神强，由于平素过食肥甘油腻，已有热痰积于体内，故云素患肺病。诊察时有呼吸急迫，痰声如拽锯，知又有诱因。哮喘已发，治疗当以清肺平喘为主，兼祛热痰。方中贝母、枇杷叶、杏仁性平微寒，降气化痰，止咳平喘（贝母当用浙贝为宜）；桔梗、薄荷辛凉清热，开提肺气，与上三味配伍，便有宣有降；苡仁、茯苓健脾利湿，清热排脓，帮助宣化热痰。李用梓说：“哮证内有胶固之痰，肺有雍塞之气，外有非时之感而患病。”如此治法，既可健脾，除去生痰之源，又可宣肺，开通雍塞之气，还能解表，发散非时之感。

虽平常数药，如矢对的，三剂哮喘就得到缓解了。当然热痰积于体内，不可能三剂除根，宜于不发时者服几剂清化痰热药方为全面。

案二是平素脾胃不足，寒痰内积，遇寒冷而诱发的哮喘。本案书写详于病机分析，而略于症状描述，根据病机来推断，患者当有冷哮发作的一系列症状。如：哮喘气急、痰清稀而粘，胸膈满闷，面色晦滞，脉象浮紧，或兼有发热恶寒，头痛无汗等。治疗当以“已发哮喘”原则论治。以治肺平喘为主。方用桑白皮、黄芩清肺利喘；款冬花、紫菀辛温止咳平喘；苏子、杏仁降气平喘；橘红、半夏化痰止咳。这样配伍既能散寒宣肺，又能化痰利气，肺气得以宣降，哮喘就可缓解。疑问在于既是冷哮。为何又用黄芩等寒性药物呢？肺之为脏，清虚嫩娇，痰凝气滞，久则难免化热；在大量的辛温药物中加一二味寒凉药，可使整个方子不致于燥热，又能照顾肺的生理特性，有利于止喘。而沉香温肾，帮助纳气止喘，茯苓归脾，利于健脾化痰，虽云发则治标，亦适当照顾脾肾虚弱的本质。

哮喘未发之时，当以扶正为主，用紫石英、蛤蚧、胡桃、杜仲补肾纳气，益肺定喘。再加一味熟地黄滋补肾阴，是照顾肾脏的生理特性，宜于阴中补阳。橘皮、半夏、茯苓、苡仁皆是健脾消痰之品。五味子、蛤蚧又能双补肺肾。整个组方，温补脾肾，消痰定喘，不燥不寒，因此可以久服而无弊病。因病非一日，因此治疗不能急于求成，一曝十寒。正如吴鞠通所说：“治内伤如相，须坐镇从容。”

（五）肺病

【概说】

早在《金匱要略》一书中对肺痈一证的病因病机、治则、方药有了比较明确的记载，又经历代医家补充，目前用中医方法治疗肺痈已有比较系统的经验。

按照发病过程，此证可分为初期、成痈期、溃脓期、恢复期四个阶段。初期由风热外侵，热伤肺气，邪束卫表。症状以发热恶寒，咳痰粘稠量少，胸疼咳嗽时加剧，舌苔薄黄，脉浮滑而数等为主。治宜疏散风热，清肺化痰。以银翘散加减为主方。近世研究，鱼腥草、鸭跖草、野荞麦根、大青叶，败酱草等皆有良效。成痈期因邪热未从表解，而内壅于肺，外感之热毒内侵，热伤血脉，气雍血淤，蕴而成痈。症状可见壮热寒战，胸闷疼痛，咳吐脓痰，其治则应清热解毒，化淤散结，以《千金》苇茎汤加减为常用。如果痈肿没有及时消散，热毒加重，痈肿内溃，就会出现咳嗽吐脓血痰，胸疼喘满，身热面赤，口微渴，苔黄腻等证，便是溃脓期。治疗应清热解毒，化痰排脓，以《金匱》桔梗汤加味为宜。后期多由热毒耗伤气阴，毒势虽大衰，正气亦受损，此时称恢复期。治疗原则有二：如气阴两伤，又见咯吐脓血痰，久延不净，午后潮热，必烦口渴，盗汗自汗，舌红绛，脉虚数，为正虚邪恋，治疗宜扶正托邪，用景岳桔梗杏仁煎。如以正虚为主，则用济生桔梗汤，以补养气血，滋润肺阴为宜。

【选案】

案一，祁阳侄妇，先时咳嗽，诸治无功，咳急则吐，用碧玉散二钱，白汤调下立止。半年复咳嗽，胸背隐隐疼痛。常内热吐出桃红脓甚多，且腥秽，右肋并乳胀痛。诊之脉洪数，大便燥、肌骨瘦立，此肺痈证也，用贝母、茜根、白芍

各3克，知母、麦冬、山梔、紫各2.4克，桑皮、当归、丹皮、杏仁各2.1克，苡仁5克，甘草葶苈各1.5克，服之甚安，但稍停即发。或云肺窍中积淤血尚多，未能即去，宜缓图之，候脓尽当愈。孙谓丹溪虽有此言，亦不可不以药消化之，必俟其自己，恐日步月深而有他变，且中年之人，何能当此，莫若清热润肺消痰化淤，久服或早愈也。或又谓久嗽伤肺宜补，每补必增热加痛加咳，而脓转多，仍依法治之，二年良愈。

《孙文垣医案》

案二，陆令仪母，平日持斋，肠胃素槁，天癸已绝，复淋漓不止，治之久痊。值秋月燥金太过，湿虫不生，人多病咳，而血虚津枯之躯，受伤独猛，胸胁紧胀，上气喘急，卧寐不宁，咳动则大痛，痰中带血而腥，食不易入，声不易出，寒热交作，申酉二时，燥金用事诸苦倍增，脉时大时小，时牢状时弦紧，服清肺药无进退。告以肺癰将成，高年难任，以葶苈大枣泻肺汤，先通肺气之壅，即觉气稍平食少，入痰稍易出，身稍可侧，大有生机。喻曰：“未也，因见来势太急，不得已取快一时，暂开者易，至复闲则前法不可再用也。今乘其暂开，多方以图，必在六十日后，交立冬节方是愈期。盖身中之燥与时令之燥，胶结不解，必俟燥金退气，肺金乃守。”后六十日间屡危屡安、大率皆用活法斡旋，缘病不可补，而脾虚又不能生肺，肺燥喜润，而脾滞又难于运食、今日脾虚，不思饮食，则于清肺中少加参术以补脾。明日肺燥，热盛咳嗽，则对清肺中少加阿胶以润燥。日复一日，扶至立冬之午刻，病者忽自云，内中光景，大觉清爽，可得生矣。奇哉，天时之燥去，而肺金之燥遂下传大

肠，五六日不大便，略一润肠，旋即解散。正以客邪易去耳。至小雪节康健加食。倍于曩昔。盖胃中空虚已久，势必复其容受之常。方为痊愈也。

喻嘉言《寓意草》

【分析】

案一为溃脓期重证肺痈，先时咳嗽、诸治不效，外感风热之邪未全部清除。仅用碧玉散（六一散加青黛）清热泻火，虽热去咳暂止，而束肺之余邪却渐渐化热，壅而为痈，终干热毒壅盛，灼伤血络，痈破为脓。咳吐桃红色脓血，其味腥臭，脉洪数、大便燥结，是典型的肺痈溃脓期症状。痈发右肺，故右胸肋乳背胀而疼，应立即清热凉血，止咳排脓，兼化淤润肺。方用白芍、当归、丹皮、茜草根入血分，能活血凉血，去淤生新；桑皮、山梔、葶苈、知母泻肺热，麦冬、贝母（当以浙贝为宜，清火散结力量以川贝为胜）紫菀、杏仁润肺止咳祛痰。如此配合得当，故服之甚安，为何停药又复发呢？案中自设问答，以启发读者，原因是中间有过误治。如有人认为朱丹溪讲过：肺中痰积淤血较多时，不能峻攻，只能缓图。因此用药过轻。孙氏认为：虽然不可峻攻，但亦不可不攻，如果只以轻药缓图，时间一久，病邪消耗正气，会转生他疾。所以此方中有葶苈子、山梔等泻肺热，亦有丹皮、茜草等凉血祛淤。又有人认为：肺病久了，咳嗽伤正。应该补肺，结果每用补药，就又助热邪，反而使咳嗽、肺疼加剧，咳脓增加，这样反复误治的结果，成为目前重证。必须清热润肺，消痰化淤，才能获效。此案用药还有一个特点是：药量很轻，方中除贝母、茜草根、白芍、杏仁用一钱外，其余诸药，仅用几分，这是附合《内经》所说的：“微

者逆之，甚者从之”的治则的。凡病势较猛的疾病，用药宜轻宜缓，不能峻猛。此证依法调治，二年即痊愈。这样一个历时较长，病证较重的肺壅，二年内痊愈，治疗是有相当水平的。

案二是成痈期肺痛证，患者本来血虚津亏，又外感秋燥，渐次化热，邪热壅肺，酿成痈肿。肿毒阻塞肺窍，故胸胁胀疼，上气喘急；邪热灼破肺络，故咳痰带血。若不急泻肺热，恐很快痈破为脓。按五运六气来说，申酉时（午后3～7点）为阳明燥金当令，燥气加重，故诸证倍增。脉象时大时小，是因为有寒热交作，邪壅肺塞，肺气不宜，肌表不温，就会恶寒，恶寒则脉紧而小；燥邪化热壅于肺中，故时而发热，发热时脉就大而数。咳嗽胸疼，痛则脉弦紧，剧痛则气血拘急，脉道不利，故脉见牢伏，当此之时，又宜急泻肺壅。《医宗金鉴》说：“葶苈大枣泻肺汤是治肺痛吃紧之方。”肺中生痈，应乘其血结而脓未成，急泻之，如日久咳脓已成，肺气大耗则泻之无益。葶苈辛苦大寒，性急不减硝黄、凡积聚症结，伏留热气，水肿痰壅，咳嗽经闭便塞至极等证，皆可用此药。故药入即痰顺气稍平，但为何不能用此方一鼓作气，继续服用呢？《内经》说：“凡大毒治病，十去其七。”过量则伤正气，再者天行燥气，肺最恶燥，因此气候条件对肺不利。要全部治愈必须天气转凉，中间多方以图，调理脾肺。如不思饮食，则于清肺药中少加参术。如咳嗽加重，则于清肺药中少加阿胶等等，直至60日后，方为痊愈。此案治疗善攻善守，急则能以峻剂攻之，不误时机，缓则能边补边清，坚持六十日调理，保护正气。正如良将用兵，攻守咸宜，虽没有开出调补的具体方药，但说理已极明

畅，读者可于其中悟出治病的机宜。

（六）胃脘疼

【概说】

脾胃为后天之本，不可一日废用，多种原因都能导致胃脘疼，而且往往反复发作，不易根治（须要注意，胃脘痛有时亦称胃疼，但不仅单单指西医所说的胃）。疼痛部位主要在心窝部，发作时可牵胁背，或兼见呕恶吐酸，嘈杂痞闷，腹泻便黑等症。按其病因，可大略分为胃脘冷痛，饮食停滞，肝气犯胃，肝胃郁热，阴虚胃疼，淤血停滞，脾胃虚寒等诸种。

胃脘冷痛者，病有夙根，遇受寒，冷食或过劳而诱发，疼痛暴作，得温稍减，常呈绞疼状，阵疼中间有较短间歇，兼见脉沉紧，当以散寒止痛为主，常以香苏散合姜附而奏效。

食积胃脘者，由于过食或食难消化的食物，而急性发作，胃脘部满闷，打呃酸馊，恶心呕吐，吐后疼减，疼痛为胀疼，常兼见苔厚腻，大便泄泻或便秘。当以消食导滞的保和丸加减治疗。

肝胃不和者，胃脘胀满，攻撑作疼，疼连胁背，以打呃为舒，常因情志因素诱发，多见脉弦，以舒肝理气法为治，柴胡舒肝散、逍遥散、金铃子散、失笑散皆为常用。

肝胃郁热者，胃脘烧灼疼痛，泛酸嘈杂，疼有定时，常兼见烦躁易怒，口干口苦，以泄热和胃为主，用滋水清肝饮、左金丸、化肝煎加减治疗。

阴虚胃疼者，胃疼隐隐，常伴有口燥咽干，舌红少津，大便不通，当以养阴和胃为治。玉液汤、玉女煎、养胃汤、

沙参麦冬饮、一贯煎等方皆可加减使用。

淤血阻胃者，胃脘疼有定外，拒按，疼如针刺，兼见黑便、呕血、舌紫脉涩等证，常宜活血化淤、理气止疼。兼热象者，用泻心汤加减；兼虚者，黄土汤进退；兼呕血者，常加三七、十灰散；体实者，多以失笑散加味取效。

脾胃虚寒临证最为常见，胃疼绵绵，泛吐清水，喜暖喜按，常兼乏力恶寒，纳差便溏等证，当以温中健脾为主。黄芪建中汤，小建中汤、香砂六君子汤、参苓白术散，皆可服用。

【选案】

案一，金男，西医诊断为消化道溃疡，久治无效。今心下空空然，欲得重压，时有隐痛，睡不好，舌淡，苔微腻。予小建中汤加味。

当归9克 桂枝3克（后下） 白芍10克 甘草5克 柏子仁9克 半夏9克 秫米9克 生姜1片 大枣7枚 饴糖12克

《章次公医案》

案二，吴××，男，42岁，1962年9月12日初诊。患十二指肠溃疡已13年，秋冬春季节之交，易发胃脘疼痛，经钡餐透视，十二指肠球部有龛影，大便潜血阳性。最近胃疼，以空腹为重。精神不佳，大便正常，小便时，脉弦急，舌红苔少黄，属肝胃不和，治宜调和肝胃。处方：

柴胡4.5克 白芍6克 炒枳实4.5克 炙甘草3克 黄连1.8克 吴萸0.6克 青皮4.5克 广木香1.5克 良姜2.4克 大枣4枚（劈） 一剂二煎，取160升毫，分早晚二次服。

9月13日复诊：药后胃疼稍减，大便不爽，小便稍黄，寐差，脉弦数，舌红苔黄腻。属湿热尚盛，胃气未复，治宜调肝胃，清湿热处方：

苍术炒4.5克 香附4.5克 川芎4.5克 焦栀子4.5克
建曲6克 厚朴4.5克 枳壳炒4.5克 茵陈6克 石斛9克
广木香1.5克 通草3克 鸡内金6克

三剂，煎服法同前。

9月16日三诊：胃疼基本消失，食纳增加，脉缓有力，舌正微有薄黄腻苔，续宜和胃，以资巩固。处方：

赤石脂30克 乌贼骨30克 香橼15克 炙甘草30克 炮鸡内金60克 共为细末和匀，每服1.5克，日服两次，白开水送下。

《蒲辅周医案》

案三，杨姓男子，患胃脘痛六七年，时发时止，近年来竟疼不休，精神忧郁，甚以为苦，并见胃脘部堵闷，饮食欠佳，干呕暖气，大便不畅，消瘦明显，其脉沉弦而细，舌苔薄，舌尖边红而有齿痕，前医迭进舒肝和胃理气之剂，未能得效，乃延诊于余。

患者久病，又屡进香燥疏利之剂，是阴愈伤而液愈亡，观病者体瘦脉弱，舌边尖红而有齿痕，大便不畅，俱属阴虚之象，不养阴则难复胃降之和，非柔肝则不能涵其横逆之气，是当益胃柔肝，稍佐理气止痛，以一贯煎参叶氏抑木安胃之法出入：

北沙参12克 石斛15克 麦冬9克 生地20克 玉竹9克
白芍20克 山楂24克 枳壳10克 木瓜10克 乌梅15克 生甘草6克 白蔻6克

服六剂后，诸症减而胃疼除，精神得振，饮食有增，但腹仍时胀，脉已转缓，舌已不红为肝逆已除，土衰已复。胃阴渐生而脾气未运之候。遂以香砂六君健脾和胃，以善其后。原方去辛燥之半夏、稍佐护阴之品。药用：

党参10克 白术12克 云苓12克 陈皮12克 白芍12克
香附12克 枳壳10克 玉竹10克 砂仁6克 生甘草9克
三付而疾俱愈。

《医话医论荟要》

案四，潘氏，脉弦涩，经事不至，寒热胃痛拒按，呕恶不纳，此因久病胃疼，淤血积于胃络，以辛通淤滞法。

川楝子 延胡 桂枝木 五灵脂 蒲黄 香附

叶天士《临证指南医案》

【分析】

案一为虚寒性胃脘痛，患者心下空空然（古时心有“中”之意，中指脾胃部位，故张仲景泻心汤即调脾胃）重压始舒，又隐隐作痛，不时而发，可见病非一日，致使脾胃虚寒，心脾不足，故见睡眠不安。方用小建中汤温中补虚，调和营卫，缓急止痛，芍归同用，和阴养血，可助安神。再加柏子仁加强养心之功。半夏秫米两味乃《内经》十三方之一，善治失眠。药只九味，兵分三路，共奏和胃安神，缓中补虚之功，对于久病虚疼，用药宜和缓平稳，是一应注意之处。

案二为肝胃不和型，据脉弦急，舌红苔稍黄可知肝气不舒。胃疼一般以空腹为重，得食稍减者是虚，而饱食加重者属实。此案平素脾胃不足，肝气乘虚作乱，因此初诊治以舒肝和胃。方为四逆散原方加入黄连、吴茱萸两味乃左金丸，可

清泻肝火；再加青皮、广木香理气舒肝止疼；加高良姜、大枣温补平素脾胃之不足，散寒止痛。

一诊治疗重点在止痛。二诊见小便黄，大便不爽，脉弦数，舌红苔黄腻，是因平素脾胃不足，湿浊不化，再加肝不疏泄，遂郁为湿热。因而二诊治疗重点是清利湿热，调和肝胃，方为越鞠丸原方，总开六郁，加厚朴、木香、枳壳、郁金理气疏肝；加茵陈、通草清利湿热；石斛清胃中虚热；鸡内金健胃消食，二诊后胃疼当基本消失。三诊应巩固疗效，配为散剂，方中赤石脂能生肌调中；乌贼骨能生肌去湿（据现代科研证实其治吞酸、胃、十二指肠溃疡有特效）；再加香橼理气健脾；鸡内金健胃；甘草和合诸药，生肌止痛，每服只五分，坚持服较长时间，自有显效。用石脂、乌贼骨促使消化道溃疡生肌愈合，为蒲老临证经验。

案三为阴虚胃疼，清代叶天士创养胃阴一法，羽翼东垣的升阳补气，使脾胃学说得成完璧，为后世又开一大法门。其代表方剂为养胃方，出自《临证指南医案》，以沙参、麦冬、玉竹、扁豆、桑叶、甘草组成。本案因为屡诊辨证不准确，总以为是肝胃不和，迭进香燥疏利之剂，重伤胃阴，因见体瘦脉细，舌尖边红，大便不畅，胃火虚亢，升降不和等证。故非柔肝则不能涵其横逆之气。方用一贯煎合养胃方，养阴安胃，加芍药，甘草合化生阴，柔肝止痛；木瓜、乌梅敛肝和胃；山楂、白蔻仁、枳壳理气消食，六剂后即获显效。后以香砂六君子汤去半夏之燥，加白芍、玉竹、枳壳、砂仁三剂而痊愈。六七年之久病，获效如此之捷，可知辨证施治准确，效如桴鼓。

案四为淤血胃疼案，由于血淤胃络，胃失和降，故呕恶

不食，疼痛拒按。淤血久积，郁而生热，证见寒热不适。淤血阻滞，气不宜通，脉涩而月经不至。关键在于祛淤通络，因而方用失笑散，活血止痛；延胡、川楝子、香附气血两通，且止胃疼。桂枝木一味，为叶氏经验，叶氏有久病入络之说，而且胃病久痛，喜用桂枝木宣通阳气，活络止痛。

（七）腹疼

【概说】

腹疼是临床极为常见的病证，可出现于多种疾患之中，因此临床辨证必须根据病因、疼痛部位、疼痛性质等，做出准确诊断。以病因而论，外感风、寒、暑、湿或内伤饮食、气滞、血淤及虫积、症瘕等都能导致腹疼。以部位而言，大腹疼者脾胃大小肠病多见；右腹疼者多见肝胆病；肠痛腹连后腰痛；掣疼肾膀胱病为多；绕脐疼痛，虫积为多。以疼痛性质而言，虚则喜温喜按；实则拒按。病在气分，疼痛走窜；病在血分，刺痛不移。当然尚需结合各个脏腑的功能特点，及伴随症状，详审细察。

除痢疾、虫积、疝疼、肠痛诸证中出现的腹疼外，其余分为四种类型来辨证。虚疼者，因脾阳不振，寒湿停滞，阻遏气血运行，疼痛是慢性钝疼，时作时止，喜温喜按，遇寒及肌劳加重，得食或休息减轻。治宜甘温补养，益气散寒，大小建中汤，附子理中汤皆可随证选用；实痛者，因暴饮暴食，误食腐馊，停滞胃脘，阻隔阳气，或气滞血淤，或肝胃不和。疼痛是胃脘胀疼，得暖气、呕吐则疼少减，当消食导滞，保和丸、枳实滞丸为首选之方；因气滞血淤者，疏肝理气为宜，柴胡舒肝汤、逍遥散、少腹逐淤汤为多用；寒痛者、有虚有实，实者腹疼急暴，脉象沉紧，当以良附汤、乌

头桂枝之类散寒为急；虚疼者，以温运中阳为先；热疼者，因恣食肥厚，湿热与食积交阻，气机不和，传导失利，腹疼胀满，大便坚燥，烦渴尿赤，当以仲景承气法清热攻下，泻腑实为急。诸种治法，不一而足。但治疼以“通”字为先，而通不仅指泻下通便而言。调气和血，使气血通畅；脾气下陷者，升提脾气；中结者，使之旁散；虚者补而通；叶天士又有久病入络，活血通络，也是“通”。总之，准确辨证、灵活用药，是其要领。

【选案】

案一，脘腹作痛，延今两载，饱食则痛缓，微饥则疼剧心悸。舌淡白，脉左弦细，右虚迟。体丰之质，中气必虚。虚寒气滞为痛，虚气散逆为胀，肝木来侮，中虚求食。前投大小建中，均未应效，非药不对证，实病深药浅。兹拟小建中加柴胡汤，合荆公妙香散、复方图治，奇之不去则偶之之意。先使肝木条畅，则中气始有权衡也。大白芍 炙甘草 肉桂心 潞党参 银川柴胡 仙半夏 云茯苓 陈广皮 乌梅肉 全当归 煨姜 红枣 饴糖 人参 炙黄芪 怀山药 茯神 龙骨 远志 桔梗 木香 甘草。上药为末，每日陈酒送下，如不能饮、米汤亦可。

《丁甘仁医案》

案二，丹溪治一人，六月投渊取鱼，而秋深而凉，半夜小腹疼甚。大汗，脉沉、弦、细、实、重取如循刀，责责然。与大承气汤加桂二服，微利痛止，仍连日于申酉时腹疼，坚硬不可近。每与前药，得微利，痛暂止。于前药加桃仁泥，下紫黑血升余，痛亦止。脉虽稍减，而责责然犹在。又以前药加川附子，下大便五行，有紫黑血如破絮者二升有

余。又伤食，于酉时复痛在脐腹间，脉和，与小建中汤，一服而愈。

俞震《古今医案按》

案三，钟××，女，28岁。1959年4月2日初诊。面色萎黄，舌淡苔薄，脉软而弱，口干，腹胀疼按之坚，月经量少。西医诊断为结核性腹膜炎，粘连性肠梗阻。中医谓之脾劳，本元虚弱，运化无力，不通则痛。宜调补内脏，理气活血。以自订验方五参五皮饮去桑白皮、地骨皮、丹皮、加陈皮、茯苓皮及干蟾皮治之。西党参、丹参，苦参，北沙参、元参、生黄芪皮、青皮、陈皮、茯苓皮、干蟾皮。三剂后腹疼减轻，按之濡，午后颧赤，脉软弱，舌淡红，苔微黄，效不更方，再进三剂。痛止腹软、纳增、眠安、二便通畅。前法踵进，再服7剂。

《著名中医学家学术经验·魏长春医案》

【分析】

案一为肝脾不和，脘腹疼痛。病已经两载，食则疼缓，左脉虚迟，腹胀舌淡白等证，皆因脾气不足，中虚寒凝所致。土虚木必乘之，因见左脉弦细。治疗宜补脾运中，稍加敛肝。前方仅以大小建中，一则病重药轻，一则未制肝旺，因而不效。现用小建中加柴胡补前方之不足，再同用妙香散补益气血，安神镇惊。妙香散方（茯苓 茯神 人参 桔梗 甘草 山药 远志 黄芪 辰砂 麝香 木香），小建中汤内用肉桂换桂枝以加强温中效果。妙香散方中去辰砂的重浊，麝香的走窜。用龙骨安神，加当归养血，乌梅敛肝，二陈运中除湿，药既灵活，又很集中，故能比前医多效。

案二为寒凝血淤，少腹作痛。前因伤于寒湿，气血凝

滯，不能宣通，久则淤血内停，阻遏肠腑，脉沉弦实可知腹疼非虚，故先用大承气通肠止疼，加肉桂去久寒通经脉。服后疼痛少止，说明下法对证。停药又发作是因病非食积热积，再于前方中加桃仁，对因治疗，即疼止脉稍缓和。但脉责然而紧犹未全除，是因寒郁既久，阳气难以骤然宣通，故前方再加附子，始得淤血皆尽，腹疼痊愈。此证始终脉象认得真切，处方则以一个桃仁承气汤，分两步治疗，先温阳通肠，用肉桂反佐承气汤；后攻淤血，以桃仁承气汤。认证准确，守方不移，堪称两绝。

案三为脾胃虚寒型腹疼，脾胃久虚，运化无力，水湿内聚、津液不布，故口干便秘；中虚升降失司，故气胀腹疼。魏长春先生用自订五参五皮饮加减，方中党参温补，茯苓皮淡渗；黄芪皮补气，青皮补气；北沙参滋阴，陈皮燥湿；玄参滋阴清火，丹参养血行血；苦参杀虫，蟾皮解毒。本方有五补五泻之妙。补中不柔腻，解毒治痼而不伤正，故三剂腹痛减，六剂睡眠安，再进7剂，诸症痊愈。

（八）呕 吐

【概说】

呕吐是胃气上逆引起的病症，一般认为：有物有声为呕，病属阳明；有声无物为吐，病属太阴。两者常同时发生。呕吐是人体对自身的一种本能性保护反应，可见于多种疾病之中。如现代医学中所说的神经性胃炎，急慢性胃炎，幽门梗阻，胆囊炎，肝炎，美尼尔氏综合征等病中皆有呕吐。辨证分为虚实两类。实者多见于伤于寒冷邪气，饮食停滞，胃火上冲，肝气上逆，痰浊犯胃，邪传少阳诸种。如伤于寒邪，必多兼胃脘疼痛，则应以神香散，《景岳全书》良

附汤之类温中散寒；因于饮食停滞者，必兼胃脘胀满，宜大和中汤、保和丸，枳实导滞等消滞通积；因于胃火上冲者，必兼烦渴。治法按胃火的原因分而为五：如湿热上蒸，宜半夏泻心汤加减燥湿清热；邪火威者，宜抽薪饮导火下行；暑热犯胃，宜竹叶石膏汤、藿香正气汤，清暑养胃；肝火犯胃者，宜抑青丸（《景岳全书》）泻火降逆；胃热挟痰者，宜黄芩二陈汤清热祛痰。因于肝气上逆者，必兼胃脘疼痛连胸胁，其治法因体质情况分而为三：肝胃有火者，宜左金丸、四七汤，泻火平肝；肝旺胃衰者，宜吴茱萸汤抑肝扶胃；肝胃阴虚者，用麦门冬汤之类养肝胃之阴。因于痰浊犯胃者，必兼见脘痞脉滑，宜小半夏加茯苓汤，二陈汤加减以宽中祛痰。因于邪传少阳者，必兼往来寒热，宜小柴胡疏散和解，以上属呕吐实证治则。

虚者多见脾胃气虚，症状纷繁复杂，有无甚诱因，时时呕吐者；有闻食味即呕者；有因生气即呕者。有因误服寒凉，攻伐胃气所致者。总宜独参汤、六君子、四君子、参苓白术，香砂养胃之类补中益气。亦有噎膈反胃证之呕吐者，则属难治。

尚有呕吐苦水，呕吐清水，呕吐涎沫，吐蛔虫诸证，亦不可不辨。呕吐苦水，邪在胆经，胆胃失和所致，宜疏利肝胆；吐清水者，不外胃寒、痰饮、水逆之证；吐涎沫者，因脾虚不能约束津液，湿痰上泛而致；吐蛔者，因各种原因，胃火、胃寒、胃虚使蛔虫不能安伏而致，必治呕兼治蛔，万应丸、乌梅丸为常用之方。

呕吐的病机比较复杂，大要是：上焦吐者，以于气逆；中焦吐者，从于积滞；下焦吐者，以于虚寒。治疗实证较

易，但痰饮与肝气所致的呕吐，则每易复发。治疗虚证较难，且常呕吐不止，饮食不进，使体力下降，变生许多其它的病证，必须引起高度重视。

【选案】

案一，许某，女，27岁，近两年来恶心，呕吐，量不多，纳少，厌油，便溏，精神萎顿肢倦乏力，两肋胀疼不适，时咳逆上气。因其爱人患有肝炎，自疑相染，于1978年1月3日赴首都医院就诊。经检查，皮肤巩膜无黄染，心肺正常，腹平软，肝肋缘下可触及，脾未及，肝功正常，HBSAg（-），上消化道钡餐造影未见异常，服西药月余未效，亦经中医诊治，服香砂六君子等温中散寒之剂，亦未见好转，遂于1978年2月8日转我院就诊。

患者除上述诸证外，面色萎黄，询知发病于产后五个月，系由情怀抑郁，饮食不慎而起。舌质红，尖有溃疡，苔薄白，脉细弦滑。审证切脉，认为此乃肺胃阴虚，肝木横逆，过胃犯肺，胃失和降所致。拟先清肃苦降以制肝，和胃化痰以治标。方拟温胆汤合苏叶黄连汤意化裁。

苏叶4.5克（后下） 黄连2.5克 枳实9克 半夏9克 茯苓15克 竹茹9克 炒枳壳9克 生甘草8克 六剂。

药后呕吐止，饮食少进，唯舌红苔少，时有咳逆，肺胃阴虚之象毕露，遂即转入甘平濡润柔肝和胃之治，仿沙参麦冬饮合一贯煎意化裁加炮姜一味以反佐之，药用：

沙参12克 麦冬9克 石斛9克 竹茹12克 山药15克 茯苓12克 杞果9克 川楝子9克 炮姜8克 十剂。

三诊时舌质转润，苔见薄白，脉亦缓和，诸证均减，精神见充，纳谷日增，遂以参苓白术散意增损，以善后调理。

《医案医话荟要·路志正医案》

案二，黄某，先患外感，医药杂投，方厚一寸，后更腹胀而呕，脉象弦数，舌色红而苔黄，口苦。余曰：此甚易事，服药一剂可愈，多则两剂，何延久乃尔，与黄连汤，果瘳。

黄连3克 法夏9克 干姜3克 桂枝3克 党参9克
甘草3克 大枣6克

《萧琢如医案》

案三，治一人，膈气，粒米不进，始吐清水，次吐绿水，次吐黑水，次吐臭水，呼吸将绝。一昼夜，先服理中汤六剂，不令其绝，来早转方，一剂而安。《伤寒论》云：噎气不除者旋复代赭石汤主之。吾于此证，分别用之者，有二道：一者以黑水为胃底之水，此水且出，则胃中之津液久已不存，不敢用半夏以燥其胃也。一者以将绝之气，止存一丝，以代赭石坠之，恐其立断，必先以理中分明阴阳，使气易于下降，然后以代赭石得以建奇奏绩。乃用旋复花一味，煎汤调代赭石末二匙与之，才入口即觉其气转入丹田矣。困倦之极，服补药二十剂，将息二月而愈。

喻嘉言《寓意草》

案四，邵性者，年五十，呕吐物如烂猪肺状，胸背胀。前医以反胃治不效，反加潮热烦躁，饮食不入，因谓肺坏辞不治。予诊之，两手滑数，左关尺涩，乃曰：若果肺坏，声音当哑，今声亮而独胸背作胀，由于酒后忿怒，淤血痰饮积于胸膈为病耳。以滑石、茜草、桃仁、小蓟、归身、香附、贝母、山梔仁、枳壳甘草，十贴而全安。

《孙一奎医案》

【分析】

案一为肝胃不和，阴虚作呕，患者病起于产后五个月，气阴两虚。加之情志抑郁，肝郁化火，更伤胃阴，故呕逆频作，且木火刑金，故时见咳逆上气，前医只见便溏肢倦，投以温中散寒，遂使阴津愈耗，虚火更炽。今治以薛生白的苏叶黄连汤清火降胃，合温胆汤和胃化痰先治其标。呕吐少止，再仿沙参麦冬饮、一贯煎合方加减养肝胃之阴，一味炮姜反佐取之，再以参苓白术散补脾肺而收全功。

案二为寒热错杂型呕吐，患者杂药乱服，致伤脾胃，脾不升清则寒湿在下而腹胀。胃不降浊则积聚生热而见呕吐，舌红苔黄，脉弦数。治疗宜寒热并用，攻补兼施。黄连清热；干姜温中；半夏降逆止呕；党参建脾温胃；桂枝辛散，去胃中之积滞；甘草大枣，缓急而止胃痛。脾胃为病，常虚实互杂，标本胶结，以仲景诸泻心汤法取效者实多，此方亦泻心汤之变方，细读之自悟。

案三为脾胃虚极的重证，胃浊不降的重证。患者剧烈呕吐，气津两伤，呼吸将绝。急则当救其垂危之气，故先服理中汤，固其中气。再以旋复花一味煎汤，下气消痰浊，调服代赭石重镇降逆，呕吐遂止。此本为旋复花代赭石汤证，病机是虚气上逆，痰浊不降。但已经大量呕吐，气津两伤，胃津将绝，原方半夏性燥，大枣柔腻，皆不宜使用，只取参、姜、草三味再加白术培土固本即是理中汤。旋复花，代赭二味不入汤煎，变换服法，亦获良效。民国时期大经方家吴棹仙亦曾变换此方服法，先服人参，再服旋、赭治愈一人大病后呃逆不止。可见经方治重病，亦在乎人之善用尔。

案四为淤血积滞，呕吐带血证，因久有淤血滞于胸膈，

气不宣通，故见胸背胀痛。淤血久积，新血不生，故见阴虚、潮热烦躁诸证，两寸脉滑数，知非淤血在肺。左关尺涩，挟瘀上冲而为呕，因久淤致腐，故呕吐物为烂肺败絮状。治疗当以小蓟、茜草、桃仁攻逐瘀血，川贝软坚，可助化淤；归身养血活血，香附、枳壳理气开郁，活通血脉；山梔、滑石、甘草导郁热下行。辨证准确无误，处方灵活不落俗套，因而十剂获显效。叶天士亦有以当归尾、京墨汁、桃仁泥、延胡索、五灵脂，韭白根治疗淤血呕吐案，亦与此有异曲同工之妙。

（九）泄泻

【概说】

泄泻是指大便溏薄，或作或止，泻指大便直下，水去如注，虽有轻重之分，但总属脾胃受伤，湿邪无从分消，以致分利无权，并走大便所致，所以常混称泄泻。

临床辨证，由大便的性状来分，有飧泄，粪便水谷不分，消化不好，随食随泄，多为湿重或伤食，宜胃苓汤升阳除湿，加減木香散消食健脾；有溏泻，粪便略带肠垢污积，多为湿热积滞，宜黄芩芍药汤渗湿清热；有鹜泻，粪便清冷如水，其中稍有结粪，多为寒湿，宜附子理中之类，温中化湿；有滑泄，粪便稀溏不成形，一下如注而不可止，多为阳气虚弱，不能固涩，宜补中益气，四神之类温阳涩肠；有濡泄，粪便色如尘水，便极溏薄，为脾湿自胜，宜五苓散以运化渗湿。

从发病脏腑来分，则有脾泄、肾泄、肝脾不和痛泄、胃泄等。

从病邪性质分，则有痰、食、湿、暑等种类。总之，泄泻多

端，不离手脾胃。李中梓有治泻九法曰：淡渗、升提、清凉、疏利、甘缓、酸收，燥脾，温肾、固涩，已将治泻诸法，囊括其中。临床若能随证配合使用，则治泻之要领，思过半矣。

【选案】

案一，腹鸣晨泄，巅眩脘痹，形质似属阳不足。诊脉小弦，非二神、四神温固之证。盖阳明胃土已虚，厥阴肝风振动内起，久病而为飧泄。用甘以理胃，酸以制肝。人参，茯苓 炙草 广皮 乌梅 木瓜

《临证指南医案》

案二，男，41岁，1961年10月以来，每日腹泄，有时失禁遗裤，初为水泄，一天20多次。近变为鹜泄，一天4—7次不等。便前肠鸣漉漉，无腹疼感，纳食尚佳。脉细带弦，舌质红，苔黄白厚腻。诊断为脾阳不运而湿不化，直趋大肠为泄，泻久伤阴，阴虚生热，且现水不涵木现象。治法仍宜温养中焦为主。稍佐升清，如果因舌红而用苦寒，势必脾阳更伤而下陷。方药：

党参 黄芪 山药 诃子 炮姜 炙草 红枣 葛根
升麻

服4剂后，苔腻化薄，舌质不红，肠鸣减少，原方去升、葛加破故纸。又服8剂。自觉周身有力，粪便转厚，但一天仍有4—5次。接用附子理中合赤石脂禹余粮汤复方。

秦伯未《谦斋医学讲稿》

案三，暴泻为实，久泻为虚。曾由饮食失调致泻，延今不已。泻色淡黄，完谷不化。火不生土，命门虚寒，脾胃肾俱亏，化机不振。经言：肾者胃之关也，开窍于二阴。拟景

岳胃关煎，略为加减。

熟地 山药 萸肉 炙草 炮姜 冬术 五味 肉蔻
补骨脂

《王九峰医案》

案四，暑湿浸淫脾土，土不运旋，气湿不能分化，水泻口渴，舌淡白而喜热饮，中脘不舒，宜调气化。川朴3克 六一散9克（包） 缩砂仁1.5克 藿香6克 白茯苓9克 橘皮3克 鲜佛手4.5克 煨木香1.8克 猪苓6克。

二诊：调气分化，水泻已止，口渴亦减。再调气通津液。六一散9克（包） 生芋术8克 猪苓4.5克 沉香曲4.5克 建泽泻4.5克 官桂0.9克 鲜佛手3克 鲜荷梗一尺（去刺） 茯苓9克 砂仁1.2克（盐水炒研，后入）。

《张聿青医案》

【分析】

案一为肝脾不和型腹泻，头巅昏眩，诊脉稍弦，为肝郁横逆之象。而肠鸣脘痹（即胃痞），久病飧泄，足见脾气不足。立法宜温中运脾，敛肝之逆。处方为四君子汤加减，因久泻伤阴，故去白术之燥，换陈皮既可温中，又可行气，加木瓜、乌梅柔肝止疼，木瓜兼能舒肝之气，药仅六味，功分两路。观此案可知叶天士书案突出主证，明辨病机，用药精简，要言不繁。

案二为脾虚湿泄，肠鸣水泄无腹疼感，为湿气下注。而舌红，苔黄白厚腻，则是因久泄伤阴，阴虚生热，热与湿合，内生湿热所致。但病变主要矛盾乃是脾阳不升，湿邪下注。治疗不能因见其舌红苔腻使用苦寒，仍宜用李东垣补中益气，升阳健脾法。处方即为补中益气汤的变方，以参、

芪、山药、炮姜、炙草、大枣温中健脾。换升、柴为升、葛。升阳举气，葛根又能益胃阴止泄泻而升胃阴。可见，换一味葛根、大有妙意。因治疗抓准重心，四剂便见显效。再以附子理中汤温脾肾之阳，辅以赤石脂、禹余粮汤涩肠止泻，赤石脂、禹余粮又能止血生肌，促进大肠恢复其正常功能。

案三为肾虚久泻。原因伤于饮食，暴泻伤脾胃，而迁延不愈，脾阳受损。五脏之伤，穷必及肾，故使肾气受损，下焦不固，火不生土，更使脾胃不运，终于脾肾双虚，水谷糟粕直下而为完谷不化。治则宜脾肾双补，温阳止泻。用张景岳胃关煎方（熟地 炒白术 干姜 吴茱萸 炒白扁豆 炒山药 炙干草），方中诸药专治脾肾，虚寒泄泻，再加五味子、肉豆蔻、补骨脂涩肠止泻。本方脾肾双补，不用附桂之温燥，而选用熟地、山药等补阴液之品；涩肠止泻不用赤石脂、禹余粮之重坠，而选用五味、豆蔻等兼理肝脾之药，是其治疗细致入微之处。

案四为暑湿伤脾致泻。暑热多挟湿邪，易伤脾胃。又湿热胶结一处，干扰气机升降，难解难分。治疗重点，一应注意分清暑湿孰重。一应注意宣畅气机。此证水泻，舌淡白，喜热饮，为湿邪不化。口渴，为热伤津液。中脘不舒，为升降失常。法宜清暑利湿，宣化气机。以藿香芳香化湿，兼可醒脾；茯苓运中祛湿；猪苓淡渗利湿，三味即叶天士所谓“杏、朴、苓”之类，宣化三焦；厚朴砂仁、佛手木香宣化气机，温中燥湿；六一散利尿清暑，通观全方能清热祛湿，而以祛湿为主。可宣化气机，以温化为重。故云：“分化”暑湿。二诊时，湿邪已去，水泻便止。故于上方基础之上再

行加减，官桂三分用于大队治湿之中，恰能助阴醒脾，配伍沉香曲少量，一升一降，尤利于升降中焦枢机，更加鲜荷梗一尺，生津养阴，清心解暑，诸药配伍，使脾胃生机活泼，暑退湿消，暑湿胶结为难治之证，此方足资效法。

（十）便秘

【概说】

便秘是指大便秘结不通，或几日一行，或虽有便意、而排便困难。可出现于多种疾患之中。主要由于粪便在肠内停留过久，水分被吸收，而变得干燥坚硬所致。临床辨证，约分为如下几种情况：

热秘，由于肠胃积热，使津液干枯，不能润滑大肠，多兼见肠胃胀闷，口臭唇疮，脉数苔黄，身热尿赤等证。轻则以更衣丸、麻子仁丸润之，重则以承气之类通导之。

冷秘，由于老年人脏寒气道涩滞，阳气不运，使肠道传送无力而大便艰难，多兼见形寒腹疼，六脉沉迟。可以三物备急丸、半硫丸之类热而通之。外用方法如蜜煎导、开塞露，饮食方法如黑芝麻、核桃仁砂糖拌服等皆可辅助使用。

气秘，由于气机阻滞，多兼见腹胀而后重，胸胁痞闷，呃噫矢气，欲便不得，脉弦等证。可以苏子降气加减，六磨汤顺气导滞。

虚秘，多见于劳倦内伤，病后产后，或老年体弱之人。气血不足，气虚则传导无力，血虚则津枯便燥。多兼虚坐努责、汗出乏力，大便并不干硬，脉虚头晕等证。以气虚为主者，宜黄芪汤之类；阳虚为主者，用济川煎加味；以血虚为主者，宜五仁丸、四物汤之类；津枯肠燥者，宜增液汤加味，活血润肠丸、通幽汤、三才汤等治疗。

总之，六腑以通为用，肠胃通则营卫得以和调，人周身血气能够畅达，若大便秘结，必使腑气滞塞，气机不畅，易变生其它不适。因此，大便常宜保持通畅。目前，杂志报道不少针灸、薄贴、小方小药皆可治疗便秘。而治疗要领是不能只通大便，以一泻为快。须找出病因，进行全身治疗，以免便虽通而泻不止，反生遗殃。

【选案】

案一，一妇因改醮乘轿劳倦，加以忧惧，成婚之际，遂病小腹胀痛，大小便秘结不通，医以硝黄三下之，随通随闭，病增胸膈胃脘胀痛，自汗食少。汪诊之，脉皆濡细近快，心脉颇大，右脉觉弱，汪曰：此劳倦忧惧伤脾也。盖脾失健运之职，故气滞不行，以致秘结，今用硝黄，但利血而不能利气，遂用人参6克，归身5克，陈皮、枳壳、黄芩各2.1克，煎服而愈。

汪石山《石山医案》

案二，一宗室夫人，年几六十。平生苦肠结病，旬日一行，甚于生产，服养血润燥药，则臑膈不快，服硝黄通利药，则若罔知，如此三十余年矣。予诊其人，体肥膏粱而多忧郁，日吐酸涎碗许乃宽，又多火病。此三焦之气壅滞，有升无降，津液皆化为痰饮，不能下润肠腑，非血燥比也。润剂留滞，硝黄徒入血分，不能通气。俱为痰阻，故无效也。乃用牵牛末以皂荚膏丸与服，即便通利。自是但觉肠结一服即瘥，亦不妨食，且食精爽。盖牵牛走气分。通三焦，气顺则痰逐饮消。上下通快矣。

李时珍《本草纲目卷十八·牵牛子》

案三，治新市陈鹿塘，有肠风脏毒之证。大便燥结，数

日不能一行。痛苦殊甚，百医不效。其脉两寸皆数，两关皆弦而无力，两尺洪滑左尤甚。曰：东垣谓大肠喜清而恶热，脾胃喜温而恶寒。以胃属土而大肠属金也。今此乃胃寒肠热之证，当以肠风脏毒之药为君主，外以养血之剂裹之，使不伤胃气，盖药先入胃，而后传入大肠，入胃时裹药未化，及入大肠，则裹药化而君药始见，亦假途灭虢之策也，因以大黄九浸九蒸九晒60克，木耳60克，槐花90克，郁李仁、皂角子、象牙屑、条芩各30克，血余炭、升麻、荆芥各15克，为末炼蜜丸，外以四物汤加蒲黄各30克为衣，空心午后，各以米汤下6克，果血止而大便不燥，饮食日加矣。

《孙一奎医案》

【分析】

案一为气虚便秘，患者因改嫁心怀忧郁，又加疲惫、饥渴，劳伤心脾。遂使中焦气伤，气机不能宣畅，二便不通。本应调气养阴，稍佐清心火之药以治之。前医反以硝黄三下，重伤脾胃，又增加了胸膈胃脘胀疼，自汗食少。脾脉细数，心脉显大等，脾气明显亏损之证。治则宜补气调气，少佐清热。方用人参、归身两补气血；陈皮、枳壳宣通气机；黄芩2.1克清郁热，而一服取效。

案二为痰热中阻便秘。患者为皇亲国戚，平素膏粱厚味，体肥而情志抑郁，故湿热结聚，痰饮中阻。痰热上泛，有吐酸涎，多上火之证；痰阻气机，升降受阻，则下为便秘。前治多误，用养血润燥，反助痰湿，故膈膈不快；服硝黄只能治标，于痰结无益。戴思恭曰：“善治痰者，不治痰而治气，气顺则一身津液亦随气而顺矣。”如此只宜畅通气机，逐痰利膈方为对证。牵牛子下气利水，治大肠气秘，风

秘最有良效；皂角功能辛散走窜，通利三焦，攻逐顽痰，以之为膏，欲其峻药缓攻，效在大肠。平常两药，于三十年之便秘证，一服即瘥，良可慨也。

案三为风秘。患者素有肠风下血，便秘不通，治疗当清热凉血，润便通肠。但凉药久服则易伤脾胃阳气，因此必精选一方，可以保护胃气，又能使药力直达大肠，所谓借道伐虢，以大黄、郁李、皂角润肠通便；以槐花、血余炭止肠风出血；条芩、象牙屑清热解毒；升麻、荆芥少量以祛肠风，并使诸药不致寒降太过，诸药做成丸药。再用四物汤料，蒲黄包裹丸药。服时以米汤送下，一则保护脾胃，一则在胃中仅得消化外面药衣，其余主药可直达大肠治肠风出血。此方匠心巧运，清热解毒药大量服而不致伤脾，可见临证必得胆大心细，圆机活法。

（十一）黄疸

【概说】

黄疸以目黄、身黄、小便黄为主要症状。尤其目黄是确定本病的主要依据。对黄疸病的病理，早已有比较明确的认识。本病初期，多出现恶心，食欲不振，甚则闻油腻呕吐，浑身乏力，小便亦黄，胸胁不舒。继则身热不适，两目黄染，或全身皮肤皆黄。

临床辨证分为阳黄、阴黄两种。阳黄证病程较短，发病较急，黄色鲜亮，属热证、实证。又有热重于湿、湿重于热、热毒炽盛、胆道阻滞几种证型。阴黄病程较长，黄色晦暗，可由阳黄失治迁延而成。属虚证寒证，又可分为寒湿为重、脾阳虚衰、气滞血淤几种证型。

黄疸发病的关键是一个“湿”字，阳黄因湿热阻滞，肝

胆不利，阴黄因寒湿久居，脾阳不升。所以去湿利小便是黄疸的主要治则。《金匱要略·黄疸篇》云：“诸病黄家，但利其小便。”小便得利，湿邪有出路，病就有转机。利湿之法，非只一径：有清热利湿、淡渗利湿、温阳化湿、宣肺、理气、通瘀、健脾，芳香、分消诸法皆可治理。治则如下：

阳黄：热重于湿者，可兼见发热口渴，恶心呕吐，便秘腹胀，小便黄赤，以茵陈蒿汤为主方；湿重于热者，兼有身热不扬，头重身困，胸脘痞闷，苔腻便溏等，以茵陈五苓散为主方；湿热并重，兼有发热口渴，脘痞腹胀，咽肿尿赤，苔黄腻，脉濡数，以甘露消毒饮为主方；热毒炽盛，兼发病急速，身目皆黄，烦躁不宁，神昏谵语，高热口渴，或见出血，斑疹，腹水等证，以至宝丹、安宫牛黄丸、犀角散急救之，胆道阻滞，兼见右胁剧疼，牵引背胛，寒热往来，口苦咽干，恶心呕吐，腹胀纳呆，反复发作等，以大柴胡汤为主。

阴黄：寒湿阻遏者，有食少纳呆，神疲恶寒，便溏而不爽，苔白腻，脉缓，用茵陈术附汤为主加减；脾气虚弱，有肢酸乏力，心悸气短，食欲不振，大便溏薄，以黄芪建中汤加减；淤血停积，有胁下症块，疼痛不舒，皮肤有蜘蛛纹，便黑，腹胀，舌紫，脉涩，以膈下逐瘀汤加减。

【选案】

案一，张××，男，36岁。仲夏，头昏，心跳，腿胀，糖泄，食欲减退，身目俱呈暗黄色，小便亦现微黄，舌苔薄白，脉象带缓。

辨证：劳伤元气，脾失建运，寒湿在里不解，阻塞胆汁入肠，渗入血液，循环外溢。

治法：温化沉寒，淡渗湿邪。

方药：加减当归白术汤主之。

当归9克 白术12克 茯苓12克 桂枝4.5克 法半夏6克 陈皮3克 茵陈30克 苍术6克 炙甘草3克 鸡内金9克

4剂脉平病减，黄退十之六、七，改加味附子理中汤治之，6剂康复。

附片9克 白术12克 黄芪9克 当归9克 西茵陈24克 炙甘草6克 干姜3克 党参12克

赖九良《蒲园医案》

案二，孙××，男，三个月，初诊日期，1971年11月18日。患儿出生半月后，皮肤及巩膜开始发黄，大便色白，溲黄，一周来吐奶。1971年11月1日血查黄疸指数79单位，总胆红质6.82毫克（每百毫克），直接胆红质6.6%毫克。凡登白氏试验，直接迅速反应。谷丙转氨酶150单位，麝浊3单位。诊为：粘液性（不全）阻塞性黄疸。治以利疸清热化湿，连服12剂，黄疸虽未加重，但也未见消退。1971年11月18日转诊，症见一身发黄，吐奶，溲黄。指纹深紫，舌苔白。

辨证：湿热中阻，淤热发黄。

治法：清热利胆，芳香活血。

方药：茵陈6克 郁金8克 酒苓6克 土茯苓6克 藿香8克 杏仁3.5克 橘红8克 赤芍6克 藕节6克 泽兰6克 车前子6克

治疗经过，以上方为主间断服药30剂，1972年4月7日复查，谷丙转氨酶193单位，总胆红质小于0.3%毫克，黄疸

指数4单位，黄疸全部退净，食睡二便正常。1972年6月复查谷丙转氨酶正常。

《关幼波临床经验选》

案三，治一女，经闭三月，膀胱急，少腹满，身尽黄，额上黑，足下热，大便色黑，时结时溏，纳少神疲，脉象细涩。良由寒客血室，宿淤不行，积于膀胱少腹之间也。女劳疸之重证，非易速痊。古方用矾石硝石散，今仿其意，而不用其药。

当归尾 云茯苓 藏红花 带壳砂仁 京赤芍 桃仁泥
肉桂心 西茵陈 紫丹参 青宁丸 延胡索 血余炭 泽泻

《丁甘仁医案》

案四，刘君之子，年12岁，缘于暑天浴水捕鱼，上蒸下溽，即感寒热，继则身黄目黄溲黄俱现，黄而鲜明，如橘子色，胸腹热满，按之灼手，神烦口渴，渴不欲饮，恶心脘痞，便秘，舌尖边红欠津，苔黄腻，脉沉弦而数。经查，黄疸指数52单位，转氨酶350单位，辨证为阳黄。因上蒸下溽，热结于里，病发于阳明胃肠，气分邪热，郁结灼津，尚未郁结于里。立辛苦辛寒法以清利湿热，重在清热，仿《温病条辨》杏仁石膏汤加味：

茵陈30克 杏仁12克（后下） 生石膏30克 炒栀子12克
黄柏10克 半夏5克 生姜汁10毫升（另兑） 连翘12克 赤小豆15克 药服10剂后，黄疸明显消退，寒热诸证均罢，后佐以和胃之品，共服30余剂，诸证悉愈，肝功亦恢复正常。

刘渡舟《肝病证治概要》

【分析】

案一为脾气虚弱寒湿阻遏型阴黄。初诊用当归白术汤温运中焦。正如仲景所说“身目为黄，寒湿在里，以为不可下也，于寒湿中求之”，故在温运中阳中，加茵陈蒿利尿退黄，加鸡内金健胃消食。尤其桂枝一味，既可芳香醒脾，又可辛温宣发，帮助诸药通利三焦，利尿退黄。继以附子理中汤加茵陈，也就是茵陈术附汤加味而痊愈。

案二为热重于湿之阳黄证。小儿吐奶，全身发黄，舌苔白，说明湿邪内阻，指纹深紫确属有血热内郁。以利胆清热化湿药服十二剂未愈者，是因患儿在胎中感受郁热，久而未化，深入血络，故出生即发黄疸。不加凉血活血之品，难获显效。因而以清热利疸，芳化湿郁，活血凉血方法治之。

方中杏仁、橘红、车前子宣通三焦；藿香、郁金芳香宣化；酒苓、茵陈利胆清热；土茯苓、赤芍、藕节、泽兰清解血分热毒，活血通络，照顾小儿体质，药量轻投，三十剂即痊愈，外加寒热的黄疸证，如果治疗得当，极易痊愈，如失治误治，引邪入内，便会迁延时日，变为阴黄。

案三为瘀血停积型阴黄，在妇女则曰女癆疸。患者膀胱急，少腹满，可知小便不利；而大便色黑，时结时溏，可知有瘀血内阻；经闭三月，纳少神废，一身尽黄，足心发热，可知瘀血停滞，干扰肝胆疏利，经脉不通，新血不生，血瘀生热，面色发黑，两脉涩滞，可知病因为寒邪内容而生瘀血。故治疗宜仿仲景矾石硝石散治女癆疸之意，温通血脉，活血化瘀，利尿退黄。以归尾、红花、赤芍、桃仁、丹参活血去血分郁热；茯苓、泽泻、茵陈利尿退黄；砂仁利气；肉桂末温通经脉；青宁丸功能活血化瘀；血余炭能止大便色

黑。本证寒热错杂，温邪淤液皆有，本虚标实，治疗颇为棘手。张锡纯氏认为：矾石硝石散治热与郁血瘀结成疸。此症乃寒与郁血淤结成疸，两论皆可取法。

案四为热重于湿的阳黄症。故仿《温病条辨》杏仁石膏汤加味治之。此与案三治法恰好交相媲美。案三内挟食滞，故用炒谷麦芽、神曲；外感以寒温为重，以麻黄、豆豉、连翘、桔梗外散内寒。此则内有湿滞，外受暑热，致暑热蒸腾、脘腹灼热、神烦口渴，便秘苔黄腻。重用石膏、栀子、黄柏、赤小豆清热去湿利小便；杏仁、连翘发越暑热；生姜汁反佐诸药，以免苦寒败胃，且可降气止呕，因治疗得当，三十余剂痊愈，可谓速效。杏仁石膏汤。《温病条辨》谓其治“黄疸脉沉中痞恶心，便结尿赤”。亦属热重于湿的主方。应用得当，不论杂病、温病，都可获效。

（十二）水肿

【概说】

水肿的形成，总是因肺、脾、肾三脏功能障碍所致。自元代朱丹溪将水肿分为阳水（实证）与阴水（虚证）两大类型辨证施治以来，至今仍以虚实论治。实证多由于风水泛滥，水湿浸渍，或湿热壅盛。虚证多由肺、脾、肾阳气之虚，具体辨证施治如下：

症状以头面，眼睑，四肢，腹背至全身浮肿为主。虚证水肿者，有肺虚，因上焦阳虚，不能敷布，兼有心下逆满，气上冲胸，治宜通阳化水，方用苓桂术甘汤加减；有脾虚，则因中焦阳虚，不能运化，水渍于中，外泛为肿。兼见腰以下肿为甚，脘闷腹胀，纳减便溏，治宜温中祛寒，方用实脾饮加减；有肾虚，则因下焦阳虚，不能温化，可兼见腰以下

肿为甚，可兼见腰酸肢冷、喘急腹胀，治宜温阳利水，方用崔氏八昧丸；实证者有风水泛滥型，多见目睑肿胀，继则全身肿胀，兼恶寒发热，咳喘脉浮。治宜祛风行水，方用越婢加术汤加减；水湿浸渍型，多见肢体浮肿，按之没指，兼身重尿少，苔白腻，脉沉缓，治宜通阳利水，方用五皮饮五苓散加减；湿热壅盛型，多见遍身浮肿，色泽光亮润泽，胸腹痞闷，舌苔黄腻，便秘尿赤，治宜分利湿热，方用疏凿饮子加减。本病施治的关键，正如景岳所说：“凡水肿等证，乃肺、脾、肾三脏相干之病，盖水为至阴，故其本在肾；水化于气，故其标在肺；水唯畏土，故其制在脾。今肺虚则气不化精而化水，脾虚则土不制水而反克，肾虚则水无所主而妄行。因此治疗抓住肺、脾、肾，其余便迎刃而解。

临床亦常见一种水血互结，淤血内停而致的水肿，多见于肝病后期，病机往往虚实夹杂，主证多见面色黧黑，腹部青筋暴起，舌质紫暗，腹部水肿。又因体质不同，有阴虚内热，血虚水停者，可兼见手足心热，消瘦乏力，两颧泛红，舌质红绛等。治宜育阴活血利水，方用猪苓汤加味，有阳虚气滞，血淤水停者，兼见面色晦滞，畏寒肢冷，舌胖苔滑，治宜温阳活血利水，方用麻黄附子细辛汤加味。此种病证又宜遵《内经》之说，活血祛淤，祛淤陈莖而利水退肿。

【选案】

案一，丁××，男，43岁，胁痛3年，腹鼓而满3月，经检查诊为“肝硬化腹水”，屡用利水诸法不效。就诊时见，腹大如鼓，短气撑急，肠鸣漉漉，肢冷便溏，小便清长而量少，舌苔薄白质淡，脉沉细，诊为阳虚气滞，血淤水停。拟桂枝去芍药加麻辛附子汤加味。

桂枝10克 生麻黄6克 生姜10克 甘草6克 大枣6枚
细辛6克 熟附子10克 丹参30克 白术10克 三棱6

克

药服30余剂，腹水消退，诸法亦减轻，后以疏肝建脾之法，做丸善后。

刘渡舟《肝病证治概要》

案二，查××，男，45岁，患血吸虫病肝硬化多年。近二月来，腹渐胀大，腹皮绷急而光亮，腹形如箕，欲便不能，欲溲不得，纳差，时泛恶，齿龈出血，体酸，口干口苦而粘，舌质红绛苔净，脉细弦而数，诊为阴虚血淤成症，水血互结，拟养阴活血利水汤增损：

生地45克 何首乌20克 玉竹15克 赤芍12克 丹皮10克
丹参30克 鸡内金6克 白茅根30克 益母草15克 郁李仁30克

服6剂而水肿明显消退，腹胀轻减，继服30剂，舌仍绛，但有薄苔，诸证亦见好转，后改汤为丸，巩固三月，渐趋平稳。

《肝病证治概要》

案三，胡××，女，平素嗜烟肝旺，且有痰红，壬寅产后患此，实因早浴而起，恶风无汗，头面独肿，四肢亦肿，腹微胀而尿少。脉浮濡，苔薄白滑。脉证合参，浮主风，濡主水，水渍膜腠，故发肿而微胀；风袭皮毛，故恶风而无汗，此仲景所谓风水肿也，以麻杏开肺发表为君，五皮达膜消肿以佐之。

净麻黄1.5克 光杏仁9克 新会皮4.5克 浙苓皮12克
生桑皮9克 冬瓜皮9克 生姜皮3克 葱须0.6克

复诊，1剂即周身溱溱汗出，浮肿骤退。不事调理善后，反而不知节食，芥辣、鸡香、冰酒恣食无忌。越数日，肿复发，来诊有微词，以脉舌审知其情，切责之，其亦愧服。随仿原方加减以调治之。方药：

生桑皮9克 浙苓皮9克 新会皮4.5克 大腹皮9克
莱菔子6克（炒） 苏噜子6克（杵） 冬瓜子12克 枳椇子12克

连服3剂，小水畅解，肿遂渐退，胃动纳香而痊。

《重印全国名医验案类编·周小农医案》

案四，魏某之母，40余岁，1938年秋诊治。缘产后二旬，面色苍白，全身浮肿，下肢尤甚，腹胀如鼓，身倦无力，不欲饮食，舌质淡，苔薄，脉沉细无力，前医用十枣汤峻剂逐水，其肿益甚，然产后多属脾肾虚损，不任克伐此病标证虽急，应以治本为要，故以健脾温肾，方可本安标除，即用实脾欲加减：

党参 白术 茯苓 山药 炙草 陈皮 木瓜 薏米
附子 肉桂

服药3剂，诸证略减。然仍感乏力，宗原方加黄芪，继进3剂，肿消胀减，后用上方加当归、白芍、熟地等药调治月余，诸证消失。病告痊愈。

《古今救误·付世杰医案》

【分析】

案一为阳虚气滞，血淤水停而致水肿。脾肾阳虚，不能温化，水寒内积，是以腹大如鼓，肢冷便溏，水停则气郁血淤，故胁痛，短气撑急。治宜温阳活血利水法。方用《金匱·水气篇》桂枝去芍药加麻辛附子汤，原方治气分心下坚，

大如盘，边如悬杯，水饮所致。以白术、附子、生姜、炙草、大枣温补脾肾；桂枝、细辛宣通阳气，以利行水；大量丹参，功同四物；少量三棱，软坚破淤。全方补而不守，善通善运，分利血水，恰有良效。三年多的腹水，三十剂即水消。后用疏肝健脾药善后，以防水肿再发。

案二为阴虚内热，血淤水停的水肿证。因肝病营阴受损，阴虚内热，故口苦舌干，齿龈出血，舌质红绛无苔，脉细而数，肝病及脾，运化失职，故水积而为肿；中焦阻滞，气机失常，故上逆而泛恶，二便不通。治宜滋阴活血利水。方用生地、玉竹、白茅根、何首乌育阴清热，柔肝敛肝；赤芍、丹皮、丹参、益母草活血淤祛；郁李润下降气；内金健脾运中。尤其本案重用生地45克，何首乌20克而无腻膈之弊，在于用大量活血行气药以助之。确为作者的经验之方。临证所见，此型水肿多预后不良，宜早期预防为主。

案三为产后风水证。洗浴伤风，风寒外束，故无汗恶风；风挟水湿，外浸皮肤，故头面四肢肿胀。治宜发散风寒，宣肺利水。外用麻杏宣肺，内用五皮利水，一剂即痊愈。后因饮食不忌，辛辣厚味内伤脾胃，中焦不运，故又发水肿，只宜五皮运中利水，加枳椇子醒脾消食，加苏罗子理气宽中，消食除胀，三剂亦获痊。本证外感风寒，因此换麻黄连翘赤小豆方为麻黄杏仁五皮饮，亦风水之变方。

案四为脾肾双虚型水肿，患者产后，气血双亏，本应温补中焦。奈前医一见水肿，便认攻逐，竟以十枣汤峻泻逐水，以致正气更伤，运化失职，肿胀更甚。只宜健脾温肾，方可本壮标除，以实脾饮加附桂而安。

（十三）淋证

【概说】

以唐·王焘《外台秘要》将淋证分为五淋以来，一直沿用至今。石淋、膏淋、血淋的发病机制多与湿热有关，但有虚实之不同。气淋多因气机失调所致，亦分虚实两种。劳淋纯属虚证。诸淋初起，以尿频、尿急、尿疼、尿道灼热为主证者，又统称热淋。石淋、膏淋、血淋多因湿热内蕴，结为砂石，下注膀胱，或伤血络而为淋。石淋实证，多见小便难，内挟砂石，有时砂石突然阻塞尿道，疼痛难忍，治宜消石通淋，方用八正散、石苇散等，金钱草用30~60克多获显效；石淋虚证，多因石淋久积，阴亏血虚，尿中带血，治宜扶正驱邪，方用六味地黄丸，八正散合方；膏淋实证，多见小便混浊如米泔水，或尿中有白色滑腻之物，尿道灼热涩痛，治宜分化湿热，方用萆薢分清饮；膏淋虚证，因实证久不愈，反复发作，淋出如膏脂，形体消瘦，腰酸乏力，治宜补肾养阴，方用六味地黄丸方加减；血淋实证，多见小便短涩刺疼，尿色紫红，尿道灼热，治宜清热凉血，方用小蓟饮子加减；血淋虚证，多因血淋日久，肾阴亏耗，见尿色淡红，腰酸神疲等，治宜滋阴清热，方用知柏地黄丸方加减。气淋总因情志郁结，肝失调达，气机不畅，膀胱不利。气淋实证，见小便短涩，少腹满疼，舌质青紫，脉象沉弦，治宜疏肝理气，通淋利尿，方用沉香散、疏肝散加减；气淋虚证，因病久不愈，见少腹坠胀，尿后余沥，舌淡脉虚，治宜升阳举陷，方用补中益气汤加减；劳淋多因酒色劳力，或诸淋日久，迁延不愈，过服寒凉，阳气亏虚。可见小便淋沥，时作时止，过劳遇寒即发，神疲脉虚。脾虚者，宜菟丝子丸温脾益气；肾虚者，宜肾气丸、鹿茸丸温补肾阳；脾肾两虚者，

宜无比山药丸双补之。

【选案】

案一，痛者为淋，不痛者为尿血。尿血半年，有时成块阻塞。脉沉细带数，左部较弦。阴虚，君相之火下移小肠，逼于营分。拟养阴清肝，以和营分。阿胶 茯神 旱莲 生地 龟板 粉甘草 北沙参 天麦冬 血余炭 丹参 丹皮 藕节。

《马培之医案》

案二，小溲淋痛，痛甚则闭结不宜，欲解难解，脉数洪滑，此温热蕴结膀胱，膀胱不能化气，所谓气淋者是也。秋石 磨沉香 滑石块 瞿麦 牛膝梢 官桂 细木通 黑山梔 木香 甘草梢。

《张聿青医案》

案三，夏勇，此下焦湿热，其热弛张起伏，小溲如浊涕，兼有红色，但不痛，舌红，脉细数，处方以猪苓汤为骨干。

陈阿胶24克（烔冲） 猪苓9克 赤茯苓9克 泽泻9克 克 飞滑石12克 马鞭草9克 瞿麦穗9克 冬青子9克 旱莲草9克 杭白芍12克 生侧柏叶30克

二诊，药后小溲之红白粘液，始则增多，继则减少，起伏之热亦不若往日之剧。再以清利湿热之剂，亦尿道消毒之意。

紫胡9克 生侧柏叶30克 苦参片6克 黄柏45克 生苍术9克 淮牛膝12克 白芍9克 紫花地丁12克 马鞭草15克 凤尾草15克 毕澄茄9克 生甘草3克

《章次公医案》

案四，1978年9月19日，诊得王××，男，45岁。据述半月前突然腰部左上缘疼痛，汗出恶心阵作（约10分钟发作1次），因到某医院门诊。内科检查无异常，经用止痛针剂及针灸未能缓解，至下午腰疼加剧，伴有尿频、尿少、少腹坠胀、恶心，水米不入，而到某医院急诊。内科检查无异常，遂转外科，血常规检查：白细胞16400/立方毫米，淀粉酶16单位，尿检细细胞10~15，白细胞0~1，蛋白极微量。触诊：左侧肾脏未触及，有压痛及叩击痛。经X光拍片，左侧肾盂有块状阴影。因而确诊为肾结石，给予排石汤，药后腹泄数次，腰疼未得缓解，反见胃脘痞满，恶心不欲饮食，头晕肢倦乏力，而来我院门诊。

患者除具上述见证外，并伴有大便溏薄，形寒怕冷，眼睑有沉重感，舌质淡，苔白水滑，脉来弦滑，四诊合参，显系脾虚气陷，肾阳虚衰所致。治拟建中益气，温阳利水排石，仿仲景黄芪建中汤合真武汤意。药用黄芪 桂枝 白芍 炒白术 茴香 乌药 官桂 川断 桑寄生 丹参 土茯苓 金钱草。

阅三日，患者来复诊，言进药3剂，胃疼止，腹泻除，纳谷有加，但腹疼延及背部如故。脉沉滑，舌质淡苔白，为脾阳见复，而下元寒湿未触之征，予以温中回阳，益肾祛湿法，方用附子汤加减主之。第三诊，腰疼已缓而尿量仍少，下肢浮肿，少腹仍有下坠感，总系肾阳不足，不能化气行水，水湿壅遏之候，但迭进温阴利水，宜防伤肾阴。故师《金匱》肾气丸意，加入丹参、桃仁等以消瘀排石。至1978年10月14日，先后共五诊，腰疼止，腹胀平，体征消失。同月9日X光摄片，未发现块状阴影，不知何时结石已排出。

12日在某医院肾图报告，双侧肾功能正常，继予肾气丸增删，以资巩固。

《蒲辅周医案》

【分析】

案一为血淋虚证，尿血半年，并无疼痛。脉沉细数，可知阴虚火旺，虚火不致似湿热暴骤，因而并无尿疼尿急，治疗亦宜滋阴为主，故用大队滋阴药物，加活血、凉血、止血药而主治。

案二为气淋实证，以方测证，知此案尚有肝气郁结不舒诸证。治疗以通淋利尿药伍沉香、木香、官桂理气舒肝；秋石能降火滋阴，治小便淋遗；牛膝梢善引诸药下行直达膀胱，组方亦可谓高出一筹。朱丹溪、周慎斋、俞震等名医皆云，土牛膝汁治血淋最效，临床亦可效法。

案三为膏淋，其热弛张起伏不退，尿亦无急疼之感，知其病久阴虚，又见小溲如浊涕兼红色，知其湿热久积膀胱，未予肃清。故以善育阴利水的猪苓汤为主干，复入二至（女贞子、旱莲草）、白芍以助阿胶育阴止血；用瞿麦、马鞭草助苓、泽、滑石利尿清热。二诊余邪未净，尚不宜补，仍宜清利湿热。今人研究毕澄茄为尿道防腐药，亦可参者。

案四为石淋虚证，亦可称为劳淋。石淋属实者不少，但此案有形寒怕冷，大便溏薄，舌苔水滑，又经服清热利湿之排石汤，反见恶心乏力，肢倦头晕。因而据其尿频尿少，腰部疼痛，及上述诸证。参合西医诊断（肾结石）可确认为是脾阳下陷、肾阳虚衰而致石淋的虚证。用黄芪建中合真武汤脾肾双补，加土茯苓，金钱草通淋排石，加茴香、乌药、官桂温通肾阳。再诊以肾气丸加通淋消淤药物。竟使结石顺利

排出，可见淋证不尽属实，仍宜强调，辨证施治的重要性。

（十四）消渴

【概说】

消渴病以多饮、多食、多尿、身体渐瘦及尿有甜味为特征。中医分为上、中、下三消论治。口渴多饮者为上消；多食善饥者为中消；多尿如脂者为下消。早在隋代《诸病源候论·消渴候》已指出：“其病变多发痈疽。”《宣明论方·消渴总论》又指出了有“变为雀目或内障”的并发症。

临床三消症状往往同时存在，因人而异，各有证候轻重不同。因此治疗大法是：上消者以润肺为主，兼治脾胃；中消者，以治脾胃为主，兼滋其肾；下消者，滋肾为主，兼补其肺。

上消，以肺热津伤为主要病机，多见烦渴多饮，口燥咽干，尿频量多，以玉液汤、消渴方加味主之；中消，以胃热炽盛为主，多见消谷善饥，形体消瘦，便秘尿多，以玉女煎加味为主；下消，以肾阴阳亏损为主，多见尿频，尿量多，尿浑浊如膏脂，或见尿甜，形瘦乏力等证。肾阴虚为主者，兼舌红脉细数，生脉散、六味地黄汤并主之；阴阳俱虚者，兼见脉细弱，苔白，膝膝酸软，阳萎滑精等证，宜金匱肾气丸加减主之。若有并发雀盲、痈疮者，又宜以羊肝丸、杞菊地黄丸、五味消毒饮等加减治疗。

【选案】

案一，张×，男，49岁。1971年发现糖尿病。尿糖（++++），血糖232毫克%，证见多食多尿，口干口渴，脉数，苔薄白。辨证属消渴。治法：滋阴清热，益气生津。方

药：

生石膏18克 熟地45克 当归15克 菟丝子30克 党参
30克 元参12克 枸杞子15克 二冬各9克 川连6克
乌梅12克 泽泻12克 花粉12克 红人参9克

每日1剂，水煎服，共服30余剂，上述症状消失，血糖下降为156毫克%，连用药四个月，自觉症状消失。复查尿糖（±）血糖下降为136毫克%，为巩固疗效，制成片剂继续服。

《赵锡武治疗经验》

案二，朱××，女，2岁，门诊号24694。1957年6月24日初诊。

其母代诉，患儿于本月上旬，即患发热，恶寒，咳嗽。曾在××联合诊所注射青霉素，发热仍然不退，继而渴饮无度，小便频数而量多。又在某中医师处诊治，谓是“消渴证”服药无效。

诊查：发育正常，营养尚可。面赤，唇红，舌质干被有微黄薄苔。头、胸、上肢蒸蒸然汗出，哭声宏亮，呼吸微促，体温39.2℃，白血球96000，嗜中性20%，淋巴球78%。指纹浮紫，据此见证，乃阳明燥热引起的“热中”。治宜辛甘而凉，直清其热，方用白虎汤加人参汤加桔梗5克，蚕茧3克。每天一剂，嘱服5天。

6月30号二诊，服药后热仍持续未退，但夜间则发热稍低，口渴减轻，尿量亦少，体温39℃，原方加竹叶2克，麦冬3克。

7月4日三诊，病情均见减轻，体温37.6℃，惟食纳不加，予原方加鸡内金3克，炒薏米2克，服5剂而痊。

郭振球：小儿发热口渴尿

多证50例临床观察，《上海中医药》，1959年7期

案三，岑××，男，46岁，初诊日期：1974年1月13日。

素患夜间盗汗，全身尽湿。两个月前体检发现血糖175毫克%，尿糖（++++），证见两胁窜痛，手足心热，夜间盗汗，口干思饮，大便偏溏，纳食差，皮肤瘙痒，脉沉弦细，舌红，证属阴虚生热，气阴两伤，方用丹栀逍遥散加减。方药：

生黄芪 山药 苍术 元参 石斛各15克 太子参 花粉各30克 生地 熟地各15克 芡实米 知母 黄柏 乌梅各9克 天冬 麦冬各9克 枸杞子12克 10剂。

二诊：服药后，诸证均减，口不太干，饮食减少。只觉腿软无力，唇色暗，舌胖，苔白，脉缓，前方去石斛 乌梅 枸杞子 知母 黄柏，加五味子9克 功劳叶12克，10剂。

三诊：服药后，疲乏好转，“三消”症状全减，仍控制饮食，原方继服10剂。

四诊，又服30剂，诸证显好，空腹尿糖阴性。但因饮白酒一斤，次日空腹尿糖（++），口干思饮，大便溏，苔白，脉滑，方药：

生黄芪 苍术 元参 太子参各15克 山药12克 五味子9克 金樱子6克 天冬 麦冬各9克 生地 熟地各15克 肉桂3克 10剂。

五诊：服药后尿糖转为阴性，血糖为100毫克%，三消症状消失，改服丸药（即上方加四倍量，研末，山药打糊为

丸，如梧桐子大，饭后服6克）。患者服药一料后，血糖，尿糖正常，已不控制饮食。

祝谌予：对糖尿病的治疗体会，

《新医药杂志》，1976年5期

【分析】

案一为三焦热甚，日久耗伤气阴所致三消。治疗在益气生津的基础上略加清热之品，不益气生津则无以制邪热，不清火则气阴无由以生。故用红参、党参、枸杞子、菟丝子益气；用熟地、玄参、当归、二冬、乌梅、花粉养阴生津；用川连、泽泻、石膏清热泻火，仅四个月，便获显效。上案以泻火为主，本案以扶正为主。治疗侧重点不同。

案二为上消，因大热耗伤气阴，阳明气分热盛，故渴饮无度，小便频多，治用白虎加参汤，两益气阴，清无形之邪热。继以原方加麦冬、竹叶养阴；鸡内金、炒苡仁健脾胃而获效。《伤寒论》曰：“伤寒若吐若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。”此证与此条若合符节。患儿本为伤寒误治不解，邪热入里而致。可见读透仲景之书，乃知白虎不独为中喝所设也。

案三为肝经郁热，耗伤气阴，而致消渴。肝热先犯脾胃，故使脾气不足，便溏纳差。肝经郁热未清，故皮肤瘙痒，两肋窜疼。郁热耗伤阴液，故有盗汗，五心烦热，治宜舒肝开郁，滋阴健脾。方用丹苑逍遥散去姜、薄，加麦冬、五味滋阴；龙骨、牡蛎平肝潜阳；黄芪、山药补脾；麦芽既可开胃，又能升发肝郁。二诊加重滋阴药量，并以肉桂3克反佐诸寒凉药，终获良效。祝谌予氏为当今治疗消渴名家，

他善于用张锡纯氏玉液汤（生黄芪、生山药、生鸡内金、知母、葛根、五味、花粉）及滋脾饮（生箭芪、生山药、大生地、生猪胰子，净莼肉）化裁治疗各种消渴病。并且善用生芪、生山药，苍术、玄参等对药配伍，确属经验之谈。消渴至今仍为临床一大难证，正如喻嘉言所说：“消渴之患，常始于微而成于著，始于胃而极于肺肾。”这确示人们，应从饮食养生角度防微杜渐，月晕知风，础润知雨。不宜高粱酒色，奉养太过。而治疗则以中焦为重心，无论上消下消，皆起自中焦，因脾胃先伤，不能运转，则不能输精于上焦，上源不足则难于施雨露于下，下源告竭，则无力蒸腾于上。三焦互为因果，恶性循环，因而致病既缓，愈病亦难。

（十五）惊悸、怔忡

【概说】

临床所见，惊悸较轻，多为阵发性心慌、心跳，身体一般情况尚好，不发作时无甚不适。而怔忡较重，稍劳即心慌，心跳气短乏力，全身一般情况较差。但惊悸往往发展为怔忡，二者关系密切，常相提并论。

本病总由心神不宁而致，导致心神不宁的原因多见心气虚、心阳虚、心血虚，心阴虚心肾不交，痰热上扰，饮邪上泛，瘀血阻络等诸种。

心阳气不足者，心悸气短，动则加剧，脉细弱结代，兼有神疲乏力，自汗形寒等。宜养心汤、保元汤、参附汤等，振奋心阳，收敛心神。《伤寒论》的桂枝甘草龙骨牡蛎汤临床效果也很好。

心阴血不足者，心悸健忘，失眠多梦，常兼舌淡脉细或五心烦热，潮热盗汗等证，宜补心丹、归脾汤等滋补营血，

安神定惊。

心肾不交者，虚烦不眠，心悸健忘，头晕耳鸣，梦遗潮热盗汗，腰膝酸软等，宜黄连阿胶汤、交泰丸、朱砂安神丸、补心丹等滋阴潜阳，交通心肾。

痰火上扰者，常口苦呕恶，头晕目眩，惊悸烦躁，失眠多梦，胸痞苔腻，宜清化痰热，安神养心，黄连温胆汤，礞石滚痰丸等皆可选用。

饮邪上犯者，常因脾肾阳虚、不能温化，水饮内停，上凌于心，多见心悸怔忡，脘痞吐涎、形寒肢冷，下肢浮肿等，宜苓桂术甘汤、真武汤等温阳化饮。

淤血内阻者，心悸怔忡，心前区发作性闷痛刺痛，疼时唇甲紫青，牵引左臂后背作疼，脉涩结代，舌暗有淤斑，严重的暴疼昏厥。宜枳实薤白桂枝汤、通窍活血汤、桃仁红花煎等温通经脉，活血化淤。

【选案】

案一，心悸，初以惊恐得之，后来习以为常，经年不愈，手振舌糙，脉芤带滑，不耐烦劳，此系心血本虚，痰涎袭入也。

人参 元参 丹参 枣仁 天冬 麦冬 菖蒲 茯苓
茯神 当归 远志 五味 桔梗 半夏 生地 橘红 枳壳
柏仁 炙草 竹茹

《柳选四家医案·曹仁伯医案》

案二，五液下亏，二火上炽，水不济火，阴不配阳，缘昔年过服克伐之剂，胃阴受伤，致见怔忡、惊悸等证。自服滋心之剂，本是合理，然治上者必求其下，滋苗者必固其根，心为致病之标，肾为发病之本，不必治心，当专补肾。

熟地 山药 萸肉 归身 五味 麋角胶为丸。

《清代名医医案精华·王九峰医案》

案三，朱××，男，24岁，未婚，农民。住院号1190。因三个月来，心悸烦躁，神志恍惚，夜寝不安，于1964年6月15日急诊入院。

病史摘要：于三个月前路遇病尸受惊，当夜即肢体违和，焦燥烘热（但体温不超过正常），心惊肉跳，夜寝不安，甚至彻夜不眠，继而常觉头晕目眩，心神恍惚，胸闷烦躁，筋肠肉跳，时或肢体麻冷，颤动汗出，肤下如蚁行，少腹拘急，脘腹动悸，举阳遗精（甚则日夜连续数次），全身软弱无力。曾经某某医院诊治，给服大量镇静剂无效。近2个月来，上述诸证增剧，卧床不起，既往身体健康，无病史可循。

诊治经过：入院时……经西医检查诊断，神经官能症（焦虑症）。中医辨证：患者禀性沉默，起病始于惊恐，又因病久不愈，而忧虑日增，致肝气郁结，胆气不宁，心悸烦躁，夜寝不安，入睡则惊梦纷纭，遗精频作，小便短赤，大便秘结。诊得舌质紫暗，苔厚糙，根心白腻，脉弦数。综合病情，此由惊恐伤肾，抑郁伤肝，相火妄动，肾阴被灼，而成水火不济之局。病属惊悸。治法，先泻其有余，以解郁泻火宁神。处方：

柴胡 黄芩 龙胆草各6克 生大黄 姜半夏各9克
龙骨 牡蛎各30克 茯苓 泽泻各12克 枳实 瓜蒌各9克

连服5剂，夜寝较稳，二便得调。仍宗原方去大黄，加礞石滚痰丸9克吞服。

连服6剂，诸恙轻减，又从原方去礞石滚痰丸，加白金

丸9克吞服。

连服6剂，神情渐振，诸恙向安。乃从前方去黄芩、龙胆草，合杞菊地黄丸加减调治。住院33天，痊愈出院，一个月后追访，已如常人参加劳动。

钱元龙：柴胡加龙骨牡蛎汤临床应用的探讨，《江苏中医》1965年7期

【分析】

案一为心阴血不足，心神不守而致心悸。血虚不濡经脉，故手为之振。血虚必有虚火，故舌干而糙。脉芤者，阴血虚弱。脉滑者，痰涎内生。故治宜养血安神，少佐化痰。以人参归脾汤为主方加菖蒲、半夏、竹茹等化痰安神，加天麦冬、五味子等专益心阴。

案二为心肾不交，肾阴下乏，心火上炎而致心悸。定惊必求其本，安神必养肾阴，因云：专事补肾，不必治心。以六味地黄加滋阴药，增一味鹿角胶，取阳中求阴之意。可谓辨证准确，竟以不治之治而获效。

案三为惊恐伤心。病始于惊恐，忧虑不解肝胆不舒，郁久化火，灼伤肝肾之阴。阴虚则肝火愈炽，火炽则肾阴愈亏。况火炼津液，必生痰热，更加痰火扰心，惊悸难平。故急治其标，以柴胡加龙骨牡蛎汤方加减，即仿龙胆泻肝汤合温胆汤方之意，清肝火，涤痰热，安心神，五剂即睡安。二诊稍加礞石滚痰丸再清痰热。三治加白金丸（白矾、郁金），涤痰安神，诸证悉平，标热已清，终以杞菊地黄丸调治肝肾之阴而痊。《伤寒论》云：“伤寒八九日，下之胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。”已明确

指出，此汤可治少阳病因肝胆不利而致的虚实夹杂，表里互现，兼有痰饮烦惊之证。恰如此案用和解肝胆，兼以化饮安神之治法。日本学者报导，以此汤治疗精神病、癫痫屡获良效。

（十六）头痛

【概说】

头痛是以主证命名的证候，可出现于多种急慢性疾病之中。头痛之因多端，但不外乎内伤，外感两大类。临床只把内科杂病中，以头痛为主要症状者做为头痛证来论治。如属于某些疾病过程中所出现的兼证，病去当自愈，不做头痛证看待。属内伤头痛者，又分为虚实两类。虚证不外气血阴阳亏损。实证有痰湿、火热、淤血、积滞等不同原因而引起头痛。虚痛者，头绵绵而痛，遇劳更甚，心悸怔忡，身疲乏力，以补血、补气或气血双补之剂调养；有肾精不足，髓海空虚而头痛者，头脑空疼，兼腰酸腿软，耳鸣失眠，当以补肾为主；如肝肾阴虚，肝阳上亢者，属虚中挟实，又当以天麻钩藤饮与杞菊地黄丸等滋阴潜阳。实证者，有肝火上炎，当以当归龙荟、龙胆泻肝之类清泻肝火；有痰浊上泛，头痛昏蒙，当以半夏白术天麻汤、二陈汤等化痰降浊；有淤血阻络者，头痛如刺，痛处不移，经久不愈者，又当以王清任之通窍活血汤加减治疗。

头为诸阳之会，五脏六腑之精华皆上会于此，若能参合经脉循行部位加以判断，亦有利于治疗。大抵太阳经头痛，多在头后部，牵连颈项；阳明经头痛，多在前额及眉棱骨等处；少阳经头痛，在头之两侧，多连及耳部，厥阴经头痛，多在巅顶部位，或连于目系。

头痛是临床常见的证候，但多兼见于其它疾病的过程中，因此必须详查全身情况，做出准确诊断，以免“头痛医头，脚疼医脚”之谓。

【选案】

案一，×××夫人，41岁，印尼人。婚后已二十年，初次妊娠为左侧宫外孕，手术治疗后，始终未能受孕，经检查诊为，手术后左侧输卵管阻塞，月经来潮时左侧头面作痛，两乳发胀，此等症候已有多多年，经治不愈，平时白带不多，舌正常，脉弦细有力，尺脉带涩象，眼睑下晦暗。

辨证：肝郁气滞夹热，治法：调肝解郁，

方药：丹栀逍遥散加减。

柴胡3克 白芍6克 茯苓6克 甘草1.5克 当归6克
白术4.5克 生姜3克 丹皮4.5克 黑栀子6克 青皮3克
薄荷1克 陈皮3克 半夏4.5克 黄连3克 香附6克

服上方6剂，此后经期无头痛。经血亦畅，量中等。除左脉稍滑大外，无其它异常，嘱照此方，于下次来潮前再服3剂，以巩固后效。

《岳美中医案集》

案二，黄××，男，45岁。

先患太阳头痛，渐至全部头痛，凡祛风散寒温补之剂，无不尝试，历医十余人，经时五六岁，病仍依然，遂置不问。近来上午头觉隐隐微痛，午后则痛如锥如刺，经脉突起，热敷可少安，然无如之何。诊脉弦涩，而症状则如昔。本病午后痛剧，晚尤剧，热则略减，是血虚扶瘀之证。盖头为诸阳之会，贼风久客，淤塞经隧，与气相搏，遏而为痛。即古人痛久入络之义。所以前投温补凉泻之药，皆非所宜，

而祛陈寒、疏经络实为要着。初用金匱桂苓丸以治之，数剂亦不效。乃思及王清任善于治血者，方多奇中，因改用通窍活血汤：

川芎4.5克 桃仁红花各6克 赤芍9克 老葱6克
生姜3片 大枣3枚 麝香0.15克（后冲） 归尾 牛膝各9克

连服3剂，头痛顿减，是淤血化行，已著微效。前方赅进2剂，痛遂全止。如是知风邪之首犯头经，若不及时宣发，则经络淤闭，又非疏解温通所能已。故今以祛淤疏络获效。然病无定型，治当随证而变，若拘拘一格，陋矣！

赵守真《治验回忆录》

案三，刘某，男，54岁，干部，于1979年6月30日初诊，患者素体肥胖，有高血压病史，经常反复头疼。近一月来，头痛且胀，逐渐加剧，呻吟不已，伴微恶寒发热，口不做渴，胸闷脘痞，食欲不振，尿清便溏等证。初投川芎茶调散祛风散寒无效，乃从辨病着眼，改用建瓴汤加减，詎知服后头痛反见加剧，迁延月余，屡治罔效。尔后，细查患者面色淡黄而垢，神倦嗜睡，苔白腻，脉弦缓。证属湿浊头疼，予雷氏芳香化浊法加减。处方：

藿香 佩兰 大腹皮 羌活 川芎 厚朴各6克 陈皮
半夏 茯苓 白芷 蔓荆子各10克

服3剂后，头痛大减，精神清爽。继服五剂，头痛若失，诸恙悉平。半年后随访，头痛未再复发。

杜勉之：雷氏芳香化浊法的
临床辨证鉴别运用，《中医
杂志》1982年7期

【分析】

案一为肝经郁热，循经上攻，致左侧头面作疼。郁热耗伤肝血，故月经来潮，血海空虚头疼更甚。兼见两乳发胀，脉弦细带涩、知肝郁未舒。治宜舒肝理气，以丹栀逍遥散加青陈皮、半夏理气开郁；加黄连清热，一方而月经通畅，头痛随除。

案二为新感未愈，邪气渐渐入络，寒凝血淤而头痛。午后痛剧如锥刺，知淤血不去，新血不生，血虚使然。热敷少安者，寒客血脉所致，血脉者，喜温而恶寒，寒则涩不能通，温则消而去之。用疏风之剂，重伤阴血；温补之剂，燥热耗阴，皆非所宜。《金匱》桂枝茯苓丸方（桂枝 茯苓 芍药 丹皮 桃仁），活血祛淤则可。去陈寒通经络则差，仍未获效。正如叶氏所云：“新病在经，久病入络。”王清任云：“查患头痛者，无表证、无里证、无气虚，无痰饮等证，忽犯忽好，百方不效，用此方一剂而愈。”此证五六年不愈，两脉弦涩，足见血络淤滞。因用通窍活血汤原方加归尾、牛膝取血府逐淤汤之意，加重活血效果。牛膝又善引气血下行。赤芍、桃仁、红花、川芎活血祛淤；老葱，姜枣温宣阳气；麝香芳香走窜，善通血络，用在诸活血化淤药之上，能促使淤血化解；用于诸温阳药之中，能使久淤经络的沉寒宣散。三剂甫咽，数年之顽疾，便药到病除，颇发人深思。

案三为湿痰上阻清窍而致头疼，患者素体肥胖，值暑湿天气，头痛发作，兼胸痞脘闷，便溏纳差，显系痰湿停积，中焦枢机不利，湿浊上蒙清窍。因有恶寒发热，故前医误认为风寒外束，以川芎茶调外散之，更伤表阳，恶寒安能骤

去？此恶寒由湿邪阻遏阳气，不能宣发而致。发热由痰浊久郁化热而生。再医反以张锡纯氏之建瓴汤（生怀山药 怀牛膝 生赭石 生龙牡 生地 生杭芍）滋阴熄风，凉药柔腻，助湿恋邪，服后益增其病。故以雷氏芳香化浊法加减：藿佩、白芷、蔓荆子、羌活芳香化浊，且消头目，亦取风药胜湿之意；大腹皮、茯苓治湿必利小便；半夏、陈皮，厚朴温运中焦，宣通气机；再加川芎穿经走络，使湿浊以三焦而化，仅八剂汤药，便使精神清爽，诸恙悉平，佩服之余，亦值得玩味。

（十七）眩晕

【概说】

眩晕一证，《内经》以为诸风掉眩，皆属于肝。而金元诸家则认为，无虚不作眩；无痰不作眩；无火不作眩。

验之于临床，多以虚实两类论治：阳虚之晕，多由饥饱劳倦，大吐大下，汗多之阳而来。其状晨起眩晕，活动即好，日以为常，头面喜温，常以布包手按。以脾阳虚为主者，常兼见腹胀便溏，食欲不振等证，当以补中益气汤、六君子汤等温中健脾，宣发阳气；以肾阳虚为主者，又当以金匱肾气丸、景岳右归丸等补益元阳。阴虚之晕，多由妇人产后，金疮失血而来，其状以日晡眩晕，得卧稍定为特征。应以地黄丸、四物汤之类补肝肾之阴；阴阳俱虚之晕，抬头则天旋地转，眼常冒黑花，甚则视一为二。宜阴阳俱补，方用秘旨正元散为适宜。其鹿茸一味，治阳虚眩晕，往往有捷效。

实证之眩晕，固于肝火、肝风者，宜清火熄风，以天麻钩藤饮加减为最有效；因于痰饮上泛而作晕者，有各种

不同。热痰用温胆汤加黄芩、栀子清热化痰；风痰宜青州白丸、大秦艽汤加减驱风化痰；寒痰用三子养亲汤温阳化痰；燥痰宜清燥救肺汤、百合固金汤润燥化痰；湿痰宜苓桂术甘汤、苓桂姜甘汤、二陈汤之类燥湿化痰。

眩晕之症，临床所见，实证少而虚证多，下虚上实者，更屡见不鲜。下虚者总因气与血；上实者无非风、火、痰。下虚为本，上实为标。治则应以治本为主，辅以治标。

【选案】

案一，曾治皇城峪一煤矿工人，痰火内发，动风上扰，证见头目眩晕，舌蹇难言，血压升高，面红如醉，痰涎壅盛，脉弦滑且数，舌黄腻而厚。遂用：

竹茹15克 胆星10克 半夏10克 黄连10克 胆草10克
羚羊角粉1克 橘红10克 天麻10克 钩藤10克 牛膝10克
益母草10克 茯苓10克服3剂头晕轻而欲睡，谈说变易。视其舌苔变薄，乃于前方又加白芍12克、当归10克，减去羚羊、胆草服6剂，而逐渐康复。

《肝病证治概要》

案二，水不涵木，则肝风熄动，水不制火，则心阳独亢，以致晕眩。经云：“诸风掉眩，皆属于肝。”然病即称肝与心，则病本在肾。先宜平肝宁心，继当滋养真阴。

羚羊角 麦冬 茯神 枣仁 远志 柏子霜 龟板 泡菊 生地

《清代名医医案精华·何书田医案》

案三，李××，男，57岁，已婚，干部。1961年4月17日初诊。

从1952年起头晕，当时头晕较剧，如立舟车，感觉周围

环境转动，呕吐，血压低，耳鸣如蝉声。于1953年、1957年亦同样发作过。西医检查有耳内平衡失调，为美尼尔氏综合征。近两月来头昏头晕，不能久看书，稍久则头晕头痛加重，胃部不适，有欲吐之感。并有摇晃欲倒，食纳减退，体重亦减，常暖气，矢气多，大便正常，晚间皮肤发痒，西医认为是荨麻疹。影响睡眠，恶梦多，小便稍频，有少许痰，有时脱肛，脉弦细无力，舌淡无苔。根据脉证认为属中虚脾弱挟痰，兼心气不足，治宜先益中气，调脾胃，佐以宁心理痰，用补中益气汤加味。处方：

炙黄芪12克 党参6克 柴胡2.4克 升麻2.4克 白术6克 当归4.5克 陈皮4.5克 炙甘草3克 茯神6克 炒远志3克 法半夏6克 生姜8片 大枣3枚 服5剂，隔天1剂。

5月12日二诊，服药后诸证均见轻。由于看报稍久，六天前又失眠严重，经某医院诊治，给予镇静剂后稍好，但大便有时燥。近日二便尚调，脉迟滑，舌正中心苔薄黄腻，似有食滞之象，仍宜调和脾胃，健强中气兼消胃滞，原方黄芪改为6克，加枣仁6克，焦山楂3克，服3剂。

5月31日三诊：服上药后自觉很见效，食欲及睡眠好转，二便调，精神佳，看书写字能较前久些，但超过二小时就觉烦躁及头部发紧，小便正常，脉虚，舌正无苔，改用心、脾、肝并调，以丸剂缓治。

补中益气丸240克，每早服6克；归脾丸240克，每晚服6克。感冒时停服。药后头晕失眠等证基本消失。

《蒲辅周医案》

【分析】

案一为痰热上攻，引动肝风，所致眩晕。面红如醉，脉弦滑数，舌苔黄厚腻，痰涎壅盛为辨证之要点。初诊即以黄连温胆汤加羚羊、钩藤、天麻等平肝熄风，清化痰热。如此之证，已有动风先兆，如不及时治疗，难免中风偏瘫之虞。故治宜急去其标，清火豁痰为首务。叶氏云：此证治有二忌三宜，一忌温燥劫阴，二忌酸涩收敛。一宜痰多必理阳明，二宜扶脾，三宜咸苦甘凉，是其证治大要。

案二为肝肾阴虚，肝阳上亢，水不涵木而眩晕。何氏书案，往往详于病机，略于症状，据此论当知患者眩晕之外，尚兼有多梦失眠，腰膝酸软，脉弦细数，舌质光红，遗精乏力等证。故以麦冬、枣仁、远志、龟板、生地等养肝肾之阴，兼清虚热；以菊花、羚羊清热宁心平肝。临床眩晕以此类证最为常见，应注意标本先后，不可忽视先兆中风症状。

案三为中气不足，清阳不升致晕。患病几年，反复发作，常有胃部不适，食纳不佳，食后胀气，全属脾气不足，运化失常。脾虚则湿痰自生。清阳不升，痰浊上泛则眩晕呕恶。湿痰阻遏阳气宣发，体表肌肤不得柔润，故燥痒不舒。治宜补中益气，理痰安神，以补中益气汤加味消息而愈。观此案又知东垣立无虚不眩之说、实为功垂后世。

（十八）中风

【概说】

据临床所见，中风多是属于本虚标实之证。“本”是指肝肾不足，气血衰少；“标”是指火（肝火上亢、心火暴甚）、痰（风痰，湿痰、热痰上壅）、气（气逆），血（瘀血阻络）等诱因，这几种病变在一定条件下，相互影响，互

相作用而导致中风发病。又根据病位浅深、病情轻重将发病分为中经络与中脏腑两大类。中经络者病位浅，病情轻，一般无神志改变，仅表现为口眼喎邪，语言不利，半身不遂等，大秦苳汤、镇肝熄风汤、天麻钩藤饮皆可随证选用；中脏腑者，病位较深，病情较重，主要表现为神志不清，喎僻不遂，多有发病先兆及后遗症出现，治疗原则又分为闭证、脱证两种。又由于发病诱因不同，闭证分阴阳，因肝阳暴盛，气血上逆，痰火壅盛而发病者，面赤气粗，脉弦滑，苔黄腻，为阳闭，多用至宝丹开闭，再以羚羊角汤治之；因于风挟湿痰上壅而见脉缓苔白腻，四肢不温，面白唇暗者为阴闭，宜以苏合香丸开闭，再以涤痰丸治之。脱证是因元气衰微，阴阳离绝所致。可见昏厥肢冷，汗多不止，二便自遗，肢软舌痿脉微，当以参附回阳救脱后，再以法治之。

风、癱、瘖、膈为临床四大难证。中风往往发病急暴，常留下难以治愈的后遗症，使患者失去生活自理的能力，因此防患于未然很重要。临床可根据患者平素常有头晕失眠等症状，分别其因痰甚、火旺、气逆、血淤给予及时治疗，如发现手指麻木，眩晕加重等中风先兆，更宜当机立断，予药物预防。平素应薄滋味、慎起居，节情欲，多运动、使气机条畅、不积湿生痰、增强体质，治之于未中之先。

既中之后，造成后遗症，则应视其何证为主，如半身不遂为主，则视其虚实以补阳还五汤或任应秋氏豨莶至阴汤、豨莶至阳汤治之。如以言语不利为主，当以解语丹加减治之。如以口眼喎邪为主，则应以牵正散加减治之。

临床于发病之时，来不及救治而死之者，亦为数不少，因此本病应引起足够重视。

【选案】

案一，年逾古稀，气阴早衰于未病之先。旧有头疼目疾，今日陡然跌仆成中，舌强不语，人事不省，左手足不用。舌质灰红，脉象尺部沉弱，寸关弦滑而数，按之而劲。良由水亏不能涵木，内风上旋，挟素蕴之痰热，蒙闭清窍，堵塞神明出入之路，致不省人事，痰热阻于廉泉，为舌强不语；风邪横窜经腧，则左手足不用。《金匱》云：风中于经，举重不胜；风中于腑，即不识人。此中经兼中腑之重证也。急似育阴熄风，开窍涤痰，冀望转机为幸。

太麦冬9克 元参6克 羚羊片2.4克（先煎汁冲）
仙半夏6克 川贝6克 天竺黄4.5克 明天麻2.4克 陈胆星2.4克 竹茹4.5克 枳实8克 全瓜蒌12克（切） 嫩钩藤9克（后下） 淡竹沥9克（冲） 生姜汁2滴（冲） 至宝丹1粒（研末化服）

二诊，两投育阴熄风，开窍涤痰之剂，人事渐知，舌强不能言语，左手足不用。脉尺部细弱，寸关弦滑而数，舌灰红，高年营阴亏耗，风自内起。风扰于胃，胃为水谷之海，津液变为痰涎，上阻清窍，横窜经腧，诸恙所由来也。本证阴虚，风熄堪虑。今仿河间地黄饮子加味，滋阴血以熄内风，化痰热而清神明，风静浪平，始可转危为安。

大生地12克 太麦冬6克 川石斛9克 羚羊片1.2克（先煎汁冲） 仙半夏6克 明天麻3克 左牡蛎12克 川贝母9克 陈胆星2.4克 炙远志3克 九节菖蒲2.4克 全栝蒌12克（切） 嫩钩藤9克（后入） 淡竹沥30克（冲服）

《丁甘仁医案》

案二，严某，男，56岁，初诊日期：1975年11月6日。

先患头晕，继即突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，面白唇暗，口角流涎，左半身瘫痪，四肢不温，口眼歪斜，先送县医院救治，不见好转，后又送××县医院扎头皮针。经两日针刺，牙关松动，仍呈半昏迷状态，两侧瞳孔大小不等，对光反射减弱，诊断为脑出血（内囊出血），医院来请会诊，诊其脉浮细而弦，舌淡苔薄，乃阳虚阴盛，闭塞清窍之候。以细辛3克煎汤化开苏合香丸3克灌服，三小时内灌二次，下午三时左右，逐渐清醒，并有饥饿感。随即疏豨豨至阳汤，以治中风的阳虚证。方药：

九制豨豨草30克 黄芪9克 天南星6克 白附子6克
川附片9克 川芎3克 红花6克 细辛1.5克 防风6克
牛膝6克 僵蚕3克 苏木6克

以其阳虚诸证颇著，而又偏于左半身也。连续进本方11剂，约两星期左右，基本恢复正常，惟行动时左侧尚有沉滞感而已。

任应秋：临证点滴，《陕西中医药》1977年2期

案三，钱，偏枯在左，血虚不荣筋骨，内风袭络，脉左缓大。制首乌120克（烘） 枸杞去蒂6克 归身6克（用独枝者去梢） 怀牛膝6克（煎汁） 明天麻6克（面煨） 三角胡麻6克（打碎水洗十次、烘） 甘菊9克（水煎汁） 川石斛12克煎汁 小黑豆衣12克（煎汁），用石膏加蜜丸极细，每服12克滚水下。

《临证指南医案》

【分析】

案一为肝肾阴虚，肝阳化风证。年已七十，气阴衰弱，阴不制阳，肝阳上亢，故已有头痛目疾。偶因跌仆，致气血逆乱，气逆而上，挟痰上涌，遂发为中风重证。人事不省，舌强不语，急宜豁痰开窍，故先以至宝丹一粒，冲服。再以家传肝熄风，豁痰开窍之羚羊角钩藤汤加减与服。二投之后，神清气回，免于死亡。然邪已中脏腑，终于留下舌蹇不语，左手足偏瘫之后遗症，又需视其阴阳虚实，各随证施治。此平素有气血衰弱，肝肾不足，故以地黄饮子加减善后。

案二为阳气素虚，湿痰内盛，继由肝风挟湿痰上涌而发中风。面白唇暗，四肢不温，舌淡苔薄，本虚之象；口眼歪邪，左半身偏瘫，昏迷不醒，乃中风阴闭证。急以细辛三克煎汤辛温开散，苏合香丸3克芳香开窍，可急救开闭。待苏醒后再用豨莶至阳汤治之。豨莶至阳汤（九制豨莶草 黄芪 天南星 白附子 川附片 川芎 红花 细辛 防风 牛膝 僵蚕 苏木）及豨莶至阴汤，乃任应秋教授，积五十余年临床经验自制治中风阳闭、阴闭证的有效之方。其中重用豨莶草，功能祛风除湿，善治麻痹、风瘫；又能活血、开郁，以之治中风，一举而三善，风、湿、血兼治。《活人方汇编》有豨莶散；《张氏医通》有豨莶丸；《方脉正宗》亦设有豨莶丸；《养生经验合集》中列有豨桐丸，皆以之为主药治疗中风偏瘫及足痿痹证。

案三为血虚生内风。以方测证，当知患者平素阴血不足，肝失所养则内燥由生，致虚风内动。初可为肌肤麻木，振颤，久则铸成偏瘫足痿。治宜滋阴、养血、润燥、平肝熄风。方用归身、枸杞、首乌、牛膝养血补阴；天麻、菊花、石斛柔肝熄风；胡麻滋阴又能润燥；黑豆衣既能补肾阴又利

肾浊。其中尤以石膏一味为丸，凉肝润燥。诸药制法，亦独具心裁。首乌用烘、怀牛膝取汁、天麻面煨，胡麻烧烘等等，皆能使诸药养阴而不柔腻滞邪，凉肝润燥而不过寒伤胃。足可体味名家于临证，深思熟虑、寝馈岐黄之甘若。

（十九）癫痫

【概说】

癫痫是与先天遗传因素有关的疾病。有的从儿童时患起，至成年不愈。亦有后天得之者。临床分发作期与间歇期来论治。

发作期常有先兆，患者觉头痛眩晕，胸闷、乏力，继则发病，轻型病人突然中断活动，呆木无知，眼睛上窜，移时复元；重型的突然仆倒，叫号声如豕羊，昏厥抽搐，口吐白沫，移时苏醒，对发作情况一无所知。有间歇数日、数月，甚至一年、几年一发者，有一日一发或一日数发者。发作时间亦有历数秒，数分至数小时之不同。间歇期常有痰浊内停诸证。

治疗原则，发作期当以治标为主，急宜熄风定痫，因此定痫丸、三痫丸皆为临床常用。

间歇期以调理脏腑为主。“痰”是本病发作的重要原因，因此健脾化痰，清心化痰，补益肝肾，豁痰定痫等为常用手法。《古今医案按》主张“颠狂多实，痫证多虚”，《金匱要略》用风引汤治大人、小儿惊痫证；日本汉医学者近年研究《伤寒论》柴胡汤加龙骨牡蛎治癫痫有特效，皆足资临床参考。

需要特别提起注意的是，中医认为癫与痫并非一种疾患。“癫”又称疯癫，病无宿根，也不是发作性病，西医称

之为精神疾患。“痫”有宿根，呈反复发作型，西医称之为神经疾患，现在称为“癫痫”，证治需从祖国医学的痫证中求之。

痫证反复发作日久，必神疲乏力，饮食欠佳，眩晕便溏，体质变差，又当以健脾温中，补益气血治之。

【选案】

案一，何××，男，13岁，1977年11月25日，门诊脑系科初诊。

癫痫三年，前二年约间隔二至三月大发作一次，近一年次数加多，特别是近三个月最长间隔三天发作。近十天每天发作1～3次。发作后头疼嗜睡，全身无力，长时间服苯妥英钠及鲁米那，近十余天自动停服苯妥英钠，单服鲁米那0.015克，每日3次。

诊查患儿精神不振，答问比较迟缓。自述夜眠不实、有时被喉中痰液塞醒，舌质红、苔白腻，脉沉弦。

辨证：心肝热盛，发为痫证，拟清心平肝，化痰止痫。

处方：抗痫灵84丸，一日3次，一次服4丸。西药鲁米那原量继续服用。

12月2日复诊，近四天来癫痫发作两次，程度轻，时间短，仍继续给服上药二周。

12月16日复诊，癫痫未发作将近两周，一般情况较好，夜间很少被痰堵醒。再开原药两周。

12月30日复诊，癫痫未发作将近一月，一般情况好，暂停鲁米那，继续开抗痫灵两周。

1978年1月13日复诊：癫痫仍未发作，开给抗痫灵续服一月观察。

《何世英儿科医案》

案二，谢××，男，22岁，1963年4月16日初诊。

据诉幼时曾患“脑膜炎”。18岁忽患癫痫证。发时周身抖战，不省人事，良久始醒。以后渐发渐重，或几日一作，或日三二发。发作时浑身麻木，仆地，不省人事，全身僵直，向右侧抽搐，口吐涎沫，喉间痰鸣如猪羊叫，时有遗尿。半年未参加劳动，终日由其老母伴随，以防不测。当时面潮红、头晕、便秘，时欲吐，自觉畏风烘热。脉弦数，舌尖红苔中腻。用温胆汤加珍珠母、龙齿、龙胆草，地龙等。服三剂后，舌苔稍薄，呕吐减，余证如前，改用柴胡加龙骨牡蛎汤：

党参 龙骨 茯苓各9克 柴胡 桂枝 黄芩 大黄各4.5克 半夏6克 牡蛎12克 甘草 广皮各3克 生姜3片 大枣3枚

连服3剂，三天内仅发一次，发时症状减轻，再以原方去桂枝、广皮，加全蝎、大黄各1.5克，明矾2.4克。

连服十余剂，第三次来诊时，距七八里不需伴随。据述半月来仅发一次，症状又此前减轻三分之二。再以原方加减续服十余剂，三个月后随访，知已参加劳动，停药后仅因过疲疲劳发作两次，而发作时仅目直视，微抽筋，几分钟即已。

钱元龙：柴胡加龙骨牡蛎汤临床应用的探讨，《江苏中医》1965年3期

案三，1978年孟春，于门诊看一抽风病人，自述患病数年，于多处医院神经科治疗罔效。

省其病因，数年前在约七米高电线杆作业时坠下，昏迷数小时，癫痫由此而作（西医诊为外伤性癫痫）。每日傍晚六时许，必大发作一次、从未间断。除具有癫痫症状之四肢抽、昏迷、口吐白沫、二便失禁外，兼有严重的恐惧感，自述疑幻身后有人跟踪，日落不敢出门，严重失眠，头痛健忘，精神疲惫不堪，异常痛苦，几丧失治愈信心，视其面部发青，表情呆滞，舌正苔白，脉细。

余据其发病原因属外伤，面带青色，发时神志不清，口吐白沫，故予通窍活血，涤痰安神法。投以清脑复神液，每次25毫升，日服3次。服至700毫升时，癫痫发作时间规律打破，持续时间亦明显缩短；累积服至1000毫升时，夜能安眠，头痛减除；服至2500毫升时，癫痫竟停止发作，面转红润，疑心幻觉等病情症状皆消失，与治前对比，判若两人。

《医论医话绘要·赵金铎医案》

【分析】

案一为宿有积痰，又因心肝火旺，热痰上壅而发病。以何世英教授自制抗痫灵丸与服，清火平肝，化痰止痛。抗痫灵丸方（天竺黄9克 胆南星9克 僵蚕9克 白附子4.7克 全虫3克 钩藤9克 白矾1.6克 郁金4.7克 青礞石9克 煅磁石31克 朱砂1.6克 半夏9克 菊花9克 灰沉香1.6克 龙胆草3克 竹沥15.6克 神曲15.6克 紫石英18.8克 牛黄0.6克 羚羊角粉0.6克 蜜丸，每丸1.6克重。）

案二痫证继发于热病之后。高热抽搐，肝肾大伤，郁热不去，炼液为痰，痰火上壅，遂发病。初诊一派痰热之象，故以温胆汤祛痰清火，加珍珠母、地龙、龙齿平熄肝风，龙

胆草泻肝热。继以柴胡加龙骨牡蛎汤和解肝胆，化饮安神。上两案治痫，皆用明矾（枯矾）。枯矾善祛痰治痫，《医宗金鉴》稀涎千缗汤治风痰昏迷；《杂兴方》化痰丸，以生矾为主药治痫，足证此药抗痫有灵。

案三为继发于外伤后发病，外伤暴骤，使淤血阻络，气血逆乱，脾运失常，痰湿内生，故治疗宜通窍活血，涤痰安神，以王齐南教授自制清脑复神液（系通窍活血汤、温胆汤、酸枣仁汤等方，加野山参、生晒园植参、鹿茸、蜂王浆等填精补髓扶正之品所组成，制以白酒冷浸，浸后蒸馏回收白酒而制得）治愈。此方能扶正驱邪，攻补兼施、化淤涤痰，并行不悖。尤其是贵重药材野山参、鹿茸、蜂王浆，对于发作频繁，正气不支之证，确有疗效。

（二十）痹证

【概说】

痹证以筋骨、肌肉、关节等处的疼痛，酸楚、沉重、麻木及关节肿大，活动受限为特征。因为致病因素不同多分为风寒湿痹、热痹及血痹来论治。风寒湿三气常杂合而致病，以风气甚者，因其性善行数变，故疼痛游走不定，称为行痹，宜祛风止痛，以防风汤主治；寒气重者，其性凝滞，疼痛常较剧烈，甚则为锥刺刀割，称为痛痹，宜温阳蠲痹，以乌头汤主治；湿气重者，其性粘着，疼痛常有固定部位，伴有麻木沉重感，称为着痹，宜治湿宣痹，以薏苡仁汤主治。热痹因寒湿侵犯经络所致，发病较急，常关节灼热，游走疼痛，局部红肿，活动受限，伴有全身发热恶寒，咽喉肿痛等症状，临床主要应当辨别是湿重于热，热重于湿，分类施治。热重于湿者，常选用白虎加桂枝汤、《千金》犀角汤；

湿重于热者，又宜二妙丸加味主之。亦有因诸痹迁延不愈，病邪深入经络，以致气血凝滞，淤血内阻，关节肿大、变形有淤斑者，呈顽固疼痛，并伴有全身淤血内停的症状，又宜化淤活血，以身疼逐淤汤加减治疗。

血痹与风寒湿所致痹证不同，以肌肉麻痹无痛者为特征，多因气血虚弱，不养肌肉而致，又宜养血行痹，以《金匱》黄芪桂枝五物汤治之。

痹证常因体质偏于阳气虚弱，因此治疗方面常用温通经脉，气化助阳为佐治法。《金匱要略·中风历节篇》桂枝芍药知母汤治湿热痹；防己地黄汤治风痹。“血痹虚劳篇”的黄芪桂枝五物汤治血痹等皆有良效。今人印会河教授以身疼逐淤汤治疗淤血痹阻，关节疼痛亦多见显效。

【选案】

案一，赵××，男，52岁。患类风湿关节炎五年，手足指（趾）漫肿变形，疼痛夜甚。初起时，串痛不定，近二年由于腰疼不能俯仰，肢端强硬等因素，已不能上班工作，严重时不能下炕活动。历经某医院中西医药治疗罔效。久用肾上腺皮质激素类药，亦渐转失灵，故由单位派人护送来京就医。余根据其初有串痛，后转定痛，漫肿变形等情况，加上舌红苔黄厚腻，确定为风热挟湿为痹，病久入络，因而出此等证情。遂按以祛风燥湿、逐淤通络之法，以身疼逐汤加青黛6克、木瓜12克、苡仁30克、草薢15克、豨莶草15克、老鹳草15克、乌蛇30克治之（外加三蛇酒送药）。服5剂，病人自觉身痛明显减轻，关节肿大亦退，于是停服“激素”，但用中药治疗。留京观察半月，觉身痛日轻，自能忍受，不需再用西药缓痛。由于家在外地，不便久留京都，故乃携带

原方，回原籍继续服用。两月后来信，谓病情日趋恢复，已自料理生活。余嘱以效不更方，仍守原方共服汤药七个月（每日一剂）外加三蛇酒送药，共用去20瓶左右，其病乃基本痊愈。后因公出差东北，路过首都，乃便道进行复诊。患者身痛，关节变形等均已消失，健步不减平人。自谓早已全日上班工作，仅于阴雨连绵时的夜间，出现右膝及左手食指、掌关节等处，轻度疼痛而已。余仍守原方。令其二至三日服一剂，冀收除恶务尽之效，今又四年矣，病情未闻出现反复。

印会河《中医内科新论》

案二，友人何镜澄之爱人，体弱瘦小，气血不充，又加操劳过渡，风湿乘虚袭入经隧，关节强直麻痹。窃风湿成痹，证属常有，但脉象乖异、参伍不调，十余至或二十余至一止。数急兼涩，在似促、似结之间，诊查多次，脉均如是。痹证羁延，久而不愈，皮肉消脱，肌肤少泽、肘腕、胫膝和手足关节硬肿突起，隐约显红色，疼痛不能按摩。盖寒已化热，湿已化燥，风燥风热相搏。拟方养血润液，沃燥撤热，柔筋通络，侧重清通而不用温通，甚至再加苦寒。方用：

当归须 桑寄生各9克 牛膝12克 地龙9克 青木香9克 鲜石菖蒲3克 山萸肉 地骨皮各9克 鳖甲12克（代犀、羚角用） 胡黄连2.4克 一星期小效，二星期痹痛显著缓解，四星期已愈其半，两月痊愈。

《冉雪峰医案》

案三，赵××，女，34岁，初诊日期：1975年7月。

半月前因洗衣被等物30余件，劳累出汗，当天晚上卧床

后，即觉右肘至肩部沉重，麻木、怕冷，酸痛，尤以肩部疼痛较甚，次日右上肢抬举困难、活动受限，入夜疼甚。望之患者痛苦病容，面色晄白少华，脉沉细无力，舌淡白而润。右臂欠温。

辨证：寒湿侵伤，血行不畅，阳气痹阻而至血痹。

治法：温阳行痹。

方药：黄芪桂枝五物汤加味。

黄芪30克 桂枝9克 白芍9克 生姜15克 大枣10枚
姜黄12克 羌活6克 5剂

复诊：右臂麻木沉重大减，但怕冷仍如前。且肩疼仍甚，脉沉细，舌苔白润，原方加制附片9克，嘱服5剂。

三诊：臂已不麻，肩部酸痛，抬肩举臂自如，但仍怕冷、沉重，脉舌如前，原方加苡仁15克、蚕砂12克，以增除湿之功，嘱服5剂，四诊时病已痊愈。

《窦伯清医案》

【分析】

案一为湿热兼淤血痹。初病在经，久病入络，两年以来，湿热未去，留滞血脉，淤血阻络，故湿热淤血久稽不退，使关节肿胀变形。治疗以身疼逐淤汤加青黛清热，木瓜柔肝宣痹；苡仁渗湿；萆薢、豨薟草、乌蛇祛风逐痰，流湿蠲痹。老鸛草即五叶草，《滇南本草》云其治筋骨疼痛，手足筋挛；《纲目拾遗》云其治痹证，通络脉。印会河教授善于用活血祛淤方法治痹证，身疼逐淤汤为其喜用之方，其临证善于用大方重剂，以治疗顽痰怪病，往往取其效。似此案乌蛇30克，且一方到底，四年以来，利用活血祛淤，散风除湿之法，竟使变形之关节完全复元。可谓有胆有识，大剂中

病。“有故无殒亦无殒也”，信然乎！

案二为湿热兼阴虚痹，因风湿久留，化热伤阴，湿热阻络，血运不利，故脉呈涩而结代；又因有湿热未去，时亦迫促血脉，又似促脉之形。据此脉象可知正虚而邪实。治疗宜养阴润燥，清热祛湿。但养阴之药难免滞湿留邪，祛湿之药亦会温燥伤阴，故云：养血润液，侧重清通而不用温通。方中归须、寄生、山萸肉平补肝肾之阴；鳖甲、黄连、地骨皮消热坚阴；牛膝、地龙祛风止疼；木香、菖蒲芳香走窜，一以宣通气机，一以引药行散全身。故两月而全愈。由此可见，名家手眼，确是不凡。

案三为血痹。《内经》云：“卧出而风吹之，血凝于肤者为痹。”此面色少华，脉沉细无力，舌淡白，显系气血不足。又伤于疲劳汗出，风邪乘虚而入经络，故麻木沉重，且有疼痛，正如《金匱》所说：“重因疲劳汗出，卧不时动摇，加被微风，遂得之。”“如风痹状”。治疗宜调和营卫气血，温阳行痹。用黄芪桂枝五物汤两和气血，加姜黄活血行气，通经止痛，加羌活辛温、外散风寒之邪。药证合拍，一诊即麻木沉重大减。二诊加制附片温通经脉，重在止痛。三诊加薏仁、蚕砂，重在行气祛湿，四诊便告痊愈。古方新用，疗效卓著。

（二十一）痿证

【概说】

痿证是指肢体筋脉迟缓、软弱无力，日久不能随意运动，日渐肌肉痿缩的一种病证。以下肢痿弱为多见，有“痿蹙”之称。现代医学的多发性神经炎、急性脊髓炎、进行性肌萎缩、重症肌无力、肌营养不良、癱病性瘫痪、小儿麻痹

后遗证等多种软瘫，皆可参考痿证辨证治疗。

临床分为四种证型施治：一，肺热伤津型，病多起自发热，热退后突然肢体软弱无力，兼心烦口渴，便秘尿赤，舌红苔黄等。治宜清热润燥、益肺生津。以清燥救肺汤，益胃汤为常用。二，湿热侵淫型，病多由于湿邪侵渍肌肤，见肢体困重，痿软无力，或兼微肿麻木，以下肢多发。兼发热，胸脘痞闷，小便涩痛赤热，苔黄腻，脉濡数等。治宜清热利湿。以加味二妙散为常用。三，脾胃虚寒型，多因脾胃虚弱，化源不足，筋脉失养所致。见肢体痿软，逐渐加重。兼食少便溏，神疲乏力，舌淡苔白等。治宜健脾益气，强壮筋骨。以参苓白术散加减为常用。四，肝肾亏虚型，因肝肾亏虚，精血不能濡养筋骨经脉所致，见病起缓慢，下肢痿软无力，腰脊酸软。兼眩晕耳鸣，失眠、遗精、遗尿、月经不调等。治宜候益肝肾，滋阴清热。以虎潜丸方加减为常用。

临床上，痿证与痹证必须做鉴别诊断，痹以疼痛为主证，而痿则以肢体软弱、痿废不用为主证。治痿还需分清虚实，凡温邪、湿邪初起为实；久病痿弱，脾胃虚损、肝肾不足属虚。本病的治疗，《内经》指出：“治痿独取阳明”，因此在临床上特别应该重视调理脾胃一则。

【选案】

案一，×××，女，30余岁，1966年秋，病已半截，经多个医院检查均诊断为重症肌无力，治疗未效。初诊：面色苍白，且无表情，目胞均垂，不能睁开，少气懒言，挣扎半晌才说出一句话，语声低微，当面询问听不清晰。倦怠乏力，举动艰难，稍一行动，须人扶持。每餐不到50克，却需一小时余，吃吃歇歇，再吃再歇，咀嚼馒头、面条，好象嚼着硬

质食物一样，吃不到两口，牙关酸困，即无力续嚼，有时把一口馒头，或一口汤水，咽到半截，也要暂时休息才能继续下咽。月经延期，量少色淡。脉虚弱，舌淡苔薄。证属脾虚，中气不足，拟升阳补气法。方药：

生黄芪24克 当归身9克 炙甘草9克 土白术12克 陈皮6克 干姜6克 党参15克 升麻6克 柴胡6克 水煎服，1日1剂，连服4剂。

复诊，服4剂后，倦怠稍减，余证如旧，嘱再服4剂。

三诊：服4剂后，除胞垂须用手上推，目才可睁，过2～3分钟，又复垂闭外，其余各证，均已明显好转，嘱再服4剂。

四诊，又服4剂后，二目开合自如，但久睁尚有乏困感，他证基本消失。嘱将原方减半，续服几剂，以资巩固。

五诊，续服六天，各症均失。

杨作樸《临证录》

案二，琴川小东门王姓，年约十七八，素有滑泄遗精，两足痿弱，背驼腰屈，两手扶杖而行，皮枯肉削。彼云我有湿气，已服三妙汤数十剂，罔效。余曰：瘦人以湿为宝，有湿则肥，无湿则瘦，观其两腿，大肉日削，诊脉两尺细软，

《难经》曰：下损于上，一损又损于肾，痿不能起于床。精不足者，补之以味，损其肾者，益其精。如再进苦燥利湿，阴分愈利愈虚，两足不能起矣。”进以六味地黄汤加虎骨、龟板、鹿筋、苁蓉大剂，填下滋阴，服十余剂，两足稍健。再将前方加鱼线胶、鹿角霜等，服十余剂，另服虎潜丸，每日15克，两足肌肉渐充，步履安稳也。云习医已三年矣。余即劝其改业，不必习此小道。夫医之一业，功少过多，利小

任重，有生计者，不必习之。

《中国医药汇海·余听鸿医案》

案三，伏热留于肺胃，胃热则消谷易饥，肺热则痿痿难行。热气熏于胸中，故内热不已，延今半载，节届春分，天气暴热，病加不寐。据述先前舌苔黄黑，今则舌心干红，阴更伤，仿仲景意用甘寒法。

生地 知母 茯神 枣仁 麦冬 滑石 夜合花 沙参 百合 泉水煎服。

天气下降则清明，地气下降则晦塞，上焦下行，下脘不通，胸膈痹痛，法当先治肺经，肺主一身之气，气化则胃开进食矣。

瓜蒌 郁金 杏仁 苏梗 橘络 川贝 薤白 半夏 茯苓 佛手露 枇杷叶

《中国医药汇海·赵海仙医案》

【分析】

案一为脾胃虚弱型痿证。《内经》有五痿，全身筋脉肌肉痿软不用，即属“肉痿”。西医诊断为“重症肌无力”之证，是有家族遗传史的，预后不良的疾患。中医用“痿证”理论辨证施治，此证属于脾气虚弱，以补中益气汤加干姜6克，服药二十余剂，获如此疗效原眼部、口部、咽喉、舌头等处肌肉筋脉皆痿弱无力，咽一口水，喉部肌肉即不能支持等证，基本完全恢复，对此，确应引起科研工作的重视。

案二为肝肾不足型痿证。因平素滑泄遗精，相火妄动，耗伤阴精，精血不足，筋骨肌肉失去营养，故两腿大肉日削，背驼腰屈，两腿痿软，扶杖而行。本应滋阴降火，补益肝肾。因自通医，迷信湿热成痿之说，竟服三妙汤（《医宗金

鉴》方，苍术 黄柏 槟榔）数十剂，燥湿耗阴，以至病情愈重。以六味地黄汤加虎骨、龟板、鹿筋、鱼线胶、鹿角胶等血肉有情之品，填补精髓，另服虎潜丸壮腰健肾，清泄相火，服药数十剂始有起色。案末的几句医话，患者习医三年，竟以医自误，对于庸医亦不无讽刺。

案三为肺热阴伤型痿证。先因热病，热退后伏热留于肺胃，耗伤肺胃津液，虚火内生，火扰心神，故不寐；胃阴大伤，则舌心干红。只述两证、却画龙点睛，治则宜甘寒濡润。仲景有竹叶石膏汤，治热伤津液，余热未清，故云仿仲景法。用知母、滑石清泻余热；用生地、麦冬、沙参、百合养阴生津；茯神、枣仁、夜合花养心安神。共奏清泻伏热，养阴生津之效。

二、妇 科 医 案

（一）月经不调

【概说】

月经病为妇科常见病，是以月经的经期、量、色、质异常及伴随月经周期所出现的症状为特征的疾病。常见有月经不调、痛经、闭经、崩漏、月经前后诸证、经断前后诸证等。

月经病的治疗原则，重在调经治本。先病而后月经不调者，当先治病，病去经自调；经不调而后病者，当先调经，经调则病自除。此外，亦应按标本缓急的治疗原则，如痛经剧烈，血崩暴下等当先治标。论治脏腑，则有固肾、扶脾、调肝、补冲任等不同。又有理气、补血、祛瘀、破结等诸多

治法，皆因证而异。

月经不调是月经的周期与经量出现异常，如月经先期，月经后期，月经先后无定期，行经期延长，月经过多，经量过少等等。

月经先期指经期提前七天以上，以至一月两潮者。多因血分有热和气虚不固所致。血分有热者，一般量多色紫。其中血分热甚，迫血妄行者为实热，宜用《付青主女科》清经散清热凉血；阴虚血热者，宜用《付青主女科》两地汤养阴清热；肝郁化热者，则用丹栀逍遥散舒肝清热。属气虚者，呈量多色淡质清稀，可用归脾汤补气养血。

月经后期是经期退后七天以上，甚至四五十天一至的。亦有虚实之分。实证多因气滞，月经量少，色暗有血块，宜用《医宗金鉴》加味乌药汤开郁行气，活血调经；虚证多因血虚、血寒。血虚者，宜人参养荣汤补血兼益气；血寒者，有寒邪凝滞不通，当用温经汤温通经脉；若阳气不足，阴寒凝滞者，又宜《景岳全书》大营煎扶阳温经散寒。

月经先后无定期（经期紊乱）主要因气血不调，冲任功能紊乱所致。而冲任与肝肾关系最密切。若因肝郁气滞者，宜逍遥散加减，舒肝理气，养血调经；若因肾虚，则宜《景岳全书》固阴煎补肾气、调冲任。

经期延长，具指月经周期基本正常，每次行经时间延至七天以上，甚至淋漓不尽，达半月之久，多因气虚，血虚所致。气虚者宜归脾汤；血热者，宜《妇人良方大全》固经丸滋阴养血，清热敛营。

月经过多是指月经周期正常，而月经血量明显增多者。

主要因气虚血热而致。气虚者，宜《景岳全书》举元煎补气摄血，升阳举陷；血热者，则用《景岳全书》保阴煎清热凉血。

月经过少是指周期基本正常，而月经血量明显减少或行经时间缩短，或点滴即净，亦有虚实之分。实证由于血瘀，可用桃红四物汤活血祛瘀；虚证由于血虚肾虚，血虚者，宜用《产宝百问》益气养血；肾虚者，则以《景岳全书》当归地黄饮滋补肝肾，养血调经。

总之舒肝、理气、健脾、运湿、补肾、温阳、祛瘀等内科治法亦为治经所习用。何子淮总结有治经十法。曰：疏理、理气、平肝、温里、化湿、益气、补养、化瘀、清邪、健脾可备临床选用。

一般说来，月经先期多热，后期多寒，调理月经周期，能使妇女正常排卵，常可达到治疗不孕的目的，因而月经病与不孕证是临床密切相关的两个病证。

【选案】

案一，周，心脾两亏。经行先期，心悸寐少，舌心光剥，脉息细数，气分亦怯，养血毋庸重滋。

人参须1.5克 牡蛎30克 天冬4.5克 大白芍9克 大麦冬6克 龙齿9克 杜仲12克 生甘草1.2克 柏子仁9克 五味子9粒 青蒿6克 生谷芽15克 炒枣仁9克

周又诊，叠进养血安神，颇合病机，诸恙皆轻，拟守前法。

生洋参4.5克 龙齿15克 柏子仁9克 生白芍6克 大麦冬6克 钩藤9克 枣仁9克 生甘草0.9克 青蒿3克 谷芽9克 鲜藕节30克 白荷花露30克

《珍本医书集成·华韵楼医案》

案二，冯女，43岁，七月，乌镇。情志抑郁，肝失疏泄，月经数月一行，量少色紫，年余于兹。自觉少腹有块不时攻痛，面色黯滞，肌肤甲错，舌紫，脉象弦滑。气滞血淤，任脉为病，治拟舒肝理气，活血行淤。

处方：抵挡丸6克（分二次吞） 丹参 生苡仁 泽泻各15克 小青皮4.5克 云茯苓12克 广木香2.4克 白芍4.5克 制香附6克 小茴2.4克 当归9克 郁金 白术各4.5克 桑海螵蛸各9克

二诊：前方服后，少腹攻痛不若前甚，而月经仍然未行，脉象弦滑，舌紫，仍守原方出入。

处方：抵挡丸6克（分二次服） 丹参15克 木香2.4克（拌炒） 白芍 炒川芎各4.5克 川楝子9克 郁金4.5克 小茴2.4克 制香附6克 桑海螵蛸9克

三诊：昨日月经来临，量多色紫，挟有血块，少腹之痛已除，肌肤甲错如前，再拟养血调经。

处方：炒当归9克 制香附6克 炙川芎3克 炒丹参15克 炒白芍9克 益母草9克 藏红花3克 云茯苓12克 郁金6克 炒川楝子9克 青皮4.5克

患者由情志抑郁，气滞血淤，而致月经不调，数月一行，且腹内有块攻痛、系有形之物为症瘕之类。用攻坚破积之法，淤去则经水通行。

《叶熙春医案》

案三，苏联医学专家某女同志，任某医院内科主任，体颇丰健。自近年患经事愆期以来，常三个月来经血一次，头脑晕闷，心膈微痛感，上下肢时或麻痹，不安寐，自为治

疗，一切状况均好，惟经事仍不准期。遂来中医研究院门诊部诊查，一则实地研究我国医学，二则商讨治疗问题。予诊得脉动数中带有涩象，动则阴伤，数则为热（前此经色过赤，即是血热象征），滞涩为热壅气滞，经隧痹阻（此即血分有热，经事不提前而反趱后的原因）。惟其血热，所以有头晕、胸痹、腹胀、不安寐等现象；惟其热壅，所以有肢节麻痹、颜面烘热等现象，拟方养血宁心，通络导滞，半调半疏，亦清亦和。药用：全当归 杭白芍各15克 云茯神12克 酸枣仁9克 威灵仙 元胡索 刺蒺藜 泽兰叶 青木香 各9克 甘草3克 次月，经事趱近（前为三月始至此为四十日始至，量多、潮期比较正常，头晕、胸痹、腹疼胀，不安寐轻减，但仍存在。拟方：全当归 杭白芍 云茯神各12克 川芎 泽兰叶 生蒲黄 玄胡索 金铃子 各9克 甘草3克 再下月，经事按月一月而至，头晕、胸痹、腹胀、不安寐等现象逐渐向愈，拟方：

全当归 杭白芍各12克 川芎9克 云茯神 酸枣仁 各12克 元胡索 金铃子 泽兰叶 桑寄生各9克 甘草8克 缓调。后回国时，来我处辞谢，并赠影印名人画像数张，情意恳挚。便中复诊，为拟归脾丸缓调善后。查调经为妇科常有证，特普通经事不调多虚证，此为实证，经趱后多寒证，此为热证，治疗共历三个月，第二月即效著，第三月向愈，颇顺利速效。

《冉雪峰医案》

案四，冯妇，年21岁。脉两关沉细而数，肝阴，脾阴均有湿热蒸炽，故血虚而燥，经来或前或后，带下极多、面黄唇燥，若不急为调治，恐成骨蒸重证，先用加味逍遥散。原

生地 当归身 白芍 黑山栀 炒丹皮 生牡蛎 白术 炙草 银柴胡 鲜石斛

次诊：天癸超前而至，不能畅行，脉见两关虚滑，总由肝脾两亏之故。趁此少用调经之法，俾气疏血和，最为合宜。

归身 白芍 川芎 泽兰叶 延胡 楂肉炭 炒山栀 炒丹皮 川通草 川郁金 艾叶

三诊：脉见两关细数，经行不畅，唇干皮茧，营分不充，脾有虚热，再用养营清脾一法。

炒丹参 全当归 泽兰叶 川石斛 茯苓 炒山药 通草 柏子仁 炙草 合欢皮

四诊：脉象渐有流利之势，经行颇畅，唇色也渐有润意，再用养营滋阴一法，可以多服。

酒炒生地 当归身 炒白芍 山药 茯苓 钗石斛 柏子仁 炙草 合欢皮

五诊：脉气渐和，带亦渐少，面色唇色皆有润泽之意。再照前方加肥玉竹、白薇、川萆薢。

六诊：阴分虽有和意，仍嫌血燥欠润，可以稍进滋补矣。

原生地 当归身 阿胶 白芍 炙龟板 川石斛 山药 玉竹 柏子仁 白薇 川萆薢 茯神 加合欢皮煎汤代水。

七诊：阴分渐有和意，带下未净，再进滋补数服，可以丸药调补矣。

生地 熟地 归身 白芍 阿胶 炙龟板 牡蛎 川石斛 白薇 川萆薢 茯神 麦冬 加合欢皮煎汤带水。

丸方：生地 砂仁 炒熟地 川石斛各120克 天冬 制

陈皮各45克 麦冬 白芍 白薇 川萆薢 蛤粉炒阿胶 四制香附各60克 当归 茯神 淮山药 沙苑子 蛤粉炒线鱼膘 煅白螺壳 煅牡蛎各90克 党参120克 炙甘草15克 上药制末，先用金针菜500克，合欢皮250克，熬浓汁，去渣，另加炼蜜为丸，桐子大，每空心淡盐水送12克

《女科医案选粹·顾晓兰医案》

案五，廖××，38岁。

初诊：1976年3月22日，月经先后无定期，周期23至37天，12天始净，量多，色黑红夹有白带，且有血块，经期少腹胀痛，腰疼。末次月经于2月19日来潮，12天净，平时脚背作痛，少腹左侧胀疼，带多，色黄气秽，大便干结，舌苔薄黄腻，中剥边尖刺，脉象细软。病因由于脾气弱，肝气逆，肾阴虚，治以建脾疏肝益肾，佐以化淤止血。

处方：党参12克 茯苓12克 山药12克 旋复花6克(包) 地黄15克 生白芍12克 生牡蛎30克 昆布12克 贯众15克 佛手6克六剂。

另：三七末18克，如经行量多，早晚各加服1.5克，开水送下。

二诊：4月9日，月经于3月23日来潮，经量明显减少，少腹及腰部隐痛，平时带下仍多，色黄气秽，面浮目肿，气短胸痛，足根胀痛，大便偏干，2~3日一行，舌苔淡黄中剥，脉象细软，仍从前法，兼清下焦湿热。

处方：党参12克 茯苓12克 山药12克 黄柏6克 知母9克 昆布12克 海藻12克 旋复花6克(包) 川断12克 贯众12克 六剂。

三诊：4月16日，服上方后，诸恙均见减轻，现在经

前，神疲乏力，舌苔黄中剥，脉象细软，治以补气养阴，兼顾冲任。

处方：党参12克 麦冬9克 生地15克 白芍9克 阿胶珠12克 生牡蛎30克 川断12克 桑寄生15克 贯众15克 椿根皮12克 9剂。

四诊：5月3日，服上方九剂，月经于4月20日来潮，四天净，量中等，色转正常，下腹痛减。此次经期感冒，头痛，胸背隐痛，食后腹胀，晨起下肢作胀，舌质绛，中微剥，边尖刺，脉左细右软，目前感冒未净，先祛风清热，兼调肝脾。

处方：桑叶9克 薄荷6克 枳壳6克 桔梗6克 生甘草6克 茯苓12克 扁豆9克 橘皮6克 木香6克 旋复花6克（包）3剂。

《钱伯煊医案》

案六，王女，38岁，经行半月未止，量多色殷，午后潮热，掌心如灼，心悸头晕，夜寐不安，口干心烦，足跟隐痛，脉来虚数，舌红中有裂纹。肝肾之阴不足，虚火内扰，冲任失固，治拟固经汤化裁。

处方：炒白芍6克 黄柏炭3克 醋炙香附6克 炙槲皮9克 炙龟板15克 炒黄芩6克 侧柏炭 地榆 炭各9克 仙鹤草30克 生地炭15克 地骨皮12克

二诊：经漏已止，心悸头晕减轻，夜寐较安。治以前方去侧柏、地榆、仙鹤草，加旱莲、女贞子，续服6剂。

《叶熙春医案》

【分析】

案一为月经先期。因心脾两亏，气血不足，血虚则有虚热，故脉象细数；气血不足，心神不安，又有心悸寐少；脾

气不足，胃阴受损，兼舌中心光剥无苔。气虚不固，经行先期，治宜补心脾，补气养血。但此案养血的目的是在补心健脾，而不是滋补阴血为主，故云“养血毋庸重滋”，处方不拘成法，以二冬、五味子、白芍敛阴；以枣仁、柏子仁、牡蛎、龙齿养心安神；杜仲兼顾冲任；谷芽升发胃气；青蒿清血虚之热；少量人参兼顾气血。一诊即诸恙皆轻。再诊稍加重滋阴凉血药比重，以方测证，二诊当有心慌脉数，口干欲饮等见证。一般经期提前多热，错后多寒，此案虽属气血虚，亦有血热证象，治疗宜补血清热，两兼顾之。

案二为月经后期。肝气淤滞，久则血行不畅，气血淤结于少腹，故少腹有块，不时攻痛。淤血阻络，新血不生，故肌肤甲错，宜活血化淤，舒肝理气。方用逍遥散加减，以抵当丸攻逐淤血；丹参、白芍、当归活血敛阴；木香、青皮、郁金、香附、小茴香行气舒肝。桑螵蛸一味，《本经》说可治疝瘕、女子血闭腰痛，故用以帮助攻逐郁血。二诊后淤血得下，月经来潮，此由淤血阻滞，月经不调，症瘕去月经自调。大毒治病，十去其七，后以养血调经药善后。

案三月经后期为血热壅滞，经脉不利所致。案中病机分析十分明白，本案较为特殊，一般月经后期多寒，而此案则为血热；一般多虚，而此则为实证。故治疗亦不寻常法，处方通络导滞，兼调兼疏。以延胡、刺蒺藜、泽兰叶，活血调血；威灵仙理气通络；枣仁茯神、白芍，当归养血安神，药虽平常，然运用得当，三月即向愈。

案四为经期紊乱。肝血不足，阴虚发热所致。阴血不足则月经后期，而虚热迫血妄行又月经先期，故使经期紊乱，治用加味逍遥散养血疏肝，加生地养阴血；换柴胡为银柴胡

清虚热，加石斛以助清热，牡蛎一味，《别录》云其能治虚热来去不定，故用以助清热养阴。

一诊以清热为主，二诊、三诊重在活血养血，四诊、五诊活血与滋养掺半，六诊以后专事滋补。前后七诊，有方善守，其中加减变化，可以基本说明治妇女月事不调的初、中、末三法。

案五为肝气郁滞，而脾营不足。营血虚弱，气滞血淤月经后期，而阴虚有热则月经先期，故先后无定期。处方以舒肝健脾，敛阴化淤，并施不悖。钱老为当今妇科专家，此案舒肝未用柴胡，而以旋复花、佛手清轻施之；化淤未用桃仁，而以贯众、昆布、牡蛎入血软坚施之。另加参苓补中，三七活血。二诊守方不变，随证加用清下焦湿热之知柏。三诊守上方略加补气养阴。桑寄生，川续断为钱老贯用对药，其平补肝肾，两和气血，故调经上带，皆可常用之。

案六为阴虚火旺，行经延长。肝肾之阴亏，虚火内扰，冲任不固，故经漏不止，方用固经汤，其中白芍、生地滋阴养血，龟板坚阴，椿根皮、地骨皮，黄柏清相火，再加侧柏，仙鹤草、地榆炒炭止血，龟板一味，叶天士善于用来滋养任脉，治妇科诸疾，任脉总一身之阴，龟板至阴之物，最能坚阴润燥清热去火。椿根皮善燥下焦湿热，专治妇人崩经带下，故《妇人大全良方》固经汤首选之。凡属肝肾阴虚、下焦相火，迫血妄行的经量过多及行经期延长，固经汤皆为好药。

（二）闭经

【概说】

闭经有原发性与继发性两种，前者是女子十八岁以上月经仍未初潮，后者是指月经已来潮又中断三月以上并非妊娠

者。临床分虚实两类论治。实证多因气滞血瘀或痰湿凝滞。虚证则多因脾虚、肾虚或气血虚。亦有生理异常，终生无月经仍可生育的叫暗经。有的虽无月经，但按月有乳胀、鼻衄等现象称为倒经，皆不属闭经之例。

实证闭经，当以通经为主。其中因气滞血瘀而致闭经者，当以血府逐瘀汤理气活血祛瘀；因痰湿阻滞，经络不通者，用《叶天士女科》苍附导痰丸燥湿祛痰，活络通经。虚证闭经，应以补气养血为治。其肝肾阴虚、血少经闭者，常以《景岳全书》归肾丸方加龟板、阿胶、鸡血藤滋补肝肾、养血调经；其脾气不足，气血虚热者，当以八珍汤、归脾汤扶土益气，养血调经。

【选案】

案一，毕×，41岁，已婚、干部，病历号182737。

初诊：1972年7月12日，主诉闭经二十年。于二十年前，足月分娩时，流血过多，后即闭经、行人工周期治疗，患糖尿病、高血压病，四年前发现垂体瘤，采用放射治疗一月余，同年停人工周期，月经不行。今年四月份始感乳房胀痛，并有周期性乳头流血现象，约三十天一次，每次持续七至八天，末次乳头出血为5月14日，六天净。胁痛腹疼，咽干口苦口渴，潮热汗多，手足心觉热，头晕头痛，腰疼溲多，尿糖（+++）。今因外感，咳嗽痰多，咽干且痛，舌苔薄白，质红，脉象细弦，病因由于肝肾阴虚，风热袭肺，先以祛风宣肺，清热化痰。

处方：桑叶9克 桔梗6克 生甘草8克 杏仁2克 土贝母12克 旋复花9克(包) 橘皮6克 竹茹9克 香橼皮6克 元参9克 8剂。

二诊：7月26日，外感已减，余如前，乳头流血未作，月经仍闭，舌苔薄白根腻，脉象小软微数，治再养阴清热，理气调经。

处方：生地12克 麦冬9克 丹皮9克 赤白芍各9克 桔梗6克 当归9克 生牡蛎15克 旋复花9克(包)柴胡6克 8剂。

三诊：8月10日，月经未至，乳房胀痛，口渴咽干，汗多，舌苔淡黄腻，根垢尖刺，脉细软微数，年久经闭，当重于治本，故以补肝肾，调冲任为法。

处方：生熟地各15克 白芍12克 山药12克 五味子9克 丹皮9克 当归12克 生龙牡各15克 丹参9克 沙苑子9克 旋复花9克(包) 8剂。

之后，根据上方加减，连服24剂。

四诊：10月24日，月经于10月21日来潮，今日未净，量中，色红，经前乳房胀，乳头痛，少腹刺痛，尿糖(++)，舌苔黄腻根垢，脉象沉细，拟再疏脉益肾为治。

处方：制香附6克 川楝子9克 丹皮9克 茯苓9克 山药12克 柏子仁12克 川断12克 桑寄生15克 杞钩子12克 当归9克 10剂。

五诊：12月11日，月经于12月9日来潮量少，色黑，今日未净，余无不适，舌苔薄黄腻，尖红，脉象沉弱，月经已行，但错后量少，此乃气血两虚，冲任失养，再以补气血，调冲任为治。

处方：党参12克 茯苓12克 山药12克 当归12克 白芍9克 丹参12克 柏子仁12克 鸡血藤12克 牛膝9克 益母草12克 8剂。

六诊：1973年1月29日，月经于1月9日应时而来，第三天始多，色鲜红，七天净，经期右少腹疼。现头晕纳差，

血压150/100毫米汞柱，尿糖（++~+++），舌苔薄白腻，脉象沉软，治以建脾和胃，平肝益肾。

处方：黄芪12克 茯苓12克 山药12克 橘皮6克 清半夏9克 泽玛9克 枸杞子12克 菊花9克 牛膝9克 桑寄生15克 8剂。

患者于7月18日来院，自述五月份去上海复查、垂体肿瘤未见增大，近几月来，月经已能自然来潮。

《钱伯煊医案》

案二，吴××，女，35岁，农，初诊：1966年9月11日。

血虚之体，经期四月未行，身体渐次消瘦，腹部作胀，舌少苔淡，脉细，拟养血调经，血海充盈，经水自行。

制香附 炒当归各9克 炒白芍6克 炒川芎4.5克 川红花2.4克 丹参6克 柏子仁（杵）熟地 炒续断 炙海螵蛸、益母草各9克 广皮1.5克 月季花8朵 服3~6剂。

9月18日复诊：药服6剂之后月经已行，行量不少，历四日始净，腹不疼，食纳少，气血久虚，再予调理气血增进食欲，缓图恢复。

党参 炒当归各9克 炒白芍6克 熟地12克（砂仁1.2克拌）炒川芎4.5克 川红花8克 丹参 广皮各4.5克 炒柏子仁 炒续断 炒六曲 炙鸡内金各9克 炒谷芽12克 服4剂。

《方永涛医案》

案三，丹溪治浦江洪宅一妇，病症三日一发，食甚少，经不行已三月，丹溪诊之，两手脉俱无，时当腊月，议作虚寒治。以四物加附子，吴茱萸，神曲为丸，心凝误。次日再诊，见其梳妆无异平时，言语行步，并无倦怠，知果误矣。乃曰：经不行者，非无血也，为痰所凝而不行也，无脉者，非气血衰而脉绝，乃积胃生热，结伏其脉而不见尔。以三花

神佑丸与之。旬日后，食稍进，脉渐出，但代而微弦，症尚未愈，因谓胃气全，春深经血自旺，便可痊愈。不必服药，教以淡滋味节饮食之法。半月而痊愈，经亦行。

《古今医案按》

【分析】

案一为继发性闭经，二十年来未通。前因出血，肝胃阴伤，遂致闭经。经闭不通，使气机停滞，久则肝火上炎，故口干口苦、乳头流血，证虽奇，但机理一也。故仍宜疏肝清热，凉血通经。但以初诊又兼外感，故先治新病，以桑菊加味。二诊感冒已清，当滋阴清热，疏肝通经。方以生地、当归、白芍、麦冬滋阴养血；丹皮、赤芍活血；柴胡、旋复花疏肝理气；牡蛎软坚破结，治乳房胀痛。因经闭20年，肝肾阴枯，无形之阴，难以骤生，故初诊未见动静。次方乃加重滋养肝肾之阴，用生熟地、沙苑子养肾精；白芍、山药、五味、丹皮、当归、丹参养肝血、敛肝阴；生龙牡软坚化结，仍用旋复花降肝气、并引诸药入肝经。连服24四剂，月经终于来潮。后坚持以疏肝益胃、补益气血、健脾和胃出入调理，月经即可自行。此案病证错综复杂，既有消渴，又曾患过肿瘤，肝气久淤化火，肝肾阴亏严重，故治疗始终注意降肝气，滋阴活血。但凉药久服，又恐有败胃之弊，后来处方注意平补肝肾，舒肝降气，照顾脾胃，终于使经闭得通。

案二为气血虚弱，月经闭阻。故以四物汤加香附、陈皮理气活血；加丹参、草红花活血通经；加续断、海螵蛸、益母草、月季花益肝肾、补冲任养血调经。诸药妙用，使阴柔药不致柔腻碍脾，故6剂而经行。再与八珍汤加减调理。

案三为痰热内结阻滞气血，而致停经。此案诊断关键在

于两手脉俱若无。如是虚证，两手脉无，必兼见气短自汗等一派虚弱之象。朱氏便由脉得到启发，按证候看，患疟疾停经三月并无上述虚证，何遽为两手脉无？反复观察之后，方知脉无并非气血大虚，乃为病邪阻碍经络，气血涩滞不能流通所致，与伏脉、牢脉同样意义。闭经也并非气血不足，病邪阻络不得流通同样可以导致。再加患者有发疟一证，“无痰不疟”，故推断为痰热内停，阻滞气血，用刘完素《宣明论方》攻逐痰热的三花神佑丸，方由大戟、芫花、甘遂、大黄、轻粉、牵牛子为丸治愈，此案宛转深思，理法皆妙，周旋不离规矩，并道出误诊原由，颇值得玩味。

（三）痛经

【概说】

痛经的主要见证是经行小腹及腰部疼痛，伴随月经周期而发。一般经前及行经时腹痛多实证，经后痛者多虚证。实证原因有二，一因气滞血瘀、一因寒温凝滞。气滞血瘀者，疼痛伴有乳房胁肋胀痛，月经量少色暗有淤块。胀重于疼为气滞、痛重于胀为血瘀，宜膈下逐瘀汤行气活血，祛瘀止痛；寒温凝滞者，经前、经期少腹冷痛，月经量少，色暗如红豆汁，可用少腹逐瘀汤加苍术、茯苓温经祛湿，通络止痛。虚证多因气血虚弱或肝肾不足。气血虚弱者，经行或经后小腹绵绵作疼，经量少色淡，宜归参建中汤加减补养气血，健脾止疼；肝肾不足者，经后少腹疼痛，腰疼腿酸，头晕耳鸣，则宜付青主的调肝汤调补肝肾。

【选案】

案一，杨××，26岁。

初诊：1976年2月6日，痛经，月经周期24至28天，六

天净，量中等，色正常，有血块，经期少腹疼痛颇剧，腰疼。大便偏稀，日一次，头晕，纳差。末次月经于1月15日来潮，六天净，平时无不适，结婚半年，未怀孕，舌苔白腻中垢，脉象细弦，病因由于寒凝气滞，治以调气温经。

处方：制香附6克 元胡索6克 当归9克 川芎6克
细辛3克 吴茱萸3克 沉香片3克 苏梗6克 乌药6克
小茴香3克 艾叶3克12剂。

二诊：2月16日，服上方12剂，痛经依然，月经于2月13日来潮，量中等，色正常，腹疼腰痛，不能坚持工作，今行经第四天，痛势稍减，舌苔中淡黄，边白腻，脉象沉细，寒气凝结，治以温经散寒，理气止痛。

处方：桂枝6克 赤芍9克 炙甘草6克 生姜6克 细辛3克 吴茱萸3克 制香附6克 青皮6克 乌药6克 6剂。

三诊：3月8日，服上方6剂，末次月经又13日来潮，现月经即将来潮，腰腹不适、腿酸、纳差、舌苔淡黄腻微垢，脉象沉细，治以调气温经，和胃益肾。

处方：柴胡6克 制香附6克 元胡索6克 青皮6克
橘皮6克 吴茱萸3克 川楝子9克 狗脊12克 焦三仙18克
牛膝9克 6剂。

另：肉桂末12克 沉香末12克 琥珀末12克 三味调和
在经行腹痛时加服3克、早晚各1.5克，痛止停服。

《钱伯煊医案》

案二，蔡女。

正值经行，骤逢拂逆，从此经少而少腹胀痛。古人谓木不条达，正对此等证候而言。

全当归9克 白芍9克 丹参9克 柴胡9克 云苓12克
薄荷尖3克（后下） 甘草2.1克 生姜3片

另：五灵脂 香附 莪术 肉桂各6克 研末，每服1.5克。

《章次公医案》

【分析】

案一为寒凝气滞以致痛经。寒凝胞宫，阻碍气血，不通则作痛。便溏，苔白腻。寒湿内阻之象。故温经行气，方以温经汤加减。钱老经验，寒凝疼剧者，加吴茱萸汤温之。本方即以温经汤与吴茱萸汤合方用之。寒凝须阳气不能宣通，故二诊加重理气药物，终以温肾养血，理气止痛取效。全案先温阳，后理气，再补肾，有条不紊，另以肉桂末、琥珀末、沉香末三味调和，经行腹疼时冲服。

案二为肝郁气滞，经行少腹疼，因正逢行经之时，加之心情不畅，遂致气滞血阻，经少而腹胀疼，宜逍遥散煎汤服下，舒肝理气以治本；而气滞血必阻，故又以五灵脂、莪术等研为末冲服，以活血止痛。

（四）崩漏

【概说】

妇女不在行经期间，阴道大量出血或持续下血，淋漓不断者，称为崩漏。一般以突然出血、来势急，血量多的叫崩；来势缓、血量少、淋漓不断的叫漏。在发病过程中，两者常互相转化，经崩不止，出血过多，气血大耗，可致漏经。而经漏不止，日久耗气，亦会成崩。两者有程度轻重不同，病因、病机常常是一致的，故一般崩漏通称。

本病发病机理，虚证由于气血亏虚，肝肾不足，脾虚而

致冲任不固，实证多由郁血内阻，经血不循常道而出，或血热迫血变行所致。

治疗原则，应急则治其标，凡气随血脱，阴阳离绝的，应参附汤回阳救逆；血崩不止，急宜止血敛气，以防暴脱。一般宜针对病机，不能只知固摄止血，反而养邪留患。

虚证者，当补气摄血。其以肾虚为主者，当分阴阳，肾阴虚火旺而致崩漏的，当以左归丸去牛膝加女贞子、旱莲草滋阴固肾止血；肾阳虚不能固摄者，当用右归丸方加减温阳止崩；脾虚为主者，应用《付青主女科》固本止崩汤益气固本，养血止崩；气血虚弱者，当以八珍汤加减双补气血而治之。实证则以凉血祛瘀为治则。其瘀血内阻者，当以四物汤合失笑散加减活血行瘀；其血热妄行者，宜以《简明中医妇科学》清热固经汤，清热凉血，摄血固经。

崩漏当以塞流（急则治标）、澄源（审证求因）、复旧（调整善后）为初、中、末三法，临证应灵活掌握应用。

【选案】

案一，胡××，34岁，已婚。患者月经17岁初潮，即伴有痛经。婚后经期偏早，而延绵日久方停，逐渐形成崩漏而无净期，曾行刮宫，术后量不见减。××医院建议子宫切除，本人不愿而来服中药。诊时，经淋漓已二十余日未停，头眩心宕、腰酸肢楚，内热口燥。望其面色，颧红目肿。切脉芤而带数，舌苔黄腻，平素畏寒，午后潮热，断为阴虚火旺型崩漏。治用壮水制火法。处方：

潞党参 归身 生地 白芍 山萸肉 女贞子 焦白术
青蒿 盐水炒川柏 蒲黄炭 熟川军 陈皮

上服4剂后，淋漓已停，而黄带绵绵，乃用健脾束带，

带下亦减，先后调治一年，经水已趋正常。三年后随访，未有崩漏现象。

《著名中医学术家的学术经验·朱小南医案》

案二，米×，女，54岁。经断三载，近忽患崩症剧，并有血块。心悸、头晕、耳鸣、全身无力，食欲不振。脉虚洪，舌苔黄燥，颜面眇白。因血虚气弱，劳累太过，肝脾不能统藏经血，宜补气血、健脾胃，滋肾阴，升提中气，大剂图之。方用：

大熟地30克 酒当归15克 炒枣仁15克 党参 生芪 炒山药 鹿角霜 山萸 姜炭 炒砂仁 升麻 柴胡 木香 莲子 煎服3剂。

复诊：崩漏白多红少，仍食欲不振，精神萎顿、睡眠不佳。治以滋养心脾、温肾补阴。归脾汤加减。方用：

人参精50滴 炙芪15克 土白术 归身 酒白芍 大熟地 朱茯神 炒远志 炒枣仁 柏子仁 阿胶 川断 龙眼肉 炒山药 炙草 煨姜 焦枣引 4剂。

三诊：红白均止，精神转佳，食欲增。嘱早服补中益气汤，晚服归脾丸，以善其后。

《著名中医学术家的学术经验·刘济民医案》

案三，易思兰治一妇患崩，去血极多，用止血药。崩愈甚、卧床月余，羸瘦食少，面青爪黑。气促痰喘，易诊之，心脉平和，肝脉弦大，时一结，肺脉沉而大且有力，脾胃脉沉涩，两尺沉而无力。曰：“此气郁证也。”询之，果因怒而致，乃用香附，乌药、苏梗为君，抚芎、白芷为臣，当归、白术、神曲、甘草为佐使。服药后，顿觉神爽，诸证减半，举家欣跃，易曰未也，明日子时分，指甲变桃红色，方

可救。至期，甲色果红。又诊之，左三部如前，肺脉微起，脾胃虽沉缓而不涩，两尺照旧，谓其家曰：午时当大崩，毋得惊慌以骇病者。至期，果下紫黑血块数枚，自此遂止。

《古今医案按》

案四，张仲华治一妇，经停三月，骤然崩冲，阅五月而又若漏后，洵系暴崩属虚，虚阳无附，额汗头震、闻声惊惕，多语神烦，脉微虚软，势将二气脱离，其危至速，拟回阳摄阴法，急安其气血。

附子 鹿角霜 杞子炭 熟地 五味子 白芍 人参
龟板 天冬 山药

《中国医药汇海·医案部》

案五，孙××，女，29岁，门诊简易病历。初诊日期：1974年3月2日。

近十年来月经行经日久，每次约持续15~20天，周期也不规律，先后不定（间隔20~70天）。末前经为1月13日至1月28日，末次月经为2月21日，至今未净，量多，色红有血块，伴有头晕，多梦，烦急，胸闷，手足心热，口干。近五个月来曾测基础体温均为单相型，某医院确诊为功能性子宫出血。舌质暗，尖红、脉弦滑。

辨证：阴虚血热、冲任不固。

治法：养阴清热，安冲调经。

方药：青蒿9克 地骨皮9克 黄芩9克 丹皮9克 白芍9克 旱莲草9克 椿根白皮9克 煅牡蛎24克 阿胶15克 侧柏炭9克

治疗经过：3月13日，服药3剂后阴道出血已止，继服3付，于3月23日月经复来潮，行经六天，周期血量恢复正

常，测基础体温示双相型（提示已有排卵）。持久疗效当待观察。

《刘奉伍妇科经验》

【分析】

案一为肾阴虚火旺而致崩漏，久漏伤血，致使肝肾精血受损，相火遂起。火热迫血妄行，经行淋漓而不能止。脉芤而数，午后潮热，全属阴虚火旺。故法用壮水之主，以制阳光。方用归身、生地、白芍、山萸肉、女贞子养阴补肾；参、术、陈皮益气以助生血，固气止崩；青蒿、川柏清下焦相火；蒲黄炭，熟军炭止血固崩。尤以大黄一味，为朱氏治崩之经验，他认为熟军炭用量从3克到4克半有清热凉血，祛瘀导滞的功能，能推陈致新，引血归经，常用于崩漏日久而体质虚弱者往往能应手而效。

案二为气血虚弱，冲任不固所致崩漏。用补脾益肾，益气养血而止崩。方为补中益气汤加减。加熟地、山萸、炮姜、鹿角霜温补肾阳；莲子、木香两益心脾。继以归脾汤补中益气而取效。

案三为肝郁气滞，血行淤阻，不循常道而致崩。面青爪黑，肝脉弦大而时有一结，又伤于恼怒之后，断为肝郁无疑。处方以朱丹溪的越鞠丸方加味，理气开郁，故一服而诸证减半。判断来日子时，阳气初生时，指甲可由紫黑变得红活，说明服药后，淤滞当除，气血通行。淤血去时当又有大崩，去尽紫黑血块，诸证即愈。可见医生辨证清楚，对于一证的发展规律变化，了然胸中，便可做到料事如神。

案四为暴崩阳气虚脱案。因停经后突然大出血，出血后又淋漓不断，以致气随血脱，见额上汗出，多语神烦，闻声

惊惕，脉虚软，一派虚阳外越的重证。急当回阳救脱，固阴止崩。方用参附汤加鹿角霜急救回阳；用熟地、五味子，白芍、天冬，山药养阴敛阳；用龟板坚阴摄阳；杞子炭止血固肾。此属血崩急证，当急救回阳，阳回后自当治本。

案五为阴虚血热，迫血妄行而致崩。固以养阴清虚热的主要治则。丹皮、白芍、阿胶养阴凉血；黄芩、地骨皮、青蒿清虚热；煅牡蛎止血安神；旱莲草、椿根白皮（即樗根皮）、侧柏炭凉血止血。3剂即血止，6剂即显效。可见血崩不仅属虚，通因通用亦是常用治法。

（五）倒经

【概说】

月经来潮前一二天，或正值经行时，出现有规律的吐血或衄血，每伴随月经周期发作，常可导致月经减少或不行，似月经倒行逆上，称为“经行吐衄”，亦称“倒经”或“逆经”。

经行吐衄的发病方理，主要是血热气逆。导致血热妄行的原因，多是肝经郁火与肺肾阴虚两种。因肝经郁火者，经前或经期吐衄，血量多色红，伴有胁胀心烦等肝火症状，宜龙胆泻肝汤加减疏肝清热，引血归经；因肺肾阴虚者，经期与经后吐衄，血量少色暗红，兼见头晕耳鸣，潮热盗汗等阴虚内热症状，当用《付青主女科》顺经汤滋阴润肺，清热凉血。

本病治则，本“热者清之”、“遂者平之”的原则，以清热降逆，引血归经为主，切不可用苦寒，以重伤其阴血。

【选案】

案一，谢女。

经停四月，代偿于口鼻而出，比来腹感胀痛，色脉皆无虚象，可攻。

泽兰叶9克 蓬莪术9克 赤芍9克 川芎6克 王不留行9克 紫丹参9克 桃仁泥12克 当归9克 丹皮9克 粉甘草3克 大黄蟅虫丸12克

《章次公医案》

案二，钟××，20岁，门诊简易病历。

初诊日期：1974年9月16日。

经期鼻衄已六年，于十二岁月经初潮，周期提前十天，量少色黑，行经二天，经期鼻衄，每遇情志影响则衄血量多，有血块，经期烦躁易怒，头晕，平素白带量多，腰疼，舌尖边红，脉弦滑。诊为肝旺血热，逆经倒行，治以平肝清热。方用：

白茅根 藕节各30克 生地15克 丹皮6克 胆草9克 牛膝12克 黄芩9克 枳壳6克 麦冬 栀子各9克

服上方后，10月15日经潮，未见倒经，月经正常，未见腹痛，随访半年余，未见发生倒经现象。

《刘奉伍妇科经验》

案三，马××，16岁，未婚，病历为21238。

初诊：1958年12月2日，初潮15岁，周期尚准，行经11天始净，血量多，色正常，经期腹痛，并常有鼻衄，衄血多时，经血即减少。曾闭经6个月，但每月衄血甚多，末次月经于11月15日来潮，量少，仅2天，经后时感头痛，全身酸软，心中烦热，少腹胀滞，腰疼，纳食尚可，二便正常，舌苔薄白，脉左弦细，右细数弦，病因由于肝火上逆，血热妄行，而致逆经，治以平肝凉血，引血归经。处方：

生地9克 丹皮2克 白芍9克 泽兰6克 黑山栀6克
菊花6克 制香附6克 当归9克 川楝子9克 益母草12克
荆芥炭4.5克 土牛膝6克 3剂。

二诊：12月6日，头疼及腹胀渐减，但仍觉全身酸楚，
疲惫无力，腰疼，食后脘胀，暖气时作，大便溏薄，日四至
五次，舌光，脉细弦数，治以舒肝益肾，健脾运中。处方：

干地黄9克 丹皮6克 白芍9克 泽兰6克 制香附9
克 党参9克 白术9克 茯苓9克 益母草12克 荆芥炭
4.5克 枳壳6克 4剂。

三诊：1959年1月15日，近二月来，月经未至，曾经鼻
衄二至三次，胃脘尚舒，二便正常，舌苔薄白，脉象沉弦，
治以养血清热。

处方：干地黄12克 当归9克 白芍9克 泽兰9克 丹
皮9克 女贞子9克 藕节12克 土牛膝9克 益母草12克
地骨皮9克 6剂。

四诊：1月24日，月经于1月19日来潮，量不多，色黑
无血块，持续三天净，腹部微痛，未有鼻衄，遍体酸痛，舌薄
薄白，脉象细数，治以养血清营，导热下行。处方：

生地12克 当归9克 白芍9克 丹参9克 地骨皮9克
土牛膝6克 茅根15克 藕节12克 4剂。

五诊：1月31日，诸证均减，鼻衄未作，舌洁有刺，脉
细弦数，治以养阴清热。

处方：知柏地黄丸120克，每晚服6克。

《钱伯煊医案》

【分析】

案一为血热上攻而倒经。经停四月，舌脉皆无虚象，至

经期则有腹胀，可知淤血阻于少腹，积而生热，随冲脉上行，则发有衄血。治宜活血祛淤，引血归经。用丹皮、赤芍、川芎、丹参、泽兰，活血凉血；莪术，王不留行，桃仁活血祛淤；当归、甘草合化养阴；再送服大黄蟅虫丸破血通经。临证亦有属血淤生热而倒经者，则不得执肝火之说而徂于一偏。

案二为经期鼻衄，冲脉隶属肝肾，肝藏血而司血海，经行之时，肝气上逆，则挟冲脉而上行，气升血升，便发为衄血，遏情志不舒衄血量增多，经期烦躁易怒，舌尖边红，脉弦滑为肝热血逆无疑，故治以平肝清热，引血归经，方用龙胆泻肝汤加減，因无湿热，去车前子、泽泻等利湿之品，加白茅根、藕节凉血止血；生地、赤芍、丹皮凉血散血；牛膝一味引血归经，一诊肝火得清，而倒逆即顺。

案三亦为肝火上逆，血热妄行而倒经。但其症以经后少腹胀滞，腰疼为重，故加理气之香附、川楝子；又有经后全身酸软，故用当归、白芍养血敛肝；经后头痛，为肝经火热所致，用菊花清肝明目。两方相比，前案火重、药亦重，此案火轻、药亦减轻，可参考学习。

（六）月经异常诸证

【概说】

月经异常证包括月经前后诸证及绝经前后诸证。

月经前后诸证，指经行前后及经期出现的一些全身症状，如头痛头晕，烦躁失眠，发热腹泄等等。一般以经前及经期较为多见。由于人的个体差异较大，再加经行前后人的精神状态，所处环境等情况不一，伴随月经产生的病证就很复杂了。临床必须四诊详察，开阔思路，辨清各证与月经的关系，根据具体情况灵活辨证施治。原则是“补虚泻实”、

“调和气血”、“气以通为主，血以和为贵”。

月经前后诸证的发生，多与肝、脾、肾三脏密切相关。由于肝脾气滞者，宜柴胡疏肝散疏肝理气，活血通络；由于脾肾阳虚者，应用《付青主女科》健固汤温肾健脾；至于血虚肝旺者，则应杞菊地黄丸方加减养阴柔肝。

绝经前后诸证，指妇女在四十九岁左右开始绝经，而有些妇女在绝经前后，往往出现经行紊乱，并伴随月经发生头晕耳鸣，心悸失眠、烦躁易怒，烘热汗出，五心烦热，浮肿便溏，腰酸骨楚，倦怠乏力，情志异常等等。这些证候往往轻重不一，三三两两综合发生，有人可延续二三年之久，称为“绝经前后诸证。”

绝经前后，肾气渐衰，冲任亏虚，天癸将绝，精血不足，因而主要是阴阳平衡失调，肝肾阴虚或肾阳不足导致本证。因肝肾阴亏者，宜左归饮滋阴柔肝，育阴潜阳，由肾阳虚衰者，用右归丸方温肾扶阳。本病治疗原则以补肾气，调冲任为主。用药不宜辛温香燥，重耗津液。此外，宜调情志，节嗜欲，适劳逸，慎起居等配合治疗，并应及时排除其它恶性肿瘤等疾病。

【选案】

案一，韩××，21岁，未婚。

初诊：1974年12月16日，初潮13岁，月经正常，1968年起月经失调，周期1～3个月，6天净，量不多，色淡，行经期间，少腹作痛，突然昏倒，冷汗淋漓，自觉全身下沉感。大小便欲解不得，最近三次昏倒，每发于经前发作后即来潮，现月经1～2个月来一次，6天净，量不多，色淡，经期情绪不宁，急躁欲哭，纳差少寐，大便干结，2～3天一

行，末次月经11月28日来潮，6天净，舌苔淡黄腻质红，脉象沉迟，病因由于血虚肝郁，阳气亢逆，治以养血平肝，调气解郁，处方：

地黄12克 白芍9克 川芎3克 远志6克 合欢皮12克
郁金6克 制香附6克 白薇9克 丹皮9克 鸡血藤12克
6剂。

二诊，12月23日，服上方4剂，情绪较宁纳食增加，舌苔淡黄，质红尖刺，脉细，经期将临，治在养血调气。处方：

地黄15克 当归9克 白芍9克 川芎3克 制香附6克
泽兰12克 甘草6克 鸡血藤12克 丹皮9克 远志6克 牛
膝9克 6剂。

三诊：12月30日，昨晨少腹剧痛，冷汗淋漓，胸痞泛恶，自觉全身下沉无力，但未昏厥，一小时后月经来潮，量不多，色初黑后红，无血块，今日少腹疼止，但觉腰酸，头痛面浮，胃不思纳，大便干结，3日一行，舌苔灰黄垢腻，脉左沉细，右细弦，现值经行，治以舒肝益肾，清热和胃。处方：

地黄15克 当归9克 赤白芍各9克 川楝子9克 丹皮
9克 桔皮6克 竹茹9克 川石斛12克 川断12克 桑寄生
15克 6剂。

四诊，1975年1月3日，末次月经1974年12月29日来潮，五天净，血量较前增多，全身自觉下沉无力，较前减轻，时间亦缩短，大便得畅，神疲乏力，浮肿依然，四肢发冷，胃纳仍差，舌苔薄黄腻，边尖略红，脉左沉细，右细弦，治以健脾和胃为主，兼益肝肾，处方：

党参12克 白术9克 扁豆9克 甘草6克 橘皮6克
山药12克 白芍9克 地黄12克 生谷芽15克 6剂。

五诊：1月10日，服上方五剂，精神较振，胃纳渐增，劳则面浮肢肿，大便干结，三日一行，舌苔薄黄腻，脉沉细微滑，治再益气养阴，佐以清热。处方：

北沙参12克 麦冬9克 玉竹12克 茯苓12克 扁豆9克
花粉12克 知母9克 地黄12克 白芍9克 6剂。

六诊：2月24日，末次月经1月30日来潮，六天净，周期已准，且性情急躁，四肢发凉，冷汗淋漓，全身下沉等症状均已消失，但行经期间，面浮肢肿依然，舌淡黄腻有刺，脉沉细滑，现值经前，治以养血平肝，理气清热。处方：

地黄12克 白芍9克 生龙骨15克 生牡蛎15克 丹皮9克
制香附6克 川楝子9克 青橘皮各6克 牛膝3克
茯苓12克 6剂。

七诊：3月7日，月经于3月2日来潮，三天净，量较前多，色红，少腹稍痛，昏厥未作，浮肿减轻，舌苔薄黄腻，脉细，仍从前法加减。处方：

地黄12克 白芍9克 生龙骨15克 丹皮9克 制香附6克
川楝子9克 鸡血藤12克 茯苓15克 瓜蒌15克 知母9克
6剂，

《钱伯煊医案》

案二，于××，21岁，未婚。1962年2月9日初诊，月经素来超早，每20天一转，经有一年，拖延日期颇长，经行时兼发高热达40℃左右，并有胸满，肋胀，甚至呕吐，热厥。适逢经前，脉弦数，性静寡言，木郁日久易于化火，引起高烧，治以舒肝清热。处方：

柴胡 青陈皮 当归 赤芍 枳壳 制香附 炙甘草
白术 川朴 青蒿 黄芩

二诊：服药时月经来临，效果不显，热势燔盛，口鼻燥热，头目眩晕，将出现热厥之势。乃于上方加钩藤18克（后下），以平肝熄风，并增强清热之功。服二剂后即感头目清凉。随访，每月经来不再发热。

《著名中医学术家的学术经验·朱小南医案》

案三，柳宝诒治一妇，两乳核痛，已属肝气不和之病，此次脘腹撑胀块痛，经行后少腹板滞，酸疼愈剧，营络淤阻，恐其郁久暴崩，拟与通络和淤。

金铃子肉（小茴香煎汁，炒） 延胡索（醋炒） 归尾桃仁
长牛膝（红花酒煎拌炒） 橘络 丝瓜络（乳香酒煎拌炒）
丹参 青广木香（桂枝煎汁拌炒） 益母草 香橡皮 白芍

《柳宝诒医案》

案四，王孟英治赵听樵妹，每汛至则腹胀呕吐，腰脊酸痛，两腿肿痛，筋掣腕痛，甚至痉厥，多药不效，孟英以金铃子散合左金加二陈、竹茹、枳实、桂、苓数剂而愈，用苁蓉、菟丝、淫羊藿、杜仲、桑椹、木瓜、续断，香附、芍归、茴、楝调之，汛至如期，略无痛苦。

《中国医药汇海·医案部》

案五，一寡妇体弱，每逢月事声哑。沈尧封曰：肝肾之络，俱上连肺，精血下注，肺中必枯，故哑。用地黄、天冬、肉苁蓉、归身等大补精血，病反甚。加细辛1.5克。通厥少之络，才入口，声即出，后用八味丸调经，经来不哑。

《古今医案按》

案六，孙东宿治马二尹媳，每月汛行，子户旁则生一肿

毒，胀而不疼，过三五日，以银簪针破，出血脓盖许而消。不必贴膏药而生肉，无疤痕。但汛行即发，或上下左右无定所，第不离子户也，内外科历治数年不效，且致不孕。因询于孙，沉思两日而悟曰：此中焦湿痰、随经水下流，壅于子也，经下而痰凝，故化为脓，原非毒，故不痛。用白螺蛳壳火煨存性为君；南星、半夏为臣；柴胡、甘草为佐，面糊丸，早晚服之，遂愈。

《古今医案按》

案七，牛，每值小溲淋闭，必因经水先期而起，此必有淤热流注膀胱，偶因劳动，肝肾之火内炎，与膀胱淤热相合，有升无降，故上则呕恶不止，下则点滴不通，此病发之情形也。刻下病势暂平，而仍觉气陷溲浊，膀胱之淤热犹恋，将来势必复发。拟方疏利淤热，清调肝肾，务使淤热得清、痛根乃拔。

小生地 赤白茯苓 猪苓 白余炭 飞滑石（红花同研）
泽兰 甘草梢 淡竹叶 大蓟炭 丹皮炭 木通

《柳宝诒医案》

案八，冉××，43岁，职员，初诊日期1977年。

主诉：经前及经期头痛，烦躁，口渴引饮2年。

现病史：病员素有月经过多，经期及周期正常。于2年前出现经前及经期头痛，以巅顶尤甚、同时烦躁易怒。经用止痛、镇静、安眠等药物治疗，头痛不减。同时伴口渴引饮，以夜间尤著，一夜饮水可达16磅之多，感手足心热，舌正常，脉平。

中医诊断：经行头痛。

辨证：气阴两虚。

治则：益气养血滋阴，生津止渴。

方药：党参、黄芪 当归 花粉 白芍 乌梅 石斛
甘草

上方服4剂，药后证顿减，以后连续三个周期于经前2~3日，或有经潮先兆时服本方四剂，随访半年情况良好，半年后有复发现象，再以原方继服而愈

《成都中医学院附属医院医案》

案九，何××，女，21岁未婚。

三年前因寒夜起床大便，感受冷气昏倒，此后每次月经来潮时，即发生麻木抽搐，经后始平，腹痛量多有紫血块，曾经各医院治疗二年余，未见显效，诊其脉象弦虚，舌象正常，乃本体血虚，风冷之气，乘虚而入，邪气附着，营卫失和，以致经期抽搐，治宜调和营卫，祛风活络。处方：

当归 桂枝各6克 吴茱萸2.4克 细辛2.1克 黄芪 白芍各9克 防风 川芎各4.5克 桑寄生12克 生姜3片 大枣8枚 连服7剂。

下月行经，既无抽搐，但感觉麻木未除，仍用前法，经净后，即停汤剂，早晚各服十全大补丸6克，再至下月经期、麻木亦微，唯腹部仍有不适感，已不似从前疼痛，经期仍服汤剂，经后，早服十全大补丸6克，数月后诸证平，经期亦复正常。

《蒲辅周医案》

【分析】

案一为经行昏厥证，月经周期延长，月经量少色淡，属血虚无疑。经期情绪急躁，少寐欲哭，大便干结，舌红苔淡黄腻，显系肝郁气滞，气血运行不利，郁而生热。故于行经

时血海骤虚、肝血为动、阴不涵阳，肝气上逆而突然昏厥，待经净人体恢复正常，肝气渐平，则神志渐清。故治宜养血平肝，理气开郁。方以地黄，白芍、川芎、丹皮、鸡血藤养血活血，滋阴敛阳；香附、郁金理肝气；白薇清肝经郁热；合欢、远志养心安神。接着依次用舒肝和胃法，补益肝肾法，益气养阴，平肝清热等法调和气血，补益肝肾而痊愈。

案二为行经期发热证。月经素来提早，经期延长，经期发热，胸胁胀满、呕吐，显然是少阳肝胆郁热所致。平素性静少言，知为肝气抑郁，久而化热。逢月经期气血下行，则肝气上厥为高热发痉。治疗仿《伤寒论》清解少阳法，用蒿芩清胆汤加减，方用柴胡、枳壳、青陈皮、香附疏肝理气，当归、赤芍活血柔肝，蒿芩清郁热，术朴顺胃气。但服药时适逢月经已行，热极将厥，急则治标，加钩藤平肝熄风，标本同治。上案阴虚为重，此以肝郁为重，上案滋阴清热，此案舒肝清热，证虽同而治不同，可于其中领悟同病异治之妙。

案三为经前乳房胀痛，两乳乃肝经所系，肝气郁滞，则经行前乳核疼痛。肝郁既久，血行为之淤阻，故少腹块疼。经行后，血海空虚，而淤血不去，少腹板滞，酸疼加剧，法宜舒肝理气，活血祛淤，方用金铃子散加味，以归尾、桃仁、丹参、益母草、白芍养血、活血、祛淤；牛膝引药下行、香橡皮、木香合金铃子散理气舒肝止疼；橘络、丝瓜络引药入络，取叶天士“新病在经，久病入络”之意，药的炮制法，都做了仔细推敲。如金铃子以小茴香煎，取其直入肝经，行气止痛；牛膝以红花酒煎拌炒，使其功善活血祛淤，直入下

焦；丝瓜络用乳香酒拌炒，用其直祛细络之淤，活血止痛；木香以桂枝煎汁拌抄，为取其温通经脉，易于行气舒肝。如此细腻处方，不是老手，难臻此境。

案四为经行呕吐。原属肝胃不和，肝气横逆，干犯胃腑，胃不降浊，痰湿内阻，痰浊上泛则呕；痰湿下注则腹胀腿肿；肝气挟痰，阻滞经络则痠厥。应舒肝理气，消胃化痰。方用金铃子散，行散肝气；左金丸清肝和胃；二陈加竹茹、枳实，即温胆汤清胃化痰；加苓桂宣散水湿。继以平肝补肾，柔肝降逆而调之。

案五为经行声哑。肝肾之脉，皆系舌本，肝肾阴虚，阴精不能上承，恰逢月事之时，精血皆下注血海，故发声哑，即以滋补肝肾之药，大补精血。但柔药滋阴，性凉下行，初服之声哑反甚，继以细辛1.5克，辛散上行，反佐取之，引诸药上达咽喉，立效。可知引经报使与反佐之用法，有时是相当关键的。

案六为经行外阴生疮，痰湿内生，经行则下注于外阴而生疮，属痰核流注。并非热毒内生，疮亦无红肿热疼，用外科治肿毒法当然也不能治愈，仍宜行气化痰，从内而治。方用白螺蛳壳烧煨存性。查白螺蛳壳甘平无毒，功能消痰散结，止疼敛疮，尤善治阴部疮肿。《奇效良方》即以此一味烧灰存性、配银粉，干贴疮上，治下疳阴头生疮。故以之为君，配南星、半夏化痰，柴胡、甘草舒肝为丸久服，去痰湿理脾气。以内治法治外科病，实为中医之擅长。

案七为经行小便热淋证。小便淋涩，每发于经水将至之前，知必因淤血积热，逢经前下注膀胱而生。下焦不行，气机阻滞，中脘不通，故上逆而为呕吐、治宜清

利膀胱湿热，兼凉液祛淤。方用猪苓汤、导赤散合方加减，用导赤散引热下行，导赤通淋；猪苓汤滋阴清热，通利小便；血余炭、泽兰、川柏、大蓟炭、牛膝、丹皮、凉血活血、清热祛淤。

案八为经行头痛，因平素月经过多，耗伤气阴，阴虚即口渴引饮，手足心热。巅顶者，人身诸阳之会，阳气不足，不能上行百会，故头痛以巅顶为甚。显然因气阴两虚，经前头痛。治宜气阴两补，兼清虚热，生津止渴。方取张锡纯治消渴方意。用党参、黄芪、当归、花粉、白芍、乌梅。益气养血，酸甘化阴，稍用石斛、甘草清热。以治消渴方法兼治经前头痛，又属法中之法。

案九为经前抽搐，因血气虚弱，风血邪入侵，始终未经发散，邪气与营血交结一处，深入经络，每逢经行，气血下行于血海，则经脉气血两虚、邪因乘机而动，发为抽搐，故治疗仍宜散风活络，调和营卫气血；以桂枝汤调和营卫，以芪归两和气血；加桑寄生强壮筋骨；防风、川芎活络祛风；细辛，吴茱萸少量辛窜经脉、祛久寒通细络，舒通筋脉。此案止抽不取平肝熄风，只以一桂枝汤加几味平淡之药而取效，蒲老临证确是见证准确，施药平稳，所谓“平淡出神奇”。

（七）带下病

【概说】

“带下”有广义、狭义之分，广义带下，泛指妇科的胎、产、经、带等疾病而言，如《史记·扁鹊仓公列传》中将妇科医生称为带下医。这里所说的带下病，是指妇女白带增多，色质，气味发生变化，或伴有全身症状而言，是妇科

的常见病之一。当然，妇女在发育、成熟时期就开始有白带，乃润滑阴道之粘液，为生理现象，在经期前后，妊娠初期，白带还会相应增多，概不属病态。

带下病的虚证多因脾虚肝旺，湿热下注，或肾气不足，下元亏损所致。实证多因阴部不洁，湿毒内侵，秽浊下流而致。

属脾虚肝旺者，白带色白或黄，质粘、量多，无臭味，宜付青主完带汤健脾燥湿；属肾气不足者，白带清冷，色白，量多，质稀薄，应以《妇科切要》内补丸温肾培本，固涩上带；属湿毒下注者，白带量多，色黄绿如脓，或挟血液，或浑浊如米泔水，其气秽臭、阴中瘙痒，则应用《世补斋·不谢方》止带方清热解毒，除湿止带。

今人以鸡冠花30克 金樱子15克 白果10克水煎服或以金樱子30克 猪膀胱一具燉服等偏方、验方治疗，亦屡获良效，可资临床参考。

【选案】

案一，刘××，女，40岁，工人，初诊1963年3月4日。

平时月经量多，腹不疼而有坠感，腰酸痛，月经净后继之带下甚多。质清色淡，头昏耳鸣，肢软，苔薄腻，脉濡细。腰为肾之府，肾开窍于耳，脾肾气虚则脉不固，予以补摄固带施治。处方：

太子参9克 熟地12克 生白术9克 煅牡蛎12克 白莲须6克 菟丝子 芡实 炒杜仲各9克 金樱实12克 枸杞子 鹿角霜 茯苓各9克 服5剂。

3月10日二诊：服补益脾肾佐以固摄之剂，白带量显著减少，腰酸亦好转，药证适应，再以原方加减续治。处方：

太子参9克 熟地12克 白术 炙黄芪各9克 菟丝子
茯苓各12克 沙苑子 枸杞子 炒川断各9克 炒杜仲12克
克 芡实9克 甘草3克 服5剂。

3月20日三诊：白带已渐少，不觉头晕耳鸣，病渐向愈，上方续服5剂后改服八珍丸半月，每日早晚分吞6克，并适当增加营养，注意休息。

《方永涛医案》

案二，胡某，38岁，已婚。

初诊：6月23日。曾生三胎，小产两次。1963年二月间第二次小产后，发热四月余未退，经医院注射抗菌素治疗无效，刻下胸闷潮热、腰酸肢楚，精力疲乏，带下似脓，有秽味，并时带红，经检查为盆腔炎。据述此次小产后即行避孕，月经三个月未来，小腹隐痛，阴道流出脓汁带有臭味，小便中亦混有血丝，口干潮热。脉细数，舌苔薄黄。

辨证：湿热内蕴，阴虚火旺。

治法：养阴清热。

方药：鲜生地30克 红藤15克 川柏9克 知母9克 甘草梢4.5克 淮山药9克 丹友9克 茯苓9克 山萸肉9克 椿根皮12克

复诊：上方加减，自九月底至10月15日，服用半月后，潮热消失，秽带减少，尿血亦止腹部已感轻快。惟尚感精神疲惫，大便燥结不畅，治拟健脾固肾，兼清余邪。处方：

黄芪9克 白术6克 陈皮6克 生地12克 菟丝饼9克
山萸肉9克 苡蓉9克 黄柏9克 茯苓9克 白槿花9克
甘草梢4.5克

《上海老中医经验选编·朱小南医案》

案三，王×，女，37岁。

带下青色，腥臭稠粘，头胀目眩，口苦胁痛，脉来弦数，舌质红，苔黄腻。证属肝经湿火下注，拟泻厥阴之火，化膀胱之湿。处方：

龙胆草6克 黑梔9克 炒白芍9克 生甘草3克 黄芩4.5克 青陈皮各8克 茯苓12克 绵茵陈15克 柴胡4.5克 川萆薢9克 炙白鸡冠花12克

三诊：带下不多，胁痛间或有之，脉弦，苔薄黄，再拟舒肝和营，兼清余热。

炒柴胡4.5克 丹皮4.5克 黑山梔9克 当归9克 制苍术4.5克 茯苓12克 炒白芍6克 甘草2.4克 薄荷纯梗4.5克 郁金6克 炙白 鸡冠花12克

《叶熙春医案》

案四，金子久治一妇，先由白带，续而赤带，益于经水淋漓，甚而色紫起块，少腹抽痛，牵及诸络，形寒头痛，脘泛食少，脉象弦芤，舌质腻白，病在奇经八脉，尚挟寒湿阻遏，治法益气血之虚，参用通气血之滞，处方：

紫丹参 茺蔚子 橘红 萆薢 淮牛膝 法夏 石英 丹皮 陈阿胶 新绛 白芍 蜈蚣

《中国医药汇海，医案部》

案五，杨某，女，18岁，1967年3月28日初诊。

1966年10月，患者因经期洗澡，以后便行经腹痛，经期提前，量多，色紫夹块，经后带多，色黄味臭，阴中灼痛，瘙痒难忍，夜间较重，有时经前乳房发胀、刺痛，触扪时疼痛更甚。妇科诊断：滴虫性阴道炎。近半月来口苦、咽干、胸腹胀满，大便三日不解，纳差，小溲短赤，口干饮冷，舌

质红，苔黄腻而干，边尖、色绛、脉左手沉弦而实，右手沉实而洪。胆经郁热，腑气郁闲，热移下焦，病在少阳与阳明之间，治宜攻里和表，先用大柴胡汤一剂投之、外用蛇床子煎剂作外阴熏洗。处方：

柴胡¹⁵克 炒枳实¹⁰克 生大黄¹⁰克 炒黄芩¹⁰克 法夏¹⁰克 炒龙胆草¹⁰克 大枣⁸枚 生姜⁷克 杭芍¹⁰克

外用蛇床子煎剂：蛇床子³⁰克 鲜银花叶³⁰克 忍冬藤³⁰克 苍耳草²⁰克 土茯苓²⁰克 苦参²⁰克 生黄柏²⁰克 水煎后熏洗外阴。

大柴胡汤一剂后，曾腹泻³次，胀满减轻，阴痒已被控制，黄带减少，夜间可以入睡，舌苔黄腻已退，惟口苦咽干未除。胸胁仍有闷胀，脉弦已经缓和，少阳与阳明郁热已去大半，治宜以小柴胡汤配四逆散加龙胆草主之，外洗法仍遵前方不变。处方：

柴胡¹²克 法夏¹⁰克 炒黄芩¹⁰克 北沙参¹⁰克 生甘草¹⁰克 炒枳实¹⁰克 生白芍¹⁰克 炒龙胆草¹⁰克 生姜⁵克 小枣¹⁰克

上方共服⁵剂，再加外用蛇床子洗剂熏洗外阴¹²次后，诸证消失，一个月后经行正常，妇科白带检查未发现滴虫，其病全瘳。

王有章：运用六经辨证方法对几种妇科病的治验《中医杂志》

1985年10期

【分析】

案一为脾肾阳虚带下证。脾肾阳气不足，不能温化，带脉不固，寒湿下注，故带下清稀、色淡，兼见腹胀、腰疼，头晕耳鸣等证。用内补丸与完带汤合方加减。熟地、菟丝

子：杜仲、金樱实、枸杞子、鹿角霜温补肾阳，配芡实，煨龙牡，固涩下元；太子参、白术 茯苓健脾燥湿，配白莲须固涩专治带下，继以八珍汤调理取效。

案二为阴虚火旺，下焦湿热带下证。小产后气血方虚，又发热四月未退，耗伤阴液，遂致阴血亏虚，内热炽盛。复因小产后，阴道感染不洁，湿毒内侵胞宫，相火与湿毒相合，相杂下注，而为带下秽臭带血。兼潮热口干，苔黄舌红，脉细而数。宜滋阴养血、清热解毒法。方用知柏地黄丸方，去泽泻之渗利，加樗根皮、红藤、甘草梢而成。红藤善能清热解毒，配樗根皮清热燥湿，治赤白带下，此二味与知柏相配，解毒清热效果增强，并专清下焦、故一诊见好，调理而安。

案三为肝经湿热带下。因肝热脾湿，蕴成湿热，胶结不解，下注胞宫，发为带下证。宜分利湿热，清肝经相火，方用龙胆泻肝汤化裁，以萆薢分利，以白鸡冠花凉血清热，治赤白带下。《孙天人集效方》用白鸡冠花，晒干为末，空心酒服，治赤白带下，亦为叶熙春氏治带的经验用药。

案四为寒湿与瘀血交结，下注为赤带证。赤带淋漓，胜于经水，甚至带下夹有紫色血块，再加少腹掣痛，为瘀血阻络之象。又兼恶寒，泛恶，食少，舌白腻，脉弦芤，又是脾虚寒湿内停之证，故宜补血活血，兼燥湿健脾。方用桔红半夏汤中燥湿；羌蔚子、白芍，阿胶滋阴养血；丹参、丹皮、茜草凉血活血；淮牛膝一味引药下行；萆薢渗湿利下，紫石英一味，乃叶天士妇科经验用药，凡属下元不足，崩漏带下，又兼上部头痛呕逆，气机不顺者，皆以紫石英治之；螅蛸亦善固涩止带。用药从不同角度，围绕带下这一类关键问题，配合紧凑、重点突出。

案五为感染湿毒，阴痒带黄证。因经期洗浴，使不洁之物由下感染，湿热毒邪蕴结胞中，遂使阴中灼热瘙痒，带下黄臭，湿热郁久，阻碍肝胆气机，致使实热结于少阳、阳明。便秘腹胀，舌苔黄腻，治疗宜疏利少阳，攻下实热，清洗热毒。法分内外，方用洗、服。内服大柴胡汤攻下阳阴，疏利肝胆；外用蛇床子、土茯苓、忍冬藤，鲜银花等煎汤熏洗，清热解毒，杀虫止痒，一剂后里气得通，再内服小柴胡加四逆疏通气机，加龙胆泻下湿热，外洗仍用原方，一月得痊愈。

（八）妊娠恶阻

【概说】

妊娠早期出现恶心呕吐，头晕厌食，甚或食入即吐，称为恶阻。亦称妊娠呕吐，为妊娠早期最常见的疾患。若仅有恶心异嗜，择食，或晨间呕吐痰涎，则为早期妊娠常有的反应。经过一段时间，可以自行恢复。但呕吐严重，不仅对孕妇本身，并且会给胎儿发育带来不良影响，必须进行治疗。

妊娠以后，一般因血聚养胎，多造成阴血偏虚，虚火上冲的状态。亦由孕妇平素禀赋不一，可分为脾胃虚寒型、肝胃不和型和痰湿阻胃型。脾胃虚寒者，常恶心呕吐不食，或呕吐清涎，兼见倦怠，嗜睡恶寒等证，宜用香砂六君子汤健脾和胃，降逆止呕；肝胃不和型，呕吐酸水或苦水，兼见胸胁胀满，头痛口苦等证，应用加味温胆汤抑肝和胃止呕；痰湿阻胃者，呕吐痰涎，口中粘腻，兼见脘痞头晕等证，则以小半夏加茯苓汤祛痰和胃止呕。若呕吐至发热口渴，尿少唇干，眼眶下陷，双目无神，出现气阴两亏的严重证候，则应用生脉散，增液汤等合方急救，若出现体温升高，黄疸等证，则必须注意及时终止妊娠，保护孕妇生命安全。

【选案】

案一，姜××，女，31岁，门诊简易病历。初诊日期，1974年8月21日。

患者闭经50天，近日来恶心，呕吐，厌食，胸闷腹胀、妊娠试验阳性、血压100/60毫米汞柱，过去有血压偏低史，舌质尖红，周边有齿痕，脉沉细弦。

辨证：妊娠恶阻（脾胃虚弱，冲气上逆）。

治法：健脾和胃、降逆止呕。

方药：藿香9克 苏梗6克 陈皮6克 砂仁4.5克 半夏6克 白术9克 木香3克 生姜汁20滴上方服三剂后，恶心呕吐已止，食纳增加，基本痊愈。

《刘奉伍妇科经验》

案二，郭××，女，成人，已婚。病历号38817。初诊日期：1959年6月18日。现妊娠一个半月，停经30天即有泛恶呕吐，近四天加重，不能进饮食，呕吐黄水，头晕，大便干燥，舌苔薄腻，根微黄垢，脉软滑微数。

辨证：肝胃气逆，痰浊不降。

治法：和肝胃，降痰浊。

方药：北秫米12克 清半夏9克 2剂。

6月20日二诊：入院后，服药仍吐。心中烦热，口干且苦，但喜热饮，胃脘做痛，小腹胀坠，舌苔淡黄腻，根微垢，现左脉弦数，右滑数，病因痰湿中阻，胃浊不克下降，治以益气温中，化痰降浊。

方药：党参3克 干姜3克 清半夏3克 三味研末，早晚各服1.5克，服前再加生姜汁4滴，调和徐服。服药后，呕吐止，诸恙渐安，以后未再服药。

【分析】

案一为脾胃虚弱型恶阻，因脾胃素虚，妊娠胎气上逆，干扰胃气而作呕。以香砂六君子加减。加藿香、苏梗，芳香醒脾，藿香兼化胃浊，苏梗兼降逆气，生姜汁和胃止呕最有效应。三剂即呕止。

案二为痰湿阻胃型恶阻。舌苔薄腻，呕吐黄水，脉滑微数，为痰浊不化，阻于中焦，胎气夹浊气上逆而为呕。治疗以《内经》的半夏秫米汤，温胃化痰，降逆止呕。服后仍有呕吐，并兼见口干而苦，舌苔淡黄腻，看似有湿痰化热趋向。但渴喜热饮一证，乃本病关键处，足证其本质为脾胃虚寒，上方似显病重药轻。再用党参，干姜合小半夏汤，温中化痰，降胃止呕，诸恙悉平。

(九) 胎漏 胎动 滑胎

妊娠后，发作阴道不时流血，一般无明显的腰酸腿痛，小腹坠胀等症状，称为胎漏。若有明显的腰酸腹胀，小腹坠痛，并伴有阴道流血是胎动不安，亦称先兆流产，严重者会发生流产。如妊娠三月以内流产的称为胎坠，三月以上流产者称为小产或半产。连续发生两三次以上妊娠后如期而胎坠者，称为滑胎（习惯性流产）。

胎漏诸证多因妇女气血虚弱，脾不统血，肾气亏虚，固胎无力，或血热妄行，外伤跌仆所引起。临床气血虚弱型，常补气养血安胎，以泰山盘石散加减为主方；肾虚者，常补肾健脾，以《表中参西录》的寿胎丸加减为主方；血分有热者，常宜凉血养血，以《景岳全书》保阴煎加减为主方；如跌仆损伤，腹痛下血，则宜补气养血，少佐活血之药，用李

东垣圣愈汤加减治疗。

本病治则以安胎为主，根据具体情况，采用补气、固肾、养血、清热等法，如阴道出血过多，小腹坠胀加剧，甚或胎儿已死腹中，不宜安胎者，应及时采取措施，促其平安坠胎，若胎已坠，则应按产后处理。

【选案】

案一，黄×，文艺工作者。

主诉：停经2个多月，月经过期二十多天时，曾作小便青蛙实验为阳性，现阴道有少量流血已五天，色鲜红，腹隐痛及下坠感，腰微酸，一年前曾自然流产一次，也是早孕两个多月，现未有小孩。

患者形体消瘦，平时有头晕腰酸，本次早孕后有轻度妊娠反应，且感疲倦。近日没有注意适当休息，几天前出现阴道流血，舌色稍淡，但尖边稍红，脉细滑略弦。

诊断：先兆流产（肾阴不足兼有肝经虚热型）。

治则：滋肾养肝，益气安胎。

处方：菟丝子24克 续断 桑寄生 阿胶各12克 旱莲草 女贞子各15克 白芍9克 甘草6克 荆芥炭9克

4剂，每日一剂，留渣再煎，并嘱卧床休息。

服药3剂后，阴道流血及腹疼已逐渐停止，但仍有腰酸及大便干燥，后按上方去荆芥炭白芍，改用桑椹肉苁蓉各15克，4剂。药后诸证已基本消失，舌脉亦正常，后按二诊方去旱莲草，改用淮山药15克，续服6剂，后每周服药3剂，以资巩固。于妊娠5个月后停药，至妊娠足月顺产一男婴。

《罗元恺医案》

案二，姚××，女，35岁，已婚。初诊日期1956年5月30日。

婚后十二年，先后流产或早产五次，其中一次是妊娠四个月时流产，余均为五个月和六个月，每于妊娠一个月后必漏血十余天，并同时出现血压降低，引起头晕，至3~4个月，左腿及左腰疼痛，虽屡次积极进行保胎措施，仍不能避免妊娠之中断，在第四次妊娠时，曾服胎产金丹，亦未获效。现已怀孕二个多月，近20天内恶心呕吐，择食，大便稍干，小便正常，精神较差，睡眠尚可，诊其脉左关沉弦短，右沉滑，舌正无苔。

辨证：滑胎（西医诊断习惯性流产）。

治法：先宜调脾胃，次固肝肾，待脾胃健强，续予补肝肾以固胎本，并建中气以养胎元。

方药：台党参6克 白术6克 茯苓6克 炙甘草8克
广陈皮4.5克 砂仁3克 藿香6克 山药9克 生姜3片 大枣3枚

此方缓服3剂，恶阻止后，继服下方。

以泰山磐石饮与安胎银芩酒加减合方。

熟地黄12克 白术6克 制黑川附子3克 别直参8克
杜仲9克 当归3克 桑寄生9克 杭巴戟9克 苁蓉9克
川续断9克 苈麻根9克

此方每剂煎两次，每次煎一小时，共取400毫升，分两次温服，一周服一剂，并绝对控制性生活，以免扰动胎元。

患者按法服之，直至足月顺利分娩。

《蒲辅周医案》

【分析】

案一为胎动不安，腹疼下坠，阴道已有流血，是为先兆流产。前有流产病史，属肝肾不足，胎元不固。又兼有舌

红，形体消瘦，脉细滑略弦，是为肝肾阴虚之象。故治疗滋养肝肾之阴，益气安胎，方用寿胎丸（菟丝子、续断、桑寄生、阿胶）加旱莲、女贞益肝肾，凉血止血；白芍、甘草合化生阴，柔肝敛肝；荆芥炭安胎止血，一诊便流血止。二诊仍有大便干结，去荆芥炭、白芍加桑椹，肉苁蓉，既益肾阴，又润肠燥，果使正复胎安，至期而产。

案二为滑胎，屡经半产、小产，损伤气血，肝肾不足，胎元不固。此次又妊娠二月，虽未漏血，但应早予治疗，以防再循前辙。舌光无苔，是胃气不足，又有恶心呕吐等胃气上逆之证。宜先调脾胃，再补肝肾。初诊用香砂六君子加减。加藿香、生姜辛香开胃；加山药健脾兼顾补下。继用泰山盘石饮。

以上可见，用中医辨证施治保胎疗法具有安全有效，无副作用等优点，在目前尚无新的、有效的、可靠的保胎方法问世之前，可以说是一种较好的保胎方法。

（十）妊娠水肿

【概说】

妊娠六月以上发生肢体肿胀，轻度的只有足踝部浮肿，无其它不适。如果肿胀超过膝盖以上，以至大腿、外阴、腹部，或全身皆肿，伴有尿量减少，全身不适称为妊娠水肿，亦称“子肿”。若有胎水过多，腹大异常，伴有全身浮肿，称为胎水肿满，即子满。此外，亦有因胎气壅塞，气机阻滞，水湿不化，也能造成肿胀。临床常见证型分脾虚、肾虚、气滞三种。本病辨证关键，应分清水肿与气肿，水肿的，大多皮薄色白而光亮，按之凹陷不起；因气滞而肿的，大多皮厚而色不变、随按随起。

本病治疗，因其本虚标实，妊娠期不宜过用淡渗行气之

品，必须标本兼顾，毋损胎气为宜。脾虚为主的，宜用千金鲤鱼汤与白术散《金生指迷方》）健脾行水；肾虚为主的，宜用真武汤温阳利水；气滞而肿者，应用《妇人良方大全》天仙藤散合四苓散利气行滞退肿。

【选案】

案一，徐灵胎治一妇，妊娠自三月成胎之后，两足脚面浮肿，以及腿膝，渐至周身喘急满闷，行步艰辛，脉虚弦滑，此为子肿，投全生白术散数服而肿退食尽，继以千金鲤鱼汤紫苏饮间服，一月而胎孕全安。

《徐灵胎医书全集》

案二，徐灵胎治一妇，妊娠四五个月后，遍身浮肿，饮食如常，脉缓沉涩，谓之子气，投天仙藤散，四服而肿势顿减，改以四君子汤加木香、苏梗，日渐调理，至弥月，进紫苏饮三服，当晚分娩，而肿势全消矣。

《徐灵胎医书全集》

案三，叶天士治某妇，气逆壅热于上，龈肿喉痹胸闷、腹肿，七月太阴司胎，法宜宣化清上

川贝 牛蒡子 连翘 苏梗 杏仁 花粉 菊花 橘红

《监证指南医案》

案四，刘××，女，35岁。因妊娠11月，全身浮肿，咳嗽气通，入院治疗已七天，曾服双氢克尿塞、利尿素以及中药五皮饮加白术、当归、黄芪等剂，全身浮肿加剧，腹水增加，病情严重，正考虑引产未决之际，经该院应邀会诊。诊得患者颜面及全身浮肿，恶风鼻衄，喘咳不止，呃逆不能食，大便尚通，小便短赤，舌粗白尖红，脉浮数有力，显未见发热口渴等证，而肺经风水高冲，挟有胃热之候显然可

见。遂从《金匱》风水论治，方用越婢加半夏汤。

净麻黄4.5克 生石膏12克 法半夏6克 生甘草³克
生姜4.5克 红枣4枚 加杏仁9克

连服6剂，虽汗出不多，而尿量增加，输出量大于输入量，每天高达29000毫升，全身浮肿消失，腹水亦除，体重由61公斤减至46公斤。心肺正常，咳喘见平，饮食睡眠恢复正常。

杨志一：医案札记《江西医药》1968年9期

【分析】

案一为脾虚水肿，喘急满闷，脉弦滑，无肾虚之象，为脾不化湿，故以全生白术散（白术 茯苓皮 大腹皮 生姜皮 陈皮）温中健脾行水，而肿退食进。再以鲤鱼汤（鲤鱼汤煎服白术 生姜 白芍 当归 茯苓）补养气血；紫苏饮（《济生方》大腹皮 川芎 白芍 陈皮 紫苏叶 当归 人参 甘草）和胃安胎，利水退肿。

案二为气滞子肿。脉缓沉涩，气机阻滞，气血运行不畅所致。全身浮肿，饮食如常，知非脾虚不运也。故曰为“子气”即气肿。用天仙藤散（天仙藤 香附 陈皮 甘草 乌药各1.5克 共研粉。每服1.5克，用生姜 木瓜 苏叶各三片煎汤送服）理气行滞，和胃宽中。天仙藤一物，《本草正义》云其善于宣通经隧，导达郁滞，疏肝行气，故治妊娠因气机不畅而致肿者尤效。肿消后，不宜再行疏散，继以四君子汤加木香、紫苏温中利湿，间服紫苏饮和胃安胎消肿。

案三为风热内壅，气机不利子肿。外感风热内侵，夹胎气上逆，而发为衄肿，喉哑。时值七月盛夏、暑湿之气困脾，加风热壅塞气机，故水湿不运而为腹肿。此热壅上焦为主，治疗宜清宣化湿，方用桑菊之意，辛凉解表，疏散风热。

案四为风水子肿。适值妊娠，又逢外感，风寒遂挟胃热上壅，外发颜面肿胀，全身浮肿；上为咳喘呃逆，气上不下，治宜散外寒，清内热，和胃安胎，散湿去肿。故用越婢加半夏汤方。麻杏石甘去肺之壅热，宣散表寒而止喘咳；姜枣半夏，和胃降逆。一诊而风寒外散，里热内清，因而上焦得通，里气因和，小便自利。所谓疏上壅，开下流，提壶揭盖之法也。张志聪亦曾用苏叶、防风、杏仁治一顽固水肿证，又可与叶天士以桑菊治子肿案羽翼比美。

（十一）子痫

【概说】

妊娠后期，或正值分娩时，或分娩后，忽然发作昏眩倒仆，四肢抽搐，牙关紧闭，两目直视，口吐白沫，少时苏醒，醒后复发，或昏迷不醒的证候，称为“妊娠痫证”，亦称“子痫”或“子冒”。

子痫发作前，常出现头晕眼花，头胀头痛，上腹不舒，胸闷恶心，小便短少，水肿等先兆症状，称为先兆子痫，先兆子痫发病原因主要因血养胎儿，肝藏血少，肝阳偏亢，又因体质的差异，分为阴虚肝旺与脾虚肝旺两种。若阴虚肝旺，宜以羚角钩藤汤育阴潜阳，平肝熄风；若脾虚肝旺，又应用全生白术散加钩藤、决明子，健脾利湿，平肝潜阳；若肝阳化风，风火相煽，蒙蔽心窍，而发生子痫。孕妇抽搐昏迷，母子都有生命危险，则应立即镇肝熄风，清心降火，方剂除采用羚角钩藤汤加减外，再用犀角粉冲服；昏迷甚者，加用至宝丹清心开窍；体质弱者，应用滋阴潜阳，熄风泻火，再加用羚角粉，犀角粉，安宫牛黄丸，至宝丹等。在此生命千钧一发之际，必须迅速无误的治疗，方可转危为安。

妊娠后期必须定期进行产前检查，一旦发现先兆子痫症状，应积极治疗，这对预防子痫发生，有重要意义。如已经发作子痫，除予治疗外，应严格避免声光刺激，以免诱发抽搐。若抽搐时间较长，发作频繁。可能导致孕妇及胎死儿亡，这是妊娠晚期严重的疾病，必须提起特别注意。

【选案】

案一，王××，21岁，病历号138639（首都医院）。

初诊：1958年4月28日，初产妇，未作产前检查，昨晚在家分娩，胎儿拔露时，发生抽搐，夜间12时牙关紧闭，又连续抽搐五次，分娩一活婴，胎盘娩出顺利，出血不多，但产后又抽搐五次，昏睡，即送医院。入院诊断，产时子痫。血压170/140毫米汞柱，体温38.4℃，尿蛋白（+++），神志不清，全身四肢浮肿，舌苔黄尖绛，口唇干燥，脉细弦滑数，病因由于心肝阳亢，心阳亢则火炎于上，肝阳亢则风自内生，风火交炽，筋脉抽搐，证属子痫，治法急以镇肝熄风，清心泻火，方用钩藤汤及羚角琥珀散加味。

处方：钩藤9克 当归9克 桑寄生12克 元参9克 桔梗6克 茯神12克 陈胆星6克 远志6克 干菖蒲 天竺黄9克 1剂。

羚角琥珀散3克，分二次服（药用胃管送下）。

二诊：4月24日，产妇抽搐未作，昨日下午3时神志渐清，已能回答简单语言，今始神志清楚，汗多口渴，恶露少，夜寐不安，舌苔燥黄中垢，脉左沉滑数，右细弦数，心肝之阳，尚未平熄，治以平肝潜阳，清心豁痰，佐以化淤。

处方：生龙齿30克 生牡蛎30克 当归9克 白芍9克 元参9克 钩藤9克 煅礞石12克 天竺黄12克 生牛膝9克

桑寄生12克 生蒲黄6克 五灵脂12克 1剂。

三诊：4月24日下午，神志清醒，自汗淋漓，恶露较多，有紫血块，嗜睡，舌苔黄腻，中根垢，脉细数而弱，左部尤甚，体温38.4℃，血压160/110毫米汞柱，治以补气养血以固本，平肝熄风以治标。

处方：生黄芪15克 党参9克 白术9克 茯神9克 五味子6克 当归9克 白芍9克 钩藤9克 桑寄生12克 淮小麦12克 大枣4枚 1剂。

四诊：4月25日，汗出渐少，口唇周围有疱疹，大便干结，体温38℃，血压160/110毫米汞柱，恶露未净，纳食一般，睡眠尚可，舌苔黄垢腻，脉象细数，治再补气血，清营热。

处方：生黄芪12克 生地黄12克 当归9克 白芍9克 白薇9克 瓜蒌15克 知母9克 钩藤9克 桑寄生12克 牛膝9克 1剂。

五诊：4月26日，大便秘通，血压及体温亦降至正常，恶露少而不尽，唇部疱疹作痛，舌苔中垢已化，边黄腻，脉细弦数，治以养血清热。

处方：生地黄12克 当归9克 白芍9克 白薇9克 丹皮9克 知母9克 生甘草6克 牛膝9克 1剂。

六诊：4月27日，诸恙均减，体温正常，但小便不利，舌根黄腻，脉细弦微数，治以养血清热，通利膀胱。

处方：生地黄12克 当归9克 白芍9克 白薇9克 丹皮9克 生甘草6克 滑石12克 车前子12克（包）2剂。

另：琥珀末1.8克，分二次冲服。服药后，神志渐清，抽搐未作，再以平肝潜阳，清心豁痰，后再从补气养血，平肝熄风，患者血压渐趋平常，证见小便不利，再从养血、清

热利水之法调治，至5月4日痊愈出院。

《钱伯医医案》

案二，管某，女，30岁，症状：孕近十月忽然足甲剧痛，同时两目流血，头痛。医以外感施治，头痛更甚，目血更多，呕吐大汗，神迷肢掣，目吊口噤。脉虚弦劲急。舌淡、苔薄。

辨证：阴虚火炽，肝风内动，属子痫前驱证。

法用：养阴濡液、平肝熄风。

处方：犀角尖0.9克(磨冲) 细生地 熟枣仁 旱莲草
女贞子各24克 阿胶珠 钩藤 滁菊 天冬各9克 沙参
12克 仙鹤草60克

疗效：服上方三剂后复诊，肢掣渐平，目血已止，神志渐清，仍感胃气上逆，咽干，头痛，失眠，系大病后亏损未复，余波未静，再予和胃、养阴，安神之剂。

处方：沙参 茯神 玉竹 石斛 麦芽 生白芍各9克
白术 藿香各6克 女贞子 旱莲草24克 连服4剂，全证获愈，届期分娩，母子平安。

子痫前驱目血《新中医》1977年2期

【分析】

案一为产时子痫。已经神志昏迷，产时连续多次抽搐，再加口唇干燥，舌苔黄，舌尖绛，属肝阳化风，心火亢盛，风火相煽，蒙蔽心窍。急宜镇肝熄风，清心降火。方用钩藤汤及羚角琥珀散加味。胆星、天竺黄、干菖蒲豁痰清心开窍；钩藤、玄参凉肝熄风；远志，茯神养心安神；桑寄生，当归滋阴柔肝，以助潜阳；桔梗上行，反佐用之，使众药不致寒凉沉降，桔梗苦凉，又能清利头目。一诊后，神志稍清，但口渴苔黄，夜寐不安，再加恶露去少，属瘀血内停，肝风未熄，宜

加活血之品，以防淤血与痰热交结为患。故在滋阴潜阳，养血熄风基础上加失笑散，见诸证显然好转。终以养气血，固根本而痊愈。琥珀末一味，功擅走血分，能活血祛淤、又能镇惊安神，利水退肿，故此证用之，一举三善。羚角琥珀散为钱老自订方（羚角、琥珀、天竺黄、天麻、蝉衣、地龙等分共研细末和匀，每服1.5克至3克，每日1~4次），具有降压、止痉作用，为临床已效之方。

案二为产前子痫，已有头痛，两目流血，显然因妊娠肝肾阴虚，肝阳上亢所致，目乃肝之窍，故肝阳亢则目血。而误反以外感治法，用发散之药，重伤阴液，使肝阳上越，至子痫发作。治宜滋阴熄风，清心定惊。方用生地、阿胶、天冬等滋阴潜阳；仙鹤草凉血、止血；滁菊花清利头目；另磨冲犀角尖急急清心凉血为要，继以滋阴养血、安神取效。此证虽奇，然辨理清晰，故能临证不惑。

（十二）子淋、转胞

【概说】

妊娠之间，出现尿频、尿急，淋漓涩痛等症者，称“妊娠小便淋痛”，古称“子淋”，又称“妊娠小便难”。

本病发生，由于膀胱气化不利，水行不通，使小便淋漓而下。导致气化不利的原因多为湿热下注，或阴虚火旺，移热于膀胱。湿热下注，多属实证，尿色深黄；小便艰涩热痛，兼面赤心烦，口舌生疮等，宜以导赤散加味泻火通淋；阴虚火旺者属虚证，有小便频数淋漓，量少、色茶黄，小便刺痛，兼潮热颧红，五心烦热等，应以知柏地黄丸方加味滋阴凉润通淋。

治疗原则，虽属有热，总宜清润为主，不宜过用苦寒通

利渗泄，以免损伤胎气，而致小产坠胎。

如果妊娠小便不通，甚至小腹胀急疼痛，心烦不寐，称为“妊娠小便不通，古称“转胞”。发病因胎孕胞宫下坠，压迫膀胱所致，多由肾虚不固，气虚不提所致，属虚证，又当与此证分别而论。治疗宜补益肾，补气，促使膀胱气化。

【选案】

案一，惠××，女，30岁，武威南山山区农民。

患者1954年6月，已怀孕七月，胎动正常，但突然小便不利，日趋点滴不通，腹部陡大，胀满不舒，抬送县医院，施行导尿，导毕腹胀大减。回家后，仍时欲小便，点滴不通，越二日，胀满更剧，急诊就医，观其腹大如鼓，舌苔正常，脉沉滑。脉沉为气虚下陷，胎无不举，胞胎压迫尿道，故小便不出；水蓄膀胱，则少腹胀满。治宜益气健脾，升举胎元。

方用：补中益气汤加减。

炙黄芪24克 当归 白术各9克 陈皮4.5克 冬葵子9克 升麻3克 党参15克 柴胡4.5克 炙甘草3克 生姜4.5克 鲜车前草9克 水煎服一剂。

二诊：上方服1剂后，即能自行小便，二剂服完，一夜小便二三次，腹已不胀，原方再服2剂，观察三天，胎动存在，小便如常，嘱其回家休息。

广州中医学院《老中医医案医话选编》

案二，贺岳精于医，曾治一孕妇将坐草，患小便不通，百药不效，愈饮愈饱，束手待毙。贺君诊之曰：此乃脾气虚弱，不能胜胞，故胞下压塞膀胱，以至水道不通。大健其脾则胞举而小便自通。以白术60克土炒，加炒砂仁10数克，别加一二辅佐之药，服一剂小便立通。

《续名医类案》

案三，儒者王文远室重身，患小便不通，小腹肿胀，喘急不能安卧者，已三日，几至于危。六脉细数，重按无神。用八味丸一服，小便滴沥。再以前丸加车前子一剂，即利，肚腹顿宽，而产顺全安矣。

《徐灵胎女科医案》

【分析】

案一为气虚下陷小便不通，脉沉而滑，少腹胀满，未有其它肾虚，内热之象，故判断其心因脾阳不足。脾气升举，有固定内脏位置的作用，故脾阳虚则清气下陷，致胎元不举，子宫下坠、压迫膀胱而为转胞，小便不得出。治以补中益气汤加味。冬葵子性平滑泄，善治妊娠小便不利。《千金要方》即以冬葵煎汤治子淋。《金匱要略》亦有葵子茯苓散，重用冬葵治妊娠有水气，身重，小便不利。

案二亦为脾虚下陷，小便不通。惟方药只用白术、砂仁两味，白术补脾，砂仁醒脾利气，一补一行，单方重剂，一剂而效，此涩因涩用之法。上案与此同证，却用时方轻药，证同、治则相同，但后案即将生产，故应当机立断，而前案妊娠七月，尚可缓图，故用时方调理，可谓殊途同归。

案三为肾虚小便不通。六脉细数，重按无神，知其元气大虚，不能温化，水积膀胱，故小腹肿胀。先以八味丸补肾固本，继加一味车前子通利小便，标本同治而获效。

(十三) 产后腹痛

【概说】

产妇分娩以后，发生以小腹疼痛为主证的病证称为“产后腹痛”，亦名“儿枕痛”。发病原因主要是气血运行不畅，

迟滞而痛。血运不畅则多因气血虚弱，血淤与寒凝胞中。

因气血虚弱者，产到小腹隐隐作痛，柔软喜按，恶露量少色淡，可以《付青主女科》肠宁汤补血益气，温经止痛；因血淤者，小腹疼痛拒按，恶露量少，色暗有块，宜用生化汤活血祛淤，散寒止痛；因寒凝胞中者，小腹疼冷，疼痛剧烈，喜温喜按，兼四肢冷而不温，阳虚自汗等证，应用《医略六书》香桂丸，散寒止痛。

【选案】

案一，范，冲任伤，督带损，皆由产时劳怖，理难复元，固摄下真，兼理奇脉，治非背谬。但腹满膨苦，若徒固补，不以通调，恐恣胀肿，大意阳宜通，阴宜固，包举形骸，和养脉络，乃正治方法，病样多端，纷纭缕治，难以立方矣。

人参 鲜河东胶 淡苁蓉 砂仁制熟地 鹿角霜 归身
茯苓 紫石英 小茴香 羊腰子

《临证指南医案》

案二，王××，26岁，因产时出血较少，产后第三天少腹疼痛，扪之有块，拒按，伴自汗、心烦、口渴、唇焦、咽燥，大便秘结，曾服生化汤合失笑散。药后淤血未下，块痛改冲，心烦益甚，口干渴，以鹿衔草汤代茶饮之不能止，此系素体阴血亏损，更因产后汗多伤津，复投辛温，益伤其阴，然阴虽伤而淤仍未去故致证情加重。治当救液为主，祛淤为辅。

处方：鲜石斛36克 鲜藕节90克 花粉15克 生地30克
丹皮10克 益母草15克 茜草10克 瓜蒌仁15克

一剂而烦渴瘳，痛减，二剂淤行病愈。

郭廷杰：补阴法产后运用两例

《中医杂志》1985年4月

【分析】

案一为产后肾虚，奇经损伤而腹疼。腹胀满痛疼由产时损伤冲任，冲任隶属肝肾，以至肾气不足，不能温化，故小腹胀满而疼，叶天士治妇科疾患善用调理奇经八脉方法。大抵以紫石英镇冲脉之下竭上逆；鹿茸补肾脉之阳虚；龟板固摄任脉之阴，当归宣补带脉之损，而且善用血肉有情之品治疗产后及各种虚损所致的精血不足。并善用平性药物补三阴之不足，曰：平补三阴法。此案便是三法兼施，一以人参、苁蓉、砂仁、制熟地、归身、茯苓不偏寒温之品平补三阴经之虚损；用羊腰子、鲜紫河车血肉有情之品补精血不足；鹿角霜温督脉；紫石英调冲脉。故云此案“病样多端，纷纭缕治，难以立方”。不愧为善治虚损之佳案。

案二为阴虚血淤而腹疼。素体阴亏，产后损伤阴血，内热由生，见口渴咽干、便秘等证。兼恶露去少，有淤血内停，少腹疼痛，有块拒按。又曾误服生化汤及鹿衔草，辛温更耗阴津，故治以育阴为主，兼以祛淤。以生地、花粉，益母草滋阴养血；茜草、丹皮、藕节凉血祛淤；石斛清热；瓜蒌仁润燥，方虽简而组合严密，故二剂诸证愈。

（十四）产后发热

【概说】

产后持续发热不减，或突然高热，并伴有其它全身症状者，称为“产后发热”。一般产后几日内，因气血骤虚，带有微热多汗，不属病变。

本病发生，多由产后淤血阻滞，气血大虚外感风寒，产褥感染受毒邪而生。

由淤血阻滞者，属虚中挟实。因产后恶露不下，淤血内

阻，营卫失调，寒热时作者，当用生化汤加味调和气血，化淤清热；由气血大虚者，则因产时失血太多，虚阳无所附，浮越于外，有微热自汗，头晕心悸等证，应以八珍汤补气益血；因感受风寒者，产后百脉空虚，腠里稀疏，寒邪易入，表而发热，当用四物汤与辛温解表或辛凉解表剂配合使用，扶正解表；因产时下部不洁，感受毒邪，乘机侵入胞中，邪正交争而发热，见发热恶寒较甚，恶露量少色紫黑如败酱，甚则高热斑疹，神昏谵语，则应以五味消毒饮与失笑散合方加减，清热解毒，养血活血。

本病治则，应注意产妇气血骤虚的体质，使用标本兼顾为宜。古有“产前宜忌滑利，产后大避寒凉”之说，亦可临证参考。

【选案】

案一，李×，24岁，住蒙化东城外桃园。

病人于1953年3月间，分娩后两月，偶感风寒，发热昏迷。病后两日，邀我往诊，证见高热汗出，神昏谵语，有时昏沉时睡，有时循衣摸物，令其静卧，恶热掀被，烦渴饮冷，恶露量少而带黑块，脉搏浮沉有力，舌尖红燥，舌白少津，目呆声洪，腹部热甚，少腹疼而拒按，食物不进，间发呕逆。证乃产后血脉空虚，感受风寒，热入血室，淤血阻滞，热邪上扰神明之候，宜和解行淤，方可奏效。以小柴胡、桃仁承气汤合方加减。

炒柴胡 炒黄芩 大枣 桃仁 延胡索各9克 红花
2.4克 炒酒军15克 甘草6克 生姜3克 法半夏9克

服药后下黑血数次，大便泻褐色，当晚神志渐清，腹痛若失，发热减轻，饮食稍进，已能安眠三四小时，次早往诊，脉

见数，稍兼芤象，尚有微热微汗，恶露未尽，以小柴胡加减

苏条荅15克 炒柴胡 香附 丹参 当归 防风 黑姜
各9克 白芍 焦芥穗 炒黄芩 甘草各6克 黄芪15克

服药后，自觉安适，睡眠饮食转好，脉缓身凉，恶露已净，稍有淡红液汁流出，虚汗亦止，唯精神尚差，投以益气养血之方，数剂痊愈。

云南中医学院附属医院

《李筱圃医案》

案二，孙××，女，35岁。因妊娠9个月感冒、发烧、头晕，肝区痛，大便呈陶土色，巩膜、皮肤黄染，于1972年11月27日引产一男婴，死胎，产后黄疸加重，四肢躯干发现少数出血点，曾疑为“亚急性肝坏死”。经中西药抢救，病情危重，并出现狂闹哭笑等精神症状。体温在38~39℃之间，心率每分钟120次/分。患者呈半昏迷状，口噤抽搐，两目上吊，大小便失禁，面目发黄，腹部膨起，胸、脉、颈满布白痞，舌苔白嫩如腐，不见舌质、齿燥，脉左细数，右弦大数无力。

辨证：妊娠湿温（产后气血大虚，内外合邪）。

治法：辛凉清热，渗淡利湿。薏苡竹叶散（汤）加味。

方药：苡仁24克 茯苓块15克 白薏仁9克 淡竹叶9克
陈皮9克 金银花15克 净连翘15克 石菖蒲18克 双钩藤
9克 合欢皮30克 首乌藤30克 甘草3克

12月14日二诊：服药6剂后，神志较前清楚，但仍有神昏谵语，体温37~38℃之间。产后阴亏，湿热伤阴，而致水不涵木，故呈肝风内动之象。

方药：西洋参4.5克（另煎） 白芍9克 龟板12克 鳖

甲12克 真阿胶9克 苡仁24克 麦冬9克 竹茹9克 生牡蛎12克（打碎） 五味子4.5克 沙参21克 炙草4.5克

12月16日三诊：患者意识渐渐清楚，黄疸减轻，瘡疹减少，体温38℃左右，皮肤灼热；上方去西洋参，加金银花、连翘、茯苓。以后曾加减使用过健脾的山药、莲子，以及养阴清热药首乌、地骨皮，或加扁豆甘淡健脾。1月11日，体温已恢复正常，食欲，二便恢复正常，整个治疗期间采取中西药结合，二月后痊愈出院。

《席梁丞治验录》

案三，梁某，女，22岁，农民。于1972年4月份顺产第一胎，产后见低热不退，未曾介意，约10天左右突然体温升高，头疼不适，经当地治疗后症状减轻，但仍低热不退，后又误为产后血虚，服大剂人参、北芪、当归、生姜之类药物，热不但不减，反而口渴不止，烦躁不安，精神萎靡，面色苍白，每天约饮水2~5公斤，勉强进食稀粥，延续二月余，于六月间抬至门诊治疗。

初见体温37.5℃，头疼不适，喉中有痰，脘闷不舒，口渴引饮，饮不止渴，大便干结，舌红、苔黄腻，脉细数无力，拟生熟地黄丸合甘露饮加减治疗。处方：

熟地30克 生地15克 元参15克 知母9克 黄芩9克
茵陈15克 丹皮9克 法夏9克

服药一剂后自觉症状减轻，再服两剂，低热退清，口不渴，能进少量软饭，诸证大减，连续服药10剂左右，上述症状基本消失，能下地活动，后再以养阴补气法调养两月余，已能参加生产劳动。

产后发热治验《新中医》1974年3期

【分析】

案一为热入血室发热。产后气血大虚，感受风寒，化热入里，与淤血结于胞宫，血热内郁，上扰神明，故证见高热汗出，神昏谵语。血蓄胞中，小腹疼痛拒按。故治疗仿《伤寒论》热入血室治法，用小柴胡汤，桃仁承气汤合方加减。小柴胡汤和解表里，畅通气机；桃仁承气汤清热攻下，活血祛淤。服药后血热淤结从大便而去，继以小柴胡汤调理而安。

案二为临产感受湿温，产后湿温邪气交结体内，化燥伤阴，以至湿热蒙蔽心包，高热神昏、痉厥，面目发黄，湿热郁蒸，外发皮肤；胸腹满布白痞，湿热邪气，夺路而出，随汗外发而致；脉数无力，舌苔白腐，皆湿热熏蒸之象。治疗宜清热利湿，宣通气机。故从湿温病治则，以薏苡竹叶散化裁。薏苡、白寇仁，茯苓块运中利湿；银花、连翘清热解毒；竹叶渗湿；钩藤止痉；菖蒲辟秽清心；合欢安神定惊；陈皮宣气；首乌藤能清热解毒，兼益肝肾。六剂后见轻，但湿热交结，其性粘滞，不能一剂即愈，故守方加减，或配滋阴熄风，或配清热解毒，或补脾健中，调理两月而愈。妊娠、新产后又患温病，确属危重，但治疗得法，亦以一轻清淡渗之品，薏苡竹叶散逆流挽舟。产后易患外感，且病证情况繁杂，并非一荆防四物汤所能包揽，还需临证细察。

案三为产后阴虚发热。先因产后阴血不足，略有低热，如能及时滋阴养血，本不致误，十日低热，不欲治疗，贻误病机，以致高热。又误服温药，重耗阴精，致低热不退。便干舌红，苔黄，脉数皆火热征象，唯脉细无力为阴虚确证，故以生熟地黄，玄参滋阴清热；丹皮凉血活血；知母、黄芩、

茵陈蒿清热渗利；半夏运化气机，亦治产后发热的法中之法。

（十五）恶露不净

【概说】

生产后，胞宫内遗留的余血浊液，叫“恶露”，正常应三周左右干净。三周以上，仍然淋漓不断者，称“恶露不净”，亦称“恶露不绝”，或“恶露不止”。如迁延下去，常使气血亏损，影响产妇健康而诱发他病。

本病发病机理，主要是脏腑受病，冲任不固，气血运行失常。发病原因有气虚不固，阴虚血热，瘀血内阻等。因气虚不固者，恶露过期淋漓不断，量多，色淡，质稀薄，无臭味。宜以补中益气汤加鹿角胶、艾叶炭补气摄血；因阴虚血热者，恶露过期不止，量多，色紫红，质粘稠，有臭味，应用保阴煎养阴清热，凉血止血；因瘀血内阻者，恶露过期，淋漓不爽，量少，色紫暗有淤块，小腹疼痛拒按，又宜生化汤活血祛瘀。

【选案】

案一，高鼓峰治一妇人，产后恶露不尽，至六七日鲜血奔注，发热口渴，胁痛狂叫，饮食不进。或用四物汤调理，或用山楂、青皮、延胡索、黄芩等药卒无一效。脉之洪大而数。此恶露未尽，留泊血海。凡新化之法，皆迷失故道不去。蓄血瘀血则以妄为常，何以御之。遂以醋制大黄30克，桃仁泥15克，干漆9克，浓煎饮之。或曰产后大虚，药勿过峻否？曰：生者自生，去者自去，何虚之有？第急饮之，果熟寐半夜，次早下黑血块数升，诸证如失矣，复用补中益气而安。

《续名医类案》

案二，黄××，女，36岁，已婚，农民。

系第五胎足月顺产，产后月余恶露不净。量时多时少，

色淡红，有时带小血块，少腹微痛，头晕心悸，面色晄白，舌质淡红，苔薄白，脉细涩。此系冲任损伤，产后气虚血滞，瘀血内阻。治宜益气行瘀，调和冲任，拟加味生化汤加党参。

方用：党参12克 川芎4.5克 当归9克 桃仁6克 干姜炭3克 黑荆芥6克 炙甘草3克

复诊：服上方三剂，恶露已止，腹已不痛。但仍感头晕心悸，舌淡红而净，脉虚细，此流血日久，冲任损伤，气血虚弱。宜峻补气血，调理冲任。拟补血汤加减。

方用：炙黄芪15克 当归9克 党参24克

上方连服5剂，诸证悉减，随访一年，月经正常。

《福建省医案》刘尚保医案

【分析】

案一为瘀血内阻、恶露不净。瘀血留阻胞宫，新血不能按正常血脉运行，故六七日新血恢复之际，忽鲜血大出。阴血伤则口大渴。失血多肝失所养，故胁痛甚。急应去瘀血，使新血恢复正常。用生地滋阴凉血，桃仁，大黄攻下瘀血，干漆苦温，性能祛瘀破症通经。张元素云：“削年深坚结之结滞，破日久凝结之瘀血。”四味大量急煎服熟睡，后下黑血块数升而愈。此案通因通用，证见鲜血奔注，仍以大黄桃仁攻逐瘀血，正是“有故无殒”之意。王世雄评论说：“此鼓峰杰出之案，然干漆可删，愈后亦不宜遽投补中益气汤。”此评论亦中肯可学。

案二为气虚不固，恶露不绝。气虚一方面不能固摄，一方面也会使血液运行缓滞，而生瘀血。故第一方用温补气血与温化汤血各半治之。二诊瘀血已祛，仍以东垣当归补血汤

加味治本为主。

（十六）不孕证

【概说】

凡婚后夫妇同居三年以上，未避孕而未受孕者，称“原发性不孕”，古称“全不产”。曾经生育或流产三年以上，未避孕而不再受孕者，称“继发性不孕”。古称“断续”。

不孕有先天生理缺陷者，古称“螺、纹、鼓、角、脉”五种，亦称“五不女”，此非药物所能医。如属病理性不孕，见肾虚、血虚、痰湿、肝郁等原因，引起冲任失调，则可随证调理，使病去而受孕。

肾虚者，命门火衰，不能化气行水，寒湿注于胞中，宫寒不孕，以《景岳全书》毓麟珠温肾益血，调补冲任；血虚者，或见阴血不足，冲任空虚，或因内热血枯，不能摄精，可用养阴种玉汤加减调养；痰湿阻络者，体多肥胖，痰湿内阻，气机不畅，胞络不通，多以启宫丸（越鞠丸方去枳壳加陈皮、茯苓，半夏），加味化湿畅中；肝郁气滞，血行不畅，冲任不调，多用付青主开郁种玉汤舒肝理气，养血调经。

此证治疗，与调经有密切关系，无论何种原因，多致冲任失调，月经异常。因而调理月经病对治疗不孕有很重要的意义，故古云：“调经方可种子。”

【选案】

案一，李××，女，32岁，初诊日期1975年5月22日。

结婚八年未孕，月经初潮17岁，周期50～60天，量少，色淡红或暗红，持续2～3天，末经1975年5月22日。小腹隐痛，腰膝酸痛，形寒肢冷，食纳欠佳，精神疲乏，小便清长，脉象细弱，舌质淡红，舌苔白薄，综上述证，乃脾肾两

虚，气血不足，治宜补脾益肾，温润填精。

诊刮病理报告：月经期子宫内膜分泌不良。

输卵管通气术：通畅。

爱人精液检查：属正常范围。

妇检：外阴阴道正常，宫颈光滑，子宫前位，核桃大小，活动质地均正常，双侧附件无异常。

方药：毓麟珠加减

熟地15克 白芍12克 川芎6克 当归6克 香附12克
党参12克 白术9克 炙草6克 鹿角霜12克 枸杞12克
川断12克 巴戟10克 川椒4.5克 服5剂。

二诊：1975年6月2日，服药后精神好转，食纳增加，改用育宫片治疗，一日3次，每次6片，连服育宫片五月余，月经对月，周期30天左右，量亦增多，诸证悉愈，于1976年7月顺产一活婴。

湖北中医学院附院《黄绳武医案》

案二，叶氏，30岁，广西蒙山县人，已婚多年不生育，某医院妇科检查诊为输卵管粘连。1975年夏季诊，据述月经周期尚准，唯经来量少，色暗，经前乳房作胀，行经小腹作痛，伴见口干苦，舌胖苔白厚。某医院用中药疏肝清热及西药治疗，罔效。审其症苔，属水亏木旺，肝经气郁，冲任失调。冲为血海，任主胞胎，冲任二脉失调，故行经量少，不能孕育，遂与逍遥散加味主之：

柴胡4.5克 薄荷3克 当归9克 白芍9克 白术9克
茯苓9克 菟丝子12克 枸杞12克 藿香9克 神曲9克 丝瓜络9克 木通6克

前方连投20剂。复诊，白厚之苔已少，又与原方中加

丹参、泽兰活血化淤，继服10剂，乳胀，口干苦均除。后经讯不至，恶心疲劳，自知已受孕，但不久流产，1976年冬再次受孕，四个月，忽又见红，但不久流产，并见口苦尿热，小腹疼，舌面红，为处保胎方，荆芥四物汤加茅根 藕节 川断 桑寄生 地榆炭 阿胶 服后而安。

《医话医论荟要·沈仲圭医案》

案三，王××，女，32岁，医生，初诊日期：1976年4月5日。

患者结婚四年多未孕，一向月经不调，均属后期，周期35~50天不等，量或多或少，经期少腹胀和腰酸，末经5月10日。

妇检：外阴发育正常，未产式，阴毛较粗而密，阴道可容二指，宫颈光滑，子宫大小正常，平位，左侧可扪及卵巢增大如荔枝样。

左乳晕有一黑毛长约4厘米，足毛较多。

舌嫩红少苔，脉沉细。

诊断：经北京，广州西医院诊断为多囊性卵巢综合征。

中医诊断：月经不调、不孕证。

治疗：遵西医嘱服用克罗米芬。

中药用补肾养血，行气调经。

方药：菟丝子30克 熟地20克 当归15克 川芎10克 党参15克 枳壳12克 淮牛膝15克 淫羊藿10克 肉苁蓉15克 杞子15克 嘱每次月经净后配服，两天1剂、留渣再煎，连服10剂。

以上方的基础，选用乌药 香附 首乌 川 楝子 白芍等适当加减化裁。经过半年的治疗，月经周期已基本恢复

正常，约30~35天一周期，经量中等，持续5~6天。仍囑继续服药调治，按上方以桑椹、金樱子、黄精、女贞子等出入其间，而1977年2月怀孕，孕后两个月，因房事曾引起少量阴道流血的先兆流产症状，经治疗后胎元得以巩固，至年底安然产下一女婴，母女健康，今已二岁多。

《罗元恺医著选》

案四，黄××，女，24岁，婚后三年不孕，月经后期，带下黄稠量多，伴小腹及腰疼半年，于1963年5月2日来院初诊。妇科检查：宫颈光滑，子宫二度后倾，较正常稍小，有深压痛，两侧附件均有明显压痛。经量少，色暗质薄，腹疼拒按，常头昏痛，倦乏，多梦，心烦，口渴，溲黄，便秘。面色萎黄，舌尖红，有朱点，脉弦数。湿热郁结，气虚血滞，拟消热化湿，益气活血。处方：银甲丸合四君子汤加减。

银花 连翘 红藤 蒲公英 升麻 炒川楝 炮甲珠
生蒲黄 益母草 党参 生黄芪 茯苓 桑寄生 菟丝子
鸡血藤 琥珀末

前后共就诊26次，随证选用五灵脂，茺蔚子 茜草 广木香 炒白芍 鹿角片 杜仲 续断 山萸肉加减化裁，服药期间，月经时腰腹痛亦渐消失，带色转白，量亦减少，至同年11月，经期也未腹疼，白带正常。妇科检查，除子宫有深压痛外，余均正常，再继续服药，并加服银甲丸，于1964年2月23日作输卵管通气实验，结果通畅，继而受孕，并于次年1月顺产一女婴。

《著名中医学术家的学术经验·王渭川医案》

【分析】

案一为脾肾阳虚，宫寒不孕。月经自来量少色淡，经期

后衍，腰膝酸疼，形寒肢冷，小便清长，肾虚之象。饮食欠佳，精神疲乏，脾气不足之证，以脾肾双补法治之。方用毓麟珠方（即八珍汤加菟丝子、杜仲、鹿角霜、川椒），去茯苓之淡渗，加香附以温中；加枸杞子，川断、巴戟温阳补肾。5剂即中阳得运，继以育宫片补肾益精，月经得正常，即孕育王子。

案二为肝郁气滞型不孕。冲为血海，任主胞胎，冲任又隶属于肝肾。肝郁气滞，必冲任不调，气血不和。证见经来量少，色暗，两乳作胀，少腹疼痛，皆肝气郁滞之象，故以逍遥散加味。舌胖苔白厚，加藿香，神曲醒脾化浊利气机；加枸杞，菟丝子益肝肾；丝瓜络清热凉血，宣通经络；木通清热利湿，可利九窍；两味合用，可通络脉痹阻，亦叶天士久病入络之意。继以原方加泽兰、丹参兼和血牙郁，后又以荆芥四物加味保胎。

案三为肝肾虚弱，血少不孕。月经素来延期，少腹胀疼，腰酸，舌红少苔，脉细沉皆肝肾不足，冲任不调之证。首用平补肝肾，益精养血之品，继而再以舒肝行气加減进退，半年而月经正常。再加用补益肾精之品，即得怀孕，又以保胎治疗，使平安生产。

案四为气虚生湿、湿热下注不孕。脾气不足，水湿不运，积湿生热，湿热下注，故带下黄稠。湿热中阻，气机不畅，则气血运行不利，故有淤滞之象，经量少，色暗，小腹疼。治疗宜标本同治。益气治本，则水湿不生，用升麻，党参，黄芪、茯苓补中益气；湿热不去，则气机不畅，故用银花、连翘、红藤、蒲公英清热解毒；淤血不去，新血不生，又以川楝子、山甲珠、蒲黄、益母草养血活血；久病冲任

伤，再加桑寄生、菟丝子、鸡血藤补肾益精；琥珀既可利水去湿，又可活血去淤。银甲丸系王渭川先生据《温病条辨》银翘散及《金匱要略》升麻鳖甲丸合方再增入活血化湿解毒诸药配合而成。配制如下：银花 连翘 升麻各15克 红藤 鳖甲 蒲公英 紫花地丁各30克 生蒲黄 椿根皮 大青叶 琥珀末 茵陈 桔梗各12克 共研细末，₂练蜜为丸，每丸3.5克，每服1～2丸，每日2～3次。乃王氏临床屡效之方。

不孕属难治之证，非朝夕所能收功。病家虽求子心切，奈医者无速成之术。故须辨证准确，有方有守，坚持治疗，自能成功。

（十七）症瘕

【概话】

症瘕是指腹内有结块，并伴有胀、满、疼痛的一种病证。男女皆有，但多见于妇女。

症瘕积聚同病而异名。症与积、坚硬成块，固定不移，推揉不散，疼有定处，病属血分；瘕与聚，痞满无形，聚散无常，推揉转动，痛无定处，病属气分。但每有先因气聚为瘕，日久则血淤为症，不能截然分开，故每每症瘕并称。

发病多因气机阻滞，淤血内停，临床分为气滞为主，血淤为主两种。气滞型，积块不坚，按之可移，时聚时散，或上或下，时有疼痛，并无定处，宜用《济生方》香棱丸行气导滞；血淤型，积块坚硬，疼痛拒按，坚定不移，应用《金匱要略》桂枝茯苓丸破淤消淤。

本病应注意，辨明气病，血病，治疗则应结合病程新久，体质强弱全面考虑。分别采用先攻后补，先补后攻，或攻补兼施等法，并应遵循“大积大聚，其可犯也，衰其大半

而止”的原则，不可峻攻猛伐而损伤元气。

【选案】

案一，吕××，36岁，干部，1963年6月初诊。

主诉：月经量多，有大血块，伴有腹疼，每次月经用纸4～5刀，曾分娩4次，末次分娩在六年前，既往有高血压病史。

妇科检查：外阴正常，阴道通畅，子宫颈中度糜烂，子宫体如妊娠两月大小，质硬，双侧宫角突出，附件阴性，宫腔9厘米，经诊断性刮宫、病理报告为增生期子宫内膜有轻度增殖现象，患者要求保守治疗。

脉和缓，两尺沉细，舌质红，舌苔白。

治则：活血化淤，通经活络。

方药：桂枝茯苓汤加味。

桂枝9克 茯苓12克 炒桃仁15克 赤芍12克 丹皮 酒大黄各9克 鳖甲12克 水煎服，每月12～18付，月经量多时服血净饮片，连续服用3个月，月经基本恢复正常、经按期复查，子宫无增大，64年9月患者断经，妇科检查，子宫如妊娠四个月大小，无其它异常发现。

《中西医结合治疗常见妇科病病案》

案二，苏×，51岁，病历号183579

初诊：1971年8月24日，患子宫肌瘤十余年，月经先期，15天一次，5～6天净，量多。近一年来，月经周期紊乱，先期十五天，或后期50～90天，3～4天净，量多。末次月经8月2日来潮，三天净。头晕口苦，失眠便秘，舌苔薄黄腻，边有齿痕，脉细滑数，妇科检查：子宫肌瘤如孕八周大小。病因由于气阴两虚，痰气郁结，治以益气养阴，化

痰软坚之法，方用生脉散加减。

处方：北沙参12克 麦冬9克 五味子6克 茯苓12克
夜交藤12克 女贞子12克 昆布12克 海藻12克 生牡蛎15克
土贝母12克 莲肉12克

以上法治14个月后，已绝经，宫体亦萎缩。

《钱伯煊医案》

案三，杨××，女，33岁，已婚，病历号65937。初诊日期：1961年10月6日。

患者述曾患两侧卵巢囊肿，经××医院检查证明，右侧卵巢囊肿3.5~3.5厘米，因不愿再做手术，特来就诊。

患者平素月经赶前错后不定，色量正常，惟觉体倦神疲，平日白带不多，近感右胁及脘腹有时疼痛，睡眠不好，脉弦弱兼滑，96次/分，右寸力弱，舌淡苔白，语声轻微，精神不振。

根据脉证，此系气逆血留壅滞，结为症瘕，但精神不振，语声低微，右寸脉无力，却属精神亏损之征；右胁脘腹时痛，睡眠不佳，又有肝胃失谐之象，此邪实正虚明显可知（由于××医院检查，本院未做内诊），拟攻补兼施之法。

方药：篇蓄草12克 刘寄奴 茯苓各9克 煅云母 军炭 丹皮 赤芍 炙甘草各6克 桂枝 桃仁泥 醋三棱各4.5克 别直参3克 连服3剂。

10月10日二诊：右胁及脘腹疼痛减轻，睡眠好转，腹泻日三二次，无腹痛。昨晚月经来潮，量正常，色较褐，周身乏力。脉弦滑，右手较细，舌薄苔白。

患者说：“已决定去南方，请酌拟汤药，丸药各一方，以便常服。”方药：

刘寄奴 煅云母 醋炒大黄炭 茯苓 赤白芍各9克
 篇蓄草15克 桂枝 桃仁泥 醋三棱各4.5克 丹皮 生甘草
 各6克 鸡内金12克(炒) 别直参3克 水煎服(此方可常
 服)。

丸药方：茯苓 桂枝 桃仁泥各30克 丹皮36克 赤白
 芍各18克 真红曲15克 上药共为细末，蜜为丸，每丸重3克
 每日早晚各服一丸。

1962年3月8日三诊：服汤药50余剂，丸药仍在续服，
 月经自去年12月18日来潮后，至今2月28日方行，3月5日
 月经又来，量少色黑，夹有烂肉样物，现少腹左侧有时隐
 痛，精神困倦，食眠尚好，脉弦滑，84次/分，右寸仍少
 力，舌边有齿痕，苔薄白。淤结已通，精力犹弱，宜补气健
 脾，调和冲任。方药：

桑寄生18克 续断12克 焦白术 生地各9克 生白芍
 焦六曲各15克 桂枝4.5克 白蔻 别直参各3克(2次分冲)
 炙甘草6克 鲜姜3片 水煎服3剂。

3月13日四诊，月经于10日已净，少腹右侧偶有隐痛，
 乘车颠簸时痛较甚，精神有时较差、饮食、睡眠好，小便正
 常，大便溏，脉略弦滑，右较细；苔白腻，舌边缘有齿痕。
 方药：

桑寄生30克 续断 鸡血藤各12克 焦白术 鸡内金
 生橘核 焦山楂各9克 桂枝 川楝子 各4.5克 炙甘草6克
 鲜姜3片 服3剂

4月7日五诊：患者述经××医院检查，右侧卵巢囊肿
 已消失。

马龙伯：卵巢囊肿医案

三则《新医药学杂志》1975年10期

案四、陈姓女，23岁，某年春三月，午后来蒲老处求诊，自诉月经三月多未潮，渐渐腹疼痛，小腹硬，手不能近，连日流血，时多时少，坠胀难受，食欲减少，某医院检查，认为是妊娠，已五六月，而患者自知非孕，与第一、二次妊娠不同。观其颜青，舌色紫，扪其腹，拒按，大如箕，脉象沉弦涩。末次月经是去年十二月中旬，正在经期，随夫运货，拉车于旅途之中，自此月经停止，下月应至不至，蒲老指出：此病实非孕也，腹大如箕非三月孕形，腹胀痛而小腹坠甚，拒按而坚，亦非孕象；且连月流血而腰不痛，又不似胎漏。此必经期用力太过，兼之途中感受气候严寒所致。

《灵枢·水胀篇》曰：“石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，衄以留止，日以益大，状如杯子，月事不以时下，皆生于女子，可导而下。”此女体素健壮，主以当归饮，血竭散合剂：

当归6克 川芎6克 醋制鳖甲15克 吴萸4.5克 桃仁
赤芍各6克 肉桂3克 槟榔3克 青皮3克 木香 莪术
三棱 大黄各3克 元胡6克 血竭3克 浓煎温服，此
方乃温通破坚之剂，服一剂，下掌大黑血一片，痛稍减、坠胀不减，脉仍如故。乃以原方再进，并随汤药送化症回生丹一丸，次日其妹来告：服药一时许，患者突然昏倒，不知人事，手足亦冷，见下衣皆湿，宽衣视之，皆为血块，大如碗者一枚，余如卵者数枚，色多淤黑，不一会，手足自温，神志渐清。今日有恶心，不思食，昨日之药，能否再服？患者自觉小腹疼痛俱减，但觉尚有似茄子硬块未去，蒲老思之良久说：“大积大聚，衰其半而止，大毒治病，十去

其六，况血海骤空，胃虚不纳，宜急扶胃气。原方止后服，易以异功散加味：

党参6克 白术 茯苓 炙甘草各6克 砂仁 香附 陈皮各3克 当归 白芍各6克 生姜3克 大枣4枚 嘱服2剂。越三日，其妹来告：“患者服药后，胃口已好，睡眠亦安，已不流血，惟连下豆渣状物，今晨复下卵大硬块，色白，坚如石，弃之厕中。”惜未将其送化验室分析。再以十全大补，连服3剂，诸证皆除，惟全身浮肿。蒲老告之曰：“此虚肿也。”仍以十全大补肉桂易桂枝又进三剂，身肿消失，精神渐复，停药，以饮食调理，又一月恢复健康，月经应期而至，一切如常。

《蒲辅周医案》

【分析】

案一为淤血内阻症瘕，为西医诊断明确的子宫内膜增殖。子宫体已大如妊娠二月，腹疼，月经量多，夹有大血块，显然是淤血内阻。已成症瘕。治疗以茯苓桂枝丸方加大黄祛淤生新；鳖甲软坚化结。连服三月，配合血净饮片，子宫便恢复正常大小。血净饮方（白术15克 黄芪30克 龙骨₁8克 牡蛎12克 生地 海螵蛸各8克 茜草9克 川断12克）。

案二为痰气郁结内生症瘕。因痰气郁结，阻碍气血，使月经周期紊乱。痰结生热，消耗阴血，故口苦、便秘，舌苔黄腻，治疗用生脉散益气养阴；加茯苓、夜交藤、女贞，连肉养血安神；用昆布、海藻、生牡蛎、土贝母软坚化结，消瘕去淤。用上述药物，配用龟板、鳖甲、乌贼骨、蛤壳、海浮石等治疗西医诊断明确的子宫肌瘤，使其软化，缩小，消

失乃钱老临证经验。

案三为气滞血淤生成症瘕，已经一次手术，又患右侧卵巢囊肿，病多反复，正气不支，治疗宜扶正祛淤，用桂枝茯苓丸方加别直参，（即朝鲜人参，道地药材，质量好）益气养血，活血化淤；加大黄，醋三棱，刘寄奴，煅云母，消淤破坚 除症 篇蓄草配大黄，开通下窍，使淤血从下而走，继用原方进退调理，待淤血从月经而去后，以补气健脾，行气活血而效。

案四为石瘕。发病正如内经所云：因寒气客于胞中，血淤留止，瘕症内生，如怀子状月经不通，治以活血祛淤，温经散寒之品，浓煎温服，一剂立下黑血片。再服汤药一剂送化症回生丹即下黑血块多量，几乎昏厥。仍有拳大包块未去，但“衰其大半而止”，故以温补脾胃之品与之。服后正气来复，又下鸡蛋大，坚硬如石的块状物，乃以十全大补调理而愈。

此案中辨证十分清楚，尤其指出其非孕为瘕的三点依据，确凿无疑，循前后缓急治法，又有条不紊，竟使一如卵大的石瘕顺利排出，读案至此，颇有叹为观止之感。石瘕并非一般症瘕，今人报道不多，唯我国1980年曾报道上海从一怀孕三十年来产的妇女腹中取出一成形的化石胎儿。而我国历代医案中却有几则记载，足可证明：石瘕是以化石胎儿为主的一类症瘕疾患。

（十八）脏躁

【概说】

妇人精神忧郁，烦躁不宁，哭笑无常，频作呵欠，称为“脏躁”常可伴有胸闷、头晕、失眠等证。多发于女子青春

发育期和更年期。发病多由于心脾两虚，精血不足，心神失守或肝肾阴虚，五脏失养，虚火妄动，上扰心神。亦有因肝气郁滞，积久化火，暗耗肝阴，虚火扰乱心神而生。《金匱要略》指出诊疗宜用甘麦大枣汤滋润五脏，而不宜苦寒清热。归脾汤、百合地黄汤，丹栀逍遥散皆可随证选用。

【选案】

案一，李姓妇人，年30余，农民。1954年春，因抑郁寡欢，内心畏怯，渐至不言不笑，畏见光，多呵欠，闻声则惊恐倍增，不时悲伤痛哭，涕泪纵横，询之，病人自谓二三月来身畔常见一人跟随，终日不离左右，呼之不应，驱之不退，颇以为累。诊得脉沉细而微，舌白，面色黯然。据《金匱·妇人脏躁病及五脏风寒积聚篇》谓：“邪哭使魂魄不安者，血气少也，血气少属于心，心气虚者，其人则畏，合目则眠，梦运行而精神离散，魂魄妄行。”因之诊为妇人脏躁，以甘麦大枣为主，方用：

生甘草12克 小麦30克 大枣10枚 归身9克 柏子仁9克 茯神9克 远志9克 酸枣仁9克（炒） 五味子8克 赤油桂15克 煎服3剂而愈。

印会河：印会河医案《中医杂志》1959年9期

案二，马元仪治吴氏妇，两寸浮数，余脉虚涩，时悲哀不能自禁，喉间窒塞，火升痰喘此忧郁过多，肺金受病也。金病则火动痰生。火痰相搏，气凑于上，故喘促不宁，而气道不利，法当疏通肺郁，则火降痰清，而悲哀喘促之症自己。用紫菀、干葛、枳壳、桔梗、半夏曲、橘红、杏仁、苏子一剂而神气清，再剂而悲哀息。继以人参，炙甘草补其心气。远志、茯神宁其神志。半夏曲、广皮导其痰涎，肉桂、黄连以

交心肾，数剂而神复脉和，以归脾汤调理而愈。

《续名医类案》

【分析】

案一为心血不足，心神不安，故以柏子养心丹方与甘麦大枣汤合方化裁，其中赤油桂（即好肉桂）一味宣通心阳，与诸养心血药配伍尤有妙用。

案二为痰火郁结。壅塞于肺，肺气不宣，而生咳喘，肺病则胸中阳气不宣，心神不安，故悲从中来，以止嗽散方加减治肺中痰热。继以甘温药物补脾生肺宁心，配肉桂、黄连交通心肾。终以归脾汤补益心脾而愈。治脏躁重在甘润五脏，临证牢记。

（十九）阴痒

【概说】

妇女阴道内或外阴部瘙痒难忍，坐卧不安，伴有不同程度的带下，称阴痒。是由于妇女情志不舒，肝郁生热，郁热下注而生。亦有多数是由于体内本有湿热，注于下焦，再加外阴不洁，感染虫毒，湿热为病虫繁殖提供了有利条件，以至虫蚀阴部而作痒。前者多有带下量多，色黄有臭，口苦舌腻，脉弦滑数等证，宜用龙胆泻肝汤，当归龙荟丸之类清热利湿，泻肝止痒，后者多有白带量多，呈豆腐渣样，米泔水样或泡沫样。并且心烦、少寐，食欲不振等，宜用萆薢渗湿汤加鹤虱、芜荑等清热利湿，杀虫止痒。

此外，可用外治法配合治疗，效果更好，如薰洗法，以蛇床子、苦参、鹤虱、花椒配伍煎汤外洗。坐药杀虫法，将杀虫剂作成锭剂，纳入阴道杀虫。外涂药膏及药粉法皆可取效。

老年妇女多因精血两虚，肝肾阴亏，血虚内燥，致生阴痒。见到阴部干燥，灼热瘙痒，带下量少色黄，甚则夹血脓样，宜用知柏地黄汤加味滋阴降火，调补肝肾。

【选案】

案一，李××，女，35岁，已婚，1972年6月15日初诊。

两月来，外阴部发现有红色丘疹，瘙痒不堪，甚则疼痛，抓破后分泌黄白色液体，随后可干燥结痂。如此反复发作，以致心烦少寐，坐卧不安，并有胸闷不舒，口干且苦，小便赤涩，带多色黄等症。月经尚属正常，但经后诸症加重。刻诊经期始过，外阴奇痒，余证如前。舌质红，苔黄腻，脉滑数。此乃肝经郁火，湿热下注为患，拟清利湿热而止痒。

处方：龙胆草 川草柏 炒山梔各9克 生苡米30克 赤茯苓 滑石块 车前子（布包）各9克 紫草根 干虎杖各12克 地肤子 白藓皮 海桐皮各9克 6剂水煎服。

另用紫地丁15克 川黄柏6克 淫羊藿6克 蛇床子9克 6剂布包泡水，坐浴熏洗，每日2次，另以珠黄散三瓶，黄柏面6克 紫荆皮粉9克，共研匀，香油调呈糊状，摊于消毒纱布上，于临睡前敷贴患处，晨起去掉。

二诊 6月23日

经服上方，并配合外治法一周后，阴痒显减，带下亦少，外阴部原有之溃疡均已干燥结痂，未见新溃疡面，余症亦均轻减，腻苔亦退，脉滑略数。

嘱内服二妙丸，加味逍遥丸各一付，每日上下午分服，白水送下，继用前述外治法。10天后结痂脱落，痒感消失，

遂停药。于7月12日月经来潮，经后未见反复。

《哈荔田妇科医案医话选》

【分析】

本案为肝经郁火，湿热下注，又因瘙痒抓挠，外阴感染，故破溃流水。以龙胆泻肝汤加减，泻肝火，利湿热。方中赤茯苓、苡米、滑石、紫草根均擅利湿热，除带下，解毒止痒。尤其配合白藓皮、地肤子更能胜湿止痒。虎杖一药，清湿热，利肝胆，解毒止痒，治带之力颇著，乃哈老治带惯用之药。又能恰当配合外敷外洗法，强化治疗，故取效甚速。

三、儿 科 医 案

（一）鹅口疮、口疮、口糜

【概说】

患儿口腔舌上满布白屑，状如鹅口，故名鹅口疮，亦称“雪口”，主要原因是由口腔不洁，感染病毒所致。婴儿口疮粘膜嫩薄，损伤感染极易，因而是新生儿常见的疾病。尤以早产儿，体质羸弱，久病乳儿为多见。本病蔓延颇速，若白屑侵及咽喉食道，堆积如雪花，可障碍呼吸及吮乳，必须及时处理。

临床分为心脾积热和虚火上浮两类。心脾积热者，面赤唇红，烦躁啼哭，指纹紫滞，多用《医宗金鉴》清热泻脾散清热散火，并配合外治法用冰硼散涂擦患处；虚火上浮者，体弱颧红，大便溏泄，指纹淡红，宜以六味地黄汤加肉桂壮水制火。

口疮则是在口颊、舌边，上腭等处，发生白色溃烂小疮，并见红肿疼痛，间或发热。口糜是满口糜烂，色红做痛，均可出现流涎拒食，躁扰哭闹等症状，发病机理基本与鹅口疮相同，可参照鹅口疮处理。

【选案】

案一，宋××，男，1岁，1966年4月7日初诊。

口内疼痛半月余，身体较弱，原有腹泄为淡黄色稀便，2~3次/日，现小便短赤。

检查：体温38.2℃，精神好，口腔有散在脓疱疹，舌质红，少苔，脉象细微数。

印象：疱疹形口腔炎，消化不良。

辨证：脾虚泄泻为本，心脾虚蕴热为标，本虚标实，急则治标，先拟清心脾之湿热，再拟整肠止泻。

处方：炒泽泻4.7克 陈皮6克 黄柏6克 黄连8克
花粉9克 白芷1.6克 竹叶1.6克

加服小儿牛黄散，每日2次，每次服0.3克外用珠黄消疳散涂抹。

服药一日热退，尿色转清，口疮有所好转，但仍腹泻，继用前药加服磨积片，每日2片，每日2次，经治三日而愈。

《何世英儿科医案》

案二，李×之子，口内起白点三天，经某医治疗无效。口内白点一天比一天多，不吮乳。查：口舌唇皆白点连成片状，且蔓延扩散向咽部，不吮乳。

拟方：生地8克 白茯苓2克 淡竹叶2克 木通4克
蝉蜕1克 甘草1克 舌焦无津加石斛8克，2剂。不分次

数频频喂服，外用鹅口末药3克，分10次，每隔2小时一次将末药醮放舌上，次日复诊，舌内白膜全部退清，能吮乳。勿需再处方，用完上药痊愈。

孙恒泉：婴儿鹅口疮《新中医》1981年3期

【分析】

案一为口疮，原因消化不良，脾胃不足，故积食聚湿，容易有病理产物堆积生热，所谓“泄泻为本，蕴热为标”本虚标实，口疮不能进食进水，急则治标，方用陈皮、白芷、泽泻健脾利湿；黄连，黄柏清郁热；竹叶，花粉养阴清热。并加服小儿牛黄散清热解毒，外涂珠黄散，何老经验，西医诊断为疱疹性口腔炎者，以小儿牛黄散治疗效果迅速，西医诊断为溃疡性口腔炎者，中成药赛金花丹疗效较好。

案二为鹅口疮，患儿内有积热，心脾热毒，循经上攻，又外感不洁而生鹅口疮。治疗宜清心火解热毒。配方为导赤散加味，加白蒺藜、蛇蜕发散外邪，清热解毒，另配外擦药。鹅口末药为硼砂50克 明雄黄20克 牛黄3克 儿茶3克 人中白4克 共研细末，罗细贮瓶备用。功能清热解毒，主治鹅口疮，为湖南张恒泉医生家传六代有效之方。

（二）小儿呕吐

【概说】

呕吐为儿科常见疾患。很多疾病中都可出现呕吐。小儿脏气清灵，脾胃较弱，多种病因都能影响脾胃，导致呕吐。严重呕吐，会耗伤阴液，诱发痉厥。

发病多由乳食不节，食滞中脘，脾胃蕴热，热气上逆；或脾胃虚寒，冷气上冲，胃阴不足不能润降；或跌扑、惊吓、胃气上逆所致。

食滞中脘者，有暖气食臭，呕吐酸腐，大便秘结或泻下酸臭等症，用保和丸加减消食导滞，脾胃蕴热者，见口渴喜饮，食入即吐，身热唇红等证，治以黄连温胆汤加藿香清热和胃，降逆止呕；脾胃虚寒者，多发病缓慢，病程长，呕吐时发时止，吐物为不消化食物或清涎粘液，当用理中汤，参苓白术散加减温中健脾，散寒止呕；胃阴不足者，知饥不食，时发干呕，便秘潮热，应用益胃汤加味滋阴清热；夹惊者，恶心、呕吐，睡眠易惊，又应以定吐丸平肝镇惊，降胃止呕。此外小儿虫证，急性瘟疫证，急性腹证中亦常发生呕吐，必须注意鉴别诊断。

【选案】

案一，黄儿，五岁，因伤食吐泻口渴。医者不问病原，冒然进以温补药，企图止之，病反剧，后医又以水湿分利失常，治以五苓散，渴未减而吐利如故。余视其指纹淡红隐隐，心烦欲饮，水入则吐，食亦少进，舌苔黄白而腻，腹鸣下利，时呕，大便稀，色淡黄有腥气，嗜睡少动，病逾月矣。综合判断，乃系肠热胃寒，食积湿困之象，即不可温，又不可汗，治宜寒温并用，处以半夏泻心汤。半夏降逆止呕，参、姜益气温中，苓、连清理肠热，枣、草、甘温和胃，枢转其间，增茯苓健脾利水，花粉生津止渴，以宏效果。服后吐泻均减，再剂病瘳。惟病久虚，进以参苓白术散平调脾胃，十剂能行，又半月而健。

赵守真《治验回忆录》

案二，刘××，女，初生19天，因颜面头部，多发性小脓肿疱疹三天，于1961年3月15日入院。

患儿皮肤，巩膜软腭黄染，黄疸指数90单位，胆红质10

毫克%，凡登向直接(+++)、间接(+++)，麝香草酚浊度8单位，尿三胆及胆红质(-)。诊断：①新生儿败血症，②脓疱病，③生理性发黄。经用抗生素及输血，脓疱已瘥，惟黄疸日渐加重，大便色白，外科排除先天性胆道梗阻。会诊时患儿皮肤、面目已发黄一月，有时呕吐，脘部胀气，小便短赤，舌淡红。

辨证：胎毒内蕴，湿热不尽，肝脾郁滞，发为胎黄。

治法：疏肝化湿。

方药：茵陈6克 白术10克 枳壳5克 桂枝8克 茯苓12克 法半夏5克 鸡内金1枚 炮姜8 2付。

复诊：黄疸减退，因更换乳食致腹泻7次此系脾胃娇弱，运化失调，治以温中健脾利湿。

茵陈6克 白术10克 茯苓10克 桂枝8克 苍术6克 炮姜8克 苡仁10克 砂仁8克 法半夏5克 麦芽10克 鸡内金1枚 2剂。

三诊：腹泻已止、乳食佳，黄疸渐退，大便色黄，继以扶脾化湿之六君汤加茵陈退黄为主。乳食积滞加曲、麦，鹅口疮加白薏仁，厚朴、通草等调理善后。

《廖浚泉儿科医案》

案三，万密斋治教谕熊文村子，二岁病呕吐，数医不效，食饮入口即吐出。万视之曰：病可治也。用何方？曰：理中汤。又问曰：服多剂不效奈何？曰：如在内经，乃阴盛隔阳之病，寒因热用，伏其所主，先其所因则效矣。乃做一剂，取猪胆汁，童便各半和药炒干煎而服之，吐立止。后称渴以汤饮之，复作吐。万曰：凡呕家多渴者，胃脘之津液干也。当得一二时，吐止胃气回，津液生，渴自止矣。令将前

药渣再煎服之，仍禁其饮食，半日而安。

《续名医类案》

【分析】

案一为伤食吐泻，因为伤食，中焦痞塞，下则肠鸣腹泻，清气下陷。上则有胃气不降，湿浊填塞，呕吐食少。误服温补助热，误用渗利更伤阴液，故见口渴欲饮。证属下寒上热，中焦不通。治疗宜仿《伤寒论》治痞之法，用半夏泻心汤加茯苓健脾运湿，加花粉生津止渴，二剂则吐泻止，以参苓白术平调脾胃而愈。

案二为胎毒内蕴，湿热郁蒸，外发脓疱疹。又湿热郁内，肝脾不利，既发黄疸。湿热干扰脾胃升降，胃气上逆，则脘部胀气，时有呕吐，治疗疏肝化湿，清利湿热。方用健脾利湿之剂加茵陈蒿、枳壳宣通气机，清利肝胆。守方调理，使黄疸退，呕吐止。

案三为脾胃虚寒型呕吐，理中汤乃为正治之方，首服不愈者，因其胃寒既甚，热药猛入，有格拒之患，犹如烧红之锅，以冷水淬之立破、应改变药物服法，加猪胆汁，童便拌理中汤料炒干煎服，取《伤寒论》白通加猪胆汁方义，寒因寒用，反佐取之。药入胃，童便咸寒，猪胆汁等寒药之性先发凉性，与胃中寒气不逆，纳药则热性乃发。此启玄子奥义，张仲景良法也。

（三）小儿泄泻

【概说】

大便次数增多，粪便稀薄，或如水样，称为泄泻。为二岁以下婴幼儿多发病。四季皆有，以夏秋两季多发。严重泄泻会耗伤气阴，导致液涸阳脱的危重证候；如果迁延不愈，会

使小儿营养不良、发育迟缓，必须及时治疗。

发病原因由内伤乳食，感受外邪，脾肾虚弱等。内伤乳食，因乳食过度或恣食生冷油腻而致。见腹胀腹疼，大便腐臭，泻后痛减或吐泻兼做等证，宜用保和丸消食导滞；感受外邪者，因感寒、暑热、湿困等引起肠胃紊乱致泄泻。有寒泻，湿热泻之分，寒泻者，稀沫便多，肠鸣腹疼，伴有发热鼻塞流涕，应以藿香正气散散寒祛湿止泻；湿热泻者，大便如水样，内夹不消化食物，肛门灼热，可用葛根苓连汤加味清热利湿；脾肾虚弱型，则见久泻不愈，便溏完谷不化、宜七味白术散健脾止泻或四神丸，附子理中丸温补脾肾。

古人云“泄泻不离脾与湿”，亦为经验之语。如腹泻兼里急后重，下利赤白，高热神昏等则属疫毒痢，当与此证做鉴别诊断。

【选案】

案一，庞某，女，4个半月，于1970年7月1日入院，住院号10749。

发热、腹泄、呕吐十余日，近五天病情加重。

入院五天来仍发热，腹泄也未减轻，昨日达22次，有时呕吐，口不渴，自昨日禁食12小时，要求中医会诊，在止泻方面积极发挥中药作用。

7月6日中医会诊所见：精神弱，面色晦暗，前囟及眼窝凹陷，腹部胀满，肠鸣音弱，大便呈淡黄色稀便，量多，尿少。舌质红，舌苔白腻而粘；脉象濡滑而数，体温39℃。

印象：中毒性消化不良、脱水。

辨证：暑湿夹食作泻。

治则：清暑解表，利湿止泻。

处方：六一散12.5克 藿香4.7克 葛根4.7克 云苓6克
大腹皮6克 炒扁豆6克 姜厚朴3克 苏叶3克 1
剂。

7月7日复诊：今日热退，身有微汗，未呕吐，腹胀减轻，尿渐增多，大便每日10次（禁食下）色质略有好转，口润，舌已不粘腻。证属暑湿渐化，脾虚益显，拟集中药力，健脾止泻。

处方：党参9克 云苓9克 炒白术9克 炒泽泻9克
广陈皮9克 白扁豆9克 莲子肉9克 炙甘草3克 炒山药
12.5克 六一散9克 煨肉果6克 大腹皮6克 苍术4.7克
2剂。

7月9日复诊，精神好，纳可，腹胀消失，昨日大便10次，夜半至今晨大便2次，水分已少，尿量增多，脱水证（+），已停止静滴。

处方：党参9克 云苓9克 炒泽泻9克 破故纸9克
炒白术9克 炒苡米9克 炙甘草3克 每日1付。

7月13日复诊：一般情况好，面色红润，精神好，大便日2~3次，色质正常，通知出院。

《何世英儿科医案》

案二，张××，男，2岁，1982年7月12日初诊。2天前，因食黄瓜过量，引起腹泻，当时大便稀水，每天10余次，伴有烦躁不安，饮食欠佳，小便少，色黄等。经服土霉素，保和散未能收获。现大便色黄，稀而臭，并夹有粘液，肛门灼热发红，舌质红，苔黄腻，指纹紫。诊为湿热腹泻。拟用：

黄芩10克 白芍5克 乌梅5克 水煎服，1天3次，

每剂服3天，服药1剂，大便次数明显减少，继服1剂，症状消食，大便恢复正常而痊愈。

杨文蔚：治小儿湿热腹泻验方《中医杂志》1984年6期

【分析】

案一为暑湿伤脾泄泻，七月天气酷暑，外感暑气，则发热，暑热挟湿气，因阻脾胃，故呕吐腹泻，治疗宜从温病治暑湿挟湿方法，先清暑祛湿，疏利中焦。以藿香、苏叶、葛根清热解暑、使暑热从表而去；扁豆、厚朴、云苓化中焦湿浊；六一散、大腹皮清热利湿，使暑湿从小便而出。亦叶氏所谓杏、朴、苓分消走泄方法。一诊使湿热邪气从三焦分利，湿不与热相结，势必孤矣。故二诊即热退，有微汗，湿热交结，非一汗可解，宜从治湿温方法，清化脾胃湿邪。湿热证以侵犯中焦为重点，故湿热一去，脾亦虚矣。继以建脾温中收效。

案二为湿热下注腹泻。七月暑热，伤食腹泄，大下伤阴、暑热外侵，内外合邪，遂攻湿热下注，腹泻不已。用黄芩清热，白芍、乌梅敛阴，药方小巧，组合严密，故取效甚捷。

（四）疳症

【概说】

疳症是指小儿脾胃虚损，运化失宜，脏腑失养，气液干涸，饮食不为肌肤，严重影响生长发育，病程较长的一种慢性疾患，多见于三岁左右婴幼儿。以不同程度的形体羸瘦，气血不荣，头发稀疏，精神疲惫，腹部胀大，青筋暴露，或腹凹如舟，有异食癖等为主证。临床分为饮食不节，脾胃损伤，喂养不当，营养失调，及其他疾患转化成疳几种。积滞

伤脾型，宜肥儿丸清积健脾；脾胃虚弱型，应用参苓白术散益气健脾；气血两虚型，以人参养荣汤补益气血，温中健脾；其它疾患致疳者，则因慢性吐泻、痢疾、虫证等损伤气血，阴阳俱虚，转化而致，又当针对具体情况，恰当治疗。

疳证既久，往往导致严重的兼证，兼目翳夜盲，应以羊肝丸滋阴明目；兼肿胀者，宜以五苓五皮饮温脾利水；兼齿衄、肌衄者，当用归脾汤补气摄血；兼口疳流脓，口腔溃烂者，又应以导赤加减泻火清热。

应注意从小合理喂养，加强室外活动，促进小儿体质，预防本证发生。

中医治疗疳证，除服药外，捏脊、针灸，割掌脂疗法，以及民间单方验方皆可配合使用。

【选案】

案一，薛立斋治一小儿，面色萎黄，眼泡微肿，作渴腹胀，饮食少思，腹中一块或移动，小便澄白，大便不实，脾疳之患。用四君子加山楂，芩薏兼肥儿丸而愈。

《续名医类案》

案二，戚幼，2岁。

初诊：4月13日，因断乳大早，胃实脾虚，喜食香甘之品，以致腹膨且硬，青筋暴露，形种羸瘦，大便时溏时坚，尿若米泔，腹疼作止无定，盖小儿脏腑嫩娇，精气未充，耗伤脾胃，已成疳疾，治宜健脾和胃，导滞化虫。

炙蟾皮4.5克 槟榔9克 枳实4.5克 使君子9克 雷丸6克 川朴2.4克 焦山楂9克 炙鸡内金4.5克 砂仁1.5克 炒于术4.5克 广青皮各4.5克 3贴。

复诊：投以导滞合化，药后大解酱粪，胶固而稠腻不

堪，移臭异常，腹膨渐松，按之已软，是佳兆也。为今之计，仍当调胃和脾，稍佐扶正。

太子参9克 炒枳壳4.5克 半夏4.5克 广皮3克 云苓9克 淮山药9克 焦山楂9克 炙鸡内金4.5克 香谷芽12克 春砂仁1.5克

此证先天充沛，后天失调而已。即做脾胃论治，用先攻后补之法。

奚泳裳：奚氏儿科经验简介
《上海中医药杂志》1962年6期

【分析】

案一为脾痞。因积滞伤脾，脾胃既伤，运化无权，既容易使痰、湿、淤血等病理产物堆积，又不能吸收营养，从而使气血虚弱，身体消瘦。腹中有块，积滞所生，小便澄白，五脏精华不能吸收，皆变湿邪随小便而出。治宜健脾消积，用四君子补脾，加山栀清积热，加芫荇祛积滞，用肥儿丸健脾消食而愈。脾胃入手，加减调理。

案二为脾虚积滞型。初治健脾和胃，消导驱虫，炙蟾皮功能解毒，消痞积腹胀，为奚氏治痞症的经验用药。药后积滞从大便而去，痞积渐解，继以调补脾胃，此证先攻后补，又与前案不同。

（五）小儿蛔虫证

【概说】

蛔虫证是小儿多发的肠道寄生虫病。临床以食欲异常、脐周腹痛，痛无定时，反复发生，有时大便下虫为主要特征。病因是饮食不洁，食入虫卵，通过一定移行途径，发育成虫，寄生肠道而成。主要症状有胃脘嘈杂，能食消瘦，脐

周疼痛，无定时，反复发作，有的厌食、异食，或有恶心呕吐轻泻便秘，有时可呕出便出蛔虫。患儿常烦躁易怒，夜睡易惊，齞齿，或有风团痒疹，皮肤瘙痒，挖鼻孔，咬指甲，脸上有白斑，唇内有白色斑点等。如果肠中蛔虫扭结成团，阻塞肠道，就出现腹部剧烈绞痛，如蛔虫穿肠入胆，会出现上腹部阵发性剧烈绞痛，冷汗肢厥，呕吐胆汁蛔虫，称为蛔厥，如蛔虫钻入阑尾，则右下腹明显压痛，称蛔虫性肠疝。治疗原则以驱虫为主，但须根据病情轻重，体质强弱，分别用不同方法驱虫。一般用使君子散，蛔虫量多的，用追虫丸。虫尽后调理脾胃。如出现虫扰、蛔厥、暂时不能攻逐的，宜用乌梅丸安蛔；兼见热象的，与连梅汤。兼体弱的用肥儿丸。一般轻证，可用使君子、苦楝根皮、榧子肉、槟榔等单方服用。

【选案】

案一，李××，男，6岁，1972年11月23日初诊。

上腹部阵痛数日，纳呆，便少，巩膜蓝瘰明显，并有花指甲，验大便有蛔虫卵。印象：肠道蛔虫病。

辨证：虫积腹痛。

治则：安蛔止痛。

处方：驱蛔一号。一剂两煎，早晨空腹口服，连服二天。

11月25日复诊，昨晚大便排出蛔虫7条，今晨食欲见佳（连服二天），腹痛已止，停药观察。

《何世英儿科医案》

案二，徐××，男12岁，1974年8月13日初诊。腹痛经常发作；已有一年。

现证：面色萎黄，消瘦、纳呆，腹疼，面部有白癍，巩膜也有蓝癍，验大便有蛔虫卵。

印象：肠蛔虫病。

辨证：虫积腹疼。

治则：安蛔止痛。

处方：驱蛔二号。

服法、两煎每日清晨空腹合服，连服2天，隔日再服，共服4剂。

服上药后，连续排出蛔虫10条，腹疼消失，食欲已振，3个月后随访，患儿迄未腹疼，面部红润，体重明显增加。

《何世英儿科医案》

案三，王幼，15岁，10月17日，半壁街一诊。

左脉细濡，右部弦滑，阵阵发热，胸闷格拒，饮食不下，得饮则做胀，大便秘结，曾经吐虫数条，胃气重伤，亟以镇逆安胃，通导大肠而中气已虚，恐再吐蛔致厥。

旋复花6克 代赭石30克 花槟榔6克 佛手片9克 鲜枇杷叶9克 苏子霜4.5克 使君子9克 赤苓12克 姜竹茹9克 全瓜蒌15克 洋芦荟1.5克 建泻9克 小枳实4.5克 制厚朴4.5克 川连2克 同炒。

二诊：10月18日。

药后大便畅通3次，膈胸已舒，舌苔垢厚浮黄、两脉弦滑而细，气分虚弱而积滞未化，再以昨法加减。

旋复花6克（包布） 厚朴4.5克 川连2.1克（同炒）
炒使君子9克（杵） 黑沉香0.9克（同炒） 全瓜蒌12克
鸡内金9克 鲜枇杷叶9克（布包） 姜竹茹9克（去皮尖）
花槟榔9克（先煎） 洋芦荟1.5克 连皮苓12克

制半夏9克 苦杏仁9克 代赭石30克 生熟麦谷芽各9克
苏子霜4.5克

三诊：10月19日。

药后大便未通，舌苔垢黄而厚、气逆欲呕吐，中脘有型积聚，两脉细弦而涩。中宫积滞不化而中气已虚，深虚再吐蛔虫而致厥逆也。慎之慎之。

旋复花6克 川连2.1克（同炒） 制厚朴4.5克 花槟榔6克 黑沉香末0.9克（同炒） 全瓜蒌15克 鲜枇杷叶9克（布包） 制半夏9（去皮尖） 使君子6克（水炙）

火麻仁9克 木香导滞丸15克（先煎） 苦杏仁9克 鸡内金9克 焦麦芽9克 代赭石30克 姜竹茹9克 洋芦荟1.5克

药后大便畅行六七次，下虫两条，中脘胀满已舒，积聚亦消，舌苔垢厚而滑，左脉细弱，右脉弦滑，病实中虚，虫积未清，再以宣达中焦，安和胃气之味，暂停一日，以冀稍事休息。

鲜枇杷叶9克 制半夏9克 黑沉香0.9克（同炒）
全瓜蒌12克 生熟麦芽各12克 越鞠保和丸3克（布包） 胡连3克（同炒） 制厚朴4.5克 史君子9克（去皮尖）
鲜柠檬皮9克 沉香曲12克 花槟榔3克 苦杏仁9克 焦苡米9克

汪逢春《泊庐医案》

【分析】

案一为肠道蛔虫证。用驱蛔一号（槟榔15.6克 芜荑9克 使君子9克 川楝子9克 延胡索9克 木香4.7克 乌梅3枚 一剂，两煎合一，晨起空腹顿服），金铃子散加

木香理气止痛，配伍其余杀虫药，大量一次顿服，药力集中，连服二日，便得虫下，但驱虫药有毒，中病即止。

案二为肠蛔虫证腹疼，用驱蛔二号（槟榔18.8克 川楝子12.5克 使君子12.5克 雷丸12.5克 木香6克 乌梅5枚），药物组成与上方相近，但药量都比驱蛔一号大，适用于年龄较大的儿童。一般10岁以内服驱蛔一号，10岁以上服驱蛔二号、但亦应注意中病即止。

案三为肠道蛔虫证，虫证既久，耗伤阴血，使大便秘结，内热胸闷，胃肠升降阻滞，蛔虫亦不得安宁而上扰，经胃而呕出。若不急急安蛔顺气，恐致蛔虫穿肠入胆，疼痛欲死的蛔虫厥证。故急以旋复花、代赭石，佛手片、枳实、厚朴降气通腑；用枇杷叶、苏子霜、瓜蒌润肺宽中；竹茹、泽泻、赤苓清热和胃；芦荟解毒祛热；槟榔，使君子驱虫。因一诊偏重在降气宽中，通腑安蛔。二诊时大便已通，胸闷得宽，唯因蛔虫久积，脾胃已虚，脾胃积滞与虫积难以骤清。故二诊加重了健胃消积的鸡内金，谷芽，去掉枳实、佛手。三诊大便未通，便觉中焦阻塞，气逆欲吐，但中虚有积，破气太过，反伤脾胃，故三诊加木香导滞丸布包同煎。四诊大便畅行，虫下二条，但中虚与虫积尚未两全，守方再行，调理可望恢复。

（六）小儿紫癜

【概说】

紫癜是皮肤、粘膜、关节、内脏出血的疾患。亦称为紫斑，以皮下为淤点，淤斑压之不褪色为特征。引起紫癜的原因主要是外感风热。内蕴湿热、肾气不足，气血亏损等导致血不循环，溢出脉外，渗于肌肤之间而为病。临床分为如下几

种。外感风热型：发病急，紫癜反复发作，且好发于下半身，尤以下肢臀部为多、颜色鲜红，呈丘疹，红斑样，大小形态不一，常融合成片，皮疹常为对称型，有瘙痒，可伴有全身发热，关节肿痛或腹痛，呕吐、便血、尿血等证，宜用连翘败毒散加减，祛风清热，凉血止血；血热妄行型：壮热不退，淤点淤斑颜色较紫，量多成片，伴有衄血，尿血，腹痛便血，血色鲜红等证，应用犀角地黄汤加减清热解毒，凉血止血；气不摄血型：紫癜反复发作，淤点淤斑颜色较淡，病程长，兼有腹胀痛，大便色黑等证，则宜归脾汤加减补气摄血；阴虚火旺型：皮肤紫癜，下肢尤多，时发时止，伴有低热盗汗等证，又应用大补阴丸加味滋阴降火，凉血止血。

此症初起多为血热实证，如迁延不愈，成为慢性、为阴虚火旺型，长期反复发作，则多为正虚不能摄血；若病程缠绵，累及肾脏，又会阴虚不摄，且发病过程中，兼证较多，宜随证加减，配合相应的药物治疗。

【选案】

案一，池××，男，2岁，1972年12月20日入院，住院号108423。

以发热伴有紫斑，消化道出血、肺炎，中耳炎而入院。入院后，高热不退，持续在39℃，呼吸急促，喉中痰鸣，口腔溃烂，右耳有脓性分泌物，两鼻孔均有出血痂、面部、胸前，四肢、臀部均有出血点，有的已形成紫红色斑片，以下肢，臀部为多，心脏未闻异常，两肺有湿鸣，大便为柏油样，尿色深，舌质红苔黄，脉象弦数，大便潜血（++）尿常规：红细胞10个以上，验血小板正常。

印象：过敏性紫癜合并消化道出血，肺炎中耳炎。

辨证：温毒入营，血热妄行。拟清热解毒，凉营止血。

处方：水牛角粉9克（先煎） 生蒲黄9克 五灵脂9克
生地9克 丹皮9克 赤芍9克 银花12.5克 甘草4.7克
川贝末1克 （冲服） 水煎50毫升， 5剂。

12月25日复诊：已不发热，全身紫斑明显减退，无新的出血点，口糜已愈，右耳仍分泌脓液。原方三剂。

12月28日复诊：一般情况尚好，紫癜已全退，停服汤剂，继续治疗中耳炎，给服清化丸28丸（当时每丸3克重，每日3次，每次半丸，后痊愈。

《何世英儿科医案》

案二，诸××，男，10岁，1972年8月10日初诊。

患原发性血小板减少性紫癜，时好时犯已有八年。近三个月未服激素。现证？头晕、无力、纳呆、便溏。面色煞白，全身有散在紫癜，斑点较稀，颜色淡红，脉象细缓。多次化验血小板均在30000/立方毫米左右。

辨证：脾虚不能统血。

治则：健脾和营。

处方：焦白术12.5克 野党参9克 云茯苓9克 紫丹参9克 杭白芍25克 生山药9克 炙甘草4.7克 川芎4.7克 桂枝4.7克 大枣5枚。

连续服用上药二个月，10月10日，症状好转，基本控制了出血，面色转红润，大便已半成型，每日一次，脉象细缓转有力。血小板增至205000/立方毫米。

12月23日复诊：一般情况好，无出血现象，血小板236000/立方毫米，停服上药，改服补中益气丸善后，每日早晚各服半丸，以巩固疗效。

《何世英儿科医案》

案三，王××，男，11岁，1975年5月15日初诊。

三年前周身发现紫红色斑疹，服中药治愈。去年又复发一次，近来四肢又出现紫色斑疹，已经二月，西医诊断为过敏紫癜，有时发热，小便黄短，大便色黑、法宜清解。

丹皮3克 赤芍6克 生地6克 山梔皮6克 黄芩6克
银花6克 连翘6克 荆芥穗6克 藕节6克 蝉蜕3克
甘草3克 鲜芦根9克 车前草6克 清宁丸6克（分
二次兑药冲服）

二诊：服前方后，疹毒消退，周后又时隐时现，伴有牙痛，此温毒未尽，血热上泛所致，拟以平肝清热之剂。

生地6克 云苓6克 泽泻6克 丹皮6克 茜草6克
骨碎补6克 刺蒺藜6克 地骨皮6克 甘草梢4.5克 淮牛
膝6克 车前草6克

三诊：诸证悉减，唯精神倦怠，面色清黄由于肝盛克脾，饮食懒进，苔黄白相间，脉息平平，本治肝实脾之义，以六君子汤调理之。

沙参6克 白术6克 云苓6克 法夏6克 广皮6克
藿香6克 砂仁1.5克 炙甘草1.5克

四诊：饮食增进，余无所苦，四肢疹痕犹有未尽，改用养阴活血佐以清解之剂为治。

生地6克 丹皮6克 赤芍6克 豆卷9克 稻芽9克
云苓6克 荆芥4.5克 防风4.5克 白茅根6克 银花6克 连
翘6克 蝉蜕3 甘草1.5克 前方服3剂，疹痕全消，神
情活泼。

王朴诚医案《中医杂志》1958年6期

案四，叶××，女，14岁。初诊，1971年10月12日。

全身紫癜已一月半，四肢突发紫癜，两上下肢不等丘疹样出血点，诊为“过敏性紫癜”。给服强的松稍好转，减至每日20毫克，全身紫癜大发。证见，全身发疹，点点斑斑，色泽鲜红，以下肢为甚，脉弦细带数，苔薄尖红。

生地黄12克 败龟板12克 川黄柏9克 肥知母9克 金毛狗脊12克 菟丝子12克 女贞子12克 旱莲草30克 鲜藕节30克 乌梅4.5克 谷麦芽各9克 大红枣6枚

以上方为基础，或加当归白芍以养血，或加紫草仙鹤草以止血，在服用中药的过程中，逐渐减强的松用量，于1971年12月12日，完全停服激素，未再发。再以八珍散加减善其后。

张羹梅《临证偶拾》

案五，刘×，女，1975年8月诊。皮肤紫癜已十余日，膝关节红肿热痛，下肢沉重，纳呆，腹胀，腰痛，溲赤，紫斑多密集于膝关节周围，或呈隆起状，按之不褪色，舌体略胖有齿痕，色红，黄腻苔，脉滑数，血象，血细胞9890；尿检：红细胞（++），蛋白（+），大便潜血（+），证由久处湿地，湿邪侵袭，郁久化热，交阻脉络。邪伤阳络，则血渗出见紫癜，伤阴络则血内溢，故为尿血、便血。药用：

苍术 白术 藿香 连翘 石苇 牛膝 木瓜 赤芍各9克 鸡血藤15克 紫草 大黄各6克 苡米 滑石 小蓟各12克 黄柏3克。3剂后，肢重及肿胀关节减轻，紫癜色变暗，未再出现新癜，续进原方，以巩固疗效。

高光信：过敏性紫癜的证治

《浙江中医杂志》1981年2期

【分析】

案一为血热妄行性紫癜，因热毒内伏，遇诱因而发，以致化火动血，灼伤血络，迫血妄行，溢出常道，外发肌表而为紫癜；血随气升，发为鼻衄；火热灼伤肠络，肠内出血，大便色黑；火热迫肺，呼吸急促；火热炽盛，上灼而为口糜，耳溃。急应清热解毒，凉血止血。方用犀角地黄汤清营凉血解毒，以水牛角代犀角；加失笑散活血祛瘀，使已出血络之瘀血得以消散；加银花取叶天士透热转气之意，给邪热以外透之机；川贝末1克冲服能化痰止咳清热。2岁小儿，用大剂清凉，5剂便热退斑收，再服3剂，紫癜痊愈。继以清化丸清热解毒，消肿排脓，专治中耳溃脓，一例较严重的出血性疾患，8剂中药，很快治愈，确属疗效极高。

案二为脾气虚弱型紫癜，先因紫癜急性反复发作，时间迁延八年，致气虚血弱，不能统摄，血流不循常道，外溢肌肤，斑点稀、颜色淡，头晕乏力，纳呆便溏，显然为脾虚不摄。故治疗以四君子汤加山药补中益气，固摄血液；合桂枝汤方调合气血营卫；加用紫丹参、川芎活血、凉血。使溢出之瘀血得以凉散。证属慢性、功非一日，故连服两月，已基本痊愈。天津儿科专家何世英治疗小儿紫癜有丰富经验，对于西医诊断确切的原发性血小板缺乏性紫癜或过敏性紫癜，皆有很高疗效。尤擅长用失笑散（蒲黄，五灵脂）治疗过敏性紫癜病，控制腹疼。龙骨、牡蛎控制出血。并提出紫癜证的四种分证法，为血热型、血瘀型、湿阻型、脾虚型，对于临床有很高的实用价值。其具体的治疗方法，亦有很高的科研价值。

案三为外感风热型紫癜。因血分郁热，又兼时令外感，风挟血热外发而为紫癜。时有发热，外邪未解。故用银翘散

方加減，銀翹、山梔，黃芩，荊芥，蟬衣辛涼宣透風熱，苦寒清解熱毒；丹皮、赤芍、生地活血、涼血散血分虛熱；車前，芦根清熱利下，藕節涼血止血，清寧丸專治腹脹尿澀，二診尚有余毒未盡，撤去表藥，繼續清熱涼血養血，後宜調理脾胃增強體質，再用滋陰涼血清熱，窮追疹毒余邪。

案四為陰虛火旺型紫癍。紫斑以下肢為甚色澤鮮紅、脉弦細數，舌薄尖紅，全屬肝腎陰虛，相火內熾，灼傷血絡，外發紫癍。故治療宜補腎滋陰，清熱涼血。以金毛狗脊、菟絲子、女貞子平補肝腎；旱蓮、生地、藕節，涼血活血；知柏清相火，龜板、烏梅善收澀斂陰，現代研究烏梅有抗過敏作用。以本方為基礎，加減進退，以獲痊愈。

案五為濕熱交阻型紫癍，外感濕邪，郁久化熱，濕熱交結，損傷血絡，血溢皮下發為紫斑，灼傷膀胱血絡，為尿血，濕熱化燥，損傷腸絡為便血。治療宜清熱利濕，涼血止血，活血祛瘀。方用四妙散清熱燥濕，治關節腫痛，藿香、連翹發越外濕，配伍其它利濕清熱，涼血活血藥而愈。

（七）小兒遺尿

【概說】

遺尿是指三周歲以上的小兒，睡眠中小便自遺，醒後方覺的一種病証，亦稱“尿床”。發病多因腎氣不足，下元虛冷，身體素弱，脾肺氣虛或肝經濕熱下注所致。下元虛寒者夜睡中遺尿，一夜1～2次，兼腎虛見証，宜桑螵蛸散加味溫補腎陽，固攝下元，脾肺氣虛者，多發於病後，睡中遺尿，尿頻而少，兼脾肺氣虛見証，可用補中益氣縮泉丸補益固攝；肝經濕熱下注者，睡中尿床，小便黃而有臊臭味，兼肝熱見証，又應用龍胆瀉肝湯清瀉肝火。

此外亦有因不良生活习惯，其它疾病如尿道口炎，膀胱炎、蛲虫病等引起的尿床，则应去除病因，遗尿自愈。

除服药外，外敷贴脐，针刺、耳针、推拿等方法皆可配合治疗。

【选案】

案一，遗尿，患儿赵××，13岁，1980年8月11日初诊。

其母述于三年前始见夜间尿床证以后症状逐渐加重，经治疗效果不佳，每于精神紧张，饮水多，疲劳过度即遗尿，但饮食尚可，睡眠亦正常，二便自调，舌质淡红，脉沉弱无力，辨证属肾阳虚，下焦不固，治以温肾益气、收敛固涩法。处方：

熟地15克 白芍9克 当归9克 龙骨3克 牡蛎3克
金樱子10克 木蝴蝶6克 芡实15克 益智仁9克 桑螵蛸
9克 砂仁3克 韭子9克 五味子9克 陈皮6克 甘草3克
15剂。

1980年8月26日复诊：服上药基本不遗尿，偶发1～2次，继续服上药巩固疗效，三个月后其母来院诊病时，言其小儿遗尿已全愈。

《医论医话荟要》

案二，杨××，男，7岁，1984年8月17日初诊。

家长代诉：患儿小便频数已四年余，迄今未愈。1970年7月某日，因患感冒，发热，咳嗽，经服中西药后发烧减退，但咳嗽未获痊愈，然而出现小便频数，每天小便数十次，量少，致患儿无法坚持学习而停学，曾在本市各医院用中西药治疗无效，固来就诊。

现证：患儿每天小便70~80次，无尿痛，尿血及腰疼等证，小便色微黄，化验小便无异常，入睡后，小便亦不自遣，咳吐黄色稠痰，口渴、汗出，不发烧，面瘦，颜色正常，饮食稍差，精神尚可，大便正常，舌质红，苔薄黄白有津液，脉大数，右脉更大。

此为肺热郁结，肺气宣降失常，影响膀胱之约而成尿频之证、治宜清肺宣气，拟麻杏石甘汤加味：

麻黄 4.5克 生石膏12克 杏仁 9克 桔梗 9克 淮山药 18克 甘草 3克 3剂水煎服。

二诊、三诊略

8月28日四诊：服上药11剂后，小便已不频数，与健康人同样，舌苔脉象均已正常。改用四君子汤，调理脾胃收功……。

成都中医学院附属医院

《资料选编》1976年

案三，曾治疗一个从幼年遗尿至24岁久治未愈的姑娘，先予中药治疗未效，改用针灸仍无效，又予气海穴封闭阿托品，但封闭一次只可保证一夜不尿，后试用此单方（硫黄90克 大葱根 7棵 共捣为泥，用法：每晚睡前，用酒精棉球将肚脐及其四周腹壁消毒，然后将药摊在脐周，再用绷带绕腰缠紧固定，次晨取下，并保持干净，存在洁净的器皿中以备再用。

吕秉义：治遗尿的单方《中医杂志》1987年12期

【分析】

案一为肾气不足遗尿。因肾气不足，下元虚寒，闭藏失职，膀胱气化功能失调，不能制约而遗尿，治疗以补肺固涩

缩尿为主要原则，用黄芪、杜仲、益智仁、旱莲草补肾益气；以桑螵蛸、芡实、牡蛎固涩止尿。此方乃缩泉丸意，然未用其方，仿古不泥，善于化裁。

案二为肺热郁结，上源不利而遗尿。根据兼有咳嗽、口渴，右脉偏数大辨为肺热壅结肺气不能宣降，水之上源不通，水道不得通调，水液循环障碍，肾主水液功能受到影响，不能使浊之清者，上归于肺，直出而为遗尿，应清肺之壅结，开通上源，使水液得以周流。故能以一麻杏石甘汤将遗尿治愈。可见中医治疾，同病异治，下病上取，颇有异曲同工之妙。

案三为外敷治遗尿方，大葱功能宣通阳气；硫黄酸温，能入肾经，补火助阳。《本草图解》云：“主命门火衰，阳气暴绝，阴证伤寒，阳道痿弱。”“秉纯阳之精，益命门之火，热而不燥。”因此葱白宣通，硫黄温补，二药配伍能起到化气助阳的作用，对于肾阳不足，气化不利，水寒遗尿者确有疗效，但硫黄有毒，内服一日量不超过6克，外用亦需注意用量适当。

（八）麻疹

【概说】

麻疹是由于感受麻疹病毒所引起的急性发疹性传染病。以发热3～4天后皮肤出现色红如麻粒大小的皮疹为特征，多发于1～5岁幼儿，冬春为流行季节，传染性很强，为儿科四大要证之一。但预后一般良好，患病后护理治疗得当，能够很快恢复健康。患过一次麻疹后，大多能终生免疫。

辨证首先应辨别顺证逆证，顺证按着发病的规律分为初热期，见型期，收没期三期。

初热期约3~4天，发病急骤，有高热，咳嗽，喷嚏、咽喉肿痛，眼红赤羞明，眼泪汪汪，或有疲倦的纳呆、头痛、呕吐、腹泻等证。2~3日后在口颊内近白齿处发色灰白色麻疹粘膜斑。此期宜用升麻葛根汤，宣毒发表汤，辛凉发散，宣毒透疹。见形期（发疹期）从见到口腔麻疹斑1~2日后开始，2~5日全身满布。发热的第4~5天耳后颈部开始出疹、渐及前额面颊，自上至下，遍布全身，最后手足掌心出齐为止，疹初发为散在玫瑰色细碎疹点，高出皮肤，逐渐融合成片，色变暗红，疹之间有正常皮肤，麻疹密布时，体温升高，呼吸道症状加重，严重者神昏烦躁谵语，常有腹泄呕吐，此时内热炽盛，但疹出为邪有外透之机，宜用清解透表方加减，清热解毒，佐以透疹，需注意发疹的具体情况，随证加减。收没期。（恢复期）约3天，疹子按着发疹顺序依次消退，体温下降，精神食欲好转，其余症状很快减轻。皮肤呈细麦糠样脱屑，留有棕色斑痕，2~3周后完全消失，宜沙参麦冬饮甘凉养阴加减治之，此方更具清解余毒之功。

出疹后常有后遗症，如麻疹后期潮热，麻后痢、麻后夜盲（麻疹入眼），麻疹后发颐，麻后口糜，麻后沙癩（皮肤瘙痒，出现如疥疮样小疹）等皆宜注意护理及随证施治，清解余邪。

逆证出疹不畅，疹出先后无次序，暴出暴收，疹色紫暗，稠稀不均，又分为疹毒闭肺、疹毒内陷心包、疹毒攻喉三型。疹毒闭肺者，证见高热不退，咳嗽剧烈，气促鼻扇，喉间痰鸣，口唇紫绀，烦躁不宁，舌红绛苔黄脉洪数，指纹青紫，宜麻杏石甘汤加味清热宣肺，解毒透疹。内陷心包

者，高热持续，神昏谵语，或幼风抽搐，严重者呼吸微弱，四肢厥逆，宜犀角地黄汤、清营汤合方加减平肝熄风。疹毒攻喉者，咽喉肿痛，声音嘶哑，吞咽不利，甚则呼吸困难，气憋胸闷等，宜清咽下痰汤清热解毒，利咽消肿。

麻疹以透为顺，不宜过早使用苦寒，冰伏疹毒，另外需与风疹，烂喉丹疹，幼儿急疹等，做出鉴别诊断。

【选案】

案一，任幼，3岁。初诊1月10日。

痧隐不达，高热气喘，咳嗽不爽，舌质绛红，口渴神烦，大便溏泻，秽臭难闻，此系热迫大肠，前医进葛根芩连汤未见微效，诊得脉象弦大且数，唇焦起裂。

辨证：邪已入营、阴津亏损，势有化燥劫阴之虑。

治法：养阴救液，凉营透表。

方药：鲜石斛15克 鲜生地21克 淡豆豉9克 粉丹皮4.5克 京川贝4.5克 带心连翘6克 黑山栀9克 郁金4.5克 淡苈4.5克 鲜茅根30克（去心）

复诊：1月12日，投以红炉泼水之法，汗畅疹达，色殷甚密，热退烦定，便泄亦止，气喘大为减轻。可见气有余便是热，热有余便是火，火能熄、热能退，则气渐平而身渐安矣。

鲜沙参12克 鲜生地15克 丹皮4.5克 银花4.5克 川贝4.5克 甜白杏仁9克 冬瓜子9克 鲜茅根30克 赤芍4.5克

奚咏裳：奚氏儿科经验简介

《上海中医药杂志》1962年5期

案二，郑××之侄，年甫髫龄。

孩体乳痰上壅，以至疹不出表，温邪熏蒸，咽喉肿痛，患儿疹隐而未透，咳嗽气急，痰多，喉关有声，咽喉红碎，指纹隐隐，此即张廉《麻疹阐注》所谓“痰闭”之证。

辨证：麻疹痰闭，痧火不得外泄，上延烂喉。

治法：宣痹通血，化痰透达（“透血”为孙复初《麻疹要诀》所载，近贤梁达樵亦时用之）。

方药：广郁金9克（生打） 炮射干2.1克 光杏仁9克 牛蒡子9克（杵） 丹参6克 鲜薄荷12克 象贝母9克 赤芍6克 元参9克 制僵蚕9克 鲜枇杷叶5片（去毛） 鲜茅根30克（去心） 紫菀9克 另用 西月石0.9克 月雄精0.6克 猴枣0.3克 研细末，茅根汤送下。

效果：1剂而痰降气平，2剂而麻疹透足，继用清肃而瘳。

《重印全国名医验案类编·周小农医案》

案三，朱贡九之哲嗣文治，年五岁，于庚申立夏后，周身壮热，出疹甚稠密，脉甚洪数，舌苔白厚，知其疹而兼瘟也。欲以凉药清解之，因其素有必下做痛之病，出诊后，贪食鲜果，前一日犹觉疼，又不敢投以重剂，遂勉用生石膏玄参各18克 薄荷叶 蝉蜕各3克 连翘6克 晚间服药，至翌日午后视之，其热益甚，喉痛，气息甚粗，鼻翅煽动，且自鼻中出血少许，有烦躁不安之意，愚不得已，重用生石膏90克 玄参 麦冬（带心）12克 仍佐以薄荷叶 连翘诸药，俾煎汤二茶盅，分三次温饮下，至翌日视之，则诸证皆轻减矣，然余热尤炽、而大便虽下一次，仍系燥粪，洵其心犹发热，脉仍有力，遂于凉解药中，仍用生石膏30克，连服二剂，壮热始退，继用凉润清解之剂调至痊。

张锡纯《医学衷中参西录》

案四，雷××，4岁。

1958年冬患麻疹、高热、咳嗽、气喘，曾入某医院服中西药治疗一星期，热退疹收病愈出院。出院第三天忽然腹泻，日十余次，神疲纳呆，至第五天前来邀诊。

患儿困倦异常，神志若明若昧、身热，肢冷。腹泻每日7～8次，粪水清稀，睡眠露睛凶门凹陷，呼吸急促，脉微弱而数，乃予四逆汤中加味。

熟附子 干姜 炙甘草加吉林参 五味子。服药二剂，利止热退，继用异功散合生脉散调理而安。

《老中医医案医话选何志雄医案》

【分析】

案一为疹出不畅。疹以透出为发疹期，但热邪内郁，不能顺利透发，内迫肺与大肠。本应清解之中佐以透疹，前医误以芩连苦寒，反使疹毒冰伏，故未获寸效，热邪势甚，耗伤阴液，口烦神烦。热毒内陷营分，舌质红绛，治疗宜清营透疹，活血养阴，方用清营汤变方，以生地石斛、鲜茅根滋阴清热；丹皮、山梔，凉营清热；郁金，带心连翘清心除烦，川贝，黄芩、清肺化痰，豆豉透热转气，助疹毒外发。一诊即汗畅疹达，继以滋阴润肺，清热余毒而效。诊为太阴风热，卫营合邪，临证宜牢记之。

案二为疹毒攻喉，疹毒热甚，循经上攻，结于咽喉，不得外透，故咽喉肿痛，疹隐未透。宜清热解毒，利咽消肿。宣通血络法为周小农治疹的临证经验，西月石、即硼砂，功能清咽消肿；雄精即雄黄之质优者，又名腰黄，明雄黄。善能解毒治痛疽；猴枣功能豁痰镇惊，清热解毒，三药配伍，

能宣喉痹清咽退肿。猴枣一味，名医马培之亦善用之。药物功效集中，故一剂疗效显著。

案三亦为疹毒闭肺。张锡纯氏创清疹汤（生石膏 知母 羚羊角 金线重楼 薄荷叶 青连翘 蝉蜕 僵蚕）治疗疹毒不透，内热壅盛，屡获奇效。此案亦两用清疹汤加减，尤用大量生石膏，清热肺胃之热，张锡纯云：“石膏并非苦寒，用之治疹最好”，“治外感实热诸证直胜金丹。”且石膏不可煨用，临床多用大量生石膏煎汤，澄清去渣、入药煎服，确为善用石膏的又一大家。

案四为疹后泄泻。因出疹已大伤正气、又因余热未清，大泻不止，气随液脱、出现阳脱阴竭的危证、仿《伤寒论》回阳救逆法，用四逆加参汤合五味子，救阴回阳。二剂即痢止。再以生脉增液，以异功散温中补脾而安。但热病以救阴为要、补阳、回阳须注意“炉烟虽灭，灰中有火”。此案两剂阳回即止，继用增液救阴。

（九） 疳腮

【概说】

疳腮是由感染疳腮病毒所引起的急性传染病。以发热、耳部腮部肿胀为特征。冬春多发。5～9岁为多发年龄。一般预后较好，可获得终生免疫，临床分为轻重两型。轻型的，湿毒在表，仅见发热恶寒，咽痛头痛，纳差呕吐等，1～2天后，一侧耳下腮部肿大，继则另一侧亦肿大，以耳垂为中心漫肿，边缘不清，肿处酸胀压痛，咀嚼不便、苔微黄，脉浮数，宜用银翘散加板蓝根、僵蚕、蝉衣疏风清热，消肿散结、消肿散结。治疗及时，则于4～5天后肿胀消退，1～2周痊愈。重型的，热毒蕴结在内，先有恶寒高热，体倦呕

吐等，1～2天后，腮部肿大拒按、漫肿坚硬，咽喉肿痛，吞咽困难，便秘尿赤，口渴烦躁，舌红苔黄脉滑数，宜用普济消毒饮加减清热解毒，软坚消肿。此症初肿，即宜用青黛醋调、如意金黄散、紫金锭等调涂腮部帮助消肿解毒，如发生在12岁以上的男孩，则易并发睾丸肿痛、一般于腮肿后一周，突然出现高热寒战，睾丸肿硬，阴囊水肿，宜加用龙胆草、荔枝核等药，大多可于十日左右消肿。如温毒炽盛，亦会热陷心包，神昏惊厥，则应用清瘟解毒饮、犀角地黄汤、安宫、紫雪之类清心开窍，凉血解毒。

【选案】，王姓、女，3岁，发病20余日，于1953年2月就诊。

证：颌下腺及耳下腺红肿热疼，大便燥，发热无汗，脉浮数。

处方：川连 子芩 牛蒡子 甘草 桔梗 板蓝根 柴胡 连翘 陈皮 薄荷 姜蚕 全蝎 麻黄 川军 双花 水煎服，外以金黄散醋调敷患处（服药后证状减轻，乃加入元参 浙贝 乳香 没药 公英 地丁服之而愈）。

《华延芳医案选》

案二，邹××，男、3岁，门诊病历号：938778。初诊日期：1975年9月25日。

病史：昨起身热39.4℃，双耳下肿痛，右侧约5×4厘米；双腮腺管开口处稍红肿；口腔粘膜少数小溃疡；咽红、扁桃体（Ⅱ°）声咳；舌淡白苔腻，上腭前浅紫色，后橘黄色，脉沉弦数。

西医诊断：流行性腮腺炎。

辨证：毒邪外袭、血分滞热。

立法：清热祛邪，活血消肿。

方药：青黛3克 紫草9克 寒水石12克 贯众9克 乳香6克 白芷6 细辛1.2克

二诊：服上方药2天后，烧已退，双耳下肿减轻，上唇颜色均较前变浅，脉沉弦缓，用下方：

青黛3克 紫草9克 乳香6克 白芷6克 白菱9克 牙皂3克 服上方药2剂后，左侧腮腺肿已全部消退。

《王鹏飞儿科临床经验选》

【分析】

案一为轻型疳腮，疳腮温毒从口鼻而入，壅阻少阳经脉，郁而不散，结于腮部，则耳下腮部坚硬作痛。热邪壅内，大便燥结。外邪未透，仍有卫分见证，发热无汗，脉浮数，宜辛凉疏散，清热解毒，消肿化结。方用银翘散加减。外以如意金黄散敷患处，继以原方加软坚化结之品而愈。

案二为热毒壅盛疳腮，患儿素有体内壅热，外受疫邪，邪热壅盛，气血受阻，经脉不通，壅于耳下，发为肿痛，王老经验，少加活血药物疗效增高。故初起即用贯众、青黛、清热解毒；白芷、细辛发散外邪；紫草、乳香活血祛瘀。二诊而全部消退。

（十）顿咳

【概说】

顿咳是小儿常见的呼吸道传染病，以间歇性发作的痉挛性阵咳、咳后伴有鸡鸣样吸气性回声为特征。病程较长，约为三个月左右，故又名百日咳。多发于冬末春初。五岁以下小儿为多发年龄。临床可分为三期施治。初期（初咳期）由发病到出现痉挛性阵咳为止，约1～2周，可见微热，流

涕、咳嗽、喷嚏等一般感冒证状。但咳嗽逐渐加重。又可分为二型，偏于风热者、可兼见舌红、苔黄、口干、脉数，以麻杏甘膏汤、金佛草散加减；偏于风寒者，以止咳散或小青龙汤加减祛风散寒，顺气止咳。中期（痉咳期）约4~6周，出现发作型、痉挛性阵咳。发作时，咳声短促，连续数十声无吸气间歇，甚至头颈筋脉怒张，涕泪交流，大小便失禁，阵咳最后以一深吸气而止，吸气时，喉中发出鸡鸣样声音，声音一止，又发作痉挛性阵咳。如此反复数次或十数次，终于咳出大量粘稠痰液，或呕出乳食，阵咳始为暂停。每日发作数次或数十次，夜间为甚，多见于口干苔燥，脉象滑数、痰中带血等，此邪毒壅肺，痰气交阻。亦根据体质不同分为寒痰束肺型和热痰敛肺型，前者用温肺化饮汤，降气化痰、温肺止咳。后者用桑白皮汤加减，清金化痰，泻热止咳。末期（恢复期）约2~3周，阵发性痉挛性咳嗽渐减，特殊吸气时消失，痰量减少，但因近两月的咳嗽，耗伤气阴，体质下降，容易合并其它疾患，治则应重在扶正。体质偏肺脾气虚的，宜用《幼幼集成》人参五味子汤益肺健脾；偏于阴虚火旺的，宜用麦门冬汤滋阴润肺。

此外用健康的猪、牛、羊、鸡的胆汁鲜用或干燥粉剂内服均有很好的疗效。

【选案】

案一，乔女，10月，病历号：99534。

二十日来阵咳频作，气呛成顿，咳剧则呕，咳后可听到吼声、痰鸣，精神饮食欠佳，肌肤不丰、二便自调，经治疗无效，转诊来院。查体：心、肺、腹无明显异常，舌无垢腻，指纹淡紫、诊为百日咳。

辨证：痰热互结，邪阻肺络。

治法：清肺化痰。

方药：炙百部5克 南橘络5克 炙桑皮6克 川贝3克
黄芩5克 瓜蒌皮10克 麦冬10克 知母6克 蜜杷叶6克
焦麦芽10克

服药3剂，痰热渐退，阵咳由每20~30分钟1次，减少到每1~3小时1次，每次由顿咳10分钟减少至2分钟左右，诸证大减，原方又服六剂，热已解，痰尽退，偶有一至二声轻咳，睡眠、饮食，二便如常，再予清肺化痰宁咳之剂，善后调理。

南橘络5克 炙桑皮6克 川贝5克 黄芩6克 焦麦芽10克 知母5克 麦冬10克 炒杏仁3克 蜜杷叶10克

《赵心波临床经验选》

案二，岑××，女，7岁，杭州市建筑科学研究所职工子女，于1980年8月23日来诊。

据家长代述：患儿于七八天前开始咳嗽，并逐日加剧而成痉咳，阵咳每日30余次，每次一分钟左右，以夜间为甚，咳时溢涕流泪，伴有回声，并易引起恶心呕吐，近日来曾数次衄血。体检：结合膜出血，咽红，舌系带糜烂。舌苔厚腻，心（-）二肺呼吸音粗糙。神经系统（-），周围血象：血白细胞总数14000/立方毫米，中性34%，淋巴64%，经服抗百日咳冲剂2日后，痉咳即由30余次减少至10余次，续服三日痉咳即逐渐好转而痊愈，疗程共5天。

百日咳冲剂方，每包冲剂内含百部15克 扛板归3克 黛蛤散15克（包） 海浮石3克 朱砂1.5克 朱砂细研过筛，其它诸药均水煎浓缩成膏，加入朱砂和适量蔗糖，制成冲剂颗

粒， 1 日 2 次冲服。

陈蓉蓉：应用抗百日咳冲剂治疗百日咳50例疗效观察《中医杂志》1981年10期

案三，徐×，男，2岁，门诊号213317，

咳嗽已半月。曾经治疗，证情不减，阵发性痉咳，呕吐，大便干结，舌苔薄白，脉滑，化验：白细胞21900，中性粒细胞20%，淋巴细胞75%。诊断为百日咳，给用百象汤3剂，复诊时咳已止，惟食欲不佳，予养胃汤调理而愈。

百象汤方：炙百部10克 象贝母10克 天竺子15克 秦皮6克 白前10克 桂苏子10克 酒地龙10克 炒麦芽10克 小茴香2克 生甘草2克 火麻仁9克

陈叔达：“百象汤”治疗小儿百日咳《上海中医药杂志》

1981年1期

【分析】

案一为痉咳期顿咳，风热与伏痰相搏结，郁而化热，煎熬津液，酿为痰热，阻遏气道，肺失清肃、痰塞不通，肺气上逆而痉咳阵作，须待粘痰尽量吐出，气机通畅，始得缓解。故治以清热化痰，滋阴降肺。方用桑白皮汤加减，只两诊诸证见愈。

案二为痰热阻肺型顿咳。目赤咽红，鼻衄舌下糜烂，舌苔黄腻，皆痰热内盛之象。治疗宜清肺化痰，降气止咳。百日咳冲剂方内，扛板归即雷公藤，善能清热解毒，利水消肿；黛蛤散、海浮石清热宣肺祛痰止咳；朱砂有宁心安神，镇惊熄风之功，五药配合能解痉止咳，清热祛痰，尤以应用朱砂解痉止咳为独到。

案三为内热壅盛顿咳。百象汤以火麻仁润下大便相表

里，肠清则气逆易平，痰积易下，咳喘可平。百部、象贝、天竺子祛痰止咳；秦皮、地龙清热；白前、苏子降气；麦芽、小茴香合用，健脾作用较白术为优。而且全方只有五味略苦，其余七味皆甘淡、宜于小儿服用。煎服可将一剂浓煎为250毫升，按年龄大小适量服用。如咳至眼结膜出血，鼻衄，痰血，可加玄参、生地、炙紫菀、仙鹤草同煎服。

（十一）水痘

【概说】

水痘是由水痘病毒引起的急性传染病。以发热、皮肤出现形状如豆，内含水液的小疱疹为特征。多发于冬春二季，1～6岁小儿易感染。一般预后良好。发病后可获得终生免疫。

发病过程，初起与感冒相似，发热较轻，发病1～2日后，于头面发际出现米粒大小红丘疹，接着躯干，四肢逐渐出现，以头面，躯干为多。继而皮疹中心水疱扩大，成为豌豆状大小不等的水疱，根脚红晕，疱疹三天左右开始结痂，有的皮肤可用时有皮疹、疱疹，疮痂存在，约2～3周痂盖脱落而痊愈。

临床分为轻重两型：轻型者，因风热挟湿，伤及肺卫，有感冒症状，皮疹颜色红润，疮疱浆清色，伴有瘙痒，一般神情清爽，宜用银翘散加滑石、萹蒡疏风清热，解毒祛湿；重型者，因湿热炽盛，有状热烦渴，口干便结，痘疹稠密，疹色紫暗，痘浆混浊不清，甚至口腔内亦有疱疹，口舌生疮等，应以加味消毒饮清热凉血，解毒渗湿。

本证邪毒一般只伤及卫分、气分、其窜入营血者甚少，并应注意与天花，脓疱疮做鉴别诊断，

【选案】

案一，刘××，女，3岁，门诊号106~606，1964年11月13日初诊。

初起鼻塞流涕，咳嗽微热，不思饮食已三天，昨日又发现头面发际等处有小红疹。今晨胸腹部及四肢均有大小不等的水泡，水泡周围微红，小便淡黄，指纹色红而浮。舌质红润，舌苔薄白，乃肺蕴热毒，外感时邪而发。拟清热透表解毒，方用麻黄连翘赤小豆汤加减：

麻黄 甘草各1.8克 杏仁3克 连翘 银花各4.5克 杜赤豆9克

服3剂、发热咳嗽均瘥，皮肤水泡消退，原方去麻黄，加牛蒡子4.5克，继服2剂而愈。

龚子夫：麻黄连翘赤小豆汤对皮肤病的应用

《浙江中医杂志》1966年4期

【分析】

案一为外感时毒，肺壅邪热而出痘。水痘始向外发，表证未解。故用清热透表，宣肺解毒方法，以助痘毒顺利外发，方用麻黄连翘赤小豆汤加银花清热解毒，加杏仁止咳祛痰，赤小豆功能利湿，有利于清利水痘湿邪。故亦取效甚捷。

（十二）小儿风水证

【概说】

小儿风水证是指感受外邪而引起的水肿证。临床以初起眼睑浮肿，继则头面全身浮肿尿少，血尿为特征。多发于3~8岁幼儿，四季皆可发生，西医诊断为急性出血性肾小球肾炎疾患，属风水证范畴。除少数变证者外，一般及时治疗，预后良好。发展为慢性疾患的小儿仅属少数。

临床按急性期，恢复期，变证、辨证施治。急性期又分为三个证型。风热型、眼睑浮肿，继则全身浮肿，肢节酸重，尿少，并可兼见风热风寒等表证，治疗宜越婢汤加减宣肺利水；湿热型，肢体浮肿，小便短赤，色如浓茶，发热神烦，皮肤疮毒，舌苔黄腻，脉象沉数，应用五味消毒饮加减清热解毒，利湿消肿；寒湿型，肢体浮肿，纳差倦怠，小便短少，舌苔白腻，脉象濡缓，可用五苓散、五皮饮加减渗湿、利水、消肿。兼有变证者，有水气上凌心肺，见肿体浮肿，呛咳气急，心悸胸闷、烦躁不得平卧等证，可用已椒萆黄丸加味泻肺逐水；有邪犯心肝，见头疼眩晕，烦躁，口苦，尿赤，甚至惊厥、昏迷；抽搐，舌苔黄躁，急宜龙胆泻肝汤加减平肝泻水，镇惊开窍；有水毒内闭者，见尿少尿闭，恶心呕吐，头晕头痛，甚至昏迷、应用温胆汤胜湿降浊，辟秽开窍。恢复期正虚邪留，脾肾已虚，湿热余邪稽留，应用参苓白术，六味地黄等随证治之。

肉眼血尿，或西医显微镜检血尿未消失者，宜酌加凉血止血药物；若尿色暗红，可酌用活血祛瘀药物。

水肿者，应控制饮水与食盐量，以免加重水肿程度，还应注意保持清洁，预防皮肤感染，及预防感冒。减少发病可能性。

【选案】

案一，张××，男，8岁，病历号56592。

一天来状热轻咳，头痛，颈部不适，面目微肿，小便短赤，大便两日未能行，血压110/65毫米汞柱，心肺、胸腹未见异常。化验尿蛋白(+++)，红细胞(++)，管型0~1。血沉第一小时28毫米，第二小时58毫米。舌苔薄黄，脉滑。

辨证：邪热郁闭，内伤络。

治法：清宣泄热化淤。

方药：银花10克 连翘10克 荆芥10克 枯芩6克 赤芍10克 丹皮6克 白茅根15克 败酱草12克 大青叶10克 大黄2.4克（炒） 栀子10克

服药3剂，肺气得宣，汗出尿增，诸证大减，病有转机，又继服三剂、面目肿已消，咳嗽壮热已平，诸证俱无，仅尿化验尚有轻微异常。继以金匱肾气丸调治月余而愈。各项化验均正常。

《赵心波儿科经验选编》

案二，向××，女，11岁，住院号10519。

因全身浮肿四天，尿闭2天，于1976年12月26日下午7时入院，患儿于20天前，突发全身红疹，瘙痒，未经治疗，1周后红疹隐退，旋即出现全身浮肿，头痛头昏，不食，脐周围阵痛，呕吐频繁，小便2天未解，经某医院用甘露醇，利尿合剂治疗无效。入院时呈急性重病容，神志清楚，精神欠佳，皮肤未见血点，双眼睑及下肢凹陷性水肿，血压130/90毫米汞柱。尿检：蛋白（++），白细胞（+），红细胞（++），管型0～3。血液：二氧化碳结合力30容积%，非蛋白氮116毫克%，诊断为急性肾炎伴尿毒症，给予抗感染、利尿、降压、能量合剂等治疗3天，病情无明显好转，改用中药治疗，证见全身轻度浮肿，小便不利、恶心，进食即吐，口苦，渴不欲饮，腹胀，转矢气才舒，纳呆，困倦、头昏，两天未解大便，舌边尖偏红，边缘不齐，脉象缓滑，辨证为湿困脾阳，浊阴上逆，湿邪有化热之势。治以温阳降浊，行气利水，佐以清热，方用温阳降浊汤加谷芽 陈皮 茯苓 连

魁 茅根 钩藤（温阳降浊汤：附子 大黄 半夏 厚朴 二丑 泽泻 生姜或加陈皮牡蛎）。另用大黄牡蛎汤每天一次作保留灌肠，3天后，小便增至500毫升左右，进食不再呕吐，腹胀减轻，大便转溏，浮肿稍减，原方去大黄加牡蛎，白术，服至8剂，除多涎外，余证全部消失，每日尿量达1000毫升左右，血中二氧化碳结合力和非蛋白氮恢复正常，尿毒症治愈，惟尿蛋白（++），改用加味参苓术草汤加减继续治疗，连服30剂，尿蛋白消退，出院。

吕敬江、唐聪：辨证治疗小儿尿毒症的体会

《浙江中医杂志》1981年4期

案三，徐××，男，3岁6个月，病案号40605，住院日期：1976年1月5日至1976年1月26日。

现病历：20天前，患儿出过脓疱疹，伴继发感染，近五天来，眼皮肿，尿少色红，不烧，食欲差，有时恶心，呕吐，诊为急性肾炎而入院。

查体：发育、营养一般，精神尚可，上眼睑浮肿，心肺正常，躯干有脓疱疹后瘢痕，口角右侧有一结痂皮疹，舌红淡、黄苔、上腭红紫、脉滑数。

化验：尿常规：褐色，蛋白（++），红细胞满视野，白细胞1～4高倍视野，血沉37毫米/第一小时，85毫米/第二小时。

西医诊断：急性肾炎。

辨证：邪毒蕴郁、气滞血淤。

立法：清热解毒，理气活血。

方药：青黛3克 紫草9克 寒水石9克 白菱9克 乳香6克

二诊：服上方剂3剂后，尿量增多，尿色变黄，浮肿见消，舌红少苔，上腭黄，脉滑数，用下方：

青黛3克 紫草9克 寒水石12克 白菱9克 乳香9克 五倍子3克

三诊：服上方药后，浮肿已消。尿常规；蛋白阴性，红细胞偶见，白细胞未见。

临床基本痊愈，带上方药三剂出院。

《王鹏飞儿科医案选》

【分析】

案一为风水急性期风热型，由于风热邪气外袭，阻于肌表，肺气不宣，通调失职，水道不通，风水相搏，致使水溢肌肤，发生风水。风热阻肿，不能外旋，壅于体内，使便秘尿短，邪热灼伤血络，便出现血尿，治疗急宜宣肺清热，凉血止血。方用银花、连翘等清热解毒配合丹皮、赤芍、白茅根凉血止血，加荆芥宣散肺热。诸药配伍、热邪内清，肺气宣通，故六剂而肿消，因化验尚有指标不正常，继以金匱肾气丸调理，务求追尽余邪，不使疾病迁延。

案二是小儿风水变证，水毒内闭型。外感风热、闭阻肺气，风水相搏，水道不通，邪无外宣之机，遂内闭于体内，影响肾与膀胱气化，导致尿闭，无尿则体内代谢毒物不能外出，浊邪堵塞，干扰脾胃升降，见呕吐；浊邪上干清阳，见头晕头痛，阳气不运，水湿内停，全身浮肿。此证湿浊邪气内阻为标实，而脾肾阳气不化为本虚。治疗宜扶正驱邪，温阳祛湿。方用温阳降浊汤加谷芽、陈皮、茯苓、连翘、茅根、钩藤治疗。外用大黄牡蛎灌肠以助清泻内热。牡蛎、钩藤可降逆清热，预防痉厥。服至八剂便转危为安。

案三为风火急性期气血郁滞型水肿，由于皮肤脓疱感染，热毒未清，内陷而使气血郁滞，热毒搏结，气滞血淤，灼伤血络，故出现尿血，气机阻滞，水道不能宣通，即水肿、尿少。治疗宜活血祛淤，清热解毒，用白芨、寒水石，清黛清热解毒，乳香、紫草活血祛淤，因一诊即注意凉血祛淤，故用原方三诊即血尿大减，浮肿已退。

（十三）疫毒痢

【概说】

疫毒痢是具有强烈传染性的消化道疾病，以发病急骤，高热、昏迷、抽搐为特征，多发于夏秋两季，2～7岁小儿易感染。发病常未见便痢患儿就已内闭外脱而迅速死亡。

本证来势急暴，病情重笃。发病前虽有呕吐腹泻，里急后重，下利赤白，但为时暂短，有的甚至没有下利症状，就突然高烧昏迷，临床分为实热内闭型与内闭外脱型辨证施治。实热内闭型：突然全身壮热，神昏谵语，频繁抽搐，痢下脓血色紫，伴有皮肤血红色疹点，或呕吐大量咖啡色血液，舌红绛起刺，苔黄厚焦干、急用玉枢丹、紫雪丹、安宫牛黄丸等清心开闭，并用葛根芩连汤、白头翁汤清肠解毒。内闭外脱型，实热内盛同时，突然出现面色苍白清灰，壮热抽搐，神昏不醒，四肢厥逆，呼吸短促等阳气将脱危证，宜急用参附汤送服安宫牛黄丸固脱镇痉，并以平肝潜阳药止抽搐而定风，脉搏有力，再以解毒清肠治之。

本证死亡率颇高，常在发病1～2日内急剧死亡。如在急性期未彻底治愈，就会形成慢性痢疾，时发时止，正气不支，治疗则宜扶正为主。

“痢无止法”，本证初起，急宜清热解毒开闭，以祛邪

为主，不宜过早使用固涩之品，防止疫毒邪气内陷营血。

【选案】

案一，高××，女，4岁，1966年5月23日入院，住院号72778。

寒战发热20小时，呕吐频繁，痢下粘冻样便脓血，神志不清。

入院后大便日数十次，仍不省人事，今晨抽风，曾给四环素，冬眠灵、非那根，输5：6：7溶液一份，推入静脉。

入院当日中医会诊：患儿神昏，尿闭7小时，颈抗（+），瞳孔缩小，腹软，肝肋下4.5厘米，剑下4厘米，脾未触及，舌面较糙，舌苔厚腻，脉象弦细而数。

印象：中毒性痢疾合并脑症。

辨证：毒热下痢、阳气郁闭不宜，关窍闭塞。

治则：开窍熄风、清热导滞。

处方：局方至宝丹3丸，每日2次，每次半丸，荡痢平24片，1日2次，每次6片。

服法：以上均鼻饲。

5月24日复诊：昨服药后当晚7时神志逐渐清醒，已有尿，今晨热退神清。颈软，仍便脓血。停局方至宝丹，继服荡痢平，一日2次，每次8片。

5月29日复诊：大便日下2次，为黄色成形便，便后仍有粘液，五天来体温均正常，本日带荡痢平五天量出院。

《何世英儿科医案》

案二，王××，男，10个月，1961年5月11日入院。住院号36025。

因消化不良住院，治疗半月余不见好转，近日来出现脓血便，病情加重，血压35/20毫米汞柱，体温突然下降至36℃以下，口内有鹅口疮。心音弱，两肺有湿性罗音。腹软，肝肋下3厘米，脾未触及，大便常规：脓球（+++），大便培养为弗氏痢疾杆菌。

6月1日中医会诊：中毒性痢疾合并休克而高热，昏迷，喉中痰鸣，呼吸喘促。今晨出现抽风，天吊，舌苔黑润，脉细弱无力，证属痢毒内陷，脾肾衰弱，拟温通开窍，健运脾阳，固涩救脱。

处方：苏合丸，每日3次，每次半丸，另用赤石脂31克 粳米15.6克 干姜3克 川黄连9克 水煎，鼻饲。

6月8日复诊：病情略见好转，呼吸稍促，痰仍不多，体温正常，神志略清，有体位性浮肿，无脱水证，心音较前有力，两肺无罗音，肋下肝大五厘米，剑下6厘米，脾可触及，舌润略黑，脉象细弱。

上方加野党参6克 肉豆蔻3克 补骨脂3克 苏合丸继续服用。

6月9日复诊：病情明显好转，神志已清大便转稀，日约10次，鹅口消退，给服附子理中汤加减，停用苏合丸。

6月12日复诊：改用磨积片治疗，两日后大便为日2次，性状正常，大便连续培养3次，无病原菌生长，7月16日出院。

《何世英儿科医案》

【分析】

案一为实热内闭形疫毒痢，由于热毒炽盛，与肠道疫毒相结，灼燔血络，故痢下脓血，热毒内陷心包，即神志不

清，急宜局方至宝丹清心开窍，清热解毒，待神清后，以荡痢平片清解肠毒，调理脾胃（荡痢平：川黄连6克 白头翁6克 秦皮6克 山楂炭6克 川厚朴4.7克 血余炭9克 藿香梗4.7克 车前子9克 谷麦芽炭各9克 每片0.3克）方由白头翁汤、香连丸化裁而来。治疫毒痢分清闭证，脱证为首要。闭属实，脱属虚，闭宜清热开窍，脱宜温阳救脱，而且有无大便是关键性问题，有大便宜以清心开窍为先，无大便者，则宜泻下驱邪为主，开窍为辅。

案二为疫毒痢内闭外脱型。热毒内陷，耗伤气阴，正不胜邪，脾肾阳气衰微，以致热毒内闭，真阳外脱，为疫毒痢最危重证型。治宜急救回阳，固涩止脱，兼清心开窍。用《伤寒论》桃花汤为主温阳、固涩，止痢，加黄连清热肠内热毒，并加苏合香丸开窍，继以温补脾肾法，辅以磨积片（炒神曲9克 生山楂9克 茯苓9克 陈皮9克 炒麦芽9克 泽泻9克 白术9克 清半夏4.7克 藿香4.7克 厚朴4.7克 苍术4.7克 甘草4.7克 每片0.3克）消导化积，健脾止泻。

四、皮科、外科医案

（一）疖、疔病

【概说】

疖多发于头面项背等处浅表的急性化脓性疾患。初起局部毛发根部出现圆形小结节，发红、疼痛，以后逐渐增大，周围皮肤出现轻度水肿，数天后化脓、破溃，出脓、结痂而痊愈。疖肿一般全身症状较轻，如果热毒特盛，或面部鼻唇周围的疖肿，用手挤压，使邪毒内散，则会发生高热寒战、

神昏口禁等邪陷心营重证，因而疖肿禁忌用手挤压。

本病尤以暑天多发，称为暑疖。如果疖肿多发或反复发作，日久不愈，称为疖病，多见于青壮年或消渴病患者；也可见于体弱小儿，辨证方法基本与疖相同，病久耗伤气阴者，可酌情加入益气养阴之品。

疖的治疗，多属阳证、实证，以清热解毒，清暑化湿为主，可选用五味消毒饮，黄连解毒汤随证加减，并应配合外治法，初起以四黄膏、金黄散、芙蓉膏、鱼石脂软膏外敷，成脓应以黑布化毒膏，丸一丹提毒拔脓，溃后可用生肌玉红膏促进愈合。

【选案】

案一，李××，男，32岁，门诊号267。

初诊：1964年8月26日。

病史：近3～4天来，头面部遍发热疖，疼痛作胀，夜不安睡，素有关节酸痛史。半月前曾在某医院治疗，服可的松30余片，效不显。

检查：头额及面颊部有散在性大小不一结块，局部皮肤微红，光亮无头，按之痛疼。

时值暑令，气候干燥酷热，兼服温热药物，以致暑邪外感，湿热血热内蕴，阻于肌肤之间发为本病。苔薄腻，脉滑数，治拟清热凉血解毒：

紫地丁18克 野菊4.5克 蒲公英30克 细生地12克 淡芩9克 赤芍9克 银花9克 连翘9克 鲜佩兰9克 车前子9克 生甘草3克

外用：千槌膏敷贴患处。

先后连续复诊8次，在治疗期间仍有反复，躯干部亦有

发生，曾经切开排脓10余处，亦有多处自溃出脓。内服方药以上方加减。

外用药：未溃用千槌膏，三黄洗剂，已溃用九一丹，太乙膏盖贴。至10月12日门诊随访时，头面躯干多发性疖已痊愈，惟患处留有色素沉着及作痒自觉症状。

顾伯华《外科经验选》

案二，周××，男，60岁，工人，门诊号7524498。

初诊：1975年8月29日。颈后、背几个月来遍发疖肿，常此愈彼起，今夏开始连续不断。目前左面颊处肿胀疼痛，脓头未出。颈后及臀处多处红色丘疹痒，大小便正常，苔薄滑腻，脉弦滑，暑湿外侵，热毒内蕴。拟清暑解毒利湿。

紫地丁30克 野菊花9克 银花12克 连翘9克 黄芩9克
绿豆衣4.5克 黑山栀12克 半枝莲30克 六一散12克(包)

外用：三黄洗剂擦颈后，臀部，千槌膏盖贴左面颊。

二诊：服药半月，疖肿痊愈，仍有发出，3～4天可自消，不溃脓，大便干结，小便溲赤，苔黄腻，脉弦滑，湿热偏重。

清解片，5片，日2次，龙胆泻肝丸9克(分吞)。

三诊：9月29日，疖肿仍不断发出，虽不溃破，存有僵块，未能根除，高年瘦弱，时口干夜饮，查尿糖阴性。苔薄舌红，脉弦，拟养阴清热法。

细生地15克 黑玄参12克 麦冬9克 蛇舌草30克 黄柏9克 生石膏12克 焦山楂12克 虎杖30克 丹参9克 生甘草3克

四诊，10月29日。上方服1剂，没有新疖肿发生，再拟前意。

滋阴补肾片，4片，日3次，蒲公英片(清热消炎片)

4片，日3次。

顾伯华《外科经验选》

【分析】

案一，为暑疖，亦为疖病，因身体强壮，服温热药物，内热炽盛，值暑令严热，外邪内热搏结于皮肤，成为多发性疖肿，治疗应清热解毒，活血、凉血。方用五味消毒饮，清热鲜毒；加生地、赤芍、凉血、活血；车前、佩兰利湿祛暑。配合外治千槌膏（上海中医学院方：蓖麻子肉150克 松香粉300克 轻粉30克 东丹 银朱各60克 茶油48克 制膏），贴患处清热解毒，拔脓消肿，凡八诊乃愈。

案二为多发性疖，亦为疖病。此证有时反复发作，不易根除，仍以清热解毒配合凉血活血方法，以银花解毒汤加減而取效。

（二）疔疮

【概说】

疔疮是发于颜面与手足等处的皮肤深部化脓性疾患。其特征是：疮形如粟，坚硬根深，如钉丁之状。发病迅速，危险性大。若热毒炽盛，常易邪陷心营，出现高热寒颤，神昏口噤，称为“疔疮走黄”。如处理不当，会导致生命危险。

疔的范围很广，历来名目繁多。《外科正宗》以五脏发疔命名为火焰疔、紫燕疔、黄骨疔、白刃疔、黑靥疔。又因发疔部位命名为托盘疔、锁口疔、坐板疔、对心发、人中疔、蛇头疔等等。尚有据疔疮形状命名为红丝疔，烂疔、鱼脐疔（疫疔）等等。

疔疖的区别在于：疖病多因暑湿，疔则多由火毒壅盛，疖随处可生，多发于头、颈、发际、臀部，疔多生于颜面、手

足；疔发肌肤浅表部位，疔则形小根底深，如疔入肉；疔证较轻，疔火毒势猛，颜面的易于“疔毒走黄”，手足的容易引起红丝或腐筋蚀骨，病势重笃。疔出脓则愈，疔则不易治疗，俗话说：“疔无大小，出脓就好”，“治疗要妥当，走黄要死亡”。

治疗原则，可按初起宜消，成脓宜托，溃后宜补的原则，并且内治外治相结合。初起宜消，即清热解毒，消肿散结。方用五味消毒饮加味，外敷宜箍毒消肿，用玉露散，金黄膏，千槌膏外贴；成脓期应清热解毒，凉血排脓。方用黄连解毒合五味消毒加山甲、皂刺等，外敷宜提毒拔脓，用二宝丹，九一丹，芙蓉膏等，或以药捻引流排脓；溃后应滋阴清热，生肌养血，方用解毒养阴汤外敷宜太乙膏，生肌散，生肌玉红膏盖贴。

疔疮走黄，是在原发疔疮处忽然疮顶陷黑无脓，肿势迅速向周围扩散，皮色暗红，并伴有高热头痛，呕吐，肢体拘急，或身发淤斑，风疹块、黄疸、神昏谵语，痉厥抽风等。属正虚邪实证者，宜用犀角地黄汤配合安宫牛黄丸、至宝丹等清心开窍，凉血解毒，若正虚邪实，病程日久，耗伤气阴，见低热，午后热甚，神昏嗜睡，自汗出，脉细数。则宜益气养阴，清热解毒。方用解毒养阴汤。

【选案】

案一，钟××，男，18岁。

下颌部生疮3天，3天前下颌部发一小疹，翌日即灼热而痛，日渐扩大，痛疼发硬，影响咀嚼，伴有恶寒发热，食欲减退。曾用西药未愈。局部5×4厘米硬肿浸润，有数个脓头已破，流脓不多，舌质红，薄黄苔，脉弦数。

辨证：疔疮散毒。

治法：清热解毒。

方药：银花 丹皮 生地 白芷 紫花地丁 栀子 蒲公英 连翘 黄芩

另服紫雪丹，每日3次，每次1.5克。

外敷拔毒膏与疮顶，疮周厚围六合丹，两天后肿硬渐消，化脓溃破，继用清热解毒之剂内服，当脓排尽，乃用化腐生肌药治之，共治二十天痊愈。

吴介诚《疮疡经验录》

案二，夏××，男，22岁。

五天前右唇生一疔，挤后高烧。诊断：唇痈，败血症，血培养证实。用大剂抗菌素、支持疗法、物理疗法，仍未效，转入昏迷，腋下体温40℃以上。中医会诊：面颊皆肿，壮热神昏，口噤不语，两手握固，目赤，上唇腐烂出血。

辨证：疔毒走黄，毒陷心包。

治法：清热解毒，芳香开窍。

方药：紫花地丁60克 带心连翘15克 金银花30克 生甘草10克 川贝（去心）10克 丹皮6克 赤芍10克 黑山栀10克 钩藤（后下）10克 用水煎，冲入菊叶汁一杯，并调下紫雪丹3克，犀黄0.6克，鼻饲给药。

外治：疮头掺黄升丹，贴黄连膏，焮肿处用金黄散外敷，两委中穴放血。

二诊：昨进药，次日下午体温37℃，神志较清，能讲一句话，治法原意扩充，药用：

安宫牛黄丸2粒（研）犀黄1克（研）犀角粉1克分3次鼻饲，5小时1次。汤药：

鲜生地30克 丹皮10克 赤芍10克 银花30克 地丁30克
天竺黄10克 川贝10克 带子青蒿10克 甘菊花10克 草河车
10克 鲜竹叶30克 灯芯3 蒿鲜菊花叶汁1杯（冲）

前药煎汤鼻饲，上唇腐烂用珠黄散和蜜调敷，其余外用
药仍按原法。

三诊：中西医治疗两天，体温、脉搏正常，神志清楚，
壮热告退，目翹既上，唇内腐烂已定，面目颈肿十去其八
九，口尚干渴，脉数未净，舌红苔黄，余邪未净，改用下
方：

银花藤30克 紫花地丁30克 连翘10克 甘菊10克 生甘
草8克 赤芍10克 丹皮10克 黑山栀10克 黄芩10克 鲜生
地30克 鲜野菊叶汁1杯，上犀黄0.3克。

会诊后5日，血培养（-），第九日局部红肿基本消
退，一般情况良好，能下床活动，以后单用西药调理一月左
右出院。

《许履和外科医案医话集》

案三，崔姓，女，11岁，于1958年8月24日就诊。

证：在口角左边生一疔疮，起小黄疱，大如米粒，木硬
红肿，痒极心烦，脉象滑。

处方：公英 地丁 双花 连翘 当归 白果 桔梗水
煎服外以芙蓉叶末为散，蜂蜜调敷患处，每日换敷一次（服
药后麻木疼痛减轻，仍以原方服之而愈）

《华廷芳医案选》

案四，王×，男，4岁，初诊日期1969年2月16日。

主诉：（家长代诉）：患儿右手中指肿痛，高烧不退，
已二周余。

现病史：两周前右手中指内侧被木刺扎伤，经处理，三天后红肿做疼，即赴医院，经检查，诊为外伤感染，服用抗菌素，肿痛不减，体温增高。三天后在中指第二节指腹中央切开排脓，三日后局部又肿起，发烧持续不退。又在中指第二节指腹两侧各作一切口引流，肿胀仍未消，现已蔓延于手掌部，发烧持续一周不退，食欲不振，大便三四天未解，小便黄赤而少，有时呕吐，因手部疼痛，经常哭闹不止，夜不成眠，曾嘱立即截指，家长未同意，来我院治疗。

检查：右手中指高度红肿，第三指节之两侧和指腹中央各有一切口约2厘米，切口周围之皮肤为灰白色，取出引流纱条后，有较多脓血流出，臭味较大，三个切口之间，探针可以通过，红肿已累及手掌近手腕部，因中指高度肿胀，不能屈伸，X线摄片报告称：中指第二、三节骨质有轻度破坏，边缘不整。

脉象：细数。

舌象：舌苔白中黄，舌质红。

西医诊断：化脓性指头炎。

中医辨证：外伤染毒，蚀筋腐骨（蛇腹疔）

立法：清热解毒，活血消肿。

方药：金银花10克 公英10克 地丁10克 丹皮10克 赤芍10克 元参15克 麦冬9克 大黄4.5克 犀黄丸10克 每次10克，日服2次。

外用红粉纱条引流，外敷化毒散软膏，每日换药一次。

服上方5剂后，已进普食，大便通畅，小溲清，患掌及患指红肿已明显消退，肿胀局限中指第三指节，脓血已减少，疮口变小，肉芽红活，再以清热解毒、化腐生肌之剂内

服，上方去大黄 地丁 加瓜蒌 白芷 停犀黄丸。外用甲字提毒药捻引流，外敷化毒散软膏。按前法治疗五六日后，已能入睡，中指两侧之切口基本愈合，患儿已能下地活动。前方去公英 丹皮 赤芍 加当归 黄芪 山药，换药如前。又经上方内外兼治，七日后，中指指腹两侧之切口基本愈合，已缩小至0.5厘米，肉芽充满，色鲜红，局部稍肿，两侧切口斑痕较前变软，手指可以轻度伸屈，停服汤药，外敷甘乳膏，每日换药1次，3日后疮口愈合痊愈后出院。

附：

犀黄丸方：乳香（醋炙） 没药（醋炙） 牛黄 麝香 黄米面。

红粉纱条：京红粉4.5克 利马锥30克 冰片3克 凡士林半磅 共研极细，凡士林调成膏涂于纱布条。

甘乳膏：乳香6克 水飞甘石粉6克 龙骨6克 石脂6克 海螵蛸6克 凡士林120克

《赵炳南临床经验集》

【分析】

案一为承浆疔。因疔毒火热炽盛，疔疮红肿热痛。《疡科心得集》云：“外证虽有一定之形，而毒气之流行，亦无定位。”热毒内陷，机体不克防御，以致疔毒走散，入于营血，内攻脏腑，临床可以见到五脏六腑的毒热证候，此证毒邪干扰气血，影响脾胃，故发热恶寒，食欲不振。治疗用清热解毒，托毒外出方法。内服五味消毒饮加丹皮、生地凉血活血；加栀子、黄芩清解内热。配合外治法，用围药及外敷药促使疔毒化脓溃破。治疗及时，避免了疔毒走黄重证。

案二为唇疔走黄。因压挤使疮毒走散，入于血分，内散

脏腑，以至热闭心营，肝风内动。治疗急以紫雪丹、犀黄鼻饲开窍；汤药用清营汤，五味消毒饮合方加减凉肝熄风，活血解毒。并配合外治以黄升丹，黄连膏外敷。二诊高热稍退，继用汤药，外用药治疗而愈。此用温病邪陷心包治法取效，亦异病同治一则。

案三为锁口疔，初起热毒即盛，红肿痒极，急宜清热解毒，消毒散结。方用救唇汤加减（救唇汤方：紫花地丁30克 金银花30克 白果20克 桔梗 生甘草 知母 各10克 水煎服），救唇汤为华氏经验方，云其久已流传民间，屡用屡效。方乃以大量清热解毒排脓药为主。木芙蓉膏外敷法也是外用良药，木芙蓉一味凉血解毒，消肿止疼，调以白蜜亦是清热解毒之品，故能速效。

案四为蛇腹疔，指疔生于手足指趾，顶端的称蛇头疔，生于指甲内的，称沿爪疔；生于指甲后的，称蛇背疔；生于指骨间骨的，称蛀节疔；生于指内的，为蛇腹疔。手足指趾疔疮初起多局部无头，有头者少。兼有麻木作痒，继则焮热肿痛，有的红肿不明显，故疔疮多生暗处，初起或疼或不痛，或痒或不痒，发时人多不觉，最易误事。此案已是疔疮出脓不畅，毒邪内陷脏腑，蚀筋腐骨。急需清热解毒、凉血活血，配合外治提毒拔脓。内服五味消毒加减与犀黄丸，外用红粉纱条引流；疮口缩小时用甲字提毒药捻引流；疮口近愈则换用甘乳膏生肌长肉，赵炳南先生是当代著名疡科大家，对于外科、皮肤科临床治疗有丰富经验。此证按西医看法，应该切除手指，以免造成骨髓感染。而中医治法，不仅保存了手指，还恢复了功能。

（三）痢

【概说】

痈指发生于皮肉之间的急性化脓性疾患。特点是痈疮范围在6~10厘米之间，局部红、肿、热痛。痈发病迅速，易肿、易脓、易溃、易敛，一般不会损伤筋骨或造成痈毒内陷证。

痈有内痈，外痈之分，内痈发于脏腑，外痈生于体表。外痈多发于颈、项、背等皮肤粗糙厚部位。外痈因为发病部位不同，亦名目繁多。如颈痈、锁喉痈、囊痈、子痈、臀痈，脐痈等。

临床分二型三期论治。实证者，初期局部红肿焮热、基底坚硬，触之剧痛，肿物与周围皮肤界线不清，并伴有全身恶寒发热，口干渴头痛泛恶，便秘尿黄、舌苔黄厚等。宜内服仙方活命饮，消痈汤清热解毒，活血祛瘀，外敷芙蓉膏，黑布化毒膏、金黄散、大乙膏、千槌膏等消肿散结，拔脓解毒。成脓期局部肿势高起，明显波动、痛如鸡啄，伴有全身发热不退，宜内服透脓散解毒透脓，清热凉血，外敷用二宝丹、九一丹、化毒散、铁箍散等，或用药卷引流。收口期，痈疮流出脓毒腐肉，为稠厚黄白脓，局部肿消痛止，全身症也随之消失。若出脓后，疮面仍四周坚硬，应扩疮排脓，若新肉不长，可服四物汤等补养气血。外敷宜生肌玉红膏盖贴，或以生肌散掺入疮内。正虚邪实型，初期疮形平塌，色暗不鲜，伴有少气无力，纳呆食少，舌淡，脉细数无力。内服宜透脓散托毒透脓；若阴虚火旺型，灼耗津液，则宜托毒排脓，佐以养阴生津。局部治疗基本与实证相同。

【选案】

案一，陆××，男，11岁，学生，入院日期：1963年11

月15日，出院日期：12月6日。

病史：两周前患者左脚背不幸被沥青烫伤淤阻，数日后继以患处因被竹杆打伤，于次日左腘窝感觉疼痛，步履不便，并日渐加重，于入院前三天骤发高热持续不退。检查：患处焮红肿胀，灼热疼痛难忍，范围约11×6厘米，按之中软应指，头面躯干皮肤出现风团样块物，伴有口干欲饮，便燥溲短。

半月前左足背烫伤，火邪热毒外侵，郁于皮肤，复因直接受到竹杖打伤，以致经络被阻，营卫失和，血凝毒滞而成痈肿。故《内经》有“营气不从，逆于肉里，乃成痈肿”之说。苔黄，脉数，由于热毒交蒸，入于营血，故见遍身皮肤疹块累累，治当切开引流。使毒邪得以外泄，内服凉血、清热解毒之剂。

银花10克 赤芍10克 丹皮6克 连翘15克 地丁15克
生山栀10克 制军10克 生草5克 川牛膝10克

入院当时，给以切开排脓，流出稠脓100毫升，二宝丹药线引流，金黄膏盖贴，外以垫棉包紧，防止袋脓。内服凉血清热解毒之品。局部痛疼减轻，肿胀缩小，皮疹块亦消失，体温降到38℃以下，考虑到患儿体弱，又有咳嗽，故应用土霉素250毫克，日4次，服2天。此后，体温正常，中药改为和营、清热、解毒之品。后期并嘱患者病后功能锻炼，痊愈出院。

顾伯华《外科经验选》

案二，尹××，男，32岁，门诊号：481187，初诊日期，1968年2月13日。

主诉：臀部初起一小红疙瘩，轻微痒痛，逐渐加重，伴

有发冷发热，注射“青霉素”数日不效，来院就诊时仍发烧，口干，不思饮食，大便干，小便黄赤，因局部肿痛影响走路。

检查：体温38.8℃，左侧臀部红肿范围约8×5厘米，灼热明显，有压痛拒按，触之稍软，但波动不明显，左侧下肢活动受限。左腹股沟淋巴结肿大，有压痛。化验检查白细胞计数30100/立方毫米。

脉象：弦数。

舌象：舌苔黄厚、舌质红。

西医诊断：左臀部蜂窝组织炎。

中医辨证：清热解毒，活血内托。

立法：清热解毒，活血内托。

方药：金银花15克 公英15克 连翘12克 赤芍9克 白芷9克 青陈皮各12克 炒山甲9克 炒皂刺9克

外用铁箍散软膏围贴。

2月15日，体温38.6℃，服药后，臀部红肿渐退、痛疼仍剧烈，尤以夜间为甚、局部波动明显，局麻下切开一小口，流出脓汁约100毫升，用红粉纱条填塞，继以解毒内托之剂。

金银花15克 公英30克 连翘15克 花粉12克 地丁15克 当归9克 败酱草15克 黄芩12克 青陈皮12克

局部每日换红粉纱条1次。

2月17日，局部周围红肿已消，疼痛已止，有时局部有痒感如虫行，疮面肉芽组织红润，有少许脓液外润溢。体温恢复正常，白细胞计数13600/立方毫米，脓汁细菌培养结果为大肠杆菌，拟以理气活血，清热解毒为法：

当归12克 青陈皮各15克 全瓜蒌15克 红花9克 金银花15克 公英15克 连翘12克 生甘草9克

局部换药同前。

按上方加减三剂后，疮口日益变浅，疮面清润，六天后疮口愈合，痊愈出院。

《赵炳南临床经验选》

案三，张×，男，30岁，1963年7月31日初诊。

四个月前每在阴雨之时则感两侧睾丸隐痛，步履时亦牵引作痛，甚至不能下蹲，曾诊为睾丸炎，现阴囊粗大下垂，副睾丸肿胀，行动时少腹隐痛，腰酸不耐久立，头昏，小溲色黄，溺时不畅。脉弦，舌边尖红，苔糙腻而厚。

辨证：肝气失疏，湿热交阻。

治法：疏肝理气，清热利湿。

方药：赤白芍各9克 粉丹皮9克 稽豆衣9克 橘叶核各9克 生枣仁15克 赤苓12克 白蒺藜9克（去刺） 梗通草4.5克 建泽泻9克 桑寄生9克 忍冬藤9克 块消石9克（包） 3剂。

三诊：睾肿渐软，久立则阴囊滞胀下坠，余证同前，系湿热蕴阻。前方去稽豆衣 白蒺藜 加佩兰梗。

四诊：睾肿渐消，阴囊上束溺清、畅利。前方加陈皮4.5克，后又以此方去橘叶核加制苍术 淮山药 川黄柏连服12剂而愈。

《上海老中医经验选编·张赞臣医案》

案四，罗××，男61岁，1982年7月20日初诊。

5天前脐部有一指头大小红色硬块，发痒，灼热疼痛，经青霉素，四环素等药治疗不效，脐周肿块约碗口大小，焮

热疼痛，全身时作恶寒颤抖，发热汗出，口干苦，大便干结，小便黄少、脉洪而数，舌红，苔黄腻乏津。此为心脾湿热流于小肠，雍塞气血，经络阻滞，营卫失和所致，治宜清火解毒，利湿活血，拟立消散合黄连解毒汤化裁。

处方：银花60克 连翘15克 地丁草60克 黄连4克 黄芩12克 栀子10克 黄柏12克 茯苓15克 花粉12克 赤芍10克 当归30克 甘草5克 水煎服，每日1剂。

外敷：金黄散（黄柏 大黄 白芷 南星陈皮 苍术 花粉等分为末，醋调外敷）。

服2剂后，肿消过半，恶寒发热，汗出，口干、便结等证消失，原方去茯苓加土茯苓12克，外敷药同前，又2剂后，肿胀全消，予前方加健脾益气之药善后。

李子周等：立消散在外科临床的运用

《中医杂志》1985年12期

【分析】

案一为委中毒。生于膝后腘窝委中穴部位的痈肿称为委中毒。本案病机阐述的极为明白，一诊以五神汤加味，又配合适当外治法而愈。委中毒往往两三周后方可溃脓，溃破又会脓出过多，筋失营养而筋脉挛缩，以致腿屈伸不利，因而治疗应注意排脓通畅，防止袋脓。（五神汤方：《外科真诠》方：茯苓 车前 牛膝 金银花 紫花地丁）

案二为臀痈，患病八日，局部脓成欲溃，内消之机已失，先用清热解毒，活血内托方法。以仙方活命饮加减。金银花、连翘、蒲公英清热解毒；败酱草消痈排脓，破血行瘀，瓜蒌消肿散结；赤芍、青皮理气活血；白芷清热消肿；山甲，皂刺软坚透脓，外用铁箍散软膏聚毒拔脓。待其局部

被动明显，疮仍无头，故配合小切口排脓，使脓毒有出路，以防毒邪流窜。继以解毒内托之剂而愈。

案三为子痈。子痈是指发于睾丸本身的化脓性疾患，分为急性，慢性两种。急性的，睾丸肿痛，阴囊灼热，皮色发红，并伴有全身寒热不适，口渴、头痛等证，一般经过治疗，可以不化脓而愈，即使成脓破溃，收口亦快。慢性者，起病缓慢，睾丸渐肿，疼痛较轻，阴囊不热，溃后浓水稀薄，硬结不消，收口较慢。急证与治痈同法，慢性当以补益肝肾为主。子痈还需与囊痈鉴别诊断。睾丸不肿而囊肿者为囊痈。以肾囊红肿热痛，囊皮绷紧光亮，大部分经过治疗能够消肿退热，部分亦会溃破出脓。此证子痈由湿热交阻体内，肝气不畅，湿热沿肝经入注阴器，而为子痈，尚属急性者，以舒肝理气，清热利湿法治之。方中梗通草即水通草，善于清湿热，利水肿，功能与白通草相仿。治疗及时，肿消热退而愈。

案四为脐痈。由于心脾积热，下注小肠，雍滞气血，阻塞经络，淤血热毒结于脐周而发痈，宜清热解毒，活血祛淤，方用黄连解毒汤合立消散（金银花 地丁草 当归 赤芍 玄参）其中重用金银花、地丁草加强清热解毒消痈的作用，故二剂即能痈消肿散，未致化脓。

（四）有头疽

【概说】

疽者阻也，指气血为毒邪阻滞不行之意。疽分阴阳，初起有脓头者，称为“有头疽”，为阳证；初起无头者，称“无头疽”，为阴证。包括附骨疽、肋疽等。

有头疽是发生于肌肉皮内的急性化脓性疾患。其特点是

初起皮肤上即有粟粒样脓头，焮热红肿胀痛，易向深部及周围扩散，脓头相继增多，溃后状蜂窝。脓液不易畅泄，肿块常超过9~12厘米以上，大则盈尺。多发于中老年人，皮肤较厚坚韧之处易发，尤好发于项、背。有头疽古称“发”，由于发病部位不同，有“手背发”、“足背发”等。生于脑后者，称“脑后疽”，生于背后的，称“发背”。

阳疽的治疗，基本与痈相同，亦分为两型、三期论治。此证与痈的区分在于痈发病迅速，易肿，易溃，易脓，易敛，疽则溃后不易收敛；痈疮脓头只有一二，疽则脓头多如粟米；痈病程较短，三周可愈，疽则在一月以外方可收口；痈为阳证，疽为阴证。

【选案】

案一，郡中朱姓患项疽，背痛彻心，时时出血，延医施治，漫肿滋甚，神思昏迷，束手待毙，延余视，急用围药裹住根盘，敷以止血散，饮以护心丸、痛缓血止，神实得寝。明日前医来，告以故，医谓同一金黄散，我用无效，彼用神验，此命运不同，非药异也，彼盖不知围药每病各殊耳，疮口已定，乃大托其脓，兼以消痰开胃之品，饮食渐进，坐卧皆安，两月而愈，凡治痈疽之法，在视其人之肥瘠，瘦弱之躯，尤忌见血，疮口若大，则肌肉难生，所以最重围药，其方甚多，不可不广求而预备也。

《徐灵胎医书全集》

案二，赵××，女，66岁，1956年11月9日初诊。

九天前项后偏右起米粒大疮头，始痒后痛，肿块日增，平塌不起，颈项转侧不利，饮食不思、精神萎顿。检查：项后右侧可见手掌大肿块，漫肿坚硬，皮色不红，疮不高突，

中间脓孔淤集，犹如蜂窝，但渗血水而无疑。痛苦病容，呻吟不语，脉沉细弱，舌淡苔薄布，体温38.2℃，白细胞17600/立方毫米，中性粒细胞86%，淋巴细胞14%，中医诊断：偏脑疽。西医诊断：痈。证属高年气血虚弱，正虚邪陷。治拟：理气和营，补卫托毒。方用黄芪 当归 赤芍 远志 大贝母 炒甲珠 皂角刺 先服1剂。

二诊：症由情志郁结所起，且在邪势鸱张之候，正不胜邪，疮不高突，尚有毒陷之虑，还当托里消肿。方用生黄芪 羌活 炒远志 当归 大贝母 茯苓 炙甲片 皂角刺，2剂。

三诊至五诊，补正托毒之后，脓毒透泄，肿痛俱减，热势盛，精神振，仍宗前方加赤芍 忍冬藤 草河车等出入，继服8剂，外用祛腐生肌药，不久即愈。

此例年届高龄而患大疡，平塌不起，正虚不能外腐成脓、势必毒陷生变，方以补托并进，得挽颓势。

《著名中医家的学术经验·朱仁康医案》

案三，俞左，背心发，漫肿不红，顶平散涣，脓腐不化，身热，脉数，数为毒盛遏而不泄之证，当以攻透泄毒。

黄芪9克 皂角刺6克 赤芍9克 姜蚕9克 丹皮6克
首乌9克 银花9克 当归9克 连翘9克 山甲6克

另蜈蚣丸一九（吞）

外用：太乙膏掺雄麝散。

二诊：高年生发背疽，疮顶不显，周围色紫，根盘平塌，坚硬不化，痛虽作而不甚剧，纳少口燥；脾土困败，脓毒不泄，防其毒陷内闭，再以托补，冀能转机。

党参6克 黄芪9克 皂角刺6克 茯苓9克 谷芽

9克 甘草节3克 陈皮6克 山甲9克 银花9克 赤芍9克

另用三年老母鸡浓煨，食鸡汁（只服一只）。

三诊：背疽腐脓渐化，根腿亦定，疮口溃烂，毒邪已得外泄，惟高年正气已伤，气血本衰，须要着意调摄，不在药餌中也。

外用五五丹药线引流，外敷太乙膏。

四诊：背疽已半月有余，脓水渐少，疮口略收功，但正气已亏、年高易虚难负，宜小心。

党参9克 黄芪9克 全当归9克 茯苓9克 谷麦芽各9克 银花9克 生地12克 赤芍9克 炙甘草3克 新会皮6克

外用太乙膏掺八宝丹。

章琴韵等：无锡章氏外科经验简介

《上海中医药杂志》1964年9期

【分析】

案一为项疽，因调治不当而毒邪走散，以致项连背肿，疽疮环项长有尺余，毒邪灼伤血络，出血不止。先以护心丸凉血解毒，安神镇惊，先安其未受邪之地，使邪不内攻，继以止血散凉血止血；外用围药（围药为徐氏所善用以金黄散，回阳玉龙膏等用醋、油、酒调和外擦于疮之周围，起到截毒、拔毒、束毒的作用）束缚毒邪，使不再继续走散；以珠黄散敷疮口解毒消肿；内服大量黄芪煎汤，促进溃脓；继用生肌药物及人参研末涂于疮口，促进生肌长肉。其后议论曰：“诸痛痒疮，皆属于火”，脓流肉腐，皆可伤阴，治疗总宜滋阴清火，确属经验之谈，徐灵胎为清代名医、亦工于外

治。《回溪医案》中记有他用胎狗配药，使一个患者因下疳疮烂掉阴茎再生。肢体再生，古今未有，可知徐氏确属身手不凡。

案二为背疽正虚邪盛型。高年正气不支，又发疽疮，正虚邪实，难以骤然驱邪外出，故疮不化脓，漫肿不红。治疗用银花解毒汤加味，清热托脓，活血散结，又配黄芪，当归补养气阴。嚙衄丸乃《外科全生集》方（用牛黄 儿茶 血竭 三七 天竺黄 大黄 乳香 没药 雄黄 阿魏 藤黄 冰片 麝香组成）善治跌打损伤，痈疽流注，再配以外治法，高年气血不足，一诊虽疮势未加剧，但亦未能托毒成脓，二诊又加党参、谷芽、陈皮等建中，并令食鸡汤助正气，后疮化脓，外敷以药，配合补气养阴，清解余毒而效。

案三为偏脑疽。正虚邪陷。正虚无力，不能抗邪，以至疽毒内陷、已是溃脓期，但不能腐脓透毒，以至浑身不适，发热不退。治宜补托并进，二诊之后肿痛减，脓毒透泄，方加用忍冬藤、草河车、赤芍凉血、活血，清热解毒排脓，连服八剂而脑疽即愈。

（五）无头疽

【概说】

无头疽是发于骨骼肌肉深部的脓疡，具有初起无头，白色漫肿，不红不热，酸多痛少（少数微红微肿，疼痛剧烈）难消、难溃、难敛，多生于胁肋及四肢部分。有胁疽，渊疽、肋疽等，此处疽疮，易伤内膜。生于四肢的，多发于长骨，有附骨疽，咬骨疽，脱骨疽，此处生疽，易伤筋骨。尚有生于腕关节的兑疽，生于踝关节的踝疽，生于股间的阴股疽等，其辨证论治大略相同。

附骨疽是附着于骨，毒气深沉的深部化脓性疾患。多发

于儿童，以下肢为多见。以局部漫肿，附筋着骨，推之不移，疼痛彻骨，溃后浓水淋漓，不易收口，可成窦道，损伤筋骨为特征，病因由于疔肿疮毒、外伤及传染病后。邪毒内攻、流窜筋骨所致，临证亦按三期论治，初起宜以仙方活命饮合五神汤加减清热化湿，行淤通络，外敷以金黄膏，回阳玉龙膏，玉露膏等；成脓期用透脓散加减透脓托毒，外治宜早期切开排脓；溃后应用人参养荣、大补阴丸合清骨散扶正祛邪，生肌收口，外治应取出死骨，手术清疮，脓尽可敷白玉膏，生肌散。

脱骨疽属寒湿，火毒侵犯筋脉，引起趾甲坏死脱落的慢性疾患。多发于青壮年，以男性为多，下肢较上肢更为多见。以初起指趾间凉冰、麻木、步履不便，继则疼痛剧烈，日久足趾紫黑腐烂，骨节脱落为特征。多因寒湿、热毒、淤血凝阻经络，气血闭塞而成。治疗原则应内外配合，分型论治。因于阳虚寒凝者，宜内服阳和汤，独活寄生汤通阳宣痹；因于血淤闭阻者，应用血府逐淤，桃红四物汤等化淤通络；因于热毒者，选用四妙勇安汤合醒消丸清热解毒止疼。外治宜及时消除坏死组织，初中期可选用红灵丹，冲和膏外敷；并用红灵酒揉搓患肢足背，小腿，或以威灵仙，桑枝等煎汤洗濯患肢。后期肿块消失，应分期分批清除腐肉死骨，疏松的先除，牢固的后除；腐肉先除，死骨后除。晚期病人，经治疗无效者，可根据具体情况进行不同平面的截肢术。

肋疽生于肋骨下软组织处，渊疽生于腋下三寸肋间，肋疽生于肋条骨间，同样具有局部初起白色漫肿隐痛，溃后浓水不尽，久不收口，易致成漏，或损伤内膜的特点。病因总由

木失条达，郁而化火，灼液成痰，痰凝气阻，滞于肝胆二经面成。治则仍从初、中、末、三法论治。初期宜清肝解郁汤清肝解郁，行气散结。外治用太乙膏掺红灵丹外敷；成脓期宜护膜散，透脓散解毒透脓，外治宜切开排脓；溃后应用人参养荣汤、大补阴丸方扶正生肌，合清骨散清透余毒。外治可以白玉膏，生肌散生肌收口。

以疽命名的外证，还有石疽、脱疽、甲疽等等。石疽分上、中、下三种，以其肿物坚硬如石，由痰气交阻而生，与瘰疬同治；甲疽则是由于指趾甲嵌入肉内所引起的外伤性疾患名曰嵌甲，治疗与疽症不同。

案一，郭某，男，43岁。住院号295016，住院日期1962年11月7日。

主诉：右足跖趾溃烂，剧痛3个月。

现病史：患者于18年前在战争中左足大趾及右小趾远端外伤，在担架途中受冻伤，两月后，患趾部分坏死脱落。11年前发现，左手3、4、5指畏冷抽搐疼痛，未明原因，继而发黑溃破坏死，先后将左手3、4指远端截除，五年前左手六指内侧皮肤颜色暗黑伴有剧烈疼痛，经服汤药四个多月，病情逐渐好转，以后右下肢疼痛逐渐加重，静止时也有疼痛，夜间疼痛剧烈，间歇跛行，日见恶化。今年八月因洗澡修脚后，局部疼痛加剧，趾端溃烂并有少量脓性分泌物，经门诊治疗一个多月，未见明显好转，患趾坏死继续发展，近50天来病情恶化，患足红肿，跖趾腐烂日益扩大，终日剧疼抱膝呻吟，每日只能睡一二小时，收住院治疗。

过去史：患者既往健康，19岁参军，多次遭受风雪冰霜侵袭，吸烟史二十二年，每天吸烟15~20支。

检查：发育良好，营养欠佳，面色萎黄，全身皮肤枯槁，体型瘦长、神志清醒，表情痛苦，扶足抱膝，坐卧不安。全身淋巴结无肿大，胸腹未见阳性体征，胸部透视右上肺硬结期肺结核。左小腿周径30厘米，右侧小腿周径28.5厘米，小腿肌肉松弛，全足皮肤枯燥，粗糙不同，毳毛消失，各趾甲肥厚不平，右足跖足背肿胀，右足趾自第一节表皮红肿光亮，近跖部有环形青紫斑，足趾远端湿性坏死，疮面 3.5×2.5 厘米，外露肌腱，趾甲松动，右小趾缺损断端表面结有肥厚性鳞屑瘢痕，双足发凉，心电图检查正常。化验检查：血、尿、便常规末见异常，血小板计数 $142000/\text{立方毫米}$ ，出血时间2分半，疮面细菌培养为金黄色葡萄球菌，大肠杆菌。

西医诊断：血栓闭塞性脉管炎三期，右跖趾湿性坏死，截趾，趾畸形，合并右上肺结核硬结期。

舌象：舌苔黑而厚，舌质红。

脉象：沉细，左足趺阳脉沉细，右足趺阳脉，太溪脉未扪及。

中医辨证：屡受风寒阳气受损，血涩气滞，郁久化热，耗灼阴津而致脱疽。

立法：养阴解毒，佐以通络。

第一阶段：1962年11月7日至1962年11月26日，共19天，经脉久闭，郁久化热，毒邪炽盛，串腐坏死，治以清热解毒，益气养阴托毒：

当归9克 金银花15克 元参9克 地丁15克 野菊花15克 石斛15克 丹皮9克 黄芪9克 党参9克 牛膝15克 生甘草9克

外用 1% 链霉素水溶液纱条外敷。

经过治疗，十天后每日可入睡 5~6 小时疼痛显著减轻，胃纳日渐好转，患足红肿消退大半，腐筋烂肉大部脱落，疮面分泌物减少。

第二阶段：1962年11月26日至 1963年 2 月 6 日，共 73 天。

毒邪已解，腐肉大部已除，但腐骨未脱，再以养阴扶正佐以温通活血托毒为法：

石斛 15 克 赤芍 9 克 金银花 15 克 炒皂刺 9 克 白芷 6 克 甘草 9 克 川牛膝 15 克 白芥子 6 克 人参面（分冲）8 克

外治法同前。

经服上方加减，一个月后到 12 月底，太溪脉隐可触及，病足转温、夜间疼痛减轻，入睡如常，疮面嫩肉新鲜，死骨暴露趾端约 1.5 厘米，疮缘形成角化斑痕，每日换药随时清除残存坏死组织。11 月 29 日趾甲脱落，至 1963 年 1 月 14 日开始加服象牙面，每次 3 克，每日 2 次，冲服，1 月 24 日，暴露在脉趾远端死骨松动，自然分离脱落，断端基底已见薄层肉芽组织，活体镜检为角化上皮及扁平上皮。

第三阶段：1963 年 2 月 6 日，至 1963 年 3 月 8 日，毒秽已除、久病气血两伤、法以双补气血，温经回阳：

黄芪 9 克 大熟地 15 克 赤白芍各 9 克 党参 9 克 白术 15 克 当归 9 克 牛膝 15 克 白芥子 9 克 茯苓 9 克 甘草 9 克

外用药同前。

2 月 23 日经服上方 17 天后，疮面完全愈合，疼痛消除，

患者足皮肤润泽，并见毳毛新生，残存甲趾逐渐生长厚甲，太溪脉沉伏，至3月初，精神日佳，胃纳好，二便调，已能下地活动，X线摄片右跖趾第二趾骨骨质正常，断端边缘不锐利，继续观察到1963年3月8日，临床治愈出院，追踪一年半，局部愈合良好，趾甲复盖、病变稳定，未见复发。

《赵炳南临床经验集》

案二，徐××，女，18岁，农民，住院号13662，入院日期：1967年12月20日

病史：患者9月下旬全身不适，关节酸痛，伴有发热，下肢活动不利，用过多种抗菌素，病情时轻时重，左大腿逐渐粗大，伴有发热，胃纳不香、全身不舒，患肢活动障碍，疼痛日益加剧，X线摄片、确诊为“右股骨急性化脓性骨髓炎。”

检查：体温38℃，脉率96次/分，血压110/70毫米汞柱。一般尚可，心肺（-）。右大腿中段骨骼肿胀、粗大、皮色未变，压痛明显，右下肢不能向腹侧弯曲，苔黄腻，脉细数。

实验室检查：白细胞总数12500/毫米³，中性91%

初诊：12月21日。右附骨疽肿胀疼痛，曾有急性发作史，高热，血中白细胞总数在20000/毫米³以上，用抗菌素控制而好转，目前疼痛加剧，有化脓之势，毒邪内盛，经脉阻塞，营卫不和，血凝毒聚，拟清热解毒、活血通络。

紫地丁30克 蒲公英15克 半枝莲15克 草河车15克 制苍术9克 黄柏9克 川牛膝12克 当归9克 赤芍15克 丝瓜络4.5克 丹参12克

外敷：大布膏，红灵丹。

二诊：1968年1月15日，上方加减服三周余，发热已退，局部肿胀疼痛仍存，压痛明显苔薄腻，脉细数，证有化脓破溃之象，拟和营通络，益气托毒为要。

丹参12克 当归9克 赤芍30克 汉防己12克 土茯苓30克 潞党参9克 生黄芪12克 炙山甲9克 皂角刺9克 忍冬藤30克

外用：同前法。

三诊：2月12日；肿胀疼痛均有减轻，屈伸活动已较前有进步、压痛不明显。X线摄片，骨质破坏有改变，有新骨形成，胃纳，二便正常。苔薄，脉濡。

前方去角针 山甲。加野赤豆18克 泽兰9克。

4月19日痊愈出院，3年后随访：参加体力劳动未受影响。

《顾伯华外科经验选》

【分析】

案一为脱疽，因久受寒湿，肾阳不足，气血淤滞，淤久化热，灼热伤及阴津，虚火与淤血交结、下注于足部，发为足趾脱疽，已属晚期，肉腐骨死，故西医建议截肢，以免淤毒上延。中医用益气养阴，活血通络，清热解毒方法。用五味消毒饮加减，10剂后正气有所恢复，疼痛减轻。然病之本质乃是由于寒凝脉络所致。二诊加白芥子、炒皂角、白芷温通经络，托毒排脓，配合服象牙末清热解毒，去腐生新，补养筋骨，朽骨自然脱落。后以双补气血，温经回阳之剂收功。使一例脱疽患者避免了截肢的痛苦，象牙末治脱疽为赵老经验，称之为“脱骨疗法”。他从《本草纲目》“诸铁及杂物入肉，刮牙屑和水敷之立出”，“诸物刺咽中磨水服之

亦出”的记载中得到启悟，并以此法使一缺盆疽患者的朽骨脱落，疮面愈合。服象牙末可以使朽骨与活骨自然分离，并使活骨与死骨分离后的断面自动修复，亦可用于治疗附骨疽的死骨形成。可见象牙末的药理作用，及“脱骨疗法”是一值得研究的课题。

案二为附骨疽（阴股疽），初起未经诊断治疗，已有溃脓趋势，急用《医宗金鉴》托里消毒散加减，补益气血，托毒消肿，活血通络配合外治法。二诊发热已退，肿痛未减，仍有化脓之证，用原方加减益气和血，托毒排脓。凡三诊，一方加减，并未溃脓，使已经伤筋附骨的阴股疽肿消热退痛减。可见中药的益气养血配合托毒排脓法对于疽证亦有双向调解作用，若有毒则促使其破溃出脓，若硬肿则可使其消散之。消肿与出脓之间有可调节的机转，亦在医之善为耳。

（六）缠腰火丹

【概说】

缠腰火丹是急性发作的疱疹性皮肤病。以皮肤上出现成簇水泡，疼如火燎为特征。每多缠腰而发，故名缠腰火丹，因其水疱累累如串珠，亦名蛇串疮、火带疮、蛇丹、肋肋疱疹等。

初发时腰肋先有索条状刺疼，不久疼处皮肤泛红，接着出现密集成群如绿豆或黄豆大小的水疱，水疱不规则的排列为带状，疱群间有正常皮肤，5～6天后透明水疱变浑，4日左右结痂、脱落痊愈，不留疤痕，很少复发。

本病多发于一侧腰肋部，胸部及颜面部亦有发生，生于面部者，病情较严重，疼痛剧烈，并易伤害眼目而致失明。

发病原因多由情志内伤，肝胆火盛；脾湿既久，湿热内蕴，肝火挟湿热外出，又兼感染毒邪而成。内治宜龙胆泻肝汤加减，泻肝胆湿热。外治：未破用玉露膏，已破用青黛散油膏外敷，无论初起末期，皆可以黄连膏加30%雄黄粉调匀外敷。

【选案】

案一，一人六月途行，受热过劳，性又躁暴，忽右肋痛，皮肤一片红如碗大，发水疱疮三五点，脉七至而弦，夜重于昼，医作肝经郁火治之。以黄连、青皮、香附、川芎，柴胡之类，进一服，其夜痛极，且憎热。次早视之，皮肤上红大如盘，水疱疮又加重三十多粒，医教以水调白矾末敷，仍于前药加青黛、龙胆草进之，夜痛益甚，肋中如钩摘之状，次早视之，红及半身矣，水疱又增至百数。乃求王金坛，为订一方，以大瓜蒌一枚，重一二两者，连皮捣烂，加粉草6克，红花1.5克，进药少顷，即得睡，及觉已不痛矣，盖痛势已急，而时医执寻常泻肝正治之剂，又多寒苦，愈添其燥，故病转增剧，水疱疮发于外者，肝郁既久，不得发越，乃侮所不胜，故皮肤为之溃也。瓜蒌味苦寒。经云：“泄其肝者缓其中”。且其物，柔而滑润，开郁不逆，甘缓润下，又如油之洗物，未尝不洁，此其所以奏效之捷也。

王肯堂《证治准绳·卷四》

案二，王××，女，24岁，病历号：484191，初诊日期，1964年2月6日

主诉：头面部起水疱，疼痛九天。

现病史：头面生颗粒状水疱，刺痛兼痒九天。初起左前

额出现红色小颗粒，并伴有针刺样痛疼，逐渐增多，形成水疱，且向头顶及左眼睑蔓延，左目红肿，流泪，视物不清，周围皮肤肿胀、灼热。诊为“面部带状疱疹，经注射维生素及抗菌素等药后，效果不显，继续扩展。胃纳不佳，头晕，口苦、大便干，二日一行，小便短赤。

检查：左侧前额及左上眼睑大片潮红肿胀，面积约 10×8 厘米，上有高粱粒至黄豆大红色丘疱疹，簇簇成群，呈带状排列。左眼球结膜充血，眼睑焮肿，左颌下淋巴结肿大，压痛明显。

脉象：弦滑数。

舌象：舌苔薄白，舌质红。

西医诊断：带状疱疹。

中医辨证：湿热内蕴，肝火挟湿上犯（蛇串疮）

立法：清热利湿解毒。

方药：金银花15克 连翘9克 野菊花9克 龙胆草3克
大青叶9克 黄芩9克 炒山栀6克 地丁12克 淡竹叶6克
赤芍9克 鲜生地9克 桑叶6克

外用化毒散软膏、芙蓉膏各等量，调匀外敷。

2月10日，服药后头面部浮肿已明显消退，部分皮疹或显露出鲜红色糜烂面，上复淡黄色渗出及结痂，疼痛减轻，未见新生皮损。再以前方去生地、桑叶、加茵陈15克，车前子9克，连服三剂。外用马齿苋一两煎水500毫升，待温后连续湿敷局部，每隔15分钟交换敷料一次。2月15日，头部前额及左上眼睑渗出停止，糜烂面出现新生上皮，红晕浮肿已全部消退，疼痛已除，微有痒感，胃纳转佳，二便正常，再以清热祛湿之药物煎水代茶，以清解余毒。

处方：茵陈30克 杭菊花4.5克 蒲公英6克

外用祛湿散30克，加入化毒散1.5克，调敷局部。

1964年2月23日来院检查，患部皮损已全部消退。仅遗有少量淡褐色色素沉着，无痒痒，两目视物清楚、红肿消退，临床痊愈。

《赵炳南临床经验选》

案三，王××，女，33岁，病历号：11931。初诊日期
1958年4月4日。

左腰部及左大腿出现集簇小水疱，剧疼已三天。

七天前左腰部及左大腿外侧出现大片红斑，小水疱、刺痛加重，不敢触碰，坐立不安，呈服正痛片亦未稍解，大便干结。

检查：左侧腰部及左大腿外侧，相当于腰1～2节段，可见成片集簇之小水疱，部分为血疱，基底潮红，脉弦而带数，舌苔薄黄。

诊断：蛇窜疮（西医诊断：带状疱疹）。

辨证：心肝二经之火内郁。

治法：泻心肝之火热。

方药：川连9克 黄芩9克 焦山栀9克 大青叶9克
番泻叶9克 银花9克 连翘9克 赤芍9克 花粉9克 青黛1.5克 水煎服，外用玉露膏。

4月6日二诊：服二剂后，水疱已见结痂，刺痛明显减轻，大便三日未行，舌苔黄糙，脉弦数，以拟通腑泻热。

生川军6克（后入） 黄芩9克 焦山栀6克 大青叶6克 连翘9克 丹皮9克 赤芍9克 忍冬藤6克 2剂。

4月8日3诊：疱疹大部干结，疼痛基本消失，大便畅通。

前方去大黄，加花粉9克。2剂后治愈

《朱仁康临床经验集》

【分析】

案一为胁肋疱疹。由于外受火热，内有肝火，热邪挟内湿外发于肝经所过之处，遂发为缠腰火丹。一诊以发越肝经郁火之药治之，使大毒之势愈盛，皮肤水疱亦增多。二诊又以前方加味与之，火邪发越，疱疹增至百枚。《经》云：

“无刺熇熇之热”。火势方烈，治宜缓和，苦寒直折或更加发越皆在所忌，故王肯堂用大糖瓜蒌一枚捣烂，少佐红花1.5克活血散瘀，生甘草解毒缓急止痛，一剂即愈。瓜蒌一味，一举而五善：利气宽胸，消肿散结，化痰开郁，甘寒泻火，润肠通便，皆有利于此证。故重用一味瓜蒌，佐以1.5克红花而取效甚捷。此方原出《赤水玄珠》，后清代《杏轩医案》续录中治叶蔚如兄胁疼便闭，亦一诊而愈。可见此方治带状疱疹乃前人已效之方，临床可资取法。

案二为面部带状疱疹。肝火挟内湿上犯，脸侧乃肝胆所辖之地，故发于左侧头面疱疹，热毒壅于血分，亦外发红疹，治疗宜清热利湿，凉血解毒，用龙胆泻肝汤加减，用桑叶、菊花清利头目，又配以外治法，三诊而愈，避免了疱疹入目的重证。

案三为腰腿部带状疱疹。以龙胆泻肝汤为主，加入通腑泻热的蕃泻叶、大黄等，完全符合肝经湿热循经外发的病机，因而疗效甚捷。

（七）丹毒

【概说】

丹毒是指急性发作的**红斑性皮肤病**，以皮肤突然出现**红斑**，色如涂丹，**焮热肿疼**，**红斑与周围皮肤有明显界线**为特征，由于发病部位不同，名称各异，症状有别。发于**头部**称**抱头火丹**，疼痛剧烈，发于**面部**称**颜面丹毒**，**容易毒邪内攻**；发于**腿胫部**的叫**流火丹毒**，多与**足癣糜烂**有关，愈后易复发，以至成为**大脚风**（**橡皮腿**、**阴囊肿大**），发于**新生儿**游走全身的称**赤游丹**，由四肢向胸腹，或**颜面攻向胸腹**者多逆证；发于**鼻额**者，面部常呈**蝴蝶样红斑**；发于**手指部**，多由**畜骨、鱼刺破伤**引起，往往病程较长。病因总由**火邪侵犯**，血分有热，**火热蕴于血分**外发皮肤而生。极少发生化脓，但容易复发，应注意隔离，避免接触传染。

治疗以**清热解毒，凉血散瘀**为主，发于头面，可用**普济消毒饮**；发于腰肋，宜用**化斑解毒汤**；发于下肢，多用**萆薢渗湿汤**合**五神汤**；发于新生儿者，可用**黄连解毒**加减；**毒邪内攻**的，可用**犀角地黄汤**合**紫雪丹**。并配合适应的外治法。局部可用**玉露散**、**金黄散**调服，已成**大脚风**，可用**鲜乌柏叶**、**鲜樟叶**、**鲜松叶**针各60克，**生姜**30克煎汤薰洗。

【选案】

案一，应××，女，37岁。初诊日期：1972年4月27日。

患者前天左足背及左小腿红肿胀痛，局部发热，行走时疼痛加剧；口渴，思冷饮，不思食，时而呕逆，尿短赤，大便三日未行，伴有发热。既往无类似病史。

检查：体温39℃，呈昏睡状态，问之不语，表情痛苦，面赤唇焦；左足背及左小腿下1/3皮色红赤，形如云

片，略肿，局部扪之灼手，白细胞计数20300/立方毫米。脉弦数有力，舌尖红，苔黄。

辨证：湿热下注，火毒攻心（左小腿丹毒。）

治法：清热利湿，解毒护心。

方药：银花24克 公英24克 大青叶10克 连翘18克 黄连6克 生栀子10克 归尾10克 赤芍10克 车前子10克 生地20克 猪苓10克 灯心炭10克 薄荷3克 川军10克（包）绿豆衣10克 陈皮6克

每日2剂，每6小时服1次

另用梅花点舌丹，每次一丸，每4小时1次。

外用：外敷雄黄软膏，每日2次。

4月12日复诊：服上方3剂，神志清，呕逆已止，疼痛减轻，大便已通，稍能进食，局部皮肤赤红变浅，体温渐退37℃，白细胞计数：12000/立方毫米。舌薄苔黄，脉弦略数，依前方加减：

银花 20克 公英25克 连翘20克 赤芍10克 当归10克 生栀子10克 猪苓10克 川军3克 车前子10克 牛膝10克 甘草3克 生地15克 条芩10克 黄连3克 每日1付半，每8小时服药1次。

外用：外敷芙蓉软膏，一日2次。

4月15日三诊：一切恢复正常，左足及左小腿皮色亦恢复正常。嘱继续按前方服药四剂，每日一剂，以巩固疗效，随访四年，未再复发。

《房芝萱外科经验》

案二，患者贾×，男，48岁，司机，左小腿焮热红肿，反复发作一年余。初发时，发热恶寒，头痛恶心，在本单位

卫生所注射青霉素一周余，病渐愈，两月后又复发，治疗同前。以后多次发作，屡用抗菌素治疗，当时虽可以减轻痛苦，但不能持久。这次来我院医治时，小腿肿胀疼痛，焮红灼热，行动不利，舌质红，苔薄黄，脉弦滑。诊为“流火”，辨为湿热下注，化为火毒之证，治以清热解毒，药用：

黄连6克 黄芩9克 丹皮9克 赤芍9克 蚤休9克
银花9克 连翘9克 生甘草6克 水煎，每日1剂。连服5天。

患处胀痛减轻，嘱宗前方再进，复诊时局部红肿已明显消退，患者恐其病复发，恳求根治，余拟苍术膏一料，并说明该药对防止复发有益，但不保证彻底根治，一料后患者下肢无不适之感，故前来再索要前方。共服三料，一年后随访，未见复发。

《医案医话荟要》

【分析】

案一为左腿流火丹毒。湿热下注，凝阻气血，湿热与淤血交结而发小腿红肿。热毒炽盛，无从外泄，内陷心营，呈高热，昏睡状态。治疗以清热利湿，凉血解毒方法，以五神汤加味，配合梅花点舌丹（《外科全生集》）清心开窍，三诊即恢复正常，得到根治。避免了反复发作的弊病及转为大脚风的后果。

案二为慢性流火丹毒的急性发作。因其正发红丹，火邪炽盛，因而用《外科全生集》夺命汤（银花 赤芍 黄连 甘草 蚤休）解毒消肿。蚤休又名拳参、七叶一枝花，金线重楼等，有很强的解毒作用，民间谚语云：“七叶一枝花，深山是我家，痈毒若遇此，定遭手擒拿。”急性期治愈后，

以苍术膏一剂（苍术1000克，加水适量，连煎3次，去渣取汁，慢火煎熬，浓缩成膏，加蜂蜜250克，调匀为膏，每服一匙，日服2次，连服三剂，预防复发）预防流火再发。苍术膏原为《医宗金鉴》方，治湿浊疥疮。朱仁康先生师其意而用来预防流火丹毒复发，亦取良效，因流火为湿热下注所致，急性期清热解毒治其标急。而湿性粘腻，很难一治即愈，湿郁体内，往往导致反复发作，故以苍术膏于不发时常服之。苍术加蜜煎成，又无伤阴之虞，确为预防良法。

（八）白疮

【概说】

白疮是一种慢性复发性皮肤病。以皮肤干燥，有白色皮屑，伴有奇痒难忍的特征。又称为干癣，松皮癣；西医称为“牛皮癣”、“银屑病”而中医称为“牛皮癣”的疾患西医则称为“神经性皮炎”。

发病原因多是内有血热血燥，外受风燥邪气，内外合邪。热壅血络发皮疹红斑，血燥不濡肌肤，而皮肤干燥生白色屑皮，临证分为寻常型、特殊型二类。寻常型好发于四肢伸侧，头、骶、指（趾）、龟头等处亦可发生。常呈对称型分布。约分为三期：进行期皮疹陆续出现，初起为米粒，黄豆大的丘疹斑丘疹，常为银币状、地图型、点滴状，表面有银色鳞屑，奇痒难忍，银屑多层复盖，状如松皮，刮除鳞屑有半透明薄膜，薄膜下呈点状出血，亦为此病特征；并伴有口干舌燥，便秘心烦，苔黄脉数等全身症状；静止期，无新的斑疹出现，消退期，鳞屑与皮疹均消失，逐渐恢复正常。

特殊型有关节型：除皮癣外，伴有关节肿胀、发热、疼痛。脓疱型：先在皮疹上出现脓疮，并伴有发热及关节疼

痛。经皮症型：急性进行期患者因刺激性外用药后，迅速出现皮肤潮红，瘙痒，同时银屑及点状出血消失。

治疗原则，寻常型分为血热型、血燥型，血淤型，肝肾不足型论治。血热型宜化斑汤、犀角地黄汤加减，凉血、祛风，解毒；血燥型应用四物加增液汤养血润燥，祛风止痒；血淤型可选用桃红四物、血府逐淤，凉血祛淤解毒；肝肾不足，或女子冲任不调者，可选用六味地黄、四物汤，二至丸等调补肝肾冲任。外治在进行期当选用黑豆馏油软膏、解毒消炎膏剂等刺激性小的外敷药；静止期可用硫黄软膏、椰油膏，橄榄油等外涂，亦可用侧柏叶等煎汤外洗。

近年来杂志报道“克银方”、“雷公藤”等方法治疗银屑病获得可靠疗效，均可资效法。惟本病不易根治，往往反复发作，故古云“内不治喘，外不治癣”。

【选案】

案一，王××，女，32岁，某军工厂化验工。患全身性脓疱脱屑性皮肤病近4年，2年来伴发全身皮肤潮红。患者于1969年8月腹部出现一黄豆大小脓疱，以后脓疱逐渐增多，密集成片，流水，结痂，脱屑，自觉痒甚，至一月余已发展成拳头大小，患者经几个医院诊治，均诊为“脓疱性牛皮癣”，曾先后服用四环素、土霉素、扑尔敏、氨本砒及氯喹等药，外涂黛蛤粉，氧化锌软膏、伉伉膏和鱼硫膏等，但病情仍无好转。于1978年8月继而出现全身红斑伴高烧，住某医院治疗时，诊为“脓疱性牛皮癣红皮病。住院期间，曾用氯化钾，氢化可的松、氟美松、促皮脂激素、胰岛素、环磷酰胺，维生素B₁₂，胎盘球蛋白，多粘菌素等药，但病情仍反复急性发作，脓疱，脱屑等皮损进一步泛发全身，每次

发作均以高热，全身起脓疱开始，二三日后烧退，疱平继而脱屑，最后遗留皮肤潮红和少量细小鳞屑，由于治疗无效于1973年4月出院，出院后急性发作仍未停止。

患者于1973年12月16日邀王老诊视。诊见病人全身皮肤潮红，干燥，复有细碎鳞屑及少量粟粒大小的脓疱，头皮部位鳞屑尤为显著，适时正是静止期，故一般情况尚好，体温不高，脓疱不多，但由于长期应用激素类药物，体型呈“柯兴氏症”肥胖，只能卧床，不能下地行走，据病家介绍，曾经医院检查患者，已有骨质疏松及糖尿。予以自拟薏土乌梅汤内服。处方：

薏苡50克 土茯苓6克 乌梅30克 甘草10克

将前3味药，水浸24小时后再纳入甘草同煎，每日1剂，分两次服完，服药期间忌茶。同时外涂擦剂：

蛇蜕1条 蜂房1个 全蝎2条 米醋300克

将三味药浸入于米醋内浸泡24小时擦患处，服药45剂后，脓疱消退，鳞屑脱落，红斑处结皮，尿糖也相应降低（24小时尿糖定量实验微量），病人不仅能坐起，并能下地散步。1974年2月10日，原方加胡连，续服20剂，皮肤接近正常颜色，能从事简单的家务劳动。3月10日，方中再加苡米，以巩固疗效。服药期间未见任何副反应。3月20日下午，由于劳累、生气、突然高烧至39.6℃，躯干及四肢又出现脓疱，全身发红，上方去苡米加紫草根15克，苦参10克，晚10时服药，至半夜热退身凉。翌日脓疱开始消退，鳞屑脱落。

最后一次1978年随访，病无复发。

马崇生：牛皮癣性红皮证治验《中医杂志》1981年10期

案二，陈××，男，20岁，1981年4月3日初诊。

缘自四五岁起患白疔（牛皮癣），15年来反复发作，先冬发夏愈，后则四季不分。原先仅局限于四肢，继而布及全身以至头皮颜面，近两年来尤甚。曾辗转于市内及外地多个医院求治，静注“利多卡因”，“二甲肿酸钠”，以及理疗，口服，外搽西药中药治疗，均未能控制。二年来皮疹从未完全消退。自觉全身瘙痒、咽干口苦，溲赤，大便干结。余无其他特殊主诉。既往无其他系统疾患史，无家族史。

身体壮实。颜面散见约铜钱大小皮疹；头皮及全身皮疹密集，呈盘状或地图状或融合成片，高出皮面，上覆盖多层银白色鳞屑，搔破处见基底鲜红或有血痂及渗液，下肢尤甚。心肺腹部未见异常。四肢关节无畸型。舌质红绛带紫气，舌根黄腻，脉数。

此证因风湿内蕴，积久化热，浸淫营血，淤热内伏，血热毒盛，肌肤失养所致。故以清热凉血解毒重剂治之。处方：

水牛角30克（先入） 生地30克 赤芍30克 丹皮15克
板蓝根30克 白花蛇舌草30克 银花20克 丹参15克 莢
藜30克 白藓皮12克 生川军12克（后入） 生甘草6克 蟾
酥丸5粒（吞）

4月16日二诊：迭进14剂药后，全身皮损消退大半，鳞屑脱落，皮色变淡，舌红绛见减，瘙痒已止。仅仍有轻度咽部不适，再宗前意进治。原方去白藓皮、蟾酥丸加玄参9克。

4月29日三诊：全身皮疹基本退尽，唯双下肢屈侧，内侧仍有残存，但无新疹出现。尿黄，大便黄软一日二行。舌质紫绛。原方出入。

水牛角15克 生地15克 丹皮9克 赤芍12克 板蓝根
30克 碧玉散12克（包） 牛膝9克 当归6克 桃仁泥9克

5月7日四诊：尿已清长。右下肢膝关节内侧少许鳞痂，但已萎退。再进前方出入。处方：

水牛角15克 生地9克 丹皮6克 赤白芍各9克 鸡血藤12克 牛膝9克 当归9克 桃仁泥9克 乌梢蛇9克 碧玉散12克

5月17日五诊：皮疹全部退清。水牛角粉及乌梢蛇粉2克吞服，日一次，以善其后。

熊晖：犀角地黄汤加减治愈顽固性牛皮癣

1例《中医杂志》1981年10期

案三，陶××，男，30岁，工人。

自1956年10月开始，右臀部出现直径约2厘米大小的斑片一块，皮色微红，作痒，抓之有白色鳞屑脱落，当时未予治疗。至1957年秋季，皮肤损害范围渐见扩大如手掌，作痒加剧。1958年7月间，右肘外侧及左眉棱部相继出现直径约0.5厘米大小与右臀部相同的皮损，当时至××医院诊治，但未获效。此后，皮损蔓延至两下肢及两臀部，大小约自1～2.5厘米不等，轻度瘙痒。1963年3月间，至××医院皮肤科诊治，诊断为“银屑病”。经中西医综合治疗，皮损逐渐消退。仅于头面及二肘膝部尚有少数皮损，瘙痒已差，但因突发“肝炎”而中断治疗。此后，病情尚属稳定。至1964年2月间，又复全身发作，头面、躯干、四肢皆有点滴大小不等的斑片。曾先后内服清热养阴，养血祛风之剂，稍获小效。

1964年5月4日入院检查：发育、营养中等。头面眉心，左耳上入发际处和右耳上头顶部，各有约自0.5～1厘米大小的斑片，二耳轮皮肤粗糙。左右上肢外侧有大片皮损，右腕及右3、4、5指指背和左4、5指指背均有小片皮损，下

肢在膝及小腿伸侧面有约2厘米大小的潮红斑片，大腿外侧有散在性斑片，大小约0.5厘米。尾臀及二臀部斑片较大，如地图状，在皮肤的损害上均附有银白色鳞屑，抓之容易脱落，抓至损害底部则有出血点。诊断：银屑病。

治疗经过：皮肤顽癣已近八年，全身遍发淡红色斑片，作痒，抓之银屑脱落，抓甚则出血。自诉每于房事及疲劳后皮肤损害增多增大，银屑也随之增厚。秋、冬之交，作痒增剧，平素头晕耳鸣，偶有腰酸，入冬四肢欠温，形寒怯冷，纳食如常，大便欠实。舌质淡，苔薄白，边有齿痕，脉象关部濡细，尺部无力。肾阳虚衰为病之本，血虚风燥为病之标。治疗采用“益火之源”，以培右肾之元阳，“治风先治血，血行风自灭”，标本兼顾，予以温补肾阳，养血祛风之法。

熟地9克 熟附块9克（先煎） 鹿角片9克 仙茅9克 仙灵脾9克 肉苁蓉9克 全当归9克 制首乌9克 鸡血藤15克 炙甘草3克 乌梢蛇片3克（吞） 每日煎服1剂。

外用：Ⅱ号癣药水，每日搽擦患处3～4次。

连服上方15剂后，皮肤损害处潮红较淡，银屑脱落较少，瘙痒也差，惟夜寐欠安。故前方加知母9克、黄柏9克，又服26剂后，皮肤损害减少，仅在两肘及膝部伸侧尚有潮红斑片，但无脱屑，夜间微有汗出，因病情好转，故予以出院治疗观察。在门诊治疗中，仍以原方连服25剂后，皮肤损害全部消失而停治。20天后，患者又来诊治，据称：因出差后疲劳过度，在二肘部又有数点隐约白色斑片。仍以前法治疗，连续服药21剂，皮损全部消失，并无新生皮疹。治愈后三个月，去信随访，复信称：上述症状至今尚未复发。

上海龙华医院《医案选编》

案四，王某，男，56岁。患牛皮癣24年之久，冬甚夏轻，曾到北京、河北、天津等多处医院治疗。询问病史，于24年前，不明原因，在头皮及发际处瘙痒，皮损呈扁平斑片状，基底色鲜红，小如钱币，大如鸡卵，上复白色干燥的鳞屑，剥脱后可见有筛状出血点。逐渐发展，蔓延全身。以四肢伸侧及臀腰部为甚，双膝关节疼痛，尤以手指关节肿痛变形。曾在几个医院确诊为“关节型银屑病”，服用过维生素B₁₂、维生素C，维生素D₂、乙亚胺等各种西药。

察其皮损，分布于头皮、胸、背、腰、臀及四肢伸侧等处，呈钱币状，地图状，大小不等。尤以肘，膝处皮损较大，在关节伸侧约有8×20厘米大小，皮损基底色红，鳞屑中等厚度，有轻度痒感。为慎重起见，在我院又重新做病理检查、X光拍片以及血、尿、免疫学诊断等，都符合其它医院诊断。

诊其舌红、苔薄黄，脉弦滑。自述指、趾关节肿痛。根据其病史叙述及及四诊所得资料，按中医辨证论治，属于血热风燥。故拟清热解毒，滋阴凉血法。用药：

生地30克 元参10克 丹参10克 大青叶10克 黄芩10克 麻仁10克 水煎服，14剂。半月后复诊，自述新皮损未作，瘙痒减轻，再进14剂后，皮损减薄，中心开始出现正常皮肤。原方再投7剂，皮损明显减轻，除肘、膝关节处皮损外，已基本痊愈。残存关节处皮损，亦较治疗前减薄，中心已出现散在正常皮肤，关节已不疼痛。因患者住家较远，自购原方二十余剂再服。来诊时已残存皮损基底色淡，上复白屑已近平复，无明显自觉症状。为巩固疗效，嘱其再服原方10~20剂，至今未再复发，基本治愈。

【分析】

案一为脓疱合并红皮症型白疟病。由于湿热内蒸，血分热毒极盛，内迫营血，外发肌肤，而为皮肤红斑；湿热郁蒸肌肤，外发脓疱。治疗以清热解毒为主，辅以甘酸敛阴，养血清热方法。用自拟菝葜土乌梅方，其中菝葜（即金刚藤的根）味苦而酸，善于祛湿利尿解毒消疮疡痈肿，《医林纂要》云善治毒疮、恶疮、肿毒。土茯苓亦擅治湿热疮毒，二药配伍，相得益彰。乌梅能生津养液与甘草相合，酸甘化合，养阴作用增强。对久病脓疮，伤耗阴血者，作用更好。乌梅亦有去恶疮赘肉之功，《神农本草经》云其主死肌恶肉。配以外治法，用蛇毒解毒，蜂房止痒，全蝎止疼。药用45付，便以疮敛肿消。又于原方加苡米渗湿健脾，基本痊愈。又因气恼复发，仍用原方加紫草，苦参凉血解毒，终于痊愈。此方用药精练，弹无虚发，颇有天士遗风。

案二为血热型白疟。用清热凉血解毒去湿方法治之。方用犀角地黄汤加减。病为进行期血热炽盛，解毒药量皆须重用，其中水牛角（代犀角）、生地、赤芍、板蓝根、白花蛇舌草、菝葜皆用30克，又加吞蟾酥丸。一诊解毒药力甚强、二诊已见显效，原方加减进退一月余而获痊愈。但缺少追访材料，是此案缺陷。

案三为肝肾不足型白疟。顽癣八年，耗伤气阴，故见形寒怯冷，头晕耳鸣等。又有素患肝病，肝阴不足，肾阳虚损为病本，血虚风燥病之标，用温补肾阳，养血祛风方法。与鹿角、附子等补肾壮阳，配乌梢蛇片祛风通络散湿，治顽麻痒痛，亦取“久病入络”之意。一诊后肾气得充，瘙痒渐平。

又因相火扰乱，夜寐不安，加知柏滋阴降火。至66剂而愈，追访三月，未见复发。可谓8年顽疾，两月而愈。

案四为关节型白疮。患病24年。阴虚血燥，肌肤失养，故白屑干燥；血分蕴热，毒邪外发于皮肤关节，故关节肿疼变形，皮发红斑渗血。治疗宜清热解毒，滋阴凉血，佐以祛风止痒。用克银二号方。麻仁、玄参功擅滋阴润燥，白癣皮能祛风止痒，亦使24年顽症，得到根治。“克银方”为朱氏多年来专题研究治疗银屑病的有效方。“克银一号方”主治血热风燥型白疮证，组成：土茯苓30克 忍冬藤15克 板蓝根15克 草河车15克 白藓皮15克 山豆根10克 威灵仙10克 生甘草6克 水煎服。“克银二号方”主治血虚风燥型白疮证，组成：生地30克 丹参15克 玄参15克 大青叶15克 白藓皮15克 草河车15克 麻仁10克 山豆根10克 连翘10克 水煎服。

（九）瘾疹

【概说】

瘾疹是指一种突然发作的发疹性皮肤病。以皮肤突然出现红色或白色，大小不等形状不一的丘疹，时隐时现，伴有瘙痒难忍为特征。亦名风痞瘤、瘾疹、风疹块、赤白游风、风丹等，西医称之为荨麻疹。全身任何部位均可发生皮疹，迅速出现，消退亦快，一天可发作多次。如侵犯胃肠，则可出现腹痛、腹泻；出于咽喉，则会喉头水肿，呼吸困难；如单纯在眼睑、口唇、外生殖器发生，会有水肿出现；据病程长短，有急慢性两种，急性者一周左右痊愈，慢性者可反复发作数月至数年不愈。

临床分为风热型、风寒型、肠胃湿热型、气血虚弱型来

论治。风热型：风团色红，遇热则发、得冷则减，宜用消风散、桑菊饮、银翘散等疏风清热。风寒型：多见于慢性荨麻疹，风团色粉白，遇冷则发，兼发热恶寒等症，应用桂枝汤，荆防败毒散疏风散寒、调和营卫。肠胃湿热型：出风团时伴脘腹疼痛，大便秘结或泄泻等，可选防风通圣散表里双解。气血虚弱型：多见于慢性荨麻疹，风团反复发作，迁延数月、数年不愈，遇劳累发作或加剧等，则应用八珍汤、玉屏风散、当归饮子等益气养血，消风止痒。

总之，风邪是导致本病发生的主要条件，《金匱要略》云：“邪气中经，则身痒而瘾疹”。故治疗应抓住“散风”这一重要环节，亦有发病与饮食鱼虾、蟹、蛋等特殊食物有关，与妇女月经来潮周期有关，有的与肠道寄生虫病有关等等，又各因人而异，随证立法。近年来倡用自血疗法，封闭疗法等亦可选用。亦可配合香樟木煎汤熏洗或针刺方法治疗。

【选案】

案一，苏××，女，32岁。

主诉：患荨麻疹已达五年之久。开始时每年发五、六次，后来逐年加剧。今年起愈发愈频，竟至没有间歇。曾大量注射过葡萄糖酸钙、内服苯海拉明及驱风、活血之中药多剂，均归无效。

症状：遍身大小不等的疙瘩块，抓痒无度，此伏彼起，日夜无宁静之时。在发作剧烈时，特别怕冷，身必重裘，大便一直两天一次，且燥结难下，腹微痛。

处方：桂枝9克 芍药9克 甘草3克 生姜9克 大枣3克 大黄9克 全瓜蒌12克 麻仁12克

服上药后约3小时，身痒渐止，疙瘩亦渐隐没，周身微

汗，大便畅通，症状全部消失，迄今已半月余，未再发过。

《伤寒论方医案选编》

案二：郭××，男，5岁。病案号：35635

入院日期：1975年6月26日至1975年7月4日。

现病史：一天来，患儿腹痛，但无泻泄及呕吐。在当地卫生所服胃气止痛丸半包，一小时后全身出现多数红色片状皮疹，发痒，全身热，腹仍痛。夜间服扑尔敏无效而入院。

查体：全身散在多数丘疹块，色红，扁平，腹有压痛，舌红苔黄，上腭紫，脉弦数。

化验：尿常规正常，末梢血象：白细胞10900/立方毫米，中性粒细胞73%，淋巴细胞24%，嗜酸细胞2%。

西医诊断：荨麻疹。

辨证：血热淤滞，汗出当风。

立法：清热散风，凉血解毒。

方药：

青黛3克 紫草12克 寒水石12克 白芷6克 乳香6克

二诊：服上方药三剂，皮疹渐退，仍低热，颌下颈后淋巴结肿大。腹已不痛。用下方：

青黛3克 紫草12克 寒水石12克 白芷6克 杭菊9克
地骨皮9克 3剂。

三诊：体温正常，烦躁，身上又起少量丘疹，发痒。

上方去杭菊、骨皮，加红花9克 服3剂。

四诊：服上方药，皮疹已全消退，体温正常，腹未再痛，舌淡红，上腭红，脉弦缓。出院。

《王鹏飞儿科临床经验选》

【分析】

案一为风寒型。因发作时恶寒特甚，身必重裘，且气血不和，风团瘙痒无度，宜用桂枝汤调和营卫气血，外散风寒无疑。又有肠燥便秘，腹中微疼，又是太阳阳明合病，乃桂枝加大黄汤适应证，故方用桂枝加大黄汤再配伍瓜蒌，麻仁润肠通便，滋阴润燥。药后风寒从外散，里热从内清，服药三小时后便诸症皆愈。此与防风通圣散治荨麻疹理出一贯。

案二为血热型。王鹏飞为北京儿科名医，号称小儿王。他临证善于看小儿上腭变化情况，判断疾病。此案据上腭色紫，脉弦数，舌红苔黄诊断为血热淤滞，外受风邪。用白芷、菊花散外风，紫草、青黛，寒水石，地骨皮清血热，加减而治愈。王老还善用紫草灵活配伍，以紫草配青黛治壮热烦躁；配乳香牙皂活血化淤，治肺痛；配白芷首乌治皮肤疮疡脓肿；配黄精、白芷治疗贫血；配寒水石、橄榄治鹅口疮；配红花、绿茶尚能退黄，改善肝功。他的药方，具有少而简，量轻，柔润甘凉，颇具叶氏之风。

（十）乳痈

【概说】

乳痈是指乳房急性化脓性疾患。以乳房局部红肿热痛、化脓为特征。发于妊娠期的，称内吹乳痈；发于哺乳期的，称外吹乳痈。以初产妇为多见，好发于产后第3～4周。

病因多由压挤乳房，乳汁淤积，肝胃不和，气滞胃热而致。分为三期论治。郁乳期：乳房肿胀触疼，乳汁排出不畅，肿块初成，局部皮肤发红，兼有恶寒发热，胸闷呕恶等全身症状，治疗宜内服瓜蒌牛蒡汤加味舒肝清热，通乳散结，并配合乳房按摩，热敷。若红肿热疼明显者，亦可冷敷

湿敷，减少乳汁分泌，或用玉露散、金黄散、拔毒提毒。酿脓期：乳房肿块增大，皮肤焮红，有持续搏动性疼痛，按之有波动感，伴有发热持续不退。治宜内服透脓散加味清热解毒，通乳透脓，外治则应切开排脓。溃脓期：肿块破溃出脓，一般逐渐愈合。若引脓不尽，会成为乳漏或传囊乳痛。可内服补气养血药，外治可敷生肌散、白玉膏等促其收口。还应注意适时地配合回乳药物治疗。

【选案】

案一：张××，女，24岁。初诊日期：1972年4月18日。

患者于产后24天，突然恶寒发热，右侧乳房胀痛，经医院检查诊为“急性乳腺炎”，曾注射青、链霉素，未见好转，发病后第三日来北京中医院就诊。当时仍觉恶寒发热，恶心，纳少，口干口渴，心烦不安，大便干燥，小便黄赤，脉弦数，舌质红，苔黄腻。

检查：体温38.6℃，面色潮红，呼吸急促，右乳内上方为11×9厘米肿块。皮色微红，压痛拒按，无波动感，右腋下淋巴结肿大压痛。

化验：白细胞计数22,600/立方毫米，中性84%。

辨证：毒热壅阻乳络，发为乳痛（西医诊断：急性乳腺炎）。

治法：清热解毒，理气活血，通乳散结。

方药：

银花12克 连翘15克 公英24克 赤芍9克 陈皮9克
竹茹9克 枳壳9克 漏芦9克 通草6克 川军6克 薄荷9克 黄连6克

患乳用温水湿热敷，行乳房按摩，红肿处贴敷芙蓉膏。

4月21日（复诊）：服药3剂，发热已退，体温36.9℃，右乳肿块缩小至4×2厘米，恶心止，纳增，口渴好转，大便通畅（日1~2次），小便微黄。复查白细胞计数9,300/立方毫米，中性70%。舌苔薄黄，脉弦滑。上方去枳壳、川军、薄荷、黄连，加归尾9克 猪苓9克 花粉12克 元参5克。

外治法：同前。

4月24日（三诊）：体温36.7℃，右乳肿块已消退，右腋淋巴结已消失，其他无不适，舌苔薄黄，脉弦滑。继服前方三剂以巩固疗效。

《房芝萱外科经验》

案二：林××，女，28岁。

产后6天，因授乳时乳头破碎，继而乳房肿胀疼痛，伴有怕冷发热，骨节酸楚，至××医院诊治，先后肌注青霉素24瓶及链霉素6瓶，发热渐退，但乳房肿胀疼痛依然，每次授乳时乳房疼痛也甚，痛如针刺。检查：体温37.8℃，右侧乳房肿胀，并有结块，大小约为4×4.5厘米，质硬，压痛明显，皮色正常，尚无波动感。乳头破碎处已结痂，乳晕有丘疹，无滋水渗出。诊断：乳痈。

初诊（1964年11月30日）：病起先因乳头破碎，不利吮乳以致乳汁壅滞不通，乳房肿胀疼痛，舌苔薄腻，脉数。治宜理气和营通乳。

柴胡3克 青皮3克 蒲公英30克 当归9克 赤芍9克
橘叶3克 金银花9克 连翘9克 生麦芽30克 路路通9克 3剂。

外治：以金黄膏敷贴患处。

二诊（12月2日）：身热已退，乳房肿块也缩小，压痛减轻；但授乳时乳络仍痛，故于前方去金银花、连翘，加香附、瓜蒌、鹿角霜连服10剂后，乳头破碎痊愈，肿块疼痛消失，乳汁通畅。

上海中医学院附属龙华医院《医案选编》

案三：刘女，左乳赤肿作痛，已将化脓，且根脚散漫，寒热迭作，脉沉数，舌红。肝阳及热毒俱重，宣泄为宜。

全栝蒌12克 大贝母12克 京赤芍6克 连翘6克 细木通4.5克 柴胡3克 黑山栀6克 粉丹皮4.5克 生甘草2.4克 当归6克 蒲公英15克

二诊：乳痛自溃，脓出颇多，疮口腐肉尚未吐出，幸寒热已清。当再清肝化坚，以消余破。

当归6克 全栝蒌6克 大贝母12克 京赤芍6克 粉丹皮6克 黑山栀6克 炙甲片9克 白蒺藜12克 甘草节2.4克 全香附4.5克 蒲公英15克 红枣3个

三诊：乳痛已近完口，余硬也无多，腐肉亦将近。脉细数，舌红，荣阴暗亏，养血清肝可也。

南沙参12克 大麦冬6克 大白芍6克 白蒺藜12克 大贝母12克 粉丹皮4.5克 炙甘草2.4克 红枣8个 全香附4.5克 茯神12克 瓜蒌12克 蒲公英15克

《贺季衡医案》

【分析】

案一为乳痈酿脓期。因热毒壅盛，乳络阻滞，肿块如拳大，全身发热恶寒，若不急治，必溃破出脓无疑，重用金银花、蒲公英、连翘等清热解毒；赤芍、陈皮、枳壳等理气活

血；通草、漏芦等通乳散结合，又配合外治进行乳房按摩，湿热敷，外用芙蓉膏消肿散结。二诊去苦寒清热的黄连、大黄，加归尾等活血养阴之品，凡三诊而肿消热退，避免了溃脓重证。

案二为乳痈郁乳期。因初产乳头破裂，不利吮吸，致使乳汁壅滞，乳房胀疼；肿块较小、质硬，无波动感，皮色正常，说明尚未溃脓，及时治疗，可以消散。以行气通乳，清热解毒为主，并配用生麦芽减少乳汁分泌。二诊又配瓜蒌、香附、鹿角霜理气散结，补气敛疮。二诊便肿疼全消，并保持了乳汁通畅，获得满意疗效。

案三为溃脓期。两乳乃肝经所主，肝火旺乳痈必重，溃脓已在所难免，因而治疗除清热解毒，凉肝疏肝外，重用贝母、瓜蒌软坚托毒，促使溃脓。继以滋阴清热，去腐生新使脓出症平。贺季衡氏乃孟河医派祖师马培之高足，马精于外治，贺氏此案治法可见一斑。

（十一）瘰

【概说】

瘰是指生于颈部肿物。以漫肿或结肿，皮色不变，无疼痛，无溃破出脓，缠绵难消为特征。常见有气瘰、肉瘰、石瘰三种。古代尚有血瘰、筋瘰，为五瘰之说。

气瘰发病与食用水质有关，再加情志不畅，气化失常，气血运行障碍，营运不通，阻塞于颈部而生肿物，相当于西医诊断的“单纯性甲状腺肿”。初起颈部呈弥漫性肿大，与周围组织界线不清，按之柔软，无疼痛变色，一般无全身症状。继则肿物过大下垂，甚者下垂至胸，伴有动则呼吸困难、喘息，声音嘶哑等证。治疗宜以四海舒郁丸加减，疏肝

理气，开郁消肿，并应在流行地区改善饮水，服用海带等食物，食用含碘盐等作为预防。

肉瘰多发于20~30岁青年人，女子多于男子。相当于“甲状腺腺瘤”。由于肝郁气滞，湿痰凝结，痰气交阻，聚于颈部，而生肉瘰。初起在结喉正中旁有单个半圆形肿块，表面光滑，可随吞咽动作上下移动，无疼痛，生长缓慢，一般无全身症状。肿块增大则压迫气道，引起呼吸困难，声音嘶哑等症。并伴有性情急躁，心悸多汗，手部震颤，或能食易饥，消瘦乏力等症，西医扫描多为“温结节”。治疗应以海藻玉壶汤加减理气开郁，化痰软坚。如服药三月以上，瘰瘤未见缩小，则应考虑手术摘除。亦可配伍适当外治法、针刺法等消肿散结。

石瘰多因气机不畅，痰湿淤血凝阻而生，相当于西医诊断的“甲状腺癌”。多发于40岁以上，女多于男。一般多年素患肉瘰，肿块突然增大，质地坚硬如石，表面高低不平，推之下移，伴有疼痛，并波及耳、枕、肩部，声音嘶哑，呼吸困难等。西医扫描多为“冷结节”。可内服海藻玉壶汤加桃仁、三棱、莪术、白花蛇舌草等，化结软坚，活血祛淤，此证多预后不良，更应考虑早期手术。

【选案】

案一：吴×× 男，49岁

右侧甲状腺肿一月余。经放射性同位素检查，印象为右叶凉结节，医院建议手术治疗。来诊时症见右侧甲状腺部有一乒乓球大肿块，质较硬，可随吞咽动作上下移动。此痰气互结而生瘰瘤，治拟化痰理气。

海藻10克 昆布10克 海浮石10克 木香2克 醋炒三棱

莪术各8克 陈皮3克 川军2克 生草2克 大枣2枚

上药服10剂后，肿瘤缩小如绿豆大，稍有触痛，即再以原方续服3剂，瘰肿完全消失。

《许履和外科医案医话集》

案二：江应宿治一妇人颈瘰，知其为少阳厥阴肝胆。因郁、怒、痰、气所成。治以海藻90克、昆布45克、海带30克，俱水洗净，半夏制。小松萝、枯矾、蛤粉、通草各08克，龙胆草（洗）90克，小麦面（炒，去湿）120克共为细末，食后用酒调下9克，去枕睡片时，或临卧服，以消止，药不必尽剂，一月愈。

《名医类案》

【分析】

案一为肉瘰。单侧肿块，随吞咽上下移动，为肉瘰无疑。惟患者已年近半百，肿块又较硬，加之西医扪摸为“凉结节”，恐有转成“石瘰”的可能，因而治疗用在化痰理气的基础上，加三棱、莪术破血祛瘀，方用《疡医大全》的四海舒郁丸加减。用少量川军配三棱、莪术以加强祛瘀功能。方中甘草、海藻虽属十八反之列，但前贤认为二者合用，尤能加强消瘰作用，故古代治瘰瘤方已有先例，如陈实功海藻玉壶等方。此案疗效亦好。

案二为气瘰。以方测证，当为无疼痛变色，按之柔软的慢肿。故以半夏、龙胆草清肝行气；枯矾、松萝化痰消肿；海藻、昆布、海带软坚化结。以面糊为丸，免诸药之毒性，以酒调服，利于行散。松萝即女萝，《本草》称“松上寄生”，功能化痰，解毒，清肝。诸药配伍，药力集中，故一丹而瘰瘤消散。

（十二）瘰癧

【概说】

瘰癧是指生于颈部的慢性化脓性疾患。因颈部结核肿物累累如贯珠而命名。以颈部结核串生，溃后脓水清稀，此愈彼溃，不易收口为特征。多发于青壮年，好发于颈部及耳后、锁骨上窝。发病多因情志不舒，脾湿生痰，痰气交阻或肝肾阴虚，炼液为痰，虚火挟痰，上阻经络而生。临床亦分三期论治。

初期：颈项部结核如豆，一枚或数枚不等，皮色不变，按之坚实，无疼痛发热。宜用逍遥散合二陈汤疏肝养血，健脾化痰。配合外治，用阳和解凝膏、冲和膏外敷。中期：颈上肿核增大，与表皮粘连，或数个结核融合成块，推之不能活动，若皮色暗红，有微热疼痛，按之有波动感，则内已成脓。宜内服透脓散加味健脾疏肝，透毒托脓，配合外治抽脓，或插入三品一条枪等腐蚀药物，使核脱落，外敷以太乙膏或生肌玉红膏等。后期：脓水清稀，内夹败絮浊物，淋漓不断，伴有阴虚内热诸证。内服宜六味地黄汤加味滋阴清热。外治用七三丹或八二丹掺入溃口，外敷红油膏、生肌散、白玉膏等，促进生肌长肉。

此病有延至数年，按之能动，又不溃破者病轻，而初期即累累数枚，坚肿不移，粘连一处者病情严重。

近年来报道的针刺法、挑治法、拔核疗法等，及西医的抗癆疗法，皆可配合使用。

【选案】

案一：霍××，男，31岁，初诊日期：1972年6月19日。

主诉：左颈部生一疙瘩，疼痛，两个多月。

现病史：两个月以前，开始于左侧颈下部生一肿物如杏核大小，有轻微疼痛。血沉快，确诊为“淋巴腺结核”。注射“链霉素”，口服“雷米封”等药物，肿块未消，反而逐渐增大，疼痛加剧。于6月19日来我院门诊就诊。

检查：左颈部有一肿物 2×2 厘米，表面皮色不变，不活动，边界清楚，按之有压痛。

脉象：沉细。

舌象：舌苔薄白，舌质正常。

西医诊断：左颈部淋巴腺结核。

中医辨证：肝郁气滞，痰湿凝聚。

立法：舒肝理气，软坚散结。

方药：夏枯草15克 贝母9克 牡蛎15克 鬼箭羽24克
当归15克 云苓12克 三棱9克 莪术9克 赤芍9克

外用麝香回阳膏。

上方服7剂后，疼痛减轻，局部肿物逐渐缩小。1972年6月30日患者曾做活体组织检查；结果报告为结核性肉芽组织。术后切口不愈合，并有脓性干酪样分泌物。7月24日复诊时，拟以内托软坚为法：

方药：香附9克 贝母9克 当归9克 二芍各9克 炒山甲9克 白术9克 甘草9克 云苓9克 生芪30克 炒皂刺9克

外用京红粉、珍珠散，隔日换药一次。

服上方后先见有清稀样分泌物，逐渐出现脓性粘稠分泌物。肿物日见缩小，一周后疮面基本愈合，肿核也消失。

《赵炳南临床经验集》

案二：王左，瘰癧溃后，脓水淋漓而无稠厚之脓，脉象弦细，宜育阴化毒。

大生地12克 川贝母6克 炙鳖甲12克 夏枯草10克 粉丹皮6克 大白芍10克 煅牡蛎12克 太子参10克 全当归10克 制首乌12克 云茯苓12克 炙芪皮10克

二诊：迭进育阴化毒之剂，瘰癧脓水已减，脉象弦细，仍拟前法加减。

大生地12克 制首乌12克 炙鳖甲12克 当归6克 白芍6克 粉丹皮6克 川贝母10克 陈广皮5克 仙半夏5克 煅石决12克 钩藤12克 夏枯草12克

三诊：瘰癧脓水未尽，腰部又觉胀痛，脉象弦细，拟再育阴化毒，参水疏理气机。

制首乌12克 太子参10克 大白芍10克 炙芪皮10克 当归须6克 旋复花（包）5克 真新绛4克 川贝母6克 青陈皮各5克 制乳没各6克 炙鳖甲12克 煅石决15克

陈树人整理：许半龙外科医案《江苏中医杂志》1981年2期

案三：曾治愈一位中年妇女患者赵某，右耳前肿痛八天，曾服中药五剂，虽略有好转，右耳前仍有肿核（约2.5×2厘米左右）局部压痛，皮色未变。脉弦细苔白，遂诊为瘰癧（耳前淋巴腺结核），证属肝胆郁火挟痰浊热毒结聚所致，治宜软坚散结，清热解毒，药用：

夏枯草15克 海藻15克 昆布15克 公英20克 地丁20克 双花20克 生牡蛎30克 丹参10克 马齿苋30克

进药5剂，耳前核肿基本消退，压痛亦消，遂加生地。减马齿苋续进12剂。药后耳前核肿已完全消退，改用下方善

后：

夏枯草15克 丹参10克 玄参12克 条芩12克 生地15克
羌活15克 珍珠母30克 寄生15克 麦冬12克

《医案医话荟要》

【分析】

案一为瘰癧中期。肿物增大，有压痛，但尚无波动感。治疗仍以消散为主。以夏枯草、贝母、牡蛎软坚化结；当归、赤芍活血通结；三棱、莪术破结通淤，特别重用鬼箭羽一味破血消肿，服后肿物渐小。但因手术后切口不愈合，后方乃以益气托毒，养血生肌方药取效。外用配合京红粉（《医宗金鉴》方：朱砂 雄黄 水银 火硝 白矾 皂矾）去淤生肌。珍珠散（《外科正宗》方，白石脂 龙骨 石膏、石决明 麝香 冰片 珍珠粉）解毒消肿，生肌长肉，使脓溃尽而症平。

案二为瘰癧后期，因气血虚损，溃后阴虚，以致脓水淋漓，治疗用育阴养血，托毒生肌方法，以八珍汤合川贝，夏枯草，鳖甲，牡蛎软坚托毒，加减调理而愈。

案三为耳前瘰癧初起。未有化脓趋势，急用清热解毒，软坚散结方法。重用马齿苋、双花、地丁、公英清热解毒；重用牡蛎、海藻、夏枯草、昆布软坚消结。前者取法五味消毒饮；后者效仿海藻玉壶汤。既取治痈之清热解毒；又仿消瘰之软坚散结。病变方补变，游刃于瘰癧二者之间而别出治瘰癧之道，可谓灵性所至，触类旁通。况且经现代科研报道，马齿苋、夏枯草等皆有抗结核杆菌之效，故此方足可取法。

[G e n e r a l I n
f o r m a t i o n]
书名 = 自学中医之路丛书
 中医病案分析
作者 =
页数 = 2 7 0
S S 号 = 0
出版日期 =

封面
书名
版权
前言
目录
正文

历代中医书籍大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

不管哪种方式，看到你的信息我会第一时间回复，尽全力帮您！

加微信可以扫描以下二维码加我！



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医